"Elegí mi vida"

Una mirada feminista sobre salud mental y experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios clandestinizados (2009-2019)

Natalia Santarelli

Editorial CEA ▶ Colección Tesis

edicea CEA 35años facultad de ciencias sociales unc

"Elegí mi vida".
Una mirada feminista sobre salud mental y experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios clandestinizados (2009-2019)

Natalia Santarelli

edicea
CEA 35años
facultad de ciencias sociales
unc

Colección Tesis

“Elegí mi vida”.
Una mirada feminista sobre salud mental y experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios clandestinizados (2009-2019)

Doctorado en Estudios de Género

Natalia Santarelli

Universidad Nacional de Córdoba
Rector: Mgter. Jhon Boretto
Decana de Facultad de Ciencias Sociales: Mgter. Alejandra Domínguez

Editorial del Centro de Estudios Avanzados
Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales,
Av. Vélez Sarsfield 153, 5000, Córdoba, Argentina

Director: Marcelo Casarin
Coordinación Ejecutiva: Alicia Servetto
Coordinación Editorial: Mariú Biain

Comité Académico de la Editorial
Magdalena Doyle
Vanessa Garbero
Bruno Ribotta
Darío Sandrone
Coordinadora Académica del CEA-FCS: Alejandra Martin
Coordinadora de Investigación del CEA-FCS: Marcela Rosales
Asesora externa: María Teresa Dalmasso

Cuidado de edición: Mariú Biain
Diagramación de Colección: Lorena Díaz
Diagramación de este libro: Silvia Pérez
Responsable de contenido web: Diego Solís

© Centro de Estudios Avanzados, 2025

Santarelli, Natalia
Elegí mi vida : una mirada feminista sobre salud mental y experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios clandestinizados 2009-2019 / Natalia Santarelli. - 1a ed. - Córdoba : Centro de Estudios Avanzados. Centro de Estudios Avanzados, 2025.
Libro digital, PDF - (Tesis)
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-631-91259-5-5
1. Estudios de Género. 2. Aborto. 3. Derechos Reproductivos. I. Título.
CDD 304.667



Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5. Argentina

A la primera mujer que me amó.
Sospecho, sin dudas, que de ella nació "todo esto".

A todas aquellas que compartieron generosamente
sus experiencias y prácticas.

No quería ni imaginar los riesgos que estaba corriendo. Pero a otra parte de mí le asombraba mi propia osadía. Lo había hecho.
Aun en mayor medida que irme de casa, esta acción que me estaba desgarrando las entrañas y que podía matarme (solo que eso no iba a ocurrir); esta acción, suponía un desplazamiento de la seguridad a la autoprotección.
Yo elegía mis dolores. En eso consistía vivir.
Me aferré a eso y traté de sentirme orgullosa.
No me había rendido. No me había limitado a ser el ojo que observa desde fuera hasta que es demasiado tarde.
Audre Lorde

En las historias feministas, en su narración, la experiencia está en el centro como búsqueda de un hilo narrativo, ya no de la memoria del yo, sino de la memoria y construcción de un lazo que pone en evidencia el doble mecanismo de enlace y separación, de atadura y corte, de identidad y diferencia.
Somos feministas porque no estamos solas, pero somos feministas porque alguna vez estuvimos solas o creímos estarlo. Buscamos un lazo que se teje resistente para hacer red entre cuerpos con potencia de enjambre.
Marta Dillon

Agradecimientos

Cada quien tiene una historia particular sobre cómo es que deviene todo el tiempo feminista, dice Marta Lamas en una entrevista en 2021. Este libro es producto de la investigación para mi tesis doctoral en Estudios de Género (FCS, UNC), presentada en diciembre de 2023. Considero que esta investigación es una parte fundamental de mi constante devenir feminista. Fue posible gracias al sostén de múltiples presencias junto a quienes transité encarnadamente un proceso feminista que, espero, dé lugar a muchos otros procesos acompañados.

Agradezco a todas las personas e instituciones que acompañaron esta investigación y su publicación como libro. Especialmente al equipo del Doctorado en Estudios de Género (FCS, UNC), a Edicea (FCS-UNC), a Conicet y a la Facultad de Psicología (UNSL).

Agradezco profundamente a las 30 mujeres que compartieron sus voces y apostaron a este proyecto. También a profesionales de la salud y activistas feministas de San Luis y Mendoza que me concedieron entrevistas y que siguen tramando, cotidianamente, formas justas y respetuosas para acompañar a construir salud.

A quienes fueron mis compañeras socorristas, especialmente en San Luis, y a todas las mujeres que confiaron en nuestros acompañamientos cuando abortaron: gracias por mostrarme cuánto de salud y bienestar pueden contener estos procesos cuando se realizan de manera autónoma y cuidada.

Agradezco profundamente a quien fue mi mayor acompañante en esta investigación, como directora de mi investigación doctoral y de la beca doctoral de Conicet y como compañera feminista, Claudia Anzorena.

A mis queridas compañeras de los Grupos de Escritura de la AAIH-MEG, con quienes compartimos la oficina virtual feminista y mucho más.

Finalmente, mis agradecimientos a quienes conforman mis familias de Mendoza y San Luis, la de origen y las construidas, todas elegidas. Gracias por ser el "nosotras" que me sostuvo en este proceso.

El Volcán (San Luis), 29 de noviembre de 2024

Índice

Prólogo 17
Presentación 19
Organización de este escrito 23
Sobre mi forma de escritura y mi posición marcada… 24

Capítulo 1. Experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios farmacológicos clandestinizados entramadas en el género. Bases conceptuales 29
Experiencias, subjetividades y significaciones generizadas 29
Embarazos no deseados/abortos voluntarios farmacológicos clandestinizados: un *continuum* 32
Sobre la desclandestinización 38
Dispositivos de fragilización de género: mandatos, estrategias y configuraciones emocionales que fragilizan 39
Dispositivos de fragilización de género 39
Maternidad sacralizada/aborto demonizado 41
Vidas y autonomías desigualadas 42
De vergüenzas y culpas, de avergonzamientos y culpabilizaciones 44
Una experiencia precarizada: entre riesgos y cuidados 46

Capítulo 2. Salud mental y experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios clandestinizados 49
Dos discursos psi contrapuestos sobre la relación entre salud mental y aborto voluntario 49
Nuestra comprensión de la salud mental. Aportes desde el modelo tensional-conflictivo, enfoque participativo y la construcción de autonomía 53

Crisis, participación, autonomía y posibilidades de transformación 54
Un modo otro de comprender la relación entre salud mental y embarazos no deseados/abortos voluntarios 57

Capítulo 3. Consideraciones metodológicas y éticas 61
Breves precisiones metodológicas 61
Apuntes éticos para un proceso feminista 66
Sobre las entrevistadas y sus experiencias 69

Capítulo 4. Escenarios de los abortos entre 2009-2019. Regulaciones, disputas y transformaciones en Argentina 81
Principales transformaciones en el marco normativo y sanitario 81
San Luis y la falta de definiciones 84
Mendoza y sus marcadas disputas 85
Estrategias feministas para visibilizar, acceder y transformar los abortos farmacológicos 87
Los feminismos afectan el silenciamiento sobre los abortos 87
Los feminismos organizan el acceso seguro a los abortos farmacológicos 90
Acompañamientos feministas en San Luis y Mendoza 93
Escenarios locales donde se insertan las experiencias 96

I. Malestares y significaciones iniciales 99

Capítulo 5. La tormenta emocional 101
Incredulidad y rechazo frente a la confirmación del embarazo 101
Incertidumbres y temores frente a un camino lleno de obstáculos 105
Autorreproches y vergüenza: el embarazo no deseado como evidencia 116
Decidir con culpas. La actuación de los mandatos religiosos 120
Emocionalidades y significaciones en el inicio de un proceso complejo 126

II. Tránsitos acompañados 129

Capítulo 6. Vamos juntas: la presencia de las amigas 131
Cuidados en el marco de las relaciones afectivas entre mujeres 131
Entre los vínculos afectivos y las significaciones de las experiencias: la construcción de salud mental 145

Capítulo 7. Descubrir esta red de mujeres organizadas: la presencia de las activistas feministas 147
Recursos, saberes y disponibilidad 148
La grupalidad: abortar como experiencia colectiva enriquecedora 156
Sentidos para cuestionar, desarticular y transformar las significaciones sobre las experiencias 160
Aportes a las significaciones y emocionalidades sobre los embarazos no deseados/abortos voluntarios 166

Capítulo 8. Un acompañamiento emocional invaluable: la presencia de las psicólogas 169
Presencias que informaron y orientaron 170
Presencias psi contenedoras 174
Presencias psi autoafirmativas de la decisión 177
Presencias que validaron la capacidad de decidir y actuar 180
Presencias que ayudaron a problematizar y resignificar 182
Las presencias psi facilitadoras de las significaciones de las experiencias. Claves para repensar el rol profesional psi 188

III. Transformaciones asociadas al bienestar de decidir, resolver y narrar los abortos 193

Capítulo 9. Autorizarse a abortar: implicancias de una decisión significada como legítima y a favor de sí misma 195

Capítulo 10. Las potencias saludables de narrar las experiencias 207
Narrarse la experiencia y dar "un gran paso" 208
Narrar para las otras y "echar luz" sobre los abortos 212
Narrar y construir salud mental 217

Conclusiones 221
Entre riesgos y cuidados… 222
Entre la estigmatización y la construcción de legitimidad y valor sobre las experiencias… 223
Salud mental y aborto: la importancia de los discursos psi críticos de los dispositivos de fragilización de género 228
Aperturas, nuevos interrogantes, nuevas incertidumbres 232

Bibliografía 235

Prólogo

Este libro no solo es necesario, sino que es oportuno.

Si bien desde el 30 de diciembre de 2020 contamos con una ley que sacó en gran medida de la clandestinidad el proceso de embarazo no deseado/aborto voluntario, las multiformes amenazas reaccionarias a nuestros derechos nos ponen en estado de alerta. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es vivir en un contexto de clandestinización del aborto. Porque sabemos lo que es habitar una corporalidad con capacidad de gestar en un sistema opresor y oprimente de las decisiones sobre nuestros embarazos, partos o abortos.

Este libro es necesario porque narra desde la voz de las protagonistas lo que significa subjetivamente atravesar el proceso de abortar en contextos restrictivos. Mucho se ha escrito sobre el aborto inseguro y sus consecuencias desde la perspectiva de quien juzga (ya sea sanitaria, filosófica o religiosa), pero poco se ha investigado sobre los procesos emocionales que se juegan desde la perspectiva de quien decide y elige interrumpir un embarazo. Natalia demuestra con gran rigurosidad científica (y no por esto con menos involucramiento y compromiso feminista) que lo que afecta negativamente en la salud mental no es la práctica en sí, sino todos los fantasmas que se construyen alrededor de quienes se atreven a cuestionar el mandato supremo de la maternidad. Pero no se queda ahí, sino que complejiza el análisis introduciendo las particularidades que aportan los avances en las tecnologías farmacéuticas, el amplio alcance que adquirieron las TIC, y –sobre todo– la organización de acompañamientos feministas para que los abortos fueran y sean seguros, en el contexto de San Luis y Mendoza entre los años 2009 y 2019.

Las barreras que enfrentamos para acceder a las políticas en materia de sexualidad y reproducción (ya sean estructurales, institucionales o sub-

jetivas) y su configuración están estrechamente vinculadas con el estatus legal de las prácticas a las que se desee acceder. Entonces, estas no tendrán las mismas formas en contextos legales restrictivos que en contextos legales permisivos, ni para quien necesita el aborto ni para quien lo practica o acompaña. Esto ha sido así ayer, lo es hoy y lo será mañana.

Las activistas hemos desempeñado un papel crucial en la superación de los obstáculos que enfrentan mujeres cis, niñas, adolescentes y varones trans para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y facilitar el acceso efectivo al derecho al aborto. Estas estrategias siempre implican poner nuestros cuerpos y nuestras emociones al servicio de transformar, enmendar o eludir las condiciones que se nos imponen.

Este libro relata minuciosamente la carga emocional y la experiencia subjetiva que viven tanto quien aborta como quienes acompañan esos abortos, ya sean amigas, familiares, activistas e incluso profesionales de la salud. Para unas/es, el estupor, la indefensión, los miedos, la soledad, el coraje. Para otras/es la presión ante una demanda creciente, el temor a ser denunciadas o perseguidas, o la responsabilidad y el estado de alerta para que salga todo bien. Todas estas sensaciones y emociones se vieron transformadas con la legalidad. Pero es inevitable que ante la amenaza de derogación o desfinanciación de nuestros derechos comience a recorrernos por el cuerpo la memoria de un contexto de clandestinidad.

Así que este libro es urgente. Porque los reaccionarios sueñan con volver a un paraíso donde para ellos todo era privilegio y para nosotras y nosotres obediencia. Natalia nos convoca a recordar las emociones que nos provoca el temor a un embarazo no deseado-aborto voluntario en la clandestinidad, en nuestros cuerpos o en los cuerpos de alguien querida o desconocida que acompañamos, como un ejercicio de memoria para no volver *nunca más* a los lugares de donde logramos salir.

Claudia C. Anzorena
Mendoza, 11 de noviembre de 2024

Presentación

"Fue como estar entre la espada y la pared"; "Desesperadísima, no podía parar de culparme a mí misma y decir: *¿cómo me va a pasar esto a mí?*"; "Yo tengo miedo porque a mí no me puede pasar nada porque mi hija depende de mí"; "Enterarme fue espantoso, esta vez"; "Yo sentí eso: mi cuerpo invadido"; "A mí lo que me desesperaba era que como tenía la decisión tan, tan tomada, no poder solucionarlo"; "¡Necesito que esto termine, nada más, yo quiero que esto termine, yo NECESITO que esto termine!"; "Lo más traumático es lo ilegal, lo clandestino, el miedo a morirte, a que te metan presa, a que te traten mal, llegar al hospital sabiendo que no te vas a morir pero que te van a humillar, esa era la sensación"; "Yo sé que hice lo correcto, no me arrepiento"; "Primero, la seguridad de los vínculos que estuvieron, muy agradecida a eso, mucho apoyo, muchas amigas"; "A mí, particularmente, me sirvió para sentirme más propia de mí misma"; "Yo nunca me sentí tan fuerte como en ese momento. JAMÁS"; "Di un giro a mi vida… como que renové las fuerzas en un punto"; "Bueno, lo que hice fue ELEGIR MI VIDA, básicamente".

Voces. Experiencias. Embarazos no deseados. Voluntades. Abortos. Cada relato sobre estas experiencias nos abre un universo particular de significaciones y emocionalidades. Nos muestran que decidir y atravesar un aborto voluntario frente a un embarazo no deseado en contextos de restricción legal y social conforma experiencias complejas, multideterminadas y heterogéneas, tanto a nivel social como subjetivo.

Desde tiempos inmemoriales, las mujeres hemos abortado y nos hemos acompañado, pero estas experiencias han ido cambiando. Al referirme a estos cambios hay dos puntos clave que no puedo dejar de mencionar: el descubrimiento, en manos de mujeres, del método farmacológico para abortar y, acompasado a ello, las estrategias de organización feministas.

En América Latina y el Caribe, desde hace más de cuatro décadas, las mujeres utilizan un medicamento denominado misoprostol para autoinducirse abortos (luego, en Argentina, pudimos acceder a la mifepristona). Descubrir y perfeccionar el método farmacológico para abortar cambió radicalmente la práctica porque brindó la posibilidad de realizarlo de forma ambulatoria y redujo las complicaciones físicas asociadas al aborto inseguro. Tanto la circulación del conocimiento sobre su uso adecuado como la creación y consolidación de estrategias y redes feministas de acompañamiento han sido fundamentales para transformar las experiencias de abortos en y a pesar de los contextos en los que se realizan.

En Argentina, la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (en adelante "la Campaña") en 2005, dio un impulso especial a las iniciativas de acompañamiento que resultaron cada vez mayores y más organizadas.

La Campaña es un espacio de articulación federal, integrada por feministas, colectivas y organizaciones con diversas orientaciones políticas y prácticas activistas, que recogió y potenció la lucha por el reconocimiento del derecho al aborto iniciada en décadas anteriores (AAVV, 2013). Su rol fue decisivo en el logro de la actual Ley Nº 27610/2020 que regula el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo y el acceso a la atención postaborto. Pero desde antes de este hito legislativo y social, la Campaña promovió iniciativas concretas para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar pudieran abortar de manera segura, en diferentes puntos del país y no solo en las zonas metropolitanas.

En 2007, feministas que integraban la Campaña, agrupadas en Feministas Inconvenientes, elaboraron folletos con información sobre el uso seguro del misoprostol que distribuyeron en diversas actividades. En 2009, esta difusión se tornó más sistemática de la mano de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto (en adelante LyF). Y, entre 2010 y 2012, activistas de la Campaña de diferentes provincias –con un fuerte impulso patagónico– dieron forma de red a las prácticas de acompañamiento de abortos farmacológicos que venían realizando y las extendieron a otras provincias. Conformaron Socorristas en Red –feministas y transfeministas que abortamos–, actora social fundamental y relevante al momento de brindar información, acompañar y gestar sentidos feministas sobre abortos. Años más tarde, esta Red apoyó la conformación de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, también parte activa de la Campaña.

En este libro nos enfocamos, precisamente, en las experiencias por las que transitaron algunas mujeres que abortaron con medicamentos y acompañadas por feministas. Nos propusimos comprender, desde un acercamiento feminista, los modos en que significaron sus experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios farmacológicos clandestinizados en relación con los procesos de construcción de salud mental, en las provincias de Mendoza y San Luis, desde 2009 hasta 2019.

Nos interesan, entonces, las significaciones y sus procesos de transformación a la luz de las diversas condiciones y entramados de género en que acontecieron. En estos procesos atendemos, especialmente, a los modos en que actuaron los diversos acompañamientos, poniendo en el centro de la escena las valoraciones de quienes abortaron.

En este trabajo, la pregunta por la relación entre salud mental y aborto está presente desde el comienzo y se asoma en cada palabra escrita. Para ello, antes de abordar esta relación, necesitamos delimitar qué entendíamos por salud mental. Es así que elegimos y apostamos a una perspectiva teórica que enfatiza tanto en la salud mental como un proceso que se transita, como en la riqueza que pueden contener estos tránsitos por experiencias críticas vitales. En este caso, los embarazos no deseados, los abortos voluntarios farmacológicos y sus condiciones y circunstancias, pensados como un *continuum*.

Abordamos la relación entre abortos y salud mental vinculándola directamente a los dispositivos de fragilización de género y sus impactos en los padecimientos subjetivos. Por ello es que nos preguntamos tanto por los malestares que experimentaron las mujeres durante el proceso, entramados con las relaciones de poder, las estrategias de fragilización y los mandatos impuestos. Como así también por los procesos de transformación de estos malestares y los matices cualitativos del bienestar experimentado. Todo lo cual lo pensamos en función de los vínculos y los cuidados involucrados.

Las experiencias elegidas ocurrieron entre 2009 y 2019. Para marcar el inicio de este recorte temporal tuvimos en cuenta el año de creación de la línea telefónica de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto (LyF). La línea fue la primera en dar información sobre uso de misoprostol en Argentina y le permitió a mujeres de todas las provincias acceder a la información oral y, luego, escrita, cuando esta misma organización feminista compiló el manual "Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas" en 2010.

Este tiempo histórico-social comprende 10 años de intensa organización y difusión de diferentes estrategias feministas de acompañamiento; la antesala de la anhelada y batallada sanción de la Ley Nacional Nº 27610/2020. En este sentido, esta investigación es contemporánea a lo que Vaggione (2014a) denomina *el proceso de legalización desde abajo*, en referencia al trabajo activista feminista para redefinir sentidos y generar un entramado normativo alternativo que desafió al derecho estatal que ilegalizaba y que, en el período elegido, se vio intensificado y masificado.

Las experiencias se sitúan en las provincias de San Luis y Mendoza, Argentina. Esta elección, por un lado, se vincula a mi historia y posibilidades, ya que en ambas provincias me crié, crecí y desarrollé mis actividades laborales y activistas, lo cual me garantizó el acceso a espacios colectivos y a personas dispuestas a brindar sus relatos. Por otro lado, tuvimos en cuenta que, si bien en la actualidad han proliferado subcampos de saberes en torno al tema y la multiplicidad de perspectivas desde las cuales se aborda, al momento de realizar esta investigación la mayoría de los trabajos sobre aborto estaban focalizados en experiencias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Existe una tendencia a considerar los acontecimientos de alcance nacional como sinónimos de lo que sucede en esa región y a pensarlos replicados en las provincias (Burton, 2021). Pero en materia de aborto, como en tantas otras experiencias, operan considerables desigualaciones y especificidades regionales e interprovinciales –incluso intraprovinciales– que conforman las experiencias concretas. Revalorizando estas especificidades, aspiramos a colaborar en la ampliación federal de los estudios sobre experiencias de abortos y en la comprensión sobre cómo las particularidades locales y provinciales se hacen texto en las experiencias de las mujeres.

También forma parte de nuestras intenciones brindar una revisión crítica hacia el campo psi, al cual pertenezco, considerando cuál ha sido y cuál puede ser el lugar del acompañamiento profesional en estas experiencias. Y, sobre todo, buscamos sumar aportes al debate sobre el aborto en términos de salud mental. Esto es, desde una mirada despatologizante y politizada, de derechos, que visibilice el carácter procesual y dinámico de la salud mental y, sobre todo, que ponga en valor las voces de sus propias protagonistas, en tanto activas constructoras de sentidos sobre el mundo social y sobre sí mismas. Una perspectiva, entonces, que porta anteojos y audífonos violetas.

Organización de este escrito

En los primeros tres capítulos de este escrito presentamos algunas precisiones teóricas y las categorías teórico-analíticas que inscriben este trabajo en el campo interdisciplinario de los Estudios de Género. Seguido de algunas consideraciones metodológicas y éticas sobre el proceso de investigación emprendido.

El cuarto capítulo está centrado en una descripción breve de las regulaciones y transformaciones a nivel nacional en torno a los abortos durante el período analizado (2009-2019). Enfocamos en las acciones y reacciones a partir del Fallo F.A.L. (CSJN, 2012) en las provincias de Mendoza y San Luis, para comprender los climas sociales provinciales y las estrategias feministas locales que, en articulación con las iniciativas a nivel país, posibilitaron que muchas mujeres accedieran a los abortos farmacológicos.

A partir del capítulo cinco entramos de lleno en nuestra propuesta analítica de las experiencias, sus significaciones y emocionalidades, dando cuenta de los procesos y sus transformaciones. Lo dividimos en tres grandes nudos temáticos.

En el primero (Capítulo 5) abordamos los malestares y significaciones en los momentos iniciales de los procesos de embarazos no deseados/abortos voluntarios clandestinizados. Aprehender las complejidades, conflictos y tensiones previas a practicarse los abortos farmacológicos: la tormenta emocional, como se refirió una de las entrevistadas.

En el segundo nudo temático (capítulos 6, 7 y 8) indagamos las valoraciones sobre los distintos acompañamientos que las mujeres gestionaron para atravesar las experiencias. Como también, los modos en que estas presencias actuaron en la desarticulación, construcción y afianzamiento de diversas significaciones, a la luz de los procesos de construcción de salud mental.

En el tercer nudo temático nos ocupamos de las transformaciones y el bienestar una vez resueltos los abortos voluntarios y asociados a la construcción y afianzamiento de nuevas significaciones (Capítulo 9). También hay lugar, en el Capítulo 10, para repensar el bienestar que les implicó a las entrevistadas poder narrar las experiencias, en la cotidianeidad y en esta misma investigación. En este sentido, ofrecemos una respuesta, que se entrelaza con el tiempo histórico social que sitúa los relatos, a una pregunta que Chaneton y Vacarezza (2011) se hicieron hace más de una década: "¿qué nuevos sentidos se arman y se abren una vez que la experiencia puede transformarse en relato y darse a conocer a otros y otras?" (p. 167).

Cerramos con conclusiones en dos grandes sentidos.

Primero, en torno al entramado entre las experiencias clandestinizadas y acompañadas y sus significaciones, en función de dos tensiones centrales que atraviesan este escrito: la tensión entre los riesgos y los cuidados, y la tensión entre la estigmatización y la búsqueda y construcción de legitimidad/valor sobre las experiencias.

Segundo, respecto a la importancia de los discursos y prácticas psi sensibles a los dispositivos de fragilización de género en los procesos de construcción de salud mental de las mujeres que abortan voluntariamente. Finalizamos con nuevos interrogantes sobre el tema, a la luz de los desafíos del momento actual.

Sobre mi forma de escritura y mi posición marcada…

Elijo escribir en primera persona, en sintonía con el posicionamiento epistemológico feminista que asumo y que me lleva a reconocer que mis posicionamientos como investigadora-activista, mis valoraciones subjetivas, mis intereses políticos y atravesamientos culturales son parte integral de este estudio. Hacen a mi posición marcada. El mostrarme en lo que escribo y en cómo lo escribo, en primera persona, me facilita el propósito de sostener la conciencia de mi presencia en quienes lean (Wolcott, 2003).

Por momentos uso y usaré la primera persona en singular y, en gran parte del texto, usaré el plural, el nosotras, con la idea de visibilizar dos grandes presencias: la de ustedes –lxs potenciales lectorxs– y la de tantas otras autoras con quienes me identifico genealógicamente y junto a quienes, siento, he pensado y transitado este proceso de investigación.

Ubico las bases epistemológicas de esta investigación en las propuestas feministas que valoran el reconocimiento de la subjetividad y de la intersubjetividad contenidas en el proceso de investigación cualitativa, como así también la intervención de los mundos culturales, las trayectorias biográficas y la condición genérica y social de quienes investigamos (Harding, 2002; Kornblit, 2007; Martínez-Salgado, 2012). Quienes investigamos somos seres reales y corpóreos, tenemos intereses particulares y específicos que construimos en función de una posición genérica, histórica y social que es necesario examinar. Como también es necesario explicitar cómo consideramos que nuestras creencias, experiencias, posicionamientos políticos y prácticas culturales influyen en las investigaciones en curso. Esta particular relación con lo investigado y sus matices intersubjetivos es denominada reflexividad de la ciencia social. La búsqueda de una objetividad fuerte y no neutral se fortalece cuando logramos transparentar la subjetividad e intersubjetividad contenida y constitutiva de dichos procesos de investigación (Haraway, 1995; Harding, 1996).

A continuación, y con la intención de posicionarme, destaco algunas marcas y experiencias previas que contribuyeron a gestar mis intereses en relación con el tema de investigación, a la vez dejo en evidencia algunas de mis condiciones de escucha e interacción, que denomino feministas.

Notas sobre mi posición marcada

¿Por qué tenemos que estar siempre sobreviviendo?
¿Cuándo, en qué era, a qué hora te toca estar viva?
Patricia Karina Vergara Sánchez (2017: 29)

Al momento de escribir esta tesis me defino como una sujeta mujer, estoy transitando el segundo lustro de mis 30 años, he elegido no maternar y aunque bautizada en el catolicismo, soy atea. Me sitúo en la línea que enlaza el activismo feminista y la investigación social, como militante por el derecho al aborto y como psicóloga que se propone aportar al campo de la salud mental con una perspectiva de género feminista.

Mis primeros encuentros con las teorías y las prácticas feministas estuvieron mediatizados por inquietudes profesionales cuando trabajaba con mujeres en situación de violencia machista en la pareja en institu-

ciones públicas del ámbito judicial y ejecutivo, y en una Casa-Refugio sostenida por un grupo de voluntarias de la Universidad Nacional de San Luis. En esta institución me formé como psicóloga y hoy continúo formándome como docente e investigadora. Esas inquietudes profesionales fueron anudándose con mis necesidades personales y políticas, y hallaron palabras e instancias de reflexión profunda en los feminismos.

Mi tránsito como becaria de Conicet y estudiante del Doctorado en Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba me incentivó a asumir la responsabilidad de identificar algunas preguntas sobre la relación entre los embarazos no deseados/abortos voluntarios y salud mental que, de diversas formas, afectan a un grupo oprimido. Entiendo, siguiendo a Harding (2002) que abordar estos interrogantes se vincula a las posibilidades de modificar sus (nuestras) condiciones de opresión; conocer las fuerzas que moldean ciertas situaciones para accionar sobre estas e ir avanzando hacia caminos de emancipación, autonomía y crecimiento de estos grupos. Grupos de los que me siento parte, fuerzas que también golpean mi carne, mi subjetividad y mis afectos.

Parte de mis intereses en el tema investigado también fueron surgiendo cuando detecté un vacío en mi propia formación de grado en psicología respecto a los entrecruzamientos entre los derechos sexuales y (no) reproductivos y la salud mental, y específicamente la falta de abordaje de la problemática de los abortos clandestinizados. En aquel entonces, busqué libros por fuera de la academia, y las ferias feministas me ofrecieron las dos primeras lecturas que realicé sobre aborto: *Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas*, compilado por Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto (2010) y *La intemperie y lo intempestivo: experiencias del aborto voluntario en el relato de mujeres y varones*, escrito por July Chaneton y Nayla Vacarezza (2011).

El compromiso con este tema excedió el campo estrictamente académico y las lecturas solitarias dieron lugar a las prácticas colectivas. Reconozco que muchos de los interrogantes que conformaron esta investigación tomaron forma a partir de procesos de praxis y reflexión en campos activistas de los que participé junto a otras.

Previo a iniciar el Doctorado en Estudios de Género y hasta 2017 me sumergí en la interacción cotidiana con mujeres que decidieron abortar con medicamentos embarazos no deseados en la provincia de San Luis. Acompañábamos desde dispositivos socorristas que proponían

formas de transitar los abortos de maneras menos enturbiadas por las (i)legalidades patriarcales, los silenciamientos y la estigmatización, y más nutridas de palabras, deseos, contención y reconocimiento de derechos. Fue una época intensa y desafiante que me permitió sentir en la piel la potencia y los alcances de la organización para construir posibilidades de vidas con menos violencias; presentes y futuros más cercanos a los deseos. En estos encuentros pude vislumbrar cuánto de bienestar y de salud circulaba cuando las mujeres lograban interrumpir los embarazos no deseados en condiciones de cuidado, en y a pesar de la clandestinización. Esta experiencia emocional y política que compartí con miles de mujeres fue un posibilitador fundamental para que emergieran los intereses y las preguntas de esta investigación.

También estas experiencias me recontactaron de forma cruda y directa con las vivencias y los relatos de las múltiples violencias en las vidas de las mujeres que se entraman con los embarazos no deseados y forzados a continuar, ante las cuales ellas (nosotras) resisten (resistimos). Violencias de sus parejas varones, violencias al interior de las familias, violencias del sistema médico hegemónico, violencias de los discursos psi, violencias institucionales y estatales, violencias escritas en las leyes patriarcales, violencias clasistas, violencias de género. Muchas de estas violencias me atraviesan directamente.

Me reconozco y sitúo como una mujer que sufrí en mi propio cuerpo y subjetividad adolescente el impacto de las violencias impuestas por la clandestinización del aborto voluntario. Hace más de 15 años me comprometí con un proceso terapéutico psicoanalítico, por un lado, y con un camino de acercamiento a los feminismos, por otro lado. Ambos espacios me permitieron otorgar sentidos propios a mi experiencia de embarazo no deseado/aborto voluntario clandestinizado, que por muchos años permaneció enquistada emocionalmente en un sin-sentido. Me permitieron aprehenderla entrelazadamente con circunstancias y condiciones subjetivas, sociales, históricas, de género, todas ellas políticas. El pasaje de la privatización y psicologización de mis malestares al entendimiento encarnado de que lo emocional también es político, social y su abordaje puede ser colectivo, fue liberador y enriquecedor para mis procesos de construcción de salud mental en torno a esta experiencia. De modo que, pude hablar de abortos y de mi aborto en voz alta, y otras estuvieron dispuestas a escucharme. Pude recrear sentidos para incorporar esta experiencia vital en mi biografía personal, y otras me

ofrecieron una biografía colectiva donde poder inscribirme. Pude comprender mi posición de género frente a los dispositivos que pretenden fragilizarnos, y otras me guiaron en esas comprensiones y me acompañaron para desarrollar potencias. Hoy, pude escuchar los relatos que las entrevistadas compartieron generosamente, y otras me acompañaron para iniciar, desarrollar y terminar esta investigación.

Inscribo este trabajo de investigación como parte del compromiso, asumido junto a todas esas otras, de sostener movimientos que no se limiten a acompañar la supervivencia, sino a reconocer y diseñar presentes llenos de vida y de autonomía, delineados por y para nosotras mismas. En esta era, en este tiempo, en esta hora. Ahora.

Capítulo 1. Experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios farmacológicos clandestinizados entramadas en el género. Bases conceptuales

En este primer capítulo conceptual vamos a delimitar las nociones básicas de la investigación que desarrollamos.

Primero, definimos las *experiencias generizadas* en relación con la *subjetividad* y las *significaciones*. Luego presentamos el *continuum* embarazos no deseados/abortos voluntarios farmacológicos clandestinizados y delimitamos sus términos. Para ello, construimos la categoría teórico-analítica de proceso de *clandestinización* y haremos, también, una breve referencia a la *desclandestinización* como proceso contrapuesto y complejo.

Para cerrar esta propuesta teórica, enmarcamos los procesos de clandestinización como parte de los *dispositivos de fragilización de género* y abordamos algunas operaciones simbólicas y configuraciones emocionales que, justamente, producen este efecto fragilizante y desigualador para las vidas y salud de las mujeres que abortan. Todo esto nos permite pensar estas *experiencias como precarizadas* y, a partir de ello, plantear dos tensiones que retomaremos a lo largo del análisis de las experiencias: la tensión entre riesgos y cuidados, y la tensión entre la estigmatización y la legitimación.

Experiencias, subjetividades y significaciones generizadas

¿A qué nos referimos cuando hablamos de experiencias generizadas y subjetividad? En principio, podemos decir que nos referimos a procesos y productos en construcción, a significados y complejos de efectos de las experiencias y el género sobre los cuerpos, las subjetividades y las relaciones sociales (De Lauretis, 1990).

Coincidimos con De Lauretis (1990) en que la subjetividad es pro-

ducto de las experiencias generizadas e historizadas, un complejo de efectos nunca acabado que se encuentra en constante construcción y que está mediada discursivamente. La subjetividad comprende el interjuego entre lo social y lo psíquico que se va construyendo, a través de las experiencias y en una interacción semiótica entre el yo y el mundo externo. Esto nos hace aprehender como algo subjetivo las relaciones –materiales, económicas e interpersonales– que son, de hecho, sociales e históricas (De Lauretis, 1992). De modo que esta noción feminista de experiencia se encuentra en estrecha relación con las prácticas sociales-materiales a la vez que con los compromisos subjetivos con las actividades, discursos e instituciones que dotan de importancia (valor, significado y afecto) a los acontecimientos del mundo.

Encontramos un punto en común entre esta noción que piensa imbricadamente la subjetividad y las experiencias con algunas visiones psicoanalíticas con perspectiva de género que reconocen que hay modos sociohistóricos de subjetivación (Burin, 1999; Fernández, 2009, 2021). Así, la subjetividad, pensada en una articulación social e histórica, además de comprender los procesos de identificaciones tempranas, involucra las prácticas de sí constituidas por el paso por las sucesivas instituciones. Entonces, el conjunto de instituciones, y ya no solo la familia y las relaciones primarias, producen subjetividad (Fernández, 2009). Se trata de un proceso con estabilidades, giros y múltiples desenlaces transitorios según las experiencias, las prácticas y los discursos por los que se transita en compañía de otras/os/es y en distintos momentos de la vida.

A su vez, subjetividad y experiencia se constituyen dentro del sistema de género, están generizadas o, dicho de otro modo, se ven afectadas y producidas por los dispositivos de género en un interjuego constante entre lo que De Lauretis (1996) denomina representaciones sociales y representaciones subjetivas (o autorepresentaciones) de género.

Entendemos al género como un aparato semiótico que otorga significados, cuya función es la de constituir individuos concretos como varones y mujeres (De Lauretis, 1996). Existe un sistema de significados que correlaciona el género, entendido de forma binaria, con determinados contenidos culturales (valores sociales, ubicación en las jerarquías, identidades). Este sistema se ve afectado por las particularidades de cada cultura y época, pero conserva una asimetría constante que marca sistemáticamente organizaciones sociales desigualadas. No podemos escapar de ocupar un lugar dentro de este entramado histórico relacional

que construye subjetividades con significados y valores diferenciales. Sin embargo, estos lugares pueden habitarse con mayor o menor conciencia, lo cual puede implicar mayores o menores posibilidades de repetir o recrear las formas hegemónicas de habitarlos.

Además, otra proposición interesante planteada por De Lauretis (1996) es que el género continúa en construcción siendo, incluso, esa construcción misma. De modo que es tanto el producto de las representaciones sociales y subjetivas construidas a partir de las complejas tecnologías de género que desigualan, como el proceso mismo de su construcción que, aún hoy, continúa siendo, mediante complejas tecnologías y discursos institucionales. Estas tecnologías cuentan con el poder de controlar el campo de significaciones sociales y subjetivas, al producir e implantar determinadas representaciones de género. Lo interesante es que esta capacidad no solo la detentarían los llamados aparatos ideológicos del Estado con sus discursos hegemónicos, sino también los discursos desde los márgenes y las prácticas micropolíticas que producen otras representaciones que hacen a esta construcción de género, como lo son los discursos y prácticas feministas (De Lauretis, 1996).

Otra noción conceptual fundamental para esta investigación ha sido la de significaciones. Las consideramos como configuraciones sociosubjetivas que se construyen sobre las experiencias y que se expresan mediante los recuerdos que adquieren mayor intensidad (Carril Berro y López Gómez, 2007). A su vez, se asocian a determinadas emocionalidades y pueden coexistir, conflictuarse, intensificarse y/o transformarse, al verse afectadas por los modos en que se transitan las experiencias.

En cuanto a los abortos, el estatus legal y social ha operado históricamente como base en la construcción de significaciones sobre estas experiencias. Se trata de sentidos sociales disponibles que forman parte de los discursos dominantes, como el legal o el religioso, donde el aborto está ligado al delito, la trasgresión, la culpa y la muerte. Esta base opera, con mayor o menor eficacia, en la construcción de los sentidos y significaciones, lo cual también se ve afectado por lo que cada mujer en particular compone acerca de lo legal y lo legítimo que hay en esa decisión de abortar (Fernández y Tajer, 2006). Es decir, esta construcción se ve afectada por las representaciones y autorepresentaciones de género que circulan y que se van construyendo y disputando sobre la sexualidad de las mujeres, los embarazos, las maternidades, los abortos, los derechos y la autonomía sexual, entre otras.

En este sentido, la capacidad para producir y disputar sentidos con la que cuentan los discursos de las periferias y de las prácticas de agenciamiento micropolítico feministas nos resulta un aporte interesante para pensar la tensión existente entre la estigmatización y la búsqueda de legitimidad sociosubjetiva para significar las experiencias de abortos voluntarios. Ya que, por un lado, existen representaciones de género hegemónicas, abundantes y eficaces en su impacto subjetivo, que generan significaciones que fragilizan a las mujeres. Pero también existen grietas donde se construyen otras representaciones de género que contactan a las mujeres con otras formas de estar siendo, de comportarse, de sentir, de desear, y que también impactan en las subjetividades y en las formas de significar las propias experiencias. Tal es el caso de los discursos feministas en relación con el aborto voluntario que lo reivindican como un derecho y como una práctica legítima que construye autonomía en el espacio público.

Entendemos, entonces, que las significaciones sobre los abortos no son estáticas ni armónicas. Tampoco hay una sola manera de significar estas experiencias. Las prácticas cotidianas junto a los discursos feministas pueden operar en las experiencias y sacudir o tensionar las significaciones dominantes sobre el aborto. Estamos hablando de experiencias que implican un alto grado de compromiso subjetivo, a partir de las cuales es posible aprehender encarnadamente una realidad histórica y social de clandestinización de los abortos voluntarios, así como la consiguiente necesidad de transformar sentidos y relaciones de género estructurales. Y aquí radica una potencia muy importante y, desde nuestra perspectiva, muy saludable.

Embarazos no deseados/abortos voluntarios farmacológicos clandestinizados: un *continuum*

Si entendemos las experiencias generizadas y sus significaciones en su complejidad simbólica y sociosubjetiva, no es posible hablar de abortos sin considerar los embarazos que los anteceden. Es muy frecuente encontrarse con discursos que hablan de abortos en el vacío, desentramados, sin contexto y sin sujetx, negando la existencia de una subjetividad que pone en acto la propia voluntad (la de abortar) y la existencia de un embarazo previo que motoriza esa voluntad. Consideramos, entonces, que los embarazos no deseados/abortos voluntarios son un entramado indisoluble que acontece, como un *continuum*, en condiciones y

circunstancias determinadas y determinantes de la experiencia. Demos más precisión y sentido a los términos de este *continuum*: embarazos no deseados, abortos voluntarios, farmacológicos y clandestinizados.

Dentro de las teorizaciones feministas, existen múltiples denominaciones posibles para referirse a los embarazos que anteceden a los abortos voluntarios, como embarazos forzados, no esperados o involuntarios (Chaneton y Vacarezza, 2011; Rostagnol, 2016; Rosenberg, 2010). Sin desacordar con estas formas de denominar, optamos por el término de *embarazos no deseados,* porque atendemos a los sentidos esgrimidos en relación con su continuidad (y no en referencia a los posibles sentidos psíquicos respecto al origen de dichos embarazos). Las mujeres cuyos relatos analizamos manifestaron que no deseaban ni sostener ese estado biológico, ni poner a disposición los propios recursos psicoemocionales y físicos para continuarlo ni para llevar adelante un ejercicio de maternaje. No había una condición deseante para sostener esos embarazos. Por el contrario, ellas anhelaban una situación diferente a la que suponía llevar a término esos embarazos y esto las motivó para gestionar y concretar el aborto voluntariamente, incluso asumiendo y atravesando los miedos, riesgos y violencias propias de la clandestinización.

Otro término del *continuum*, y que distingue entre otros tipos de abortos, es la voluntad implicada de la persona gestante en inducirse el aborto. Es decir que abordamos experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios, que no fueron espontáneos sino inducidos y que les supusieron diversas gestiones y esfuerzos para concretar esa voluntad. De allí la denominación de *abortos voluntarios*.

En cuanto al método utilizado para abortar, nos ocupamos de los *abortos farmacológicos*, también llamados abortos con medicamentos, medicamentosos o con pastillas. Este es uno de los métodos seguros detallados por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) y reconocido en los diversos Protocolos para la atención de la Interrupción Legal y, más tarde, Voluntaria de Embarazos (MSAL, 2015, 2019, 2021)[1].

Si bien el método farmacológico más seguro y eficaz es combinando mifepristona y misoprostol (OMS, 2012) en países donde no se dispone

[1] Existen dos métodos que, cuando son correctamente empleados, aseguran abortos seguros: el quirúrgico, es decir, la utilización de procedimientos transcervicales para finalizar un embarazo entre los que se incluyen la aspiración de vacío y la dilatación y evacuación; y el farmacológico o médico, es decir, la utilización de fármacos para finalizar el embarazo (OMS, 2018).

de mifepristona, como en la mayoría de los latinoamericanos, se utiliza solo misoprostol, aunque su eficacia disminuye (de un 98% a un 90%), el tiempo necesario para completar el aborto es más prolongado y el proceso es más doloroso. El misoprostol es un análogo de prostaglandina E1 (PgE1) que administrado en determinadas dosis y por determinadas vías provoca contracciones del músculo liso del útero, estimula la maduración cervical y aumenta el tono uterino, facilitando la expulsión del saco (Flasog, 2013; MSAL, 2021). Los síntomas de estos abortos provocados durante el primer trimestre de embarazo son similares a los de un aborto espontáneo o no inducido. Considerando numerosas investigaciones como la práctica extendida, el método farmacológico puede ser utilizado durante el primer trimestre de embarazo en forma ambulatoria en tanto opción segura, eficaz y aceptable, y las personas gestantes pueden usarlo sin tener que acudir a centros sanitarios (OMS, 2018; MSAL, 2021).

Por su seguridad, por la reducción de complicaciones físicas y su posibilidad de ser autoadministrado, el aborto farmacológico ha transformado radicalmente la práctica del aborto a nivel mundial, y particularmente en los contextos legalmente restrictivos. Otras de sus ventajas son que, con adecuada información, puede ser aplicado de forma ambulatoria, sin intervención de personas desconocidas y con la opción de ser acompañadas por sus redes de apoyo (Lafaurie *et al.*, 2005; Carril Berro y López Gómez, 2008; CLACAI - Ipas, 2011; OMS, 2012, 2014; Zamberlin, Romero y Ramos, 2012).

El último punto que tenemos en cuenta para denominar y delimitar las experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios como un *continuum* se asienta en las condiciones sociales, sanitarias, legales, institucionales, que son clave para comprender la configuración subjetiva de las significaciones. Es lo que llamamos *abortos clandestinizados*.

Las regulaciones legales restrictivas, las políticas públicas diseñadas sobre estas regulaciones, los marcos sociales, las denominaciones de la práctica, los sentidos sociales disponibles, entre otras cosas, producen determinadas significaciones y afectaciones emocionales y morales en las mujeres en torno a las propias prácticas abortivas (Fernández, 2009). Es decir, inciden tanto en las condiciones para acceder a la práctica (cómo se logra abortar) como en las significaciones construidas y en las configuraciones emocionales asociadas (cómo se significa y se siente haber abortado). Por lo cual, lejos de ser un contexto, se instalan como textos que determinan las experiencias (Carril Berro y López Gómez, 2010).

El término aborto clandestino ha sido frecuentemente empleado en la región por autoras que trabajan el tema desde una perspectiva sensible al género, así como por los espacios activistas pro-legalización. Esta denominación permite caracterizar y sintetizar algunas cualidades comunes de los abortos que derivan de la situación restrictiva en lo legal y en lo social. Sin embargo, estas cualidades no son propias de la práctica en sí misma, sino que son construcciones sociohistóricas que responden a los dispositivos de fragilización de género sobre las mujeres y otras personas con capacidad de gestar y abortar. Para dar cuenta de su característica de proceso construido es que optamos por la denominación *abortos clandestinizados*.

Definimos la clandestinización como el conjunto de procesos de penalización/criminalización, de marginación de los servicios de salud y de estigmatización/silenciamiento que recaen sobre las experiencias y las subjetividades de quienes abortan voluntariamente embarazos no deseados. Estos procesos se articulan de diversas formas y configuran un conglomerado complejo y dinámico de efectos que operan entrelazadamente y con distintos pesos en función de determinantes históricos, sociales y subjetivos.

Los abortos clandestinizados son los que están penalizados por normas jurídicas que los tipifican como delitos, por ende, están criminalizados, sometidos a un proceso que los convierte en crimen. Su práctica ha sido marginada de los servicios de salud en cuanto a su reconocimiento, acceso y trato recibido, lo cual propicia condiciones poco o nada seguras para su realización o un acceso diferencial a las condiciones de seguridad sanitaria en función de las posibilidades económicas de quien aborte o de sus contactos con profesionales de la medicina. Están estigmatizados, es decir, se asocian a una marca diferencial negativa e inferiorizante que induce al silenciamiento y al ocultamiento.

La penalización y la marginación del ámbito institucional de la salud están estrechamente unidas, ya que las instituciones de salud han funcionado, en la práctica, según un modelo de prohibición absoluta, a pesar de existir un sistema de regulación legal mixto. Por años, incluso los abortos legales en lugar de ser considerados como derechos que requerían una práctica médica, fueron convertidos en eventos excepcionales y anormales, y su acceso era inaccesible o solo posible tras superar múltiples obstáculos y juicios morales (Dosso, 2017; Drovetta, 2018; Santarelli y Anzorena, 2020).

A su vez, las instituciones de salud, con sus lógicas instituidas y sostenidas por gran parte de sus profesionales, han sido una de las principales instrumentadoras del estigma del aborto. De modo que la práctica, históricamente, quedó por fuera del repertorio de servicios legitimados (Kumar, Hessini & Mitchell, 2009) y con ello, fue clandestinizada sistemáticamente.

A su vez, la penalización/criminalización, en los contados casos en que se inician procesos penales contra las mujeres que abortan, sostienen la estigmatización asociada a toda criminalización, además de otras consecuencias negativas para las mujeres criminalizadas que operan como un castigo en sí mismos por la angustia y las dificultades que generan (Defensoría de la Nación, 2018). Estas consecuencias negativas tienen un sesgo de discriminación por género y clase ya que los procesos penales iniciales han estado determinados por la intersección entre el racismo, la procedencia de clase y el género (Carrera, Saralegui Ferrante y Orrego-Hoyos, 2020).

Además, los procesos de criminalización y marginación se materializan en los discursos disciplinadores y en las prácticas violentas de profesionales de la salud que afectan las experiencias emocionales de las mujeres, ya sea por acciones directas (es decir, cuando hubo una interacción concreta con la mujer que abortó) o indirectas (cuando toman conocimiento de estas acciones por los medios de comunicación o por el relato de otras mujeres). Sistema de salud y sistema penal se asemejan en el imaginario de las mujeres e intensifican sus temores, promueven sentimientos de incertidumbre, sensación de falta de control sobre la propia vida y de persecución, miedo al maltrato e imponen el silenciamiento (Santarelli, 2019a). La estigmatización condiciona la búsqueda de atención médica, máxime en contextos de penalización, donde estigma y criminalización se articulan en un círculo vicioso (APA, 2008; Zamberlin, 2015). Esto limita gravemente el derecho a la salud y a la vida de quienes abortan.

Respecto a la estigmatización, destacamos la definición pionera de estigma de Goffman (2003) como un atributo de descrédito y devaluación negativa que recae sobre quienes se han desviado de las normas y expectativas culturales dominantes. Puede tratarse de un rasgo físico visible y manifiesto o de una característica no evidente, y por lo tanto ocultable. Kumar, Hessini & Mitchell (2009) definen el estigma sobre las mujeres que abortan como un atributo negativo que las marca do-

blemente como inferiores al ideal de mujer, ya que abortar es transgredir un ideal de género y su consecuencia es portar interna y externamente la marca de esa transgresión.

Consideramos que la estigmatización es un proceso político, no natural, en tanto depende de mecanismos de poder diferenciales que han llevado a su construcción y normalización en distintos niveles, en consonancia con los discursos dominantes y las tecnologías de género (Zamberlin, 2015). Los campos y niveles de acción del estigma asociado al aborto son múltiples (Kumar, Hessini & Mitchell, 2009). Entre ellos, el de la cultura masiva y la opinión pública, el nivel estructural / de gobierno, que abarca las regulaciones legales y lo que denominamos procesos de penalización/criminalización; el institucional/organizacional que implica aquellas lógicas institucionales que expulsan y marginan estas prácticas del ámbito sanitario y de las formaciones profesionales en salud; el nivel de la comunidad, vinculado al rechazo del entorno cercano que dificulta conseguir apoyos; y el nivel individual, psicológico y emocional, que nosotras elegimos llamar subjetivo, en un sentido psicoanalítico que no asemeja lo subjetivo con la interioridad ni la individualidad, ya que rescata las dimensiones históricas, sociales y relacionales que operan en la producción de subjetividades feminizadas en relación con las experiencias generizadas.

Dentro de los niveles de expresión del estigma a nivel subjetivo, se puede diferenciar entre el estigma percibido, el experimentado y el internalizado (Goffman, 2003). El estigma internalizado implica la incorporación de aquella valoración cultural negativa sobre esos rasgos o características distintivas, la marca interna. El estigma percibido puede conceptualizarse como "la apreciación individual acerca de lo que los demás piensan sobre el aborto, y lo que podría ocurrir si la experiencia propia tomara estado público" (Zamberlin, 2015: 175). Una de estas consecuencias puede ser anticipar la posible retirada del cariño y del aprecio por parte de sus seres queridos por ser catalogada como "una mala mujer", y esto conforma un dispositivo eficaz de silenciamiento.

La estigmatización, el silenciamiento y los malestares van de la mano. Un recurso explicativo que aborda estos procesos, su construcción y deconstrucción es la *paradoja de la prevalencia del silenciamiento* en torno al aborto (Kumar, Hessini & Mitchell, 2009). El hecho de que las mujeres no hablen sobre sus abortos para evitar la desaprobación social y la estigmatización refuerza la percepción social de que es un

evento poco frecuente, excepcional, lo que automáticamente lo alinea con una conducta desviada y negativa, justamente, que merece ser ocultada, lo cual sostiene esta situación en su circularidad. Entonces, la paradoja es la consecuencia de un círculo vicioso que se produce por el silenciamiento de las experiencias de aborto como parte de las vidas de las mujeres, debido a su estigmatización.

Sobre la desclandestinización

En términos generales, la despenalización, legalización y legitimación del aborto que indica Luc Boltanski (2016) conforman lo que llamamos *desclandestinización*, como contracara de la clandestinización. Para este autor, la despenalización está vinculada a la promulgación de leyes que dejen de considerarlo delito y crimen, la legalización convierte la práctica en un derecho y, por lo tanto, conlleva una garantía estatal para su acceso en el sistema de salud, y la legitimación se corresponde con el plano moral; es la dificultosa empresa de asentar este derecho en principios cuya validez sea general. Parte de la legitimación implica dejar de construir una justificación del aborto como el "mal menor" ya que, si continúa siendo un mal, menor en función de la determinada circunstancia concreta pero un mal al fin, no es posible legitimarlo de forma general (Boltanski, 2016). El autor, analizando el caso francés, las considera como fases que van dando lugar a las siguientes y que contribuyen luego a fortalecer las conquistadas anteriormente. Nosotras, en cambio, atentas a nuestro devenir local, los pensamos como procesos entrelazados, simultáneos y en tensión.

La clandestinización, así como ha sido un proceso construido, puede sortearse y transformarse. Los feminismos han gestionado y sostenido estas tareas de desclandestinización en Argentina en múltiples frentes. Además de proponer y demandar las reformas legales para despenalizar y legalizar, se han dedicado a afectar los procesos de estigmatización y silenciamiento al disputar sentidos y significaciones, movilizando otros repertorios político-afectivos para aprehender los abortos propios y los de otras, y colaborando fuertemente en los procesos que instituyen la subjetivación del derecho al aborto (Vaggione, 2014a; Bellucci, 2014; Santarelli y Anzorena, 2017; Vacarezza, 2018; Rosenberg, 2020). Todo lo cual ha operado en las experiencias de las mujeres a la vez que, recíprocamente, las experiencias han nutrido los sentidos feministas sobre embarazos no deseados/abortos voluntarios legitimados.

Dispositivos de fragilización de género: mandatos, estrategias y configuraciones emocionales que fragilizan

> *La mujer que aborta es una figura degradada y prohibida de la abyección. Ininteligible. Requiere esfuerzo, dar muchas explicaciones, mantener el secreto, desestabilizar el maniqueísmo de las imágenes de lo femenino maternal igual a abnegación y sacrificio; y lo femenino no maternal igual a egoísmo, concupiscencia e individualismo.*
>
> Martha Rosenberg

Los modos de significar y sentir las experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios se entraman y se entrampan en las relaciones de género, en sus dispositivos, representaciones y autorepresentaciones de género que delinean la feminidad y la maternidad, en tanto producciones históricas y sociosubjetivas de gran impacto.

En este apartado nos ocupamos de pensar cómo los *dispositivos de fragilización de género* actúan en estas experiencias clandestinizadas, a partir de ciertas sofisticadas estrategias simbólicas que generan algunas configuraciones emocionales frecuentes. Entre ellas la culpa y la vergüenza, en tanto malestares psíquicos emergentes que vinculamos con la transgresión de representaciones normativas de género sobre la feminidad y, principalmente, sobre la maternidad como mandato.

A su vez, consideramos algunos de los riesgos que los procesos de clandestinización imponen al conformar experiencias precarizadas, en y contra las cuales, las mujeres gestionan diversos cuidados y sostenes. En este sentido, planteamos dos tensiones que retomaremos al momento de analizar las significaciones sobre las experiencias: la tensión entre estigmatización/legitimación y la tensión entre riesgos/cuidados.

Dispositivos de fragilización de género

A lo largo de este escrito venimos sosteniendo, junto a Burin (1999), que la ubicación social de las mujeres en una cultura por definición patriarcal forma parte de los procesos de subjetivación y genera marcas debido al hecho de subjetivarse en y por determinados procesos de exclusión, inferiorización y marginación, en el marco de determinadas relaciones de género asimétricas. Estas relaciones generan diferencias desigualadas, que en las experiencias se interseccionan con otras diferencias no solo de gé-

nero, sino también geopolíticas, culturales, étnicas, de clase, de orientación sexual (Fernández, 2009). La construcción de estas diferencias y la institución de la desigualación se producen en el mismo movimiento a causa de determinados *dispositivos de fragilización de género.*

Los dispositivos de fragilización de género son estrategias de poder y operaciones simbólicas que se expresan en la discriminación, la marginación, la inferiorización, la estigmatización, la exclusión y el exterminio, entre otras (Fernández, 2009). Tienen posibilidad de existencia y de actuación a nivel sociosubjetivo, lo cual pone en jaque la histórica dicotomía entre lo subjetivo y lo social. Tal como señala Fernández (2011), a nivel social, las diferencias desigualadas requieren de estas sutiles y/o feroces estrategias que subalternan y se acompañan de variadas producciones sociales de sentido que naturalizan las desigualaciones. Al mismo tiempo, para que su eficacia perdure históricamente, necesitan afectar la dimensión subjetiva. Es decir, necesita que aquellos sistemas argumentales y tecnologías de género que indican lo necesario, justo y conveniente que es desigualar, formen parte del bagaje subjetivo tanto de los grupos que los promueven como de los grupos que se ven desfavorecidos por tales estrategias y argumentos discursivos.

Estos dispositivos de fragilización en torno a las experiencias de embarazos no deseados/aborto voluntario clandestinizado están conformados por una serie de operaciones y estrategias violentas simbólicas que actúan en la superficie social y subjetiva, y habilitan las manifestaciones de otras violencias, visibles e invisibles (Fernández, 2009). Y se materializan de diversas formas: en prácticas, discursos, mitos, significaciones y configuraciones emocionales, todo lo cual queda reflejado en los procesos de clandestinización del aborto voluntario en Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica.

Los procesos de clandestinización que llevan a penalizar, criminalizar, estigmatizar, silenciar y marginar a las mujeres que abortan se valen de estas operaciones simbólicas fragilizantes para sostenerse y reproducirse, de las cuales destacamos dos que mencionamos a continuación y, luego, desarrollamos.

Primero, la construcción de una antítesis entre maternidad sacralizada y naturalizada/aborto demonizado y anormalizado, por lo tanto, estigmatizado y patologizado. Segundo, la desigualación del valor de la vida autónoma de las mujeres. Ambas operaciones implican la existencia de repertorios sociales emocionales que configuran un marco de legibi-

lidad de los abortos desde lo repugnante, lo trágico, lo despreciable, lo malo. Estos sentidos y sentires son el resultado de una sedimentación histórica y del cotidiano ejercicio de poder criminalizador y disciplinador, y están en la base de las múltiples violencias y condenas sociales (Vacarezza, 2019).

Maternidad sacralizada/aborto demonizado

La primera operación simbólica que señalamos se apoya en los mandatos instalados sobre las subjetividades feminizadas sobre la maternidad como destino natural, ineludible, obligatorio y el mandato de ser-para-otros. Sus efectos sociales y en la subjetivación de las mujeres han sido trabajados por diversas autoras feministas. Entre ellas, Marcela Lagarde de los Ríos (2011) y Ana María Fernández (2016, 2021).

Lagarde de los Ríos (2011) nos aporta la noción de cautiverios para sintetizar la situación cultural y política que define a las mujeres en el mundo patriarcal y que se concreta en su relación específica con el poder. Estar en cautiverio se caracteriza por la privación de libertad y autonomía vital, de gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de elegir y de decidir sobre los hechos fundamentales de sus vidas y del mundo. Implica ser ocupadas por las instituciones, por otros y por los discursos patriarcales socialmente disponibles que se encarnan subjetivamente y dificultan tomar decisiones sobre sí mismas, en condiciones dificultosas para hacerlo. De modo que ciertas decisiones fundamentales para la propia vida quedan atadas a los permisos que establecen las normativas legales y sociales.

Uno de estos cautiverios es el de *madresposa* que implica, entre otras cosas, una subjetivación de ser-mujer-para-otros y de estar allí para satisfacer necesidades y deseos ajenos, que pasan a ser los suyos propios en la condición de cautiverio. Por lo tanto, la abnegación, la renuncia o la postergación de lo propio han sido las cualidades que históricamente subjetivan como "buenas mujeres" (Lagarde de los Ríos, 2011).

Ana María Fernández (2016, 2021) hace un gran aporte cuando plantea la ecuación Mujer = Madre y cómo las sociedades organizan el universo de significaciones imaginarias relativo a las mujeres alrededor de esta construcción mítica. Esta es una operación simbólica que, por deslizamiento de sentidos, deviene en un movimiento "madres en más, mujeres en menos". Implica, entre otras cosas, la sacralización de la maternidad

y la apelación a lo instintivo, por lo cual todas las mujeres vendrían programadas genéticamente para saber y desear maternar. Utiliza la noción totalizadora de deseo de hijo, que intenta direccionar el orden de prioridades y el sentido pleno de la feminidad y, con ello, opera por violencia simbólica al apropiarse y obturar sentidos. El carácter totalizador con el que se presenta niega la diversidad de sentidos que las mujeres otorgan a las maternidades, oculta prácticas y posicionamientos que lo desdigan y se sitúa como un imperativo que pretende estar más allá de las experiencias y deseos singulares, incluso a costa de estos (Fernández, 2016). Además, su inscripción en lo instintivo y en lo naturalizado niega el trabajo emocional, físico, cultural, simbólico y económico que le supone a cada mujer instituir subjetividad humana en un proceso biológico y comenzar ese proceso de humanización, si es que decide tomar ese organismo como objeto de sus cuidados, su trabajo y su deseo (Rosenberg, 2020).

Atento a este mandato de maternidad, la estrategia de fragilización se completa por la construcción de una oposición rígida entre la mujer Madre y la mujer que aborta –A y no A, en tanto valor verdadero y valor falso–. Esta polarización no permite que maternar y abortar se configuren como opciones posibles y que el aborto sea una alternativa legítima para "las mujeres de verdad". Este artilugio que genera efectos de verdad sobre las subjetividades feminizadas, fragiliza y habilita que sobre las mujeres que abortan recaigan diversos procesos de estigmatización e inferiorización. A nivel del estigma interiorizado, estos procesos se traducen en sentimiento de falta, inadecuación, culpas y avergonzamiento (Goffman, 2003; Zamberlin, 2015).

Es decir que, los efectos de verdad del mandato de la maternidad obligatoria y del ser-para-otros, como constitutivo esencial de lo femenino, se ven desestabilizados cuando se pone en juego la voluntad de abortar un embarazo no deseado y cuando se trata de una elección a favor de sí misma. Y esta transgresión tiene costos emocionales, acarrea malestares y conlleva riesgos concretos que entendemos como efectos de los dispositivos de fragilización de género.

Vidas y autonomías desigualadas

La segunda operación estratégica fragilizante que mencionamos es la que desiguala el valor de la vida autónoma de las mujeres y las deja en el lugar de receptáculo o medio para el Hijo (Chaneton y Vacarezza, 2011; Ro-

senberg, 2020). Para llegar a considerar a las mujeres como un medio, que frente a un embarazo no pueden hacer más que cumplir su función de receptáculo, ha existido un proceso histórico y continuo de deshumanización y cosificación de las mujeres que redujo y desigualó el valor de sus vidas autónomas. Esta estrategia de fragilización de género, en su necesidad de ser legitimada y reproducida, se vale de múltiples discursos, procesos y tecnologías de género y supone repartir los significados y los valores de una determinada manera. Por ejemplo, desde el ámbito jurídico, la penalización y criminalización inscribieron al aborto como un crimen contra la vida y a las mujeres que abortaban como delincuentes/asesinas, cuyas vidas perdían valor. O los discursos religiosos que se autoproclaman provida fueron instalando representaciones legitimadas sobre qué vidas son consideradas bienes y merecen ser valoradas y protegidas, y cuáles no. La estrategia de fragilización de género consistió en afianzar un proceso complejo de humanización del embrión, a la vez que la degradación de las vidas de las mujeres que abortan, de modo que pudieran ser arrojadas al espacio abyecto (Butler, 2002, 2007).

Dentro del campo psi, tema que trataremos en el siguiente capítulo, también se puede observar cómo actúan estas estrategias de fragilización de género. Por ejemplo, el uso de la humanización del embrión a priori y de la significación del aborto como asesinato se observa en los discursos psi patologizantes que asocian aborto con daño. Es a partir de la significación de aborto como asesinato y daño que postulan una sintomatología de un supuesto síndrome post aborto. Para estos discursos, lo que se daña con el aborto es un vínculo filial, es decir, un vínculo con otro ser humano que aparece como una persona ya hecha. Esto niega la capacidad de humanización que las mujeres gestantes ponen en juego al decidir continuar y sostener un embarazo, en tanto trabajo simbólico fundante (Rosenberg, 2013).

Sumado a lo anterior, los discursos psi patologizantes del aborto consideran descontextualizadamente las implicancias emocionales del estigma. El impacto emocional y psicológico del estigma se expresa en sentimientos de vergüenza, culpa, ansiedad, pero estos discursos no identifican el origen de estas implicancias emocionales justamente en la vivencia estigmatizada, sino que los normalizan como parte inherente a la práctica (Kumar, Hessini & Mitchell, 2009; Zamberlin, 2015).

Tanto la patologización y la estigmatización del aborto como la naturalización, esencialización y obligatoriedad del rol materno han sido

factores de riesgo para la salud de las mujeres. Ubicar el trabajo materno en el plano de lo natural y de lo esencial despoja a la maternidad de su costado deseante, no considera la voluntad de abortar como una elección legítima y genera malestares, sufrimientos y tensiones a quienes, con sus actos o deseos, desdicen este imperativo. Los castigos y riesgos para las mujeres que atraviesan experiencias clandestinizadas afectan diversos órdenes de sus existencias. Pueden ser físicos, como consecuencia de las condiciones de inseguridad sanitaria de los abortos penalizados y marginalizados, pero también pueden ser emocionales y sociales.

De vergüenzas y culpas, de avergonzamientos y culpabilizaciones

La decisión y el acto de interrumpir un embarazo enfrenta a las mujeres, de manera real o imaginaria, a los ataques y juicios de valores peyorativos y estigmatizantes sobre esta práctica (Rosenberg, 2013). Muchas mujeres que abortan temen recibir una sanción social –además de la legal en contextos que penalizan– que se expresa en la posibilidad de perder el afecto o la estima de las personas significativas para ellas (Rosenberg, 2013; Cedeño *et al*., 2019). Entonces, lo silencian y lo esconden para sortear estos efectos de la estigmatización. Además del miedo a la pérdida del afecto, las vergüenzas y las culpas son configuraciones emocionales frecuentes y funcionales a los dispositivos de fragilización de género.

La construcción histórica de una imagen avergonzante sobre la práctica y sobre quienes la practican, puede edificarse ante sí misma y ante los ojos de los demás, es decir, puede experimentarse (lo que se siente) o percibirse (lo que se debería sentir) y puede vincularse con el sentimiento de transgresión a los ideales normativos de género. Para Sara Ahmed (2015), la vergüenza puede tener una función de domesticación, de ligazón con las normas sociales morales que regulan las conductas, en particular, la conducta sexual. Su sentir, esto que llamamos vergüenza experimentada, confirma el compromiso con los ideales normativos y es el costo emocional por haberlos transgredido. A nivel político, la dificultad para dejar de sentirla puede leerse como "un signo del poder de lo normativo" (Ahmed, 2015: 170).

Las culpas, cuando aparecen, también pueden pensarse en vinculación con los procesos de estigmatización y las significaciones asociadas a la transgresión de ciertos mandatos morales sociales y legales vincula-

dos al *continuum* embarazo no deseado/aborto voluntario. Pueden ser culpas por no desear esos embarazos, culpas por no desear continuarlos, culpas por no adecuarse al deber ser, culpas por decidir sin someterse a una decisión heterónoma, por ejemplo, la de una pareja. Incluso, podemos empezar a pensar en una culpa por no sentir culpa y/o por sentirse aliviada tras superar la situación crítica.

En el caso de las mujeres creyentes en religiones, la culpa suele ser una configuración emocional vinculada a una triple transgresión: en lo social, en lo legal y en la moral religiosa institucional. Es así que, no acatar el mandato social de la maternidad obligatoria se acompaña de la violación a la norma legal que penaliza el aborto voluntario y se le suma el atropello de las normas morales de las instituciones religiosas que se rigen por el androcentrismo, la regulación patriarcal y la vinculación de las mujeres con lo doméstico y con lo reproductivo (Morán Faúndes, 2017).

El discurso religioso contribuye a engrosar las expectativas dominantes de género sobre el ser-para-otros y la abnegación en la maternidad sin importar las circunstancias. Parte de la condena por transgredir estas expectativas es la caracterización de las mujeres que abortan como pecadoras, malas, egoístas, irresponsables, descorazonadas, además de asesinas. Estas cualidades quedan acentuadas y confirmadas por las políticas que criminalizan el aborto voluntario y se retroalimentan por las normas religiosas (Zamberlin, 2015). Así, las prácticas de abortos quedan cargadas negativamente con significaciones de maldad, pecado y muerte que influye en las construcciones que las mujeres hacen sobre sus propias decisiones y experiencias de aborto, a la vez que propicia la aparición de efectos psíquicos culpabilizantes. Las mujeres que significan sus abortos como asesinatos, experimentan mayor sufrimiento psíquico al decidir abortar y posteriormente (Ramos, Romero y Aizenberg, 2015).

Sin embargo, la diversidad de vivencias sobre lo religioso da cuenta de experiencias sobre la sexualidad de mujeres creyentes que no necesariamente se ligan a sentimientos de culpa (Johnson, 2018), porque existen múltiples maneras de vivir la religiosidad más allá de los valores o mandatos dominantes. El fenómeno denominado *pluralización de lo religioso* permite entender que existen discursos y prácticas heterogéneas dentro del espectro creyente y permite comprender algunos entrecruzamientos complejos entre prácticas sexuales e identificaciones religiosas (Vaggione, 2014b). La creciente autonomía de la religiosidad de las per-

sonas, cada vez más alejada de las instituciones, y la reelaboración de la presencia de dios como independiente de la Iglesia contribuyen a la desculpabilización en mujeres religiosas que han abortado (Johnson, 2018).

Finalmente, no podemos desconocer que las negociaciones subjetivas entre religiosidad y aborto asumen formas complejas. Las diversas creencias se conjugan con la realidad social y con el deseo personal, configurando una *moralidad de la situación*, concepto que remite a la circunstancialidad específica y singular en torno al embarazo y a la decisión de cada mujer. Es decir que las mujeres que interrumpen voluntariamente sus embarazos, al decidirlo, realizan una compleja y singular negociación entre sus ideologías, sus realidades sociales y sus deseos (Petchesky,1984, 1986 en Rostagnol, 2016).

Una experiencia precarizada: entre riesgos y cuidados

Los procesos de clandestinización sobre los embarazos no deseados/abortos voluntarios ponen de manifiesto cómo los dispositivos de fragilización de género dan lugar a formas de padecimiento y emocionalidades, en tanto textos comunes. Pero las formas en que estas textualidades se inscriben en los tránsitos por estas experiencias se encuentran marcadas diferencialmente, dando lugar a la posibilidad de que los efectos de las desigualaciones se vean multiplicados o queden inscriptos en ciertos posicionamientos de menor desventaja, por ejemplo, en cuanto al acceso diferencial a recursos para superar la crisis o en cuanto a la disponibilidad de varios repertorios afectivos para significar las prácticas. De modo que, estos dispositivos afectan diferencialmente en función de las condiciones materiales y simbólicas de existir y de abortar, dando lugar a experiencias singulares.

Sin embargo, estas experiencias tienen algo en común: ocurren entramadas en condiciones no elegidas que se relacionan directamente con la forma en que se presenta el Estado, sus instituciones, sus leyes y sus políticas que delimitan y limitan las formas de nacer, vivir y morir (Anzorena, 2013b) y en este caso, de abortar. Las políticas sexuales, cristalizadas en las regulaciones estatales y sociales, limitan los derechos no reproductivos y, con ello, la ciudadanización de las mujeres, a la vez que profundizan las diferencias intragénero al no asegurar igualdad de condiciones para todas (ciriza, 2009). La clandestinización moldea las necesidades de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar debido a las limitaciones, dificultades, sufrimientos y malestares que les

impone cuando intentan resolver la situación crítica en el desamparo de las garantías institucionales y sociales.

Este marco político hace que entendamos los abortos clandestinizados como experiencias precarizadas, apoyándonos en el sentido que Butler (2010, 2017) otorga al problema de la precaridad unido a la noción de vulnerabilidad humana.

La noción de precaridad viene a señalar el manejo desigual de la exposición a los daños que ya no es del orden de lo inevitable de la vulnerabilidad humana, sino que es políticamente inducido y recae sobre ciertos grupos y/o poblaciones. Es así que "la precaridad designa esa condición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones adolecen de falta de redes de apoyos sociales y económicos y están diferencialmente más expuestas a los daños, la violencia y la muerte" (Butler, 2010: 46). Nuestra persistencia está directamente ligada a contar con el apoyo o no de estructuras sociales, económicas y políticas que nos sustenten y de instituciones sociales para tales fines. Son los arreglos biopolíticos los que definen cuáles vidas preservar y proteger –y con ello, ser valiosas y reconocidas–, y cuáles no son merecedoras de protecciones frente al daño y la muerte –y por lo tanto ser desechables–.

En este sentido, la clandestinización remite a un manejo político que induce precaridad sobre este grupo, en sintonía con las regulaciones propias de un ordenamiento de género opresivo y fragilizante. La ausencia de una trama que, desde lo institucional, contenga dichas experiencias vitales maximiza la exposición a riesgos y violencias, frente a lo cual las mujeres deben protegerse haciendo uso de sus recursos, que al interior del grupo son diferenciales y desiguales. Uno de estos recursos, como veremos a lo largo de esta investigación, es la posibilidad de contar con la presencia de personas o redes del entorno con quienes armar tramas de cuidados para sostener los aspectos orgánicos, emocionales y sociales de este proceso.

Abortar, entonces, implica entablar una diversidad de interacciones sociales e interpersonales. Algunas, en tanto violentan y refuerzan la precaridad, son fuente de malestares que conforman el proceso mismo de aborto y que las personas que abortan necesitan atender. Pero en el tránsito por estas experiencias, las mujeres también gestionan presencias y redes que las cuidan y las protegen de las violencias o aminoran sus efectos. Dicho de otra manera, frente a la precarización de las experiencias por las condiciones políticas no elegidas, las mujeres y otras personas con

capacidad de gestar protagonizan y gestionan estrategias y relaciones con personas de sus entornos que presentaremos en términos de cuidados.

En síntesis, pensamos la precarización de las experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios en relación directa con los procesos de clandestinización. Así como también sostenemos que las estrategias de cuidados entre mujeres son una forma de resistir e incluso de transformar dicha precaridad inducida. Entre las violencias y las presencias que cuidan, ubicamos dos tensiones que afectan estas experiencias y sus significaciones y que iremos desarrollando. Por un lado, la tensión entre la estigmatización –uno de los procesos que conforman la clandestinización– y la legitimación sociosubjetiva. Y, por otro lado, la tensión entre los riesgos y los cuidados.

Estas tensiones se sostienen en las prácticas, discursos y significaciones que buscan la legitimidad del aborto y su inscripción en el orden de los cuidados, principalmente desde los márgenes y los feminismos, en una disputa tensa de sentidos con las prácticas, discursos y significaciones dominantes sobre aborto que estigmatizan, precarizan y ponen en riesgo a las subjetividades de quienes abortan.

Capítulo 2. Salud mental y experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios clandestinizados

En este capítulo presentamos nuestro posicionamiento teórico y político sobre la relación entre salud mental y experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios. Para ello, delimitamos cómo y qué comprendemos por salud mental y de qué posturas o discurso psi nos diferenciamos.

Dos discursos psi contrapuestos sobre la relación entre salud mental y aborto voluntario

Dentro del campo psi existen diversas posturas teóricas que abordan la relación entre salud mental y aborto. Estas, a su vez, se enmarcan en determinados discursos psi, prácticas y consideraciones sobre el rol de los acompañamientos profesionales y los servicios de salud mental en las experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios.

Por *discursos psi* entendemos aquellos discursos que son puestos en escena por sujetos/as/es que se reconocen y obtienen reconocimiento social como parte del campo de conocimiento disciplinar teórico-profesional conformado principalmente por la psicología, el psicoanálisis y la psiquiatría. Consideramos importante abordar los discursos psi sobre la relación entre aborto y salud mental de las mujeres porque estos tienen el poder de enunciar y performar algo del orden de la verdad sobre la salud mental. Al mismo tiempo que enuncian una verdad, cuentan con carácter y efectos performativos. Es decir, detentan la posibilidad de producir y generar prácticas y significaciones, siempre y cuando estos enunciados se enmarquen en determinados contextos, en determinadas cadenas discursivas ideológicas y políticas y condiciones de enunciabilidad y de referencialidad que le otorgan dicha potencia performativa (Butler, 2002).

Dentro del amplio espectro de ópticas y posicionamientos que abarcan la relación entre aborto y sus implicancias en la salud mental, nos interesa destacar dos.

Por un lado, aquellas teorizaciones que sostienen que el aborto inducido es siempre una experiencia traumática con daños emocionales para la mujer. Esta postura sostiene que abortar es malo para la salud mental y que puede causar una supuesta patología psiquiátrica específica denominada síndrome post aborto. Parte de la premisa de que abortar es un acontecimiento traumático porque se vive como la destrucción de un ser, la participación intencional en un acto violento que transgrede los "instintos parentales" y que resquebraja el vínculo entre "la madre" y el no nacido, sumado a la culpa de la mujer por haber sobrevivido, entre otras cuestiones (Speckhard & Rue, 1992; Gomez Lavín y Zapata García, 2005, 2012; Gurpegui y Jurado, 2009).

El término síndrome post aborto surgió como parte de un cambio en las estrategias de sectores conservadores, autodenominados provida y nombrados desde los feminismos como anti derechos, que se oponen a la legalización del aborto e intentan instalar discursos en la opinión pública y en los espacios académicos. Estas estrategias viraron en la década de los 80, desde el énfasis en los valores religiosos y morales al uso de un lenguaje científico y del argumento sobre la preocupación por la salud mental de las mujeres que abortan (Lee, 2001 citado en Maroto Vargas, 2009).

Las líneas defensoras de este supuesto síndrome lo ubican dentro de los trastornos por estrés postraumático y detallan diversos síntomas como parte de su presentación clínica, en tanto cuadro afectivo depresivo-ansioso con sentimientos específicos de culpa-vergüenza, incapacidad para perdonarse por el aborto realizado, necesidad de reparar el daño y deseos de "expiación" (de borrar la culpa, de purificarse de ella).

En cuanto al rol de los servicios de salud mental y de los acompañamientos profesionales, esta línea sostiene la existencia de una asociación intrínseca entre aborto y trauma y el devenir de un estado de duelo. Proponen intervenciones dirigidas a disuadir a las mujeres de su decisión de abortar, o bien, a trabajar en estas consecuencias patológicas que, suponen, el aborto tendría sobre quien se lo practica. Sostienen que, en el primer contacto asistencial, cuando las mujeres solicitan una interrupción del embarazo (en países donde esto es posible), es recomendable ofrecer ayudas económicas y laborales y trabajar en la resolución de posibles am-

bivalencias frente al embarazo, "fomentando los sentimientos positivos ante el embarazo y señalando los riesgos psicopatológicos que conlleva el aborto" (Gomez Lavín, Uroz Martínez y Zapata García, 2018: 32).

Una vez practicado el aborto, recomiendan abordar la sintomatología y el estado de duelo que le asocian, mediante una serie de medidas psicofarmacológicas y psicoterapéuticas vinculadas a resolver la culpa (Gomez Lavín y Zapata García, 2005, 2012; Curley y Johnston, 2013; López Martín *et al.*, 2014). Por ejemplo, promover que logren vivenciar emocionalmente la pérdida "dotando de sentido saludable a la "relación" de maternidad con el hijo perdido" (Gomez Lavín y Zapata García, 2012: s/p) o promover sentimientos de arrepentimiento y de recepción del perdón por parte del "hijo abortado", por ejemplo, mediante prácticas religiosas o trabajo voluntario en organizaciones autodenominadas provida. Curiosamente, estas posturas remarcan la necesidad de que este supuesto síndrome se estudie desde posturas que consideran no ideologizadas. También le dan importancia a que desde el Estado se propongan medidas estatales para prevenir el acontecimiento traumático de los abortos y sus consecuencias psicopatológicas (Gomez Lavín y Zapata García, 2012).

Lo cierto es que este síndrome, como tal, no ha sido incluido en los manuales diagnósticos reconocidos mundialmente, entre otras cosas, por sus deficiencias teóricas y metodológicas que incluyen grupos de comparación inapropiados, confusión entre causalidad y asociación, no tomar en cuenta los factores psicológicos de riesgo preexistentes en la mujer e imposibilidad de replicar los hallazgos (Adler *et al.*, 1990; Cohen, 2006; Rondón, 2009; IBIS, 2018). Su validez científica ha sido negada por la Academia de Medicina de EEUU en varias oportunidades. Revisiones exhaustivas de estudios internacionales publicados indican que haberse realizado un aborto no provoca problemas de salud mental como postula este supuesto síndrome (IBIS, 2018), ni se puede establecer fehacientemente una relación entre aborto y problemas de salud mental tardíos en las mujeres que han abortado (Charles *et al.*, 2008).

Diversas revisiones e investigaciones a nivel internacional y latinoamericano rechazan que se pueda afirmar que existen efectos traumáticos o un síndrome post aborto cuando ha mediado la decisión de la mujer y que el aborto *per se* no es causante de enfermedad psiquiátrica (Stotland, 1992; Adler *et al.*, 1992; Asociación Americana de Psicología, 1998 citada en Rondón, 2009; Knowles, 2007; APA, 2008; Fielding y Schaff, 2004; Carril Berro y López Gómez, 2008; López Gómez y Carril

Berro, 2010; Major y cols., 2009; Robinson y cols., 2009; Maroto Vargas, 2010; Steinberg & Finer, 2012; Steinberg & Rubin, 2014; Aznar y Cerdá, 2014; Pistani y Ceccato, 2014; Foster *et al.*, 2015; López Gómez, 2015; Biggs *et al.*, 2016; IBIS, 2018). A pesar de lo cual, este tipo de discurso continúa teniendo notable circulación social e impacto político en nuestro país. Así lo observamos en el primer debate legislativo sobre la interrupción voluntaria del embarazo ocurrido en 2018 (Santarelli, 2019b)[1].

En cambio, las investigaciones y revisiones bibliográficas de diversas investigaciones regionales coinciden en afirmar que los contextos legales restrictivos son los que tienen efectos negativos para la vida y la salud de las mujeres. Entre los factores de mayor peso figuran: el temor a la sanción penal y moral, el riesgo de vida o de integridad física, el efecto disuasivo en profesionales de la salud y el estigma social. La estigmatización impacta en términos negativos en las experiencias psicológicas posteriores y en las posibilidades de lograr un aborto seguro, mucho más en contextos de ilegalidad, donde estigma y criminalización se articulan en un círculo vicioso. A la vez que, considerar los efectos de la estigmatización permite una mejor comprensión de los sentimientos negativos asociados al aborto voluntario en condiciones restrictivas, cuando estos aparecen (APA, 2008; Zamberlin, 2015; López Gómez, 2015).

En coherencia con esto último y en contraposición a los discursos psi que tienden a patologizar el aborto *per se* y a desconocer las condiciones y circunstancias en que pueden ocurrir, en esta investigación adherimos a un enfoque teórico que pone el foco en los efectos perjudiciales de la clandestinización en la salud integral de las mujeres o de quienes abortan, incluida la salud mental. Esta postura coincide en que lo trágico no está puesto en la práctica de un aborto voluntario sino en

[1] En aquella oportunidad, para nutrir el debate sobre el proyecto de Ley presentado por la Campaña, se desarrollaron una serie de audiencias públicas donde diversas personalidades invitadas expusieron sus posturas. La línea argumentativa aborto/trauma/daño a la salud mental estuvo presente en la mayoría de los discursos de profesionales de psicología/psiquiatría que se situaban en la línea opositora a la legalización del aborto, aunque mostrando preocupación por la salud mental de las mujeres. Incluso, el principal promotor del supuesto síndrome y miembro de agrupaciones estadounidenses contrarias a la legalización del aborto, Vincent Rue, tuvo un lugar en este debate. Fue invitado a disertar el día 24 de abril de 2018 en la Cámara de Diputados de la Nación por ser considerado un especialista en el tema, más allá de su cuestionada pertenencia académica formal al campo psi (Santarelli, 2019b).

la situación de tener que sostener un embarazo en contra de su voluntad debido a normatividades que constriñen y no respetan la autonomía implicada en esta decisión no reproductiva (Rosenberg, 2020). En países donde el aborto voluntario no es legal, si hablamos de salud mental y aborto es necesario remitirnos al impacto de la penalización y la clandestinidad en las subjetividades, como así también a las habilitaciones saludables que producen los acompañamientos desde posiciones de despenalización social del aborto (Tajer, 2020).

En cuanto al rol de los acompañamientos profesionales y los servicios de salud mental, desde este enfoque consideramos que el aborto voluntario es una decisión autónoma a respetar y a acompañar sin prejuicios, con intervenciones tendientes a facilitar el tránsito por dichas experiencias. En este sentido, resulta importante la información y el trabajo en la decisión autónoma y en la deconstrucción del imaginario social e individual sobre el aborto asociado al imperativo de maternidad obligatoria para que cada cual pueda tomar una decisión informada y en línea con su deseo (Pistani y Ceccato, 2014; Paragis *et al.*, 2020). La intervención debe atender las necesidades emocionales que las mujeres expresan y estar a favor de sus propios procesos de construcción de salud mental (Santarelli, 2019c). Todo lo cual exige la incorporación de la perspectiva política de género y de derechos en el abordaje profesional, el cuestionamiento de las visiones simplistas, reduccionistas y patologizantes, y el trabajo reflexivo sobre las tensiones, emocionalidades y significaciones sobre el aborto –y también, sobre la maternidad, la subjetividad femenina, la sexualidad, las relaciones de poder entre los géneros y las relaciones de poder sociosanitarias– que inciden sobre las prácticas y van, recursivamente, produciendo subjetividad en las mujeres usuarias (Lenta, Longo, Zaldúa, 2018; Santarelli, 2019c; Paragis *et al.*, 2020).

Nuestra comprensión de la salud mental. Aportes desde el modelo tensional-conflictivo, enfoque participativo y la construcción de autonomía

En este apartado desarrollamos brevemente el modelo teórico de comprensión de la salud mental que utilizamos para acercarnos al *continuum* embarazo no deseado/aborto voluntario farmacológico clandestinizado.

Nos ubicamos dentro del enfoque sobre la relación entre aborto y salud mental que visibiliza los efectos perjudiciales de la clandestiniza-

ción en estas experiencias y los malestares –articulados con las opresiones y las violencias que recaen sobre las mujeres–, a la luz del sistema relacional de género y de los dispositivos de fragilización de género. Pero damos un paso más en la consideración de esta relación, ya que entendemos la salud mental como un proceso en devenir que sus protagonistas construyen a medida que transitan diversas experiencias críticas. Consideramos estos tránsitos, que están acompañados, en sus potencialidades y aspectos saludables, a partir de la construcción y transformación de significaciones sobre la experiencia de abortar.

Comprendemos la salud mental de las mujeres entramada con las nociones de autonomía y ejercicio de derechos, y tomamos aportes del modelo tensional-conflictivo desde una concepción participativa propuesto por la psicoanalista Mabel Burin. Este modelo se enriquece de diversos aportes interdisciplinarios: del campo de la salud, de las ciencias sociales, del psicoanálisis y de los estudios de género (Burin, 1990, 1992, 2009, 2017; Burin *et al*., 2002).

Crisis, participación, autonomía y posibilidades de transformación

El modelo de comprensión tensional-conflictivo (Burin, 1990, 1992; Burin *et al*., 2002) se apoya en la noción de *crisis y conflicto*. La palabra crisis cuenta, al menos, con dos acepciones. Una está asociada a dificultad, riesgo, ruptura. Y la otra pone de relieve el cambio, la decisión, la oportunidad de generar un análisis crítico y reflexivo de los hechos que la desencadenaron y de propiciar búsquedas para su resolución, elaboración e incorporación con sentido a la vida cotidiana (Velázquez, 2010).

Las crisis, en tanto agudización de conflictos, implican la situación impactante que la produce, así como el trabajo y los recursos del yo para resolverla (Velázquez, 2010) y el abanico de recursos disponibles o construidos –del orden de lo relacional, lo grupal, lo comunitario– que se puedan instrumentar para transitar por estas experiencias. Tránsito que es continuo e inacabable, proceso en construcción, devenir signado por las diversas experiencias críticas y los tránsitos que se van realizando constantemente por ellas. De modo que este modelo comprende que las subjetividades femeninas pueden entenderse a través del modo en que se atraviesan estas crisis vitales evolutivas –como la adolescencia, la mediana edad– y las crisis accidentales, surgidas de situaciones inespe-

radas –entre las que figuran los embarazos, los divorcios o separaciones, o los abortos–.

La situación crítica puede representar una oportunidad que propicie la construcción y transformación de la salud mental, en tanto promueva la generación y el uso de recursos y sentidos. Frente a circunstancias vitales que pueden generar conflictos, fracturas vinculares y/o psicopatologías, lo saludable es poner en juego estos recursos en pos de la recreación de nuevos sentidos "que permitan transitar por experiencias no previstas en el proyecto vital, sin significarlas forzosamente como pérdidas o injurias narcisísticas" (Meler, 1999: 246).

Entonces, la construcción de la salud mental se relaciona con cómo transitamos las crisis y transformamos las tensiones y malestares. Pero, además y no menos importante, supone la posibilidad y capacidad de transformar las situaciones y condiciones que generan dichos malestares. Es decir,

> la capacidad de transformar las problemáticas de la vida cotidiana, la posibilidad y la capacidad de participar y decidir en los procesos que tocan directamente la misma; y, por último, las oportunidades para incidir en los procesos de desarrollo social y de ciudadanía, en especial si se considera la salud mental como un derecho humano de las personas (Caridad y Rodríguez, 2002: 39).

Desde este posicionamiento, que coincide con lo establecido en la legislación argentina específica sobre el tema, salud mental y derechos van de la mano. La salud mental como proceso multideterminado queda ligada a la posibilidad de sostener dinámicas sociales complejas de participación para concretar los derechos humanos y sociales de todas las personas. Y su preservación y mejoramiento, lejos de ser una responsabilidad individual y solitaria, implica una dinámica de construcción social (MSAL, 2013).

En esta línea, destacamos como parte de los procesos de salud mental, la posibilidad de incidir en la realidad mediante la construcción de autonomía subjetiva y grupal. Al respecto Ana María Fernández (2021) piensa la construcción de la salud mental en función de las cicatrices subjetivas que generan los dispositivos que fragilizan a las mujeres y que habilitan el ejercicio de poder/dominio a los varones. Esta construcción, para el caso de las mujeres, supone construcción de autonomía subjetiva en un sentido político, es decir, como:

> … la capacidad de instituir proyectos propios y la producción de acciones deliberadas (voluntad) para lograrlos, es decir, subjetivarse como sujetas. Sujetas capaces de discernir sus deseos y sus intereses y de elegir las mejores acciones para concretar dichas elecciones (Fernández, 2021: 274).

La autonomía de género implica poder reconocer el deseo propio, y poder actuar según sus elecciones. Se vincula a los espacios de poder que puedan instituirse como grupo, ya que el grado de autonomía subjetiva es inseparable del grado de autonomía posible para su grupo social. Es decir, no depende de la voluntad personal aislada de las sujetas que lo componen, sino de las condiciones de posibilidad histórico-sociales en el marco de las cuales traccionan, que son complejas y de lenta pero posible transformación (Fernández, 2021).

La posibilidad de participar en la visibilización, denuncia y transformación de aquellas condiciones histórico-sociales opresivas que cercenan las autonomías de género y generan realidades enfermantes se intrinca con las posibilidades de autonomía subjetiva y son una parte fundamental para atender los procesos de construcción de salud mental.

La autonomía subjetiva, además de verse directamente afectada por la autonomía de género, como dijimos, se encuentra delimitada por los entrecruzamientos con otros factores de estratificación social como la edad, las condiciones socioeconómicas de vida, la pertenencia a un grupo racializado o migrante, la nacionalidad, la ubicación geopolítica, entre tantas otras. Todo lo cual da lugar a una diversa gama de experiencias, signadas por unas formas particulares de actuación de las opresiones y por posibilidades diferenciales de construcción de autonomía.

Un tercer gran aporte que tomamos proviene del enfoque participativo, desde el cual se considera que la salud mental es una noción que las mismas mujeres van construyendo en distintos momentos de sus vidas a partir de diversas experiencias y situaciones críticas y en colaboración con diversos agentes sociales. En este sentido, este enfoque legitima especialmente los saberes y experiencias de las propias mujeres y sus grupos en los procesos de construcción de la salud mental y en la definición y redefinición de acciones y criterios en salud mental (Burin, 1990, 1992, 2009).

La salud mental implica dinámicas interpersonales y sociales que posibilitan el acceso y el ejercicio de este derecho en interrelación con otros. Se pone en un primer plano a las mujeres y a las grupalidades y/o com-

pañías con las que gestionan dichas situaciones críticas. A nuestro entender, esto se acerca a la propuesta de las perspectivas queer de saludes (Pérez, 2019) en el cuestionamiento a la autoridad epistémica tutelar atribuida a los/as/es especialistas sobre la definición de lo saludable y de lo enfermo. Estas perspectivas bregan para que esa autoridad vuelva a quienes llevan ese cuerpo sobre el que se producen discursos y que atraviesa esas experiencias. En este caso las mujeres o personas con otras identidades de género con sus experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios.

Un modo otro de comprender la relación entre salud mental y embarazos no deseados/abortos voluntarios

Nuestra elección teórica abre tres grandes posibilidades al momento de comprender la relación entre salud mental y las experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios farmacológicos clandestinizados.

Primero, posibilita comprender la salud mental en términos entramados con los ordenamientos sociohistóricos de género y la producción de subjetividades feminizadas en el marco de los dispositivos de fragilización. Segundo, permite entender la salud mental en su carácter participativo, relacional, procesual y estrechamente ligado a procesos de construcción de género y de autonomía. Y tercero, supera concepciones psicopatologizantes y visiones normativas sobre salud mental sin desatender los padecimientos y malestares específicos, lo cual resulta fundamental para atender las experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios clandestinizados.

Este tercer y último punto nos parece muy importante porque una de las limitaciones frecuentes con las que nos encontramos al investigar sobre salud mental reside en la falta de deslinde entre el campo de la salud y aquel que focaliza en los trastornos mentales, lo patológico y/o en la enfermedad mental, por lo cual abundan las teorías sobre enfermedad, no así sobre la salud y su construcción (Caridad y Rodríguez, 2002).

Desde este modelo, si bien se reconoce el sufrimiento, no se patologiza su manifestación ni las situaciones críticas cotidianas, sino que se las intenta comprender críticamente en el marco de las relaciones sociales de poder para vislumbrar estrategias y posibilidades de transformación. Al respecto, un útil recurso conceptual que proviene del modelo tensional-conflictivo es el de *malestar psíquico* que, justamente, supera esta dicotomía entre normal/patológico, salud/enfermedad (Burin, 1990, 1992,

2009). El malestar psíquico alude a los sufrimientos psíquicos y emocionales de las mujeres como emergentes de su condición cultural de género, que se traduce en una percepción ambigua de disconfort y desasosiego que no permite sentirse ni saludable ni enferma. Se trata, entonces, de un recurso con enfoque de género para analizar las condiciones que producen, preservan y afectan los procesos de salud mental de las mujeres, pues se plantea desde un posicionamiento teórico e ideológico que enfatiza las dimensiones socioculturales e históricas en la producción de subjetividades femeninas y las posiciones de género que conforman factores de riesgo para la salud mental de estas (Burin, 1990).

Además, esta perspectiva se interesa en la construcción social de las mujeres como sujetas insertas en la cultura patriarcal y en cómo esto incide sobre su salud mental, sus malestares y los modos de padecerlos y de afrontarlos. Pone en suspenso la noción de salud mental como normativización, en el sentido de adaptación o ajuste a las normas culturales. Contrariamente, ofrece una postura crítica frente a las representaciones culturales sobre el "ser mujer". Reconoce, como parte de la salud mental, la necesidad de concientizar y transformar aquellos factores opresivos que constituyen modos y condiciones de vida enfermantes, como lo son aquellos imaginarios, normas, valores, mandatos, roles asignados a las mujeres en una cultura por definición patriarcal (Burin, 1990, 1992). Considera que las mujeres son sujetas sociales activas en este proyecto de concientización y transformación, que es parte de los propios procesos de construcción de salud mental y autonomía.

Por ello entendemos que este enfoque forma parte de las propuestas potenciadoras dentro del psicoanálisis: aquellas que apuestan a modos de pensar que rearticulan las inscripciones y las marcas del ordenamiento histórico sociopolítico de género con y en la construcción de las subjetividades y los padecimientos (Fernández, 2016).

A modo de síntesis, nuestra categoría de salud mental se caracteriza por ser un constructo no psicologizante ni patologizante, donde el peso no está puesto en variables intrapsíquicas ni en la noción de enfermedad. A través de esta, buscamos atender malestares y bienestares implicados en las experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios, entendidos en el marco de relaciones de poder y de procesos de subjetivación generizados que dan lugar a comprensiones sociosubjetivas situadas.

La salud mental es un proceso que se construye relacional y participativamente, a partir del tránsito por diversas experiencias críticas,

como puede serlo un embarazo no deseado/aborto voluntario. Estas experiencias suponen la movilización de recursos para superar los riesgos o dificultades asociados a la situación crítica y son oportunidades de resignificación y transformación continua, tanto de los malestares como de las condiciones opresivas que los enmarcan. Incluso, pueden favorecer procesos de construcción de autonomía subjetiva y de género, al incidir en la propia realidad y en la realidad social.

Capítulo 3. Consideraciones metodológicas y éticas

Breves precisiones metodológicas

El objeto de investigación de este trabajo fueron las significaciones que las mujeres construyen en torno a sus experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios farmacológicos clandestinizados en relación con la salud mental. Lo abordamos desde un diseño cualitativo interpretativo y un posicionamiento epistemológico situado y feminista del punto de vista, que considera las perspectivas de las mujeres que transitaron dichas experiencias (Haraway, 1995; Sautu, 1999; Harding, 2002; Sautu *et al*., 2005; Mendizábal, 2006; Bach, 2010).

Desde un enfoque microsocial, orientamos nuestra mirada hacia las experiencias contextualizadas y relacionales como fuente de construcción de significados, a las interpretaciones sobre las propias experiencias, los vínculos con sus entornos, sus acciones y estrategias dentro de sus posiciones e inserciones sociales (Sautu, 1999). Entretejer el universo de significaciones y acciones particulares con la densidad de los sentidos sociales fue una de las posibilidades que nos ofreció el método biográfico que utilizamos (Sautu *et al*., 2005).

El trabajo de campo fue arduo y sostenido por más de seis años. El acceso al campo me fue facilitado por mi actividad –y la de la directora de esta investigación, Claudia Anzorena– como socorristas y, luego, como integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en San Luis. Complementamos diversas técnicas cualitativas: entrevistas en profundidad, entrevistas semiestructuradas a informantes clave, observaciones participantes y no participantes, y el análisis documental.

Trabajamos con relatos biográficos acotados a las experiencias de embarazo no deseado/aborto farmacológico voluntario, en cuya construcción

las entrevistadas pusieron en palabras una selección de recuerdos y emocionalidades, así como realizaron un trabajo de significación constructiva y de interpretación de la experiencia vivida. Este trabajo estuvo mediado por las experiencias y procesos reflexivos posteriores, por las expectativas e interpretaciones desde la situación presente (Lomsky-Feder 1995 en Sautu, 1999). El mismo ejercicio de narrar una experiencia personal de aborto habilita otra forma de acceder a la misma porque implica volver a pensarla y a significarla, abrirla a lo nuevo, a lo actual y al afuera, en el intento de comprenderla y hacerla comprender, de transmitir algo significativo de esta experiencia (Chaneton y Vacarezza, 2011).

Los relatos, lejos de ser soliloquios, fueron relacionales, a la vez que fueron articulados entre sí para su circulación social y pública. Parte de la estrategia analítica desde la que escuchamos estos relatos fue articulándolos con el mundo compartido de las narrativas feministas, que Hemmings (2018: 13) define como "el conjunto de relatos a partir de los cuales los dispositivos discursivos producidos por mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries y queers intervienen como una práctica epistémica para la recuperación de la historia de las/es/os sujetas/es/os feministas". Encontramos en los relatos que conforman nuestro corpus empírico un nosotras que refiere a una dimensión colectiva de lo narrado y que se propone como un discurso capaz de intervenir en la disputa de sentido sobre abortos.

En las 32 entrevistas en profundidad que realicé con 30 mujeres, durante el primer semestre de 2017 y de 2019, ellas narraron 43 experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios farmacológicos ocurridas entre 2009 y 2019 en San Luis y Mendoza[1].

Las entrevistas semiestructuradas a informantes clave fueron con activistas socorristas y de la Campaña de Mendoza y San Luis Capital entre 2016 y 2021, y con profesionales de la salud pertenecientes a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de ambas provincias y funcionarias de servicios públicos de salud de San Luis.

Las técnicas observacionales abarcaron un número amplio de ob-

[1] El muestreo fue intencional, no probabilístico y de bola de nieve. El criterio de inclusión fue mujeres mayores de 18 años que hubieran abortado, al menos una vez de manera farmacológica y voluntaria entre 2009 y 2019, en Mendoza o en San Luis acompañadas por feministas u organizaciones feministas o socorristas, es decir, que tuvieron la oportunidad de interactuar en un momento de alto compromiso subjetivo con discursos feministas sobre el aborto.

servaciones participantes entre 2014 y 2017 en las "consejerías" o "talleres" donde las mujeres que necesitaban abortar obtenían información por parte de las socorristas. Además, realicé observaciones en otras actividades socorristas, como Plenarias Nacionales (2015 y 2016), una Plenaria Regional Cuyo (2016), reuniones convocadas por socorristas con profesionales de servicios públicos de salud en San Luis (2016 y 2017) y en una capacitación organizada por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en Gran Mendoza y el Programa Provincial de Salud Reproductiva de Mendoza (2019).

El análisis documental fue de tipo cualitativo interpretativo. Comprendió el contenido de la legislación vigente en Argentina que regulaba las prácticas de aborto, incluyendo artículos del Código Penal, el Fallo F.A.L. (CSJN, 2012), las sucesivas Guías Técnicas y Protocolos de Atención Integral de Interrupciones Legales de Embarazos del MSAL (Ministerio de Salud de la Nación) desde 2007 a 2021, documentos e informes de distintas organizaciones sociales y gubernamentales, y declaraciones, documentos, informes y artículos científicos elaborados por activistas de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del aborto y de Socorristas en Red –feministas que abortamos–. Esto se complementó con una lectura analítica de las versiones taquigráficas de las Audiencias Públicas sobre Aborto No Punible realizadas en San Luis en 2012.

A través de las entrevistas en profundidad con las mujeres, accedimos a los procesos de significación reconstructiva, que se actualizaron en el narrar y de los cuales participamos, así como a detalles ricos de los significados, en términos de emocionalidades, deseos, propósitos, relevantes para captar la complejidad de las experiencias (Ricoeur, 1999 citado en Ripamonti, 2017).

Las observaciones y entrevistas a informantes clave nos permitieron obtener una visión más completa y detallada de las circunstancias de encuentro entre las mujeres que necesitaban abortar y las activistas socorristas, y sobre las formas de articulación con profesionales de la salud. También, y junto al análisis documental, pudimos conocer diversas visiones sobre los acontecimientos locales significativos y sobre la situación de accesibilidad, o no, de los abortos, todo lo cual formó parte de las experiencias.

De modo que, la complementariedad de las técnicas cualitativas nos permitió la reconstrucción de una microtrama social local para comprender mejor la construcción de significaciones sobre las experiencias

porque los escenarios de las experiencias, lejos de ser un mero contexto, se instalan como textos determinantes en las formas de significar y atravesar los embarazos no deseados/abortos voluntarios (Carril Berro y López Gómez, 2010).

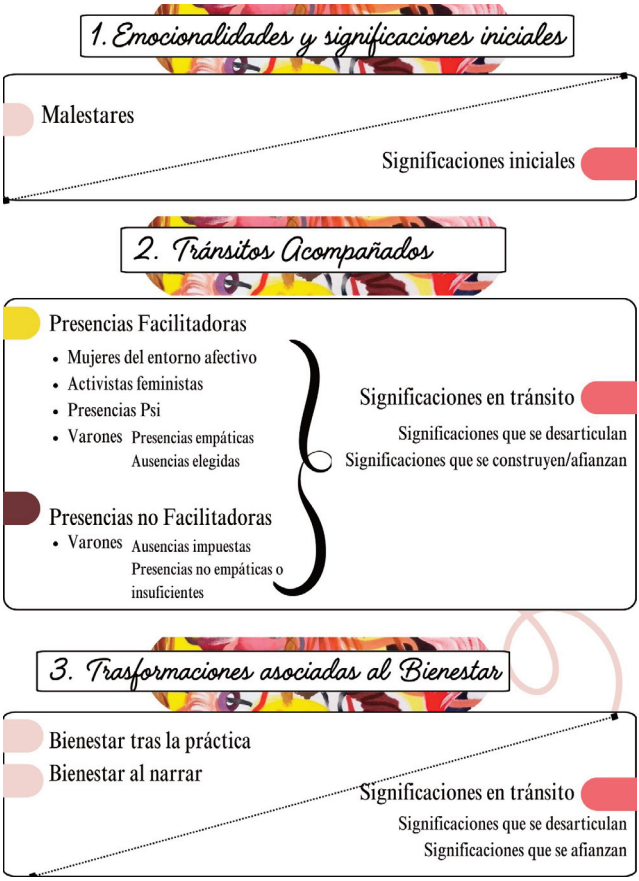
En cuanto al procedimiento de análisis de los relatos, realizamos un proceso inductivo de codificación y de análisis temático que comprendió diversos momentos y dio lugar a la construcción de tres grandes nudos temáticos, donde fuimos desarrollando las significaciones (*iniciales* y *en tránsito*) sobre las experiencias.

En el primer nudo temático, correspondiente al Capítulo 5, abordamos las emocionalidades y significaciones centradas en momentos iniciales del proceso de embarazo no deseado/aborto voluntario, previo a practicarse los abortos.

Al segundo nudo lo denominamos Tránsitos acompañados y allí abordamos las valoraciones de los distintos acompañamientos que conformaron *presencias facilitadoras* de las experiencias. Se corresponde con los capítulos 6, 7 y 8.

En el tercero nudo temático abordamos las transformaciones y bienestares una vez resueltos los abortos voluntarios y al narrar las experiencias que podrán observar en los capítulos 9 y 10. La siguiente es una representación esquemática de esto:

Gráfico 1. Nudos temáticos del análisis[2]



[2] En este esquema pueden observarse dos categorías dentro de los llamados "Tránsitos acompañados": las presencias facilitadoras y las presencias no facilitadoras. Estas últimas estuvieron conformadas por las valoraciones sobre los varones. Los varones que participaron de la ocurrencia de los embarazos no deseados aparecieron en todos los relatos a través de las distintas valoraciones sobre sus formas de estar presentes o de no estarlo. Hubo quienes valorizaron su empatía y un modo de estar sentido como adecuado a las necesidades expresadas, como así también modos de estar no empáticos e, incluso, violentos. Y también hubo quienes destacaron la ausencia, tanto impuesta por ellos como elegida por ellas. Todo esto afectó las significaciones sobre las experiencias en función de ciertas dinámicas de género que impregnaron las experiencias singulares. Por razones de espacio, este contenido no pudo ser incluido en este libro. Para conocer cuáles fueron las significaciones vinculadas a las presencias/ausencias de los varones, se puede consultar la versión original de esta investigación (escribir a mnsantarelli@email.unsl.edu.ar)

Apuntes éticos para un proceso feminista

Las entrevistas en profundidad se configuraron como un intercambio conversacional y emocional; intercambio guiado por algunos recaudos ético-feministas a los que atendí, y que me gustaría compartir a continuación. Además, estuvieron completamente atravesados por un tiempo de posibilidad singular de los encuentros.

Qué se narra y qué se puede narrar, pero también qué es escuchable de lo narrado y qué se puede escuchar queda determinado por cada interacción intersubjetiva, recíproca y bilateral. Lo que se elige decir o preguntar, en lo que se profundiza o no, lo que se omite o no se dice o no se pregunta; todo ello está mediado por la intersubjetividad y los significados compartidos, en un tiempo-espacio único.

Considero como ético-feminista a esta herramienta técnica cualitativa, las entrevistas en profundidad, porque además de las cuestiones éticas generales (como el consentimiento informado oral, la confidencialidad, el anonimato, la reserva cuidadosa del material obtenido) estuvo impregnada de otros recaudos éticos feministas. De modo que el enfoque feminista se aunó en lo teórico, en lo técnico y en lo ético de este proceso de investigación, y se propició mediante el sentir y el pensar intencionado que se traduce concretamente en los modos de presentar, escuchar, preguntar, observar, cuidar, afectar y dejarse afectar (Harding, 2002; Bartra, 2010).

El cuidado en el intercambio, cuando se trabaja con narrativas o relatos de otras personas, nos exige un resguardo atento y un accionar con la advertencia de lo que este intercambio puede provocar en la otra persona. En este sentido, considero que mis experiencias personales previas en relación al aborto en clandestinidad y el apoyo en criterios de otras investigaciones similares (como la de Carril Berro y López Gómez, 2008, 2010) favorecieron la construcción de advertencias y cuidados acorde a una ética feminista.

Una de estos recaudos fue prever un sistema adecuado y disponible de derivaciones a dispositivos psicoterapéuticos, en lo posible públicos y gratuitos en Mendoza y San Luis. Es interesante señalar que no fue necesario hacer uso de estos dispositivos porque las mujeres no lo solicitaron ni advertí la necesidad de ofrecerlos luego de realizar las entrevistas.

Otros recaudos éticos feministas estuvieron presentes al momento de invitar a participar, en el modo de ejercer la escucha y de interactuar,

y en la intencionalidad de establecer relaciones empáticas de autorización mutua, y de reconocer el valor de cada experiencia.

Con algunas entrevistadas ya existía una relación previa por haberlas acompañado como socorrista en sus abortos. Por ello, les transmití la propuesta de entrevista de modo tal que no fuera interpretada como una obligación, ni como una deuda a saldar (ni con mi persona, ni con el grupo socorrista que enmarcó el acompañamiento, ni con "la causa"). Sino que, en caso de aceptarla, lo hicieran motivadas por una decisión autónoma y una voluntad de compartir el relato de la experiencia. Esta reflexión devino del reconocimiento de que en toda relación humana el poder existe y circula, y que es necesario explicitar las formas en que este se ejerce en un proceso investigativo, de modo de no caer en formas abusivas, patriarcales o extractivistas, con o sin intenciones.

El segundo recaudo estuvo en la forma de escucha e interacción. Caracterizo mi escucha como generizada, relacional y feminista, que se fue gestando a partir de un amplio bagaje de experiencias previas ligadas a los activismos feministas socorristas y a mi experiencia profesional como psicóloga en el trabajo con mujeres en situación de violencia machista. Como así también, estuvo marcada por mis propias experiencias generizadas. Esta escucha y modo de intercambio se fueron nutriendo de los aprendizajes que adquirí en los sucesivos encuentros con las mujeres, a partir de reconocer y contactar tanto con la heterogeneidad como con los puntos puentes entre las distintas experiencias compartidas que, en ocasiones, me habilité a mostrarles y a pensar junto a ellas.

En cuanto al modo de interacción trabajé para que mi actitud afectiva fuera lo más desprejuiciada posible, sensible y abierta frente a lo que cada mujer realmente quisiera compartir y expresar a nivel verbal y no verbal, haciendo uso de mi formación en la escucha con tinte psicoanalítico, a la vez que sin confundir mis roles de entrevistadora y psicóloga.

En las interacciones, me dispuse a establecer relaciones empáticas, de confianza y reconocimiento recíproco. Estas no quedan aseguradas por compartir la condición genérica (Gregorio Gil, Pérez Sanz y Espinosa Spínola, 2020). Pero podemos construirlas a partir de dicha condición, cuando nos disponemos a acercarnos y a estar con la otra de un modo que denominamos feminista. Este acercamiento feminista se basa en el reconocimiento del saber valioso contenido en las experiencias de las mujeres y del valor de sus vidas en sí mismas. Lo cual, en ocasiones, trastoca la relación investigadora-investigada para dar lugar a una rela-

ción intragenérica y pedagógica recíproca, de validación de saberes y experiencias, de búsqueda y encuentro de intereses compartidos. De modo que reconocer que las experiencias de las mujeres son valiosas y que era necesario que sus voces y sus significaciones pudieran ser parte de las narrativas sobre aborto y salud mental fue el centro de esta investigación; le dio razón y posibilidad de ser a mi trabajo y fue un recurso empírico valioso desde donde comenzamos a interrogar y a construir respuestas lo más fieles a esas experiencias (Harding, 2002).

Además, la reciprocidad en el reconocimiento y la confianza se logran por el ejercicio de concesión de un rango de autoridad entre mujeres, ya sea por sus conocimientos, sus habilidades para vivir y sus capacidades –a pesar y en las opresiones– de ser constructoras activas de significados en el mundo y generar constantes aportes en sus propias vidas y en la vida social. Este reconocimiento recíproco contribuye a robustecer la autoridad de las mujeres, en tanto "dimensión simbólica legítima de identidad, cimiento de autoestima personal y colectiva" (Lagarde, 2000: 26). Este planteo que aúna reconocimiento recíproco y concesión de autoridad intragenérica entre mujeres, llevado al campo de la investigación sobre y a favor de la vida de las mujeres que somos, nos lleva a reconocer la contribución del intercambio en el fortalecimiento mutuo de las condiciones comunes de existencia, tanto de las mujeres que investigan como de las mujeres con quienes se investiga (Castañeda Salgado, 2006). Y esto hace, también, que dicho intercambio pueda considerarse feminista.

Finalmente, quisiera hacer una mención a lo singular del tiempo de posibilidad de los encuentros, las coordenadas temporales de las entrevistas. En este proceso de investigación hubo dos tiempos que, interrelacionadamente, mediaron entre la narración del pasado y su interpretación activa en el presente. Delinearon el acto de poder enunciar algo sobre esa experiencia y las aprehensiones subjetivas de las mismas: el tiempo biográfico personal, propio de cada una, y el tiempo histórico social común, configurado por el devenir de ciertos procesos sociales dinámicos.

El tiempo social en el que transcurrió nuestro trabajo de campo estuvo signado por la ampliación progresiva de los márgenes para el despliegue de todo tipo de narrativas sobre abortos. Fue en este tiempo que el tema, largamente silenciado y con escasa audibilidad social, pasó a estar en agenda y en debate en diversos espacios sociales, antes inaccesibles. Las entrevistas realizadas en 2017 y en 2019 anteceden y preceden de manera inmediata al año 2018, donde alcanzamos una generalizada y amplificada

expansión activista feminista (la *Marea Verde* en alusión al color que representa a la Campaña) en el marco del primer debate social y legislativo sobre el proyecto de legalización del aborto voluntario de la Campaña.

También veremos cómo el 2018 fue clave en ambas provincias, porque algunos avances a nivel sociosanitario favorecieron el comienzo de un mayor acceso a prácticas de aborto en algunos servicios de salud, bajo la causal "peligro para la salud". Estos avances, junto a la visibilización de nuevas prácticas y sentidos desestigmatizantes sobre abortos ampliaron las habilitaciones sociales para poder hablar y escuchar sobre el tema, por ejemplo, en la televisión, en redes sociales, en espacios de trabajo y estudio, al interior de los mismos servicios de salud y de los espacios domésticos. Este tiempo sociohistórico fue el preludio al segundo debate parlamentario que finalmente dio lugar a la Ley Nacional Nº 27610/2020 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post aborto. Y con ello, a la conquista legal de este derecho largamente reclamado desde los sectores feministas y de Derechos Humanos.

Por todo ello, la singularidad del tiempo histórico-social en el que realizamos las entrevistas tuvo efectos a nivel sociosubjetivo y político en general, que también se vieron reflejados al interior de este proceso. Habilitó las condiciones de posibilidad de muchos de los relatos que le dan cuerpo a esta investigación y condicionó las motivaciones para compartir dichos relatos. De hecho, advertimos un cambio notable en la forma de contacto con quienes participaron. Mientras que en la primera tanda de entrevistas de 2017 era yo quien buscaba a las mujeres –atendiendo a los recaudos éticos mencionados–, en la segunda tanda de entrevistas de 2019 muchas de ellas se ofrecieron voluntariamente sin necesitar mi invitación. Al tomar conocimiento sobre esta investigación en curso, ellas fueron quienes buscaron el espacio para poder testimoniar, favorecidas por un tiempo histórico-social más amable con la posibilidad de hablar de abortos y de sus abortos.

En el siguiente apartado, presentamos a las mujeres con quienes realizamos este intercambio conversacional feminista donde pusieron voces a las experiencias y procesos de significación que analizamos.

Sobre las entrevistadas y sus experiencias

Las entrevistadas fueron mujeres cis, mayormente heterosexuales y de nacionalidad argentina, a excepción de dos, una oriunda de Bolivia y otra mujer nacida en Chile. De ellas 29 habían completado estudios secundarios

y habían accedido a alguna instancia de estudios terciarios/universitarios. Residían en zonas urbanas. La mayoría no eran creyentes en religiones al momento de abortar, tres sí lo eran y dos se autodefinieron además como practicantes, del catolicismo y del evangelismo, respectivamente.

En cuanto a los abortos voluntarios, 29 de las entrevistadas contaban con, al menos, una experiencia de aborto farmacológico realizada por fuera de los circuitos legales. Incorporamos un relato sobre una ILE por causal peligro para la salud integral ocurrida en marzo de 2019 que nos acercó a una experiencia triplemente acompañada: por las amigas, por las activistas socorristas y por profesionales de la salud en el marco de una práctica considerada legal.

De las entrevistadas, 22 atravesaron un solo aborto, seis mujeres entre dos y tres abortos, y dos mujeres relataron cuatro experiencias de abortos voluntarios. Los abortos fueron practicados durante el primer trimestre de gestación; solo dos en el segundo trimestre de embarazo, alrededor de la semana 16 de gestación. La mayoría de las experiencias ocurrieron entre 2014 y 2017, en coincidencia con una actividad más organizada de los grupos socorristas locales y estuvieron situadas en el aglomerado urbano del Gran Mendoza y del Gran San Luis[3].

Entrevistadas en 2017

• Bárbara es profesional de la salud con larga trayectoria de militancia popular y, años previos a su segundo aborto, se definió como feminista y participaba activamente de la Campaña.

Relató dos experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios. El primero fue quirúrgico, a los 22 años. Contó con el apoyo de su padre que gestionó los contactos y los recursos económicos necesarios. Relató haber vivido esta situación con culpa, que resolvió en compañía de su psicóloga. Su segundo aborto fue a los 32 años, con medicamentos, en su casa y con acompañamiento de su pareja. Tenía conocimientos sobre el uso de misoprostol y, además, mantuvo una consejería con socorristas. También recibió el apoyo de sus amigas que eran o habían sido socorristas. Consideraba que esta experiencia fue de "decisión y empoderamiento; una experiencia 100% autónoma".

[3] Gran Mendoza comprende la ciudad de Mendoza (capital de la provincia), Godoy Cruz, Luján, Maipú, Guaymallén y Las Heras. Gran San Luis comprende la ciudad de San Luis (capital de la provincia), La Punta, Juana Koslay, Potrero de los Funes y El Volcán.

A lo largo de las dos entrevistas que mantuvimos, expresó su necesidad de diferenciar los tránsitos emocionales de sus dos experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios.

• Nadia se realizó un aborto farmacológico a los 24 años, acompañada por socorristas y una amiga que estuvo fuertemente presente en todas las instancias, a punto tal que narró su experiencia en plural.

Al momento del embarazo, se encontraba avanzando en su carrera universitaria con el apoyo económico familiar y sin ingresos propios. Estaba en una relación de pareja que decidió finalizar tras sentir un acompañamiento insuficiente durante su aborto.

• Virginia abortó con medicamentos a los 21 años. La entrevisté medio año después y, luego, en una segunda oportunidad. Era estudiante universitaria y vivía con su familia de origen en una "casa católica". Recibió el apoyo de sus hermanas, no así de su madre a quien no le contó. En la segunda entrevista, Virginia se definió como feminista y participaba del grupo socorrista que la acompañó.

• Betzabeth profesional, con ingresos económicos propios y atea. Entre sus 27 y 31 años había atravesado cuatro abortos con medicamentos en el primer trimestre de embarazo. El primero fue en 2012 cuando se encontraba finalizando su carrera universitaria y manteniendo una relación a distancia con su novio. Recibió asesoramiento telefónico de la Línea telefónica de Lesbianas y Feministas. En el segundo, en 2013, se encontraba conviviendo, pero finalizando la relación de pareja. Como ya contaba con una experiencia similar, consideró que no necesitaba asesoramiento. En 2015 y 2016 atravesó su tercer y cuarto aborto con acompañamiento socorrista; se encontraba en otra relación de pareja conviviente que acompañó todo el proceso.

• Charo trabajaba en un emprendimiento junto a su pareja con quien convivían y tenían una hija en edad pre-escolar. Antes de abortar estaba "totalmente a favor del aborto. O sea, básicamente es la decisión de la mujer sobre su cuerpo. Y sobre su vida" y consideraba que sus experiencias "a nivel emocional fue algo insignificante para mí, no tuvo ninguna repercusión emocional". Sus dos embarazos no deseados/abortos farmacológicos voluntarios fueron en 2016, a los 23 años, en su domicilio y acompañada por su pareja, su hermana y las socorristas.

• Andrea había abortado en 2016, vivía en la casa de su familia de origen. No creía en religiones ni tuvo una educación religiosa. Abortó con medicamentos en casa de su padre/madre, contando con sus apoyos

y el de su pareja, con quien estaban en la etapa final de la relación. Previamente, consultó con una psicóloga feminista que la orientó y la contactó con las socorristas. Luego del aborto, decidió finalizar esa relación de pareja y dedicarse de lleno a su pasión artística, buscando que también fuera su fuente de ingresos económicos.

• Emilia abortó a los 23 años, en 2013. Estuvo embarazada al comienzo de una relación de pareja, de quien tiempo después recibió violencia emocional y física. Cuando abortó se sintió acompañada por él, pero luego recibió reclamos y culpabilizaciones. Tuvo apoyo de su grupo de amigas –una de ellas era socorrista en otra provincia– y mencionó como un gran recurso el Manual de Lesbianas y Feministas. Previo a la administración de las pastillas hizo una consulta con una médica que la amenazó y la maltrató.

• Vera estaba en los últimos años de la carrera universitaria. No sostenía creencias religiosas y era feminista y, desde adolescente, activista en la Campaña. También había participado en la conformación de un grupo socorrista, previo a su aborto.

En 2014, a los 24 años, había retomado la relación con su expareja cuando ocurrió el embarazo no deseado. Abortó con medicamentos, previo asesoramiento de sus compañeras socorristas, aunque consideraba que se "autoacompañó". Prefirió no hacer partícipe a sus amigas en esta experiencia. Cuando se realizó ecografías o tuvo que interactuar con personas de servicios de salud se sintió "expuesta" y perseguida.

• Eluney abortó en 2014, a los 25 años, cuando estaba por dejar su trabajo formal y dedicarse a viajar y cambiar su manera de vivir. Estuvo acompañada por sus amigas que eran parte de "un grupo de mujeres" y por su pareja, con quien al regreso de su viaje comenzaron una convivencia sostenida hasta el momento de la entrevista. Gestionó información con un médico y con sus amigas feministas y sintió el apoyo de "todo un equipo". Fue una de las pocas entrevistadas que no aludió haber sentido miedo de las consecuencias penales de abortar en contexto de restricción legal, ya que contaba con saberes sobre el funcionamiento del sistema judicial desde adentro.

• Marcela era profesional de la salud, había completado sus estudios universitarios en una situación económica ajustada mientras gestó y crió, sin presencia del progenitor, a su hijo, que al tiempo de la entrevista era adolescente.

Tenía 40 años al momento de atravesar la situación de embarazo no

deseado/aborto voluntario, en 2015. El embarazo ocurrió en el marco de una incipiente relación con un hombre con quien compartía el espacio laboral. No contó con su acompañamiento emocional ni económico, por el contrario, relató recibir múltiples violencias de su parte. El circuito previo a concretar el aborto fue espinoso: tres médicos ginecólogos, seis ecografías, malos tratos por parte de los médicos, información incorrecta sobre el uso de misoprostol y un intento fallido de aborto. Mientras tanto, ocultó el embarazo a todas las personas de su entorno cotidiano. Tras semanas de búsqueda desesperada, logró contactar a una médica feminista que la contactó con las socorristas y logró abortar con medicamentos en su casa.

Dos años después, quiso compartir su relato por primera vez, lo cual le representaba "un gran paso (…) un desafío (…) para darme la posibilidad de ponerle palabras de nuevo [a algo que] la sociedad no lo puede poner todavía en palabras".

• Anahí abortó a los 22 años, seis meses antes de la entrevista que mantuvimos en 2017. El embarazo no deseado fue producto de la relación con un joven de su edad con quien no mantenía un vínculo afectivo estable y a quien decidió no contarle. Se autodefinió como creyente en el catolicismo. Creció en una localidad semi-rural y desde hacía dos años residía en la Capital. Iba a la Universidad y los fines de semana hacía trabajo rural de manera informal. Con ese ingreso económico mínimo, junto a la ayuda económica de un tío, sostenía sus estudios.

• Carlota trabajaba en relación de dependencia y era madre de dos hijos en edad pre-escolar a quienes criaba sin presencia del padre biológico. En 2016 atravesó dos embarazos/abortos voluntarios; uno producto de una única relación ocasional y el segundo de su pareja actual con quien convivía. En su primer aborto contó con el apoyo de su madre y hermanas y en el segundo estuvo acompañada por su pareja. En ambos, contactó a las socorristas.

• Karina se autodefinía como atea y militaba en un partido de izquierda. Vivía con su hijo de edad escolar en una casa prestada por su familia y contaba con ingresos económicos limitados; el principal era una pensión no contributiva.

El embarazo no deseado/aborto voluntario se dio en simultáneo con una separación de su pareja conviviente que vivió con mucho sufrimiento por situaciones de violencia psicológica, verbal e infidelidades por parte de él. Abortó a fines de 2014, a sus 31 años y acompañada, principalmente, por sus hermanas, su madre y por las socorristas.

• Fabiana era atea, profesional de la salud con ingresos propios y tenía 40 años al momento de la entrevista. Era madre de dos hijos/as adolescentes con quienes convivía.

A los 37 años atravesó un embarazo no deseado producto de una relación incipiente y abortó sin contarle sobre el embarazo ni sobre el aborto, acompañada por sus amigas y primas. Definió el momento de practicarse el aborto como "un aquelarre". Luego de abortar, se incorporó al grupo socorrista que la acompañó y retomó la militancia feminista que había dejado en suspenso con la llegada de sus hijos/as. Una de sus amigas acompañantes también se incorporó al grupo.

• Amy, con 27 años, trabaja en un comercio de manera informal y vivía con su hermana en una casa prestada por su madre.

Relató haber atravesado tres abortos voluntarios con medicamentos, el primero a los 16 años, en una adolescencia "envuelta en cosas malas", en un "ambiente que era muy tóxico". En aquel entonces, año 2006, estuvo acompañada por su papá, asesorada en el uso por su tío ginecólogo.

El segundo fue en 2012, a los 22 años y estuvo acompañada por sus amigas activistas de la Campaña y su padre. Abortó en la casa que compartía con su padre, rodeada por la contención de sus amigas. Decidió no comunicar la situación a los varones con quienes se encontraba manteniendo relaciones sexuales.

La tercera experiencia fue en 2017 y contó con el asesoramiento de socorristas de La Plata, a donde viajó porque relató que en su provincia no conseguía la medicación, también por el miedo a la persecución legal de profesionales del sistema de salud. Su pareja de aquel entonces la acompañó y, esta vez, prefirió no contarles sobre el embarazo ni a su padre ni a sus amigas.

Entrevistadas en 2019

• Leonor tenía una excepcional formación académica e ingresos formales propios. Vivía sola y no era creyente en religiones.

Relató que a lo largo de su vida había ejercido un eficaz control anticonceptivo hasta que ocurrió este embarazo en el marco de un vínculo afectivo incipiente y armónico. Abortó a los 30 años, en 2017, en su casa y "con los acompañantes que quería": un amigo y una amiga que había sido socorrista. Estuvo asesorada por el grupo socorrista y una médica que coordinaba con ellas. También destacó la presencia de su

analista como un "acompañamiento emocional invaluable". Luego de su aborto, se incorporó al grupo socorrista. Al saber de mi investigación, me ofreció su relato.

• Lorela era atea y trabajaba en su profesión, con ingresos formales y propios. Vivía con su hija de siete años y compartía su tenencia con el padre, de quien se separó en 2013. El embarazo que abortó voluntariamente ocurrió en 2015, a los 37 años y se produjo en el marco de "una relación casual". No contó con acompañamiento por parte de este hombre, que era médico. Abortó con medicamentos en casa de su madre, quien la ayudó a cuidar a su hija mientras abortaba.

Fue la única entrevistada que había intentado, porque prefería, hacerse un aborto quirúrgico pero el día en que se lo iban a realizar el médico no asistió. Como segunda opción, habló a una amiga feminista que la contactó con socorristas. Semanas después de autoadministrarse las pastillas, tuvo un sangrado abundante y le hicieron un legrado. Fue la única entrevistada que no recomendaba el método farmacológico autoadministrado, "la verdad que no, a menos que tuviera algún médico que la pudiera seguir".

Con su relato mostró una experiencia difícil que, hasta el día de la entrevista, le generaba angustia por haberse sentido en riesgo, por la "falta de monitoreo" médico y la actitud de indiferencia y abandono del hombre de quien había estado embarazada.

• Ernestina tenía 41 años al momento de su aborto y de la entrevista, cuatro meses después. Era atea y trabajaba en relación de dependencia. Se encontraba en pareja desde la adolescencia con su marido y tuvieron dos hijas "muy deseadas" que iban a la escuela primaria.

Se enteró del embarazo una semana antes de que su marido se realizara la vasectomía, ya que habían decidido conjuntamente un método anticonceptivo irreversible. Abortó con medicamentos en su domicilio a fines de 2018, acompañada por él. Previo, contactó a las socorristas locales y sintió una presencia fuerte por parte de ellas. Durante la entrevista mostró una marcada indignación y enojo por las restricciones legales y sociales que existían sobre las prácticas de aborto.

• Pato, 29 años, atea, se encontraba finalizando una carrera universitaria vinculada al arte y trabajaba de forma independiente al momento de la entrevista.

El embarazo no deseado ocurrió en 2015 con quien había sido su novio y prefirió no contarle. Abortó con medicamentos acompañada

por su grupo de amigas y por las socorristas. En momentos posteriores a la práctica fue muy importante la presencia y el sostén de su madre. Tras el aborto, se incorporó al grupo socorrista y, desde ese entonces, llevaba adelante una comprometida militancia feminista por el derecho al aborto legal.

• Paz, 40 años, era madre de dos hijas, una en edad escolar y otra mayor de 18 años, cuyo embarazo ocurrió a sus 19 años. Trabajaba profesionalmente en el campo de la salud y convivía con su hija menor y su pareja actual.

Relató cuatro experiencias de abortos con medicamentos. El primero fue en 2015. Se encontraba finalizando la relación de pareja con el padre de su hija menor y se mantuvo firme en la decisión de interrumpir este embarazo. Buscó información en internet hasta que encontró que una conocida suya, feminista, seguía las redes sociales de la Campaña y recurrió a ella. El segundo embarazo/aborto se dio en el marco de una relación de noviazgo incipiente en 2016 y lo realizó en su casa sola, "rapidísimo (…) creo que me han dolido menstruaciones más que eso". A los seis meses hubo otro embarazo que llegó al segundo trimestre de gestación. Lo empezó con medicación en su casa y la experiencia física fue "con mucho dolor". Decidió recurrir a una clínica donde la maltrataron y la legraron en contra de su voluntad, ya que por sus conocimientos profesionales sabía que no era necesaria esa intervención: "me obligaron. Les dije que no, pero me lo hicieron igual. Después del legrado me deprimí". El cuarto aborto ocurrió cuatro meses después, con un DIU puesto, estuvo acompañada por la pareja y asesorada por socorristas.

• Lola no contaba con un trabajo formal y al momento de la entrevista vivía en la casa de un familiar, con él y su hija de tres años.

Relató dos abortos provocados con pastillas, en 2014 y en 2018. En el medio de ambas experiencias tuvo un embarazo deseado y llevado a término. Los dos embarazos que decidió abortar se dieron en el marco de relaciones con personas que eran consideradas "solo amigos". En el primero, contactó con las socorristas para saber cómo abortar y sus amigas la apoyaron y acompañaron. En el segundo, la acompañaron dos amigas y acudió a socorristas de otra provincia porque no recibió respuestas de los grupos locales.

• Úrsula tenía 35 años y se encontraba culminando estudios universitarios sobre salud. Compartió su experiencia de embarazo no dese-

ado/aborto voluntario farmacológico ocurrida en 2011, a los 27 años. El embarazo ocurrió con su novio de aquel entonces que la acompañó en la decisión y en la búsqueda para lograr abortar, junto a una amiga que consiguió la medicación y la ayudó "en la logística". Consultó el Manual de Lesbianas y Feministas y también llamó a la línea telefónica. Consultó con varios que no le brindaron información y la maltrataron. El primer intento de aborto resultó fallido. Cuando usó las pastillas por segunda vez buscó asesoramiento de "mi ginecólogo de toda la vida" y de una médica feminista que trabajaba en un servicio público y que le indicó, una vez autoadministradas las pastillas, que fuera a una guardia para terminar el aborto con un legrado.

• Guadalupe abortó a los 40 años, en 2017. Contaba con un trabajo formal e ingresos económicos propios. Tenía tres hijos adolescentes. Se autodefinía desde niña como creyente y practicante de la religión católica, como su familia de origen. Relató haberse casado y embarazado joven y haber sufrido violencias de todo tipo en esta relación que duró 20 años y que logró finalizar hacía dos años, intervención judicial mediante. Luego había conocido a su pareja actual, con quien ocurrió el embarazo. Una amiga que había abortado farmacológicamente le pasó el contacto con socorristas.

Decidió administrarse las pastillas sola en su domicilio, asesorada por las feministas de quienes rescató la "seguridad" brindada para no sentir miedos. Alrededor de los 10 días posteriores al uso de la medicación, advirtió que la sangre que seguía despidiendo tenía olor y consultó con su "médico de confianza", quien le expresó su opinión personal en contra del aborto y le hizo un legrado, diciendo en la clínica que había sido espontáneo. Luego del aborto, se ligó las trompas.

• Eva nació, se crió y realizó sus estudios universitarios en la capital de Bolivia. Residía en Argentina desde hacía tres años, a donde vino por posibilidades laborales. Era profesional de la salud. Vivía sola. Se autodefinía como creyente y practicante evangélica, al igual que su familia.

En 2017 abortó con medicamentos un embarazo que se produjo en el marco de una relación "nada seria", acompañada por las socorristas que contactó gracias a la única amiga a quien le contó del embarazo. Al momento de abortar, relató un estado emocional sufriente y mucha soledad. Utilizó la medicación llorando, sintiendo que merecía dolor físico y pidiendo perdón a "Dios, su hijito y su madre". Meses después del aborto, inició un proceso psicoterapéutico.

A Eva la contacté por otra entrevistada que había sido una de las socorristas que la acompañó. Intentamos encontrarnos en 2017, sin éxito. Dos años después, me escribió para avisarme que había cambiado su número de teléfono y que le gustaría realizar la entrevista, manifestando un gran interés en participar de la investigación con su relato.

• Kristina, 30 años, se practicó su primer aborto farmacológico a los 26 años, en 2015, cuando se encontraba dedicada al estudio, a la militancia y en "una relación tóxica" de noviazgo. La acompañaron las socorristas y su novio. Tras el aborto, experimentó mucha culpa y necesitó comenzar una terapia psicológica.

Su segundo aborto en 2018 coincidió con el debate legislativo del proyecto de legalización de la Campaña y la gran movilización social, de la cual participó activamente. En esta oportunidad, la pareja ejerció reproches sobre el aborto anterior y no acordó con la decisión de abortar. Se sintió acompañada por sus compañeras de militancia y por una socorrista. Entre ambos abortos –2015 y 2018– había iniciado, junto a sus compañeras de militancia, un proceso de acercamiento al feminismo.

• Violeta estudiaba en la Universidad y trabajaba de forma independiente. Vivía con su madre y padre. Nunca profesó una religión. Era militante feminista; desde antes de su aborto "ya usaba el pañuelo verde". Había abortado cuatro años antes, a los 23, con el apoyo de todas las personas de su círculo afectivo cercano con quienes compartió la decisión, principalmente por su madre, sus amigas y su pareja. También se sintió fuertemente acompañada por las socorristas, con quienes estaba "agradecida a un nivel supremo".

• Marisa, 25 años, era creyente de la religión evangélica. Relató que dejó la escuela secundaria en el último año "por rebelde", formó pareja y tuvo a su primera hija a los 17 años. Desde ese entonces, se dedicaba a las tareas domésticas y de cuidado de sus dos hijas, mientras su marido trabajaba en la construcción. Abortó con medicamentos, sola en su casa dos veces, en 2016 y a inicios de 2019. La primera experiencia ocurrió unos meses después del nacimiento de su segunda hija, con la orientación del médico del Centro de Salud, quien le informó sobre el método farmacológico y el grupo socorrista. En el segundo aborto también estuvo asesorada por el mismo médico que le facilitó medicación disponible para ILE (aunque ella no mencionó su aborto como una interrupción legal). Nunca había hablado de sus abortos ni de sus sentimientos al respecto.

• Clara tenía 33 años cuando se enteró de la investigación y me ofreció el relato sobre su aborto ocurrido 10 años antes. Se autodefinió como "clase media", estaba terminando estudios universitarios y se había incorporado recientemente a un grupo socorrista.

En 2008, cuando estuvo embarazada, se encontraba estudiando, trabajando, haciendo trabajo barrial y militando en un partido de izquierda que sostenía una postura a favor de la legalización del aborto –ella también– y que, ya en ese entonces, manejaba información sobre la existencia del aborto farmacológico. Inició el aborto con medicación en su casa y lo terminó en un hospital, donde dijo que era un aborto espontáneo. Prefirió no contarle a su padre/madre ni a sus compañeras/os/es del partido sobre la situación, sí a algunas amigas y al "chico con el que salía".

• Estefanía vivía sola en un departamento céntrico, iba a la Universidad y trabajaba freelance. Era atea y feminista. Ya conocía el método farmacológico porque otras mujeres lo habían usado exitosamente, entre ellas, su hermana. Abortó en 2017, a los 21 años. Se encontraba finalizando sin conflictos una relación "de compañerismo" y disfrutando de su vida actual. La decisión de abortar fue propia, firme y sin dudas. Remarcó el acompañamiento de su hermana mayor que era su "mejor amiga". Gestionó lo necesario para abortar en Córdoba y se practicó el aborto en San Luis en la casa de su padre/madre (sin que supieran) para poder contar con la compañía de una amiga/vecina de la infancia. Previo, se contactó con socorristas y accedió al sistema de salud pública para un control pre y post aborto con "mucha facilidad" gracias a un circuito "aceitado" entre las socorristas y ese servicio de salud cordobés.

• Camila. Docente, era el soporte económico de su grupo familiar conviviente conformado por su madre, hermanos y su hija en edad escolar.

Cuarenta días antes de la entrevista, se había enterado del embarazo y decidió interrumpirlo sin dudas ni ambivalencia. Prefirió mantener a su novio al margen y se apoyó en sus amigas, que le facilitaron contactos con socorristas. Su práctica fue enmarcada como una Interrupción Legal de Embarazo por causal salud integral en el primer trimestre de embarazo, a la cual accedió por un protocolo reciente de su obra social. Se enteró por una amiga que existía la causal salud y una psicóloga le facilitó el acceso al circuito. La administración del primer tratamiento no tuvo el efecto deseado y debió repetirlo; esta segunda vez lo hizo siguiendo las indicaciones de las socorristas, que eran distintas a las indicaciones de la médica de la obra social.

Capítulo 4. Escenarios de los abortos entre 2009-2019. Regulaciones, disputas y transformaciones en Argentina

En diciembre de 2020, el aborto voluntario por plazos –hasta la semana 14 de gestación– fue legalmente reconocido como un derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar con otras identidades de género, mediante la Ley Nacional Nº 27610/2020. Pero hasta la sanción de esta ley, la restricción legal del aborto voluntario convivía con cierta tolerancia frente a la práctica.

En ese clima de penalización formal, tolerancia consuetudinaria y acontecer clandestinizado de los abortos, los feminismos organizaron diversas estrategias, en sinergia con ciertos sectores de salud, para afectar los procesos de silenciamiento y transformar los modos de acceso al aborto farmacológico. Además, durante el período que analizamos (2009-2019) se dieron algunas transformaciones clave en el campo de lo normativo y de las políticas sanitarias, con distintas repercusiones en las provincias de San Luis y Mendoza.

A continuación, haremos un breve recorrido a nivel nacional, sobre todo en cuanto a aspectos vinculados con la ILE, y puntualizaremos en el contexto de San Luis y Mendoza. Luego presentaremos las estrategias feministas a nivel nacional de la Campaña, de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, de Socorristas en Red –feministas que abortamos– y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Para, luego, focalizar en los acompañamientos feministas en San Luis y Mendoza.

Principales transformaciones en el marco normativo y sanitario

En Argentina, desde 1921 hasta fines de 2020 el aborto estuvo regulado por un régimen mixto establecido en el Código Penal. En el artículo 85

se penalizaba y tipificaba como delito contra la vida a los abortos no contemplados en las excepciones establecidas en el artículo 86. Estas eran: cuando el embarazo pusiera en peligro la vida o la salud de la mujer gestante y este peligro no pudiera ser evitado de otro modo, o cuando fuera producto de "una violación o de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente". A pesar de la existencia de estas causales, durante la mayor parte del siglo XX la norma funcionó como si no existieran y la penalización fuera total (Checa, 2006; Bergallo, 2011; Dosso, 2017; Santarelli y Anzorena, 2020; Vacarezza, 2020). La letra del Código Penal no sufrió modificaciones durante casi un siglo, pero sus interpretaciones fueron terreno de grandes disputas.

Un conjunto de hechos y fuerzas presionaron para visibilizar la situación de incumplimiento de las ILE en Argentina, favoreciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en 2012 se hiciera eco de esto y se expresara a través del Fallo F.A.L. Este fue un hito que habilitó progresivamente, aunque de forma diferencial entre las provincias, la consideración de ciertos abortos como no punibles y, luego, como derechos a ser garantizados, siendo un parteaguas en el avance hacia la conquista del reconocimiento legal del derecho al aborto.

Entre otros lineamientos, mediante el Fallo F.A.L. se estipuló el alcance de la causal "violación" como derecho de todas las mujeres (independientemente de las facultades mentales de la víctima de la agresión) y se enfatizó en la no judicialización de estos casos. Además, reafirmó la obligación del Estado de garantizar el acceso a este derecho, de remover obstáculos y de generar lineamientos precisos para atender los abortos que ya eran legales. Señaló que no garantizar la interrupción legal de un embarazo era discriminatorio y violatorio de los derechos humanos. También, exhortó a los gobiernos provinciales a implementar y garantizar la aplicación de protocolos hospitalarios para su atención sin dilación ni judicialización, con la sola declaración jurada de la mujer ante el médico, siguiendo la Guía Técnica que se encontraba vigente (CSJN, 2012).

En el orden de la política sanitaria, en 2007, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del MSAL había elaborado la primera Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punible, de carácter federal, con indicaciones sobre el encuadre jurídico y los procedimientos clínicos recomendados por la OMS, que incluían al aborto farmacológico. La Guía fue actualizada en 2010 y en 2015 fue reemplazada por el Protocolo para la Atención Integral de las Personas

con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (en adelante el Protocolo ILE), nuevamente actualizado en diciembre de 2019.

El paso de las Guías al Protocolo ILE implicó un salto cualitativo evidenciado ya en la misma denominación de la práctica: de ser "abortos no punibles" a ser "interrupciones legales de embarazos". Con ello se avanzó en el reconocimiento de la ILE como un derecho, al menos en lo formal, considerado en su positivo y en su plena legalidad y, por lo tanto, cuyo acceso debía estar garantizado en el ámbito sanitario (De Lellis *et al.*, 2017).

En cuanto a la causal "peligro para la salud", el Protocolo ILE clarifica su correcta interpretación y las responsabilidades de los equipos de salud para garantizar el acceso. Es "de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino", "por todas las instituciones sanitarias" (MSAL, 2015: 4). Tanto la versión de 2015 como la de 2019, establecen una visión integral de salud que contempla las dimensiones físicas, mentales-psíquicas y sociales, que no exige la configuración de daño ni la constatación de una enfermedad. Sino que abarca la posible afectación de la salud y al bienestar, y en cuanto a la salud mental incluye "el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima" (MSAL, 2019: 16). Es decir que, si la continuación de un embarazo generaba un riesgo de afectación al bienestar físico, mental o social de la persona gestante, su interrupción era legal y su práctica debía ser garantizada como un derecho, sin sufrir obstaculización ni negación alguna.

Sin embargo, el acceso en los servicios de salud a través de esta causal fue prácticamente inaccesible y geográficamente desigual en las distintas provincias y localidades del país hasta avanzado el año 2018. A pesar del sentido de integralidad y multidimensionalidad de la salud que indicaban el Protocolo ILE y la OMS, los servicios de salud la consideraban como daño físico grave y la equiparaban con la causal peligro para la vida. Es así que, la interpretación restrictiva de los alcances de la causal salud, y la negación y desconocimiento de las experiencias subjetivas de afectación del bienestar de las propias mujeres que portaron los embarazos no deseados se convirtieron en dos de los condicionantes centrales de las experiencias que analizaremos, directamente vinculados a los procesos de clandestinización.

Veamos con mayor profundidad lo que ocurrió en San Luis y Mendoza con la recepción del Fallo F.A.L. y la implementación de las causales para Interrupciones Legales de Embarazos.

San Luis y la falta de definiciones

Cuando analizamos cómo se procesó el Fallo F.A.L. en San Luis, lo que observamos son las resistencias y ciertas estrategias de dilación desde los sectores religiosos y conservadores que ocupaban lugares de poder en el escenario político puntano. Lo cual hizo que esta provincia, hasta fines de 2018, no contara con la adhesión al Protocolo ILE ni con lineamientos claros para los servicios de salud.

Años antes y posterior al Fallo F.A.L., en el Palacio Legislativo de la Ciudad Capital, se llevaron adelante 14 jornadas llamadas Audiencias Públicas sobre Aborto No Punible (agosto a septiembre de 2012). Integrantes de las Comisiones de Diputados de Asuntos Constitucionales, de Salud y de Derechos Humanos convocaron a las personas interesadas en participar con su opinión desde "la ciencia, la teología y las diferentes interpretaciones legales" para conocer "el punto de vista (…) respecto al procedimiento a llevar a cabo en los casos enumerados por el artículo 86º del Código Penal" (Cámara de Diputados, 2012, 30 de agosto).

Se inscribieron 76 personas, algunas en representación de instituciones o grupos religiosos, feministas, universitarios y/o de espacios comunitarios culturales y sociales, principalmente de San Luis Capital.

Lo que observamos, a partir de la lectura analítica de las versiones taquigráficas de estas Audiencias, es que la posición desde los sectores antiderechos insistía en equiparar todo aborto con un asesinato y, así, desviar el tema de las Audiencias. No opinaban sobre cómo la provincia debería cumplir con el Fallo F.A.L., sino que insistían, desde miradas religiosas, en que todo aborto era un asesinato y, como argumento secundario pero presente, que generaba consecuencias negativas en la salud mental de las mujeres que se lo practicaran. Mientras que los sectores vinculados a los feminismos y los derechos humanos insistían en la necesidad de respetar el derecho a acceder a los abortos no punibles según la interpretación del artículo 86 brindada por la CSJN.

En la Cámara de Diputados se habían presentado dos anteproyectos (uno, en consonancia con lo establecido por la CSJN y otro antagónico) que iban a ser tratados luego de escuchar las opiniones vertidas en las Audiencias. Pero al terminar esos dos meses ninguno fue debatido. En las audiencias, Alberto Rodríguez Saá[1], ex gobernador y figura política

[1] Alberto Rodríguez Saá fue senador nacional en los años 80 y 90, gobernador peronista de la provincia desde 2003 hasta 2011, y desde 2015 hasta 2023.

del peronismo local de gran influencia, se manifestó a favor de cumplir con lo establecido por la Corte, pero cuando retomó la gobernación de la provincia en 2015 tampoco realizó ninguna acción al respecto. Es así que San Luis continuó, hasta fines del 2018, sin ninguna definición formal sobre cómo se garantizaría el derecho a las ILE.

Además, tras las Audiencias, algunos gobiernos municipales dictaron ordenanzas para limitar aún más los derechos vinculados a lo no reproductivo, o para avanzar en institucionalizar y legitimar una ideología no laica. Villa Mercedes en 2012 fue declarada "Ciudad provida" por ordenanza municipal y la Municipalidad de San Francisco del Monte de Oro, que en 2014 también fue declarada "Ciudad provida", ordenó la prohibición del uso, distribución, difusión o promoción de anticoncepción oral de emergencia que "por sus efectos abortivos atente contra la vida del niño por nacer", yendo en contra de la Ley Nacional que establece su acceso gratuito.

En definitiva, la falta de una definición formal de políticas sanitarias en San Luis para acceder a las ILE, contribuyó a seguir perpetuando las dificultades ya existentes para garantizar ILE por causal salud integral y este tipo de situaciones fueron sistemáticamente clandestinizadas, al menos hasta finales del 2018.

Mendoza y sus marcadas disputas

En Mendoza la disputa por los derechos sexuales y (no) reproductivos aparece más marcada y viva, vinculada con una actividad ardua y sostenida desde las agrupaciones feministas junto con acciones más determinantes desde los sectores conservadores[2].

Ya entre 2006 y 2008, a partir de la sucesión de pedidos de abortos legales con gran repercusión mediática, para niñas y adolescentes que habían sufrido violaciones, algunas colectivas feministas, la Campaña, la Dirección Provincial de Derechos Humanos y el Programa Provincial de Salud Reproductiva presentaron tres protocolos ante el MSAL de la provincia, uno de ellos para atención de abortos no punibles en los hospitales públicos, que no fueron aprobados (Foro, 2009; Anzorena, 2013a).

Encontramos otro hito importante en 2009, cuando se aprobó la Ley provincial Nº 8116 que restringía al ámbito institucional sanitario

[2] Para profundizar en algunas de las complejidades del contexto mendocino, se recomienda consultar a Brown (2006) y Anzorena (2002).

el expendio, suministro y/o fraccionamiento de medicamentos con misoprostol. Esta Ley entró en vigor en 2012, como expresión de las reacciones conservadoras frente al Fallo F.A.L., y suspendió por completo la venta del medicamento en farmacias de la provincia, sumando otro obstáculo en el acceso a la ILE con método farmacológico (Anzorena, 2013a). Esto también dificultó las condiciones de seguridad de todos los abortos, que eran marginados de los ámbitos de salud institucionales, y desigualó notablemente a las mujeres que residían en Mendoza, empujándolas a los mercados clandestinos para adquirir misoprostol o a someterse a prácticas riesgosas en caso de no conseguirlo o de no contar con el dinero suficiente.

El Fallo F.A.L. no corrió mejor suerte que en San Luis. Autoridades como el gobernador y el ministro de Salud declararon públicamente que no habría adhesión del Poder Ejecutivo al Fallo. La Campaña en Mendoza repudió, en una actividad pública frente al ministerio, estos pronunciamientos y exigió la adhesión a la Guía Técnica de ANP. Entonces, fueron convocadas a una reunión donde el ministro reiteró su posición (Anzorena, 2013a). Simultáneamente, en el Poder Legislativo se presentó un proyecto de ley de adhesión que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero no alcanzó los votos necesarios en la Cámara de Senadores.

Recién en 2018, Mendoza logró tener algunos lineamientos sobre ILE avalados desde el Estado provincial, aunque con escaso compromiso para su difusión entre todos los efectores de salud. Ese mismo año, después del rechazo de la Ley de IVE debatida en el Congreso Nacional, se habían presentado dos proyectos en la Legislatura Provincial: uno para adherir al Protocolo ILE y otro para derogar la Ley Nº 8116. Ambos quedaron paralizados porque las fuerzas a favor y en contra estaban parejas. La restricción a la venta de misoprostol continuó vigente hasta la sanción de la Ley Nacional Nº 27610 en 2020.

De modo que, durante el período que sitúa las experiencias que analizamos, en este contexto mendocino de agudización de la clandestinización de los abortos y de marcadas dificultades para conseguir misoprostol para abortar de forma farmacológica, las organizaciones feministas dedicadas al acompañamiento cobraron un papel fundamental.

Estrategias feministas para visibilizar, acceder y transformar los abortos farmacológicos

Desde hace varias décadas, los feminismos entendieron y sostuvieron públicamente la necesidad de desandar el largo camino construido sociohistóricamente que ubica al aborto y a quienes abortan en el terreno de lo abyecto: lo criminalizado, lo anormalizado, lo estigmatizado, lo susceptible de reproche y de condena social y legal. Reconocieron la necesidad de desarmar toda una compleja maquinaria de disciplinamiento y fragilización de género que, además de influir notablemente en las legislaciones y políticas públicas de la mayoría de los países de nuestro continente, impone modos hegemónicos de atravesar y vivenciar los abortos, en tanto experiencias subjetivas y sociales.

Es así que promovieron estrategias para transformar el silenciamiento y la estigmatización, a la vez que generaron dispositivos, cada vez más complejos y organizados, para brindar información y acompañamiento a quienes necesitaban abortar. Estos son dos de los pilares del trabajo feminista que han impactado en las experiencias de abortos clandestinizados analizadas y que profundizaremos a continuación; primero a nivel nacional y luego enfocado en las organizaciones feministas de San Luis y Mendoza.

Los feminismos afectan el silenciamiento sobre los abortos

Históricamente, los marcos institucionales, legales y sociales en Argentina han tolerado las prácticas de abortos voluntarios a condición de que sucedieran bajo el manto del silencio y del ocultamiento, en consonancia con su acontecer clandestinizado. En este sentido, parte del trabajo desde los feminismos ha sido habilitar progresivamente espacios para visibilizar, compartir y socializar estas experiencias, sacarlas del aislamiento y secretismo impuestos, mostrar su cotidianeidad y el carácter político de los efectos nocivos del silenciamiento sobre quienes abortan.

Ya en los años 90 se registran acciones activistas basadas en la socialización de experiencias de abortos de mujeres reconocidas públicamente y de mujeres anónimas, con vistas a visibilizar su acontecer cotidiano e instalar el tema de la necesidad de su legalización, frente a los oídos de los sectores políticos y sociales que permanecían sordos y que sostenían la clandestinización (Bellucci, 2014).

Los entonces llamados Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM) también fueron espacios que las feministas disputaron para instalar la temática del aborto en los talleres, siendo en Rosario, en 1989 cuando el taller Anticoncepción y aborto apareció por primera vez en la nómina "oficial" (Alma y Lorenzo, 2009). Otro hito ocurrió en el Encuentro de 2003, también en Rosario, tanto por el logro de estrategias de impacto y visibilización, como por el desarrollo de acciones para la organización para reclamar la legalización. En este Encuentro fue que inauguraron el taller de Estrategias para el acceso al aborto legal y seguro, realizaron la Asamblea por el derecho al aborto, que tuvo su continuidad en el Encuentro de Mendoza de 2004 y dio lugar, posteriormente, a la conformación de la Campaña. La multitudinaria marcha de cierre de 2003 se tiñó de verde para reclamar la legalización. Usaron por primera vez los pañuelos distribuidos por la organización Católicas por el Derecho a Decidir Córdoba, que resultó una eficaz estrategia de impacto y visibilización en varios medios masivos de comunicación (Alma y Lorenzo, 2009; Bellucci, 2014; Burton, 2017; Tarducci, 2018).

Al año siguiente tuvo lugar la campaña "Yo aborté", impulsada por la Red Informativa de Mujeres de Argentina (Rima). Esta acción fue un medio inaugural para que un número significativo de mujeres y lesbianas, a partir de sus testimonios escritos en primera persona y a pesar de los tabúes sociales, aumentaran los lazos de comprensión sobre estas experiencias tan heterogéneas como acalladas[3].

En 2005 se lanzó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, luego de concretar una reunión federal en Córdoba que se había acordado en el XIX ENM en Mendoza 2004. Esta articulación federal está integrada por una diversidad de organizaciones de diferentes orientaciones políticas y prácticas activistas, unidas bajo el objetivo de lograr la despenalización y legalización del aborto, lo cual se conquistaría 15 años después, tras presentar sucesivos proyectos de ley. En el orden de lo simbólico, la exigencia y redacción de una ley implicaba inscribir la diferencia entre sexualidad y reproducción y el derecho de las mujeres a disponer libre y autónomamente de sus cuerpos como ciudadanas.

Asimismo, las feministas organizadas en la Campaña acompañaron situaciones en que se violaba el derecho a las ILE, las convirtieron en li-

[3] Los testimonios están disponibles en http://www.rimaweb.com.ar/articulos/aborto/campana-yo-aborte/

tigios estratégicos y las visibilizaron como injusticias y muestras del incumplimiento sistemático. Reclamaron sanciones a nivel internacional, presionaron a las autoridades locales para que adecuaran las normativas sanitarias de atención de las ILE. Otro gran logro de la Campaña fue proyectar el tema del aborto de la agenda feminista a la agenda de la salud pública, la justicia social, la democracia, la laicidad del Estado y la defensa de los derechos humanos de las humanas, a la vez que continuar instalando el tema en voz alta, sustraerlo del silenciamiento, con vistas a la despenalización social (Anzorena y Zurbriggen, 2013).

Pasada la primera década de los años 2000, las experiencias de abortos farmacológicos acompañados por socorristas encontraron una luz expresiva a través de las acciones activistas vinculadas al trabajo cinematográfico y literario. Destacamos la propuesta cinematográfica de Carolina Reynoso en 2013 con el film *Yo aborto, tú abortas, todxs callamos* y el libro compuesto por relatos ficcionalizados *Código Rosa. Relatos sobre abortos* (2015), de Dahiana Belfiori.

La puesta en circulación del libro de Belfiori, en una gran cantidad de ciudades y localidades de Argentina y del exterior, contribuyó a poder imaginar, pensar, sentir y representar los abortos de diversas maneras y hacer circular socialmente otras sensibilidades con respecto al aborto (Vacarezza, 2015). Así como también a lograr identificaciones emocionales más complejas con y entre las mujeres, al sortear las visiones estáticas y dicotómicas hegemónicas que polarizan la situación entre la maléfica o la santificada mujer, ambas representaciones de género descontextualizadas (Santarelli, 2021). Mientras tanto, feministas dedicadas al mundo del periodismo y de los medios masivos de comunicación lograron introducir el tema en este espacio e irradiarlo en todas las direcciones.

Fue en el marco del debate legislativo y social del 2018, que las acciones de socialización de las propias experiencias de aborto proliferaron enormemente y las narrativas sobre aborto inundaron los canales de expresión. En las redes sociales se multiplicaron los perfiles y hashtags que contenían el "Yo aborté", provocando una marea de voces que ya no podría ser silenciada. Este año se configuró como el momento clave en que las mujeres y otras personas con capacidad de abortar se aventuraron a asumir la palabra con el respaldo colectivo para continuar sacando del espacio abyecto e individual las experiencias de abortos clandestinizadas.

De modo que, las diversas y creativas estrategias feministas fueron ocupando progresivamente y cada vez más los espacios públicos para

afectar el silenciamiento y la estigmatización sobre los abortos, al encontrar modos contra-hegemónicos de decir y decirse.

Los feminismos organizan el acceso seguro a los abortos farmacológicos

A continuación, nos centraremos en el acceso a los abortos farmacológicos clandestinizados y presentaremos brevemente algunas acciones a nivel nacional de la Campaña, de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, de Socorristas en Red –feministas y transfeministas que abortamos– y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

Las líneas de información sobre aborto seguro son estrategias formuladas por colectivas feministas, sobre todo en países latinoamericanos con restricciones legales, que varían en sus metas y asumen distintas formas. Pero todas tienen como objetivo ofrecer información por teléfono sobre aborto farmacológico y, así, reducir el riesgo del aborto inseguro para la salud de las mujeres, a la vez que promover la autonomía y el apoyo a la decisión implicada en los abortos (Drovetta, 2014, 2015).

En Argentina la primera línea telefónica "Más información, menos riesgos" fue inaugurada en 2009 por Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto (de ahora en adelante LyF) y se afianzó en el 2010 junto con la primera edición digital e impresa del manual *Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas*, compilado por esta misma organización. El manual cuenta con un lenguaje sencillo y comprensible que recupera las palabras y experiencias de mujeres que llamaban a la línea. Su circulación fue masiva y exitosa tanto en los Encuentros, como por internet y a través de distintas organizaciones sociales. Para fines de 2011, el libro tenía 500.000 descargas directas desde internet y 10.000 ejemplares en papel distribuidos y en 2012, actualizaron su edición (LyF, 2012).

En el año 2012, activistas de la Campaña de diferentes provincias, y especialmente de La Colectiva neuquina La Revuelta, dieron forma de red al trabajo de acompañamiento y contención cara a cara que venían realizando. Socorristas en Red –feministas y transfeministas que abortamos– es una articulación que nuclea grupos y colectivas de todo el país y que participa activamente de la Campaña. Considerando el período 2014 a 2020, es decir, desde los inicios de sus sistematizaciones

de información sobre sus prácticas hasta la sanción de la Ley Nº 27610, las socorristas habían acompañado a 55.650 mujeres y otras personas con capacidad de abortar (Socorristas en Red, 2021).

En el 2013, año siguiente a la emisión del Fallo F.A.L., las socorristas ampliaron notablemente la difusión de su accionar bajo la premisa del derecho a la información. Acordaron múltiples formas y espacios para hacer más pública su existencia, por ejemplo, en un blog con un instructivo interactivo sobre uso de la medicación para abortar y con las formas de contacto en las distintas provincias, con folletos, afiches e intervenciones en el XXVIII Encuentro realizado en San Juan (Maffeo *et al.*, 2015).

Dos de sus grandes objetivos eran, primero, promover y priorizar el derecho a la información para decidir sobre el propio cuerpo. Y segundo, politizar la experiencia de abortar con medicamentos, de manera autogestionada, autónoma y con acompañamiento feminista. Al mismo tiempo que ofrecían una visión política del aborto como derecho a ser conquistado y vinculado al valor de la propia vida, de la salud y de la capacidad de decisión en el marco de cada proyecto de vida singular, estos discursos y prácticas activistas pretendían promover experiencias de abortos que no quedaran asociadas a la soledad, lo indecible, lo pecaminoso, sino como un verdadero y legítimo acto de ejercicio de soberanía sobre los cuerpos (Socorristas en Red, 2014; Maffeo *et al.*, 2015; Santarelli y Anzorena, 2017).

Más allá de las particularidades de cada contexto, los dispositivos socorristas contaban con lineamientos comunes al momento de brindar información y acompañar: un primer llamado telefónico a líneas que circulaban principalmente por internet o de boca en boca y, posteriormente, un encuentro entre las socorristas y las mujeres en espacios denominados "consejerías" o "talleres". Preferentemente, estos encuentros se hacían en espacios públicos y abiertos, y eran grupales, es decir, que varias mujeres eran convocadas al mismo encuentro, previo a la práctica o después, y podían concurrir con sus acompañantes.

En las consejerías, las mujeres podían evacuar dudas, conocer o completar la información sobre el uso del misoprostol para abortar y contar con un espacio de escucha desprejuiciada y de contención emocional. Las activistas les entregaban folletos con la información más importante. En función de las articulaciones logradas y posibles con algunas/es/os profesionales de la salud, les ofrecían turnos o contactos para acceder a prestaciones profesionales como ecografías, consultas mé-

dicas o consejería en métodos anticonceptivos, luego del aborto. En este espacio de escucha de la situación singular –personal, familiar, relacional, social– de cada mujer, se disponían a ayudarlas a diseñar las mejores estrategias para abortar sin riesgo. Luego ofrecían un seguimiento telefónico de la práctica del aborto y la posibilidad de hacer algún control post aborto, si el contexto y las relaciones con profesionales de salud lo hacían posible junto con la posibilidad de asistir a un encuentro post aborto (Socorristas en Red, 2014; Maffeo *et al.*, 2015).

En 2014 fue surgiendo la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir (en adelante, la Red de Profesionales) que se hizo pública el 28 de mayo de 2015, día de acción por la Salud de las Mujeres, y a 10 años de la conformación de la Campaña de la que cual es parte. Este espacio interdisciplinario y federal incluye, principalmente, a trabajadores/as de salud del ámbito público y se autodefine como un "entramado feminista dentro del sistema de salud que garantiza cuidados" (Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, 2021, s/p). Su conformación estuvo impulsada por la Campaña, por las socorristas y por la iniciativa de profesionales que ya se encontraban en el camino de la garantía de los abortos legales, aunque en soledad institucional (Drovetta, 2018).

En un principio, su objetivo central era garantizar el acceso a las ILE a través de profesionales que se visibilizaban como prestadores/as de este servicio en las instituciones donde trabajan. Organizarse en la Red de Profesionales les permitió obtener el apoyo mutuo para afianzar prácticas al interior de las instituciones que ampliaran el reconocimiento de las diversas circunstancias para acompañar una ILE, sobre todo por la causal "peligro para la salud integral". También les permitió "sacar del closet" sus prácticas de acompañamientos y mostrarse cada vez más disponibles, colaborando con el proceso de desclandestinización y desestigmatización de los abortos, tanto de quienes se los practicaban como de quienes acompañaban como profesionales. Un claro ejemplo fue la campaña en redes sociales "#ContásConNosotrxs" en julio de 2018 y el armado de un recursero de instituciones a donde acudir en cada provincia. A partir del 2018, y como consecuencia del proceso de discusión social y legislativa del proyecto de legalización del aborto de la Campaña, el número de profesionales adherentes a la red aumentó significativamente y en varias provincias, como en San Luis y en Mendoza, fue en ese año que se organizó la misma.

Acompañamientos feministas en San Luis y Mendoza

En San Luis Capital, a mediados del 2013, se conformó el primer grupo que luego devino en socorrista. Dos hechos significativos que impulsaron la integración de este grupo a Socorristas en Red, en 2014, fueron: la asistencia al XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan donde realizaron el contacto con activistas de La Revuelta y, luego, la asistencia a la Tercer Plenaria Nacional de Socorristas en marzo de 2014, en Neuquén. Las redes interprovinciales también se extendieron al interior de la provincia y en 2015 se conformó un grupo socorrista en la ciudad de Villa Mercede[4].

Sus integrantes iniciales éramos principalmente feministas psicólogas y estudiantes de psicología. El hecho de estar vinculadas al ámbito de la salud favoreció el armado de redes con médicos y médicas amigables que trabajaban en centros de atención primaria de salud, en hospitales y en el mismo Programa de Salud Sexual, Reproductiva y no Reproductiva provincial (Santarelli *et al*., 2014). Sosteníamos la articulación mediante reuniones semestrales y participación activa en instancias de capacitación dirigidas a los servicios de salud. Durante gran parte del período que sitúa las experiencias narradas y previo a la conformación de la Red de Profesionales en esta provincia, a través de estas articulaciones se garantizaban ecografías, consultas médicas si las mujeres expresaban esta necesidad y recetas para la colocación de vacunas de inmunoglobulina anti-D, posibilitando que esto se hiciera en los servicios públicos. Contar con estas articulaciones, escasas pero fuertes, brindaba mayor seguridad en las prácticas de acompañamiento.

En 2018, las repercusiones del debate parlamentario sobre la legalización del aborto, del mismo modo que en muchas provincias, fueron fundamentales para la conformación de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir San Luis. La campaña a nivel nacional en redes sociales "#ContásConNosotrxs" fue el disparador para que las/os/es profesionales garantistas de derechos o con intenciones de hacerlo se reconocieran y comprobaran que eran más de los/as/es que

[4] Desde fines de 2013 el grupo de San Luis Capital funcionó bajo los lineamientos de Socorristas en Red hasta que a principios de 2018 se produjo la desvinculación de esta red y la adhesión, por un período breve, a la agrupación feminista de acompañamiento "Fuega". En ese entonces, la conformación grupal se había modificado y el grupo socorrista se llamaba "Las Hidras".

creían. Este reconocimiento entre trabajadores/as llevó a que un grupo comenzara a reunirse y a afianzar las articulaciones entre profesionales, con las socorristas locales y con autoridades gubernamentales con responsabilidades en este tema.

A fines de ese año, el entonces gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá (PJ, 2015 a 2023) adhirió por Decreto 34/2019 a la Resolución 1/2019 del MSAL que aprueba la segunda edición del Protocolo. Esta adhesión impulsó a que más profesionales garantizaran ILE y solicitaran a la Red recursos sobre cómo hacerlo. También implicó, de manera muy progresiva, que la interpretación de la causal salud integral se adecuara a lo que el Protocolo indicaba y los servicios públicos abrieran sus puertas. Aunque con una distancia entre la letra del Protocolo y las prácticas institucionales, principalmente por la falta de formación laica en trabajadores/as del subsistema público y la falta de capacitaciones con perspectiva de género en derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, la escasez de tratamientos de misoprostol, mucho más en zonas alejadas de la Ciudad y una estrategia comunicacional débil desde el Ministerio de Salud provincial para que la comunidad conociera cómo y dónde solicitar una ILE (Integrantes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir San Luis, comunicación personal, 15 de junio de 2019).

En Mendoza, los acompañamientos de abortos farmacológicos comenzaron en el marco de la Campaña, con la elaboración de folletos sobre el uso del misoprostol y la conformación, en 2010, de la Comisión Salud dedicada a dar apoyo local a las acciones que se hacían a través de la Línea de LyF.

A fines de 2011, en una plenaria de la Campaña y en articulación con otras colectivas feministas de diferentes provincias (Neuquén, Córdoba, Mendoza, Rosario, Buenos Aires, CABA) fueron parte de la conformación de la red de Socorristas hasta 2018. Las integrantes de la Comisión Salud decidieron conformarse como una colectiva feminista socorristas y se denominaron La Malona Rosa. La restricción de la venta de misoprostol en Mendoza y la marginación de estas prácticas en los servicios de salud significó un aumento exponencial de la demanda a la colectiva.

Uno de los principales motivos, señalados por las activistas, que las llevó a agruparse fue la necesidad de cuidado y contención entre feministas frente al contexto de criminalización y de persecución por algunos

sectores antiderechos. Estas estrategias de cuidado también se extendían a las mujeres que solicitaban sus acompañamientos para abortar.

En el período que sitúa la mayoría de las experiencias que recogimos, la articulación entre las activistas y profesionales/servicios de salud era dificultosa y prácticamente inexistente. Esto comenzó a modificarse en 2018, con la conformación de la Red de Profesionales en Mendoza que implicó la visibilización de profesionales que garantizaban o buscaban garantizar el derecho a la ILE. Tras varios intentos frustrados de reunirse porque se infiltraban personas anti derechos, la primera reunión de la Red se concretó en un espacio público con una gran convocatoria: alrededor de 50 personas que, en su mayoría, trabajaban en Gran Mendoza o cercanías, de profesiones diversas y pertenecientes al subsistema público y privado.

La presencia de la Red de Profesionales en Mendoza implicó cambios notables, entre los que destacamos, la presencia de otra voz social que desde el ámbito profesional se pronunciara a favor de garantizar el derecho a la ILE y a favor de la legalización de los abortos voluntarios, un mayor acceso a las ILE por causal salud integral y la posibilidad de realizarlas dentro de los servicios de salud. También les permitió a las activistas feministas ofrecer prácticas médicas a las mujeres, gracias a un trabajo arduo y tenso de articulación entre sus acompañamientos y las prácticas de trabajadores/as de la salud (Maure, 2021).

En 2018, la Red de Profesionales exigió la adhesión al Protocolo ILE y las autoridades sanitarias de Mendoza respondieron elaborando su propia Guía técnica para la atención de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo que, si bien no se institucionalizó sistemática y homogéneamente en todos los efectores de salud, permitió contar con algún lineamiento, abrir el debate al interior del sistema sanitario y disminuir los obstáculos para acceder al misoprostol (Maure, 2021).

Además, durante el primer trimestre de 2019 la Obra Social de Empleados Públicos (Osep) mediante la Resolución 191/2019 aprobó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de Nación, inaugurando un circuito específico para que sus afiliadas solicitaran y realizaran la práctica.

Escenarios locales donde se insertan las experiencias

Las particularidades del contexto de San Luis y Mendoza dan cuenta de las complejidades y dificultades para abortar en estos territorios y de lo importante de la presencia de las activistas organizadas.

Las repercusiones del Fallo F.A.L. (CSJN, 2012) quedaron atadas a las arbitrariedades de los gobiernos provinciales. Hasta finales del 2018, prácticamente las mujeres de todas las edades, así como otras personas con capacidad de gestar, se vieron impedidas de acceder a los abortos legales. Las reacciones conservadoras de sectores con poder de decisión en las políticas sanitarias, junto a la falta de reconocimiento e implementación de las sucesivas Guías y Protocolos reforzaron la clandestinización de la gran mayoría de los abortos. Frente a lo cual, las grupalidades feministas pertenecientes a la Campaña fueron fundamentales para favorecer el acceso a los abortos farmacológicos.

En San Luis el Fallo F.A.L. no se acató formalmente ni se crearon instrumentos sanitarios para alojar las demandas de ILE en los servicios de salud, favoreciendo un clima de informalidad por la falta de reconocimiento expreso de las normativas. En su lugar, las socorristas locales comenzaron a acompañar abortos en 2014 y recibieron las "derivaciones" de profesionales de la salud con quienes habían logrado, desde el comienzo de su organización, articulaciones puntuales y sostenidas en el tiempo, aunque carentes de institucionalización. Además, atendían los pedidos de acompañamiento que las mujeres realizaban, cada vez más, a la línea telefónica.

En Mendoza, la respuesta de las autoridades frente al Fallo F.A.L. fue un rotundo "no" y fueron más marcadas las disputas desde los movimientos feministas, con fuerte presencia de la Campaña. También se registraron ofensivas contra reacciones y limitaciones, como la puesta en vigencia efectiva en el 2012 de la Ley Provincial Nº 8116/2009 que restringió el acceso al misoprostol y desigualó notablemente a las mujeres que necesitaban abortar en Mendoza.

En esta provincia, a las activistas les fue difícil identificar y articular con profesionales de la salud, por lo que se dedicaron, en gran parte, a construir y compartir estrategias de cuidado y de autocuidado al momento de acompañar, frente a las persecuciones y boicot contra sus actividades por parte de grupos anti derechos.

El año 2018 marcó el inicio de varias transformaciones en ambas pro-

vincias. En términos generales, mejoraron las condiciones para garantizar ILE por la causal salud integral y se conformaron las Redes de Profesionales provinciales. En San Luis se logró la adhesión por decreto al Protocolo de ILE y en Mendoza se generó una Guía Técnica propia, hubo mayor acceso al misoprostol y, en 2019, la obra social Osep comenzó a implementar su propio Protocolo ILE, en consonancia con el nacional.

Todo lo cual favoreció una acogida más amable, aunque no sin nuevos obstáculos, de la demanda feminista histórica para acceder a los abortos permitidos por ley desde hacía casi un siglo y para que se considerara la causal peligro para la salud desde una noción más multidimensional e integral que contemplara, así, una mayor gama de situaciones.

I. Malestares y significaciones iniciales

Capítulo 5. La tormenta emocional

En este capítulo comenzamos a profundizar en el entramado de malestares y significaciones iniciales de las experiencias. Es decir, al momento de anoticiarse, decidir y comenzar a resolver los embarazos no deseados/abortos voluntarios farmacológicos en determinadas condiciones y circunstancias que dieron lugar a múltiples emocionalidades.

Incredulidad y rechazo frente a la confirmación del embarazo

En estas experiencias, anoticiarse sobre el embarazo fue el momento inaugural donde se pusieron en juego las emocionalidades y las significaciones sobre el proceso que comenzaba. Tomar conocimiento del embarazo las sorprendió, para algunas resultó inicialmente inverosímil y, sobre todo, les generó rechazo.

Previo a que realizaran las pruebas de embarazo, hubo un período en que desestimaron los indicios físicos como las náuseas, esperaban una próxima menstruación que les desdijera lo disruptivo de la situación y se negaban a atribuir algunos cambios que sentían a un embarazo. El shock frente al embarazo fue tal que algunas entrevistadas repitieron las pruebas, sintieron incredulidad frente al positivo o recurrieron a un análisis de sangre con la esperanza de obtener una noticia distinta a la del embarazo en curso. Incluso, luego de realizar las pruebas de orina o sangre, el rechazo se expresó en el intento de buscar alternativas para interpretar el resultado. Por ejemplo, dudar de la eficacia del test o mantener la expectativa de tener "un quiste", lo cual era menos terrible que confirmar un embarazo.

> Tenía un dolor, estaba con constipación, dolores de panza… tenía todos los ¡re-síntomas! de embarazo. Vomitaba en la mañana, me levantaba

mareada. Pero no nunca. Negando la situación a full (...) Los retiro [a los análisis], así, positivo. "¡Ay, no!" dije yo. "¡No!" (Virginia).

No, no, le digo, no, no, no puede pasar. Bueno, tres me hice [test] y los tres me dieron positivo. Yo decía: "no, debe estar mal, me voy a hacer otro", "este también debe estar mal, me voy a hacer otro" y no. Estaba (Violeta).

[cuando vio el test de orina positivo] Esta mierda tiene que estar fallada en algún lugar, la meó alguien antes (Leonor).

(…) dije "¡qué bajón, qué bajón!" [al ver el test de orina positivo]. Después, para asegurarme, que siempre dicen que podés tener un quiste y por eso da positivo el Evatest, de que en realidad sea otra cosa. Digo: "¡Ay, por favor, que sea otra cosa! ¡Ay, por favor!". Después, al otro día me hice el de sangre y me dio re positivo (Clara).

Para representar el malestar y el rechazo que les generó el saberse embarazadas sin esperarlo ni desearlo, Marcela utilizó reiteradamente la palabra "espanto" y Ernestina lo señaló como un "baldazo de agua fría". Ambas mujeres, cercanas a los 40 años, describieron que frente a la estabilidad de su situación familiar y laboral y la falta de deseo de maternar nuevamente, estos embarazos inesperados les representaban un problema y su continuación era inadmisible.

Y entonces, no entra en ese parámetro la idea de empezar de nuevo ni de ser madre, ni, ni, ni de cambiar pañales ni de nada, o sea, no. No había manera. Entonces, enterarme fue espantoso, esta vez (Marcela).

Inesperado y aparte por la edad, por todo. Fue como un baldazo de agua fría y sentir que algo que una no desea, no quiere, no busca, tenés que hacerlo (…) Bajo ningún punto de vista yo tenía deseos de ningún tipo de seguir adelante con un embarazo. (…) Nunca dudé un segundo, para mí fue siempre un problema (Ernestina).

Las mujeres sintieron que estos embarazos eran ajenos a ellas e incompatibles con sus deseos e intereses. Esta extrañeza llevó a que algunas ni siquiera se consideraran embarazadas, mucho menos a significarlo como un posible "hijo". En cambio, lo significaron como una invasión perturbadora de la que necesitaban liberarse: necesitaban dejar de estar

embarazadas. De tal manera que, hasta no resolverlo, se encontraban "en una realidad paralela" y atravesadas por diversos malestares. Se sentían acorraladas y presas, donde el límite del encierro era el propio cuerpo embarazado.

> Para mí era un extraterrestre, ni lo nombraba como un hijo (Bárbara).

> Y yo decía: "yo no tengo un bebé, no puedo". Era terrible. (…) Es que yo no usaba la palabra embarazo, yo realmente no me sentía embarazada (…) yo, la verdad, que sentía que tenía algo extraño en mi cuerpo (Marcela).

> Yo sentí eso: mi cuerpo invadido. Como si fuera otro cuerpo en mi cuerpo. Yo no deseaba eso, para nada. (...) Y toda esa espera, en el tiempo que estaba embarazada, me sentía esclavizada de algo ¿me entendés? Me sentía invadida, esclavizada, molesta (Andrea).

> Sentía una cosa de invasión física que no estaba en condiciones de acuerpar psíquicamente. Me sentía ¡ahhhhhh! Tensa, molesta… (Leonor).

De modo que estos embarazos no eran integrables a sus vidas, ni la maternidad era una opción viable. Por el contrario, continuarlos resultaba inasimilable a nivel psíquico y un atentado contra su integridad personal (Rosenberg, 2010). Camila no encontraba otra situación en su trayectoria de vida que le hubiera producido tanto malestar y desgano como tener que cargar con ese embarazo no deseado.

> Yo sentía adentro mío un cansancio, una angustia (…) quería volver a mi vida porque todas esas semanas sentí como un paréntesis en mi vida, es la verdad. Sentí que no podía ni manejarme, no tenía estado de ánimo, no podía hacer nada, no quería hacer nada del trabajo, no quería juntarme (…) "Nunca en la vida me ha pasado de sentirme así", esas frases que dice la gente cuando sentís el mundo encima, que no te podés levantar (…) tenía que trabajar porque no me quedaba otra, pero mi vida se había paralizado… (Camila).

Camila señaló la parálisis y el paréntesis que sintió en su vida. Por un lado, estuvo la angustia y la desvitalización que le implicó la carga del embarazo no deseado, vivido como una situación de detención de los ritmos propios y de enajenación de la propia vida que aminoraba las

posibilidades de bienestar. Pero, por otro lado, estaba la obligación de tener que continuar con las actividades laborales y cotidianas a pesar del malestar, justamente, para disimularlo. Varias mujeres expresaron el malestar de tener que simular la incomodidad física y emocional de estar embarazadas sin desearlo.

> ¡Era horrible! Era como que yo tenía que estar disimulando esa situación. En ese momento trabajaba también, por ejemplo, un sábado trabajaba 12 horas y lo tenía que aguantar, también. Era un bajón (Nadia).

> ¡Lo difícil que es seguir tu vida como si nada, criando hijos, yendo al trabajo! (…) No es algo que te pase y todos lo saben, entonces tener que aguantar todo ese proceso simulando, es horrible… (Lorela).

De modo que se vieron obligadas a silenciar y ocultar los malestares asociados al embarazo, sin poder expresarlos abiertamente con las personas de sus entornos cercanos. Esto duplicó el malestar, ya que no solo se trataba de la carga de un embarazo no deseado ni esperado, sino también del esfuerzo de tener que disimularlo, todo lo cual hizo que lo recordaran como un momento "horrible" y "difícil".

Motivadas por este rechazo y por sentir que la propia integridad se veía afectada, confirmar los embarazos les generó la negativa inmediata sobre continuarlo. Definieron la decisión como "una cuestión automática" "automáticamente", "desde el minuto uno", "de una", "sobre el positivo", "apenas me dio positivo el test". A partir de ese momento, la pregunta no fue qué hacer frente al embarazo no deseado en curso, sino que la desesperación se centró en cómo dejar de estar embarazada lo antes posible.

> Desde que me enteré pensé: iba a abortar; el tema era cómo (Lorela).

> Apenas me enteré de que estaba embarazada supe que no quería tenerlo y eso era lo que más preocupación me generaba, bueno, ¿cómo voy a hacer para conseguir las pastillas al no ser legales? (Andrea).

> Y del segundo uno fue: "esto yo no, no va a seguir, esto lo voy a cortar cuanto antes". (…) Fue más una sensación de desesperación: "¡Tengo que hacer con esto ahora, YA!, antes que… ¡el tiempo, el tiempo, el tiempo…!" (Úrsula).

> A mí lo que me desesperaba era que como tenía la decisión tan, tan tomada, no poder solucionarlo (Ernestina).

Vemos cómo superada la incredulidad y la sorpresa, fue apareciendo inmediatamente el rechazo frente a embarazos significados como una carga y una invasión que interrumpía sus propias vidas. De allí surgió la necesidad de interrumpir urgentemente lo que fue significado como embarazo-problema: las mujeres no querían estar embarazadas, pero lo estaban. Rosenberg (2020) habla del shock que supone para una mujer un embarazo no esperado, no buscado, no querido o que le fue impuesto donde, en todos los casos, no ha mediado su voluntad. A partir de ese shock, lo que sigue es elaborar una solución entre las dos opciones: seguirlo o interrumpirlo, sin términos medios. La autora argumenta que los discursos sociales restrictivos del aborto han desplazado el shock traumático desde la situación del embarazo a la situación de realización de un aborto como si esta fuera una vivencia trágica. Sin embargo, cuando el embarazo es significado por quien lo porta como una carga y una invasión que hace trastabillar sus proyectos o condiciones de vida existentes, el aborto se presenta como la solución. Lo problemático no es abortar, sino lograr esa interrupción emprendiendo un camino que se significa como lleno de obstáculos.

Incertidumbres y temores frente a un camino lleno de obstáculos

Entre lo inesperado y la necesidad de resolver los embarazos-problema, se ubica la urgencia de actuar "cuanto antes". Las entrevistadas significaron que lograr un aborto sería un camino lleno de obstáculos que deberían enfrentar o sortear y esto las contactó con diversas incertidumbres y temores.

A continuación, nos centramos en tres de estos obstáculos y las incertidumbres y temores que despertaron. El primero, dónde y cómo conseguir la información para usar adecuadamente el misoprostol y las pastillas. El segundo, si efectivamente podrían lograr el aborto usándolas y qué sucedería si no lograban abortar. El tercero estuvo centrado en si podrían abortar sin ser "descubiertas" por otras personas, al significar que el aborto era una experiencia (auto) reprochable y sancionable.

El primer obstáculo fue acceder a los recursos necesarios: las pastillas y la información/orientación para su uso correcto y seguro. Algunas mu-

jeres que consideraban que la figura médica era la adecuada para brindar esa información experimentaron lo dramático de no contar con profesionales o servicios de salud que las proveyeran de una explicación para abortar con pastillas.

> Fue traumático en ese sentido, de algo inesperado y, además, de yo no saber que existían las socorristas… Y buscando alternativas por todos lados para no tenerlo, para no seguir con el embarazo (...) a los hospitales, a muchos lados fuimos (…) conocíamos las pastillas, pero no el método ni cómo se usaban. Era la imposibilidad de tener un médico a quien preguntarle. Información, falta de información, de no tener a quien preguntarle cómo usar esas pastillas (Karina).

> Y bueno, tenía miedo porque no conseguía, o sea, iba a los hospitales y te decían que no, que no sabían de nadie. Entonces, pensé que no iba a conseguir, digamos (Anahí).

Estos dos fragmentos de las entrevistas con mujeres que abortaron en San Luis en 2015 y 2017, respectivamente, muestran la desesperación ante la falta de respuestas cuando se acercaron a un hospital y la consiguiente incertidumbre: ¿a quién recurrir?, ¿cómo conseguir información confiable? Los servicios de salud no se hicieron eco de la situación que estaban planteando ni propusieron una respuesta dentro de los marcos legales existentes, ni sugirieron alguna alternativa.

Para las mujeres que abortaron en Mendoza, ni siquiera fue una posibilidad recurrir a un servicio público de salud para encontrar la información. Los evitaron a toda costa e imaginaron que algo muy malo podría pasarles si acudían, lo cual fue una expresión del clima persecutorio en esa provincia. Vera, quien contaba con información provista por grupos feministas y que había acompañado previamente otros abortos, consideró necesario hacerse una ecografía para obtener mayor información sobre el embarazo. Utilizó el término "fantasmas" para expresar sus incertidumbres y angustias respecto a tener que asistir a un servicio público a realizarla.

> Y de repente dudaba de todo: ¿y cómo pido el turno para la ecografía?, ¿y qué digo?, ¿y cómo hago cuando voy? Me aparecieron un montón de fantasmas (…) tienen que ver con la persecución que sufrimos las mujeres y me acuerdo que fue super angustiante ya la etapa de la ecografía (Vera).

Es decir que frente a las incertidumbres sobre cómo abortar y cómo conseguir información confiable, se presentó la necesidad de buscar ayuda externa. Por una parte, quienes la buscaron en los servicios públicos de salud no la encontraron, a diferencia de otras situaciones que atañen a la salud y a su atención. Por el contrario, lo que primó en los relatos sobre las interacciones con los servicios de salud fue el desentendimiento de la situación y la falta de sostén desde las instituciones. Otras mujeres evitaron interactuar con profesionales de servicios de salud porque se sentían perseguidas y temían el maltrato.

Por otra parte, nos encontramos con relatos de mujeres que, en el intento de superar el obstáculo de la desinformación, consultaron con profesionales de servicios privados. Pero en estas consultas recibieron humillaciones, comentarios reprobatorios, infantilizaciones, ridiculizaciones e indiferencia. Emilia relató lo que sucedió en la consulta con una ginecóloga que le recomendó una amiga de la siguiente manera:

> Una lección moral, de que iba a llamar a un juez de paz, que ella me podía meter en cana, "¿a vos te parece que yo aborto?", "¡Yo no te estoy diciendo que me hagas un aborto, yo te estoy pidiendo que me des información sobre qué provoca el misoprostol, a nivel médico!". "No –me dice– yo no tengo por qué darte eso, yo soy católica". (…) Yo ya estaba llorando (…) o sea, fue lo más heavy de todo el proceso (…) Me decía: "yo te veo en el hospital y llamo al juez". Eran amenazas. Era decir: "loco, si voy al hospital…" (Emilia).

> Me acuerdo un viejo que me dijo: "y si no querías ¿por qué te quedaste embarazada? ¿Sos tonta?". Me lo dijo así. (…) La consulta fue más de culpabilización que de otra cosa. (...) Fuimos a otro, no sé si me trató de asesina o de "te vas a morir en el intento" (Úrsula).

En el relato de Emilia vemos que la médica quedó ubicada como un agente moralizador y criminalizador, más cercana al sistema penal que a atender la consulta de salud. Úrsula fue objeto de ataques culpabilizadores y disciplinadores por uno de los tantos médicos del ámbito privado que consultó para obtener información. Al encontrarse con estas prácticas discursivas, lo que las mujeres planeaban como una estrategia de autocuidado para lograr el aborto y disminuir los riesgos, se convirtió en una situación de persecución que alimentó la desesperación. Estas interacciones fueron señaladas como "lo más traumático de la experien-

cia", "una experiencia espantosa", "momento horrible", "lo más heavy de todo el proceso". Úrsula fue rotunda al respecto: "Saco en limpio que la experiencia en sí misma no conlleva sufrimiento alguno más que el circuito de la salud, entrar en ese circuito".

La culpabilización o los intentos de desalentarlas no generaron tales efectos, ninguna modificó su decisión de interrumpir el embarazo ni asumió esas culpabilizaciones. Insistieron en sus búsquedas, de acuerdo con la decisión tomada para ese momento vital. Aunque estas intervenciones disciplinadoras sí tuvieron un impacto emocional nocivo ya que intensificaron el temor a ser denunciadas y encarceladas, y las incertidumbres respecto a poder enfrentar adecuadamente las posibles complicaciones físicas durante el aborto. Y con ello, alimentaron la significación de que abortar era una práctica de riesgo.

> Esa mina sí [le afectó emocionalmente]. Pero creo que fue más por el ataque, o sea, no es que me hizo dudar. (…) te generaba miedo. Era el miedo, permanentemente. Y obviamente si no estuviera eso legal creo que no sería tan violento. Para mí lo más traumático fue esa doctora (Emilia).

> No me movían el eje en la decisión, no me hizo dudar el hecho de que me trataran de tonta, o de asesina, o de suicida. Esto de "te vas a morir", ¿no? No, no, creo que tenía la decisión tomada y había que buscar la forma de cómo hacerlo, nada más… algún médico tenía que haber. Era encontrarlo (Úrsula).

Marcela tampoco desistió en la búsqueda de información sobre cómo abortar, pero las interacciones con los médicos del ámbito privado tuvieron un impacto subjetivo altamente negativo porque aumentaron su sentimiento de ser humillada y de estar expuesta. Uno de ellos la atendió en la vereda, detrás de la ventana de rejas para negarse a darle orientación y recordó esta escena con pesar en la entrevista:

> Hasta no hace mucho tiempo yo pasaba por la vereda de [apellido del médico] y era todo un tema mirar esa ventana y decir: "¡la puta madre, qué humillante esto, donde el tipo por poco me atiende así!". Y era un desafío pasar viva por ahí. Y también era un desafío pasar por ahí y no sentir nada. Que no tenga que sentir esa bronca... que pueda hacer alguna otra cuestión con eso (Marcela).

Elaborar y dejar de sentirse afectada por la sensación de riesgo y de enojo por haber sido humillada injustamente era el desafío que aún tenía pendiente de resolver al momento de la entrevista, a dos años de su experiencia de embarazo no deseado/aborto voluntario.

Estas interacciones emprendidas en la búsqueda por superar el obstáculo de la falta de información nos muestran los malestares por la actuación de la estigmatización y de la criminalización. Nos permiten dimensionar las experiencias emocionales en función del impacto nocivo del ejercicio del poder disciplinador médico que desconoce principios éticos profesionales, como la garantía de secreto profesional y los derechos del/a/e paciente, contemplados en la Ley Nacional Nº 26529/2009. Cuando ellas demandaron apoyo a profesionales de la salud para obtener información, lo que encontraron fueron discursos disciplinadores y moralizantes sobre la sexualidad femenina y las decisiones no reproductivas que no respondieron a sus demandas. Estas configuraron instancias violentas de actuación del poder criminalizador que las dejaron expuestas a mayores sufrimientos y temores, que no las ayudaron a superar el obstáculo de la desinformación, precarizando aún más sus experiencias.

Y no solo en las interacciones interpersonales de este tipo, sino también en el imaginario de las mujeres el sistema de salud y el sistema penal se asemejaron, lo cual hizo que muchas lo evitaran para cuidarse de la amenaza que representaba, limitándose así el derecho al acceso a la salud.

Otro obstáculo vinculado al acceso a los recursos fue cómo y dónde conseguir las pastillas de misoprostol.

Marcela emprendió la búsqueda por farmacias de San Luis tras contactar a un médico que le dijo que le induciría el aborto usando misoprostol y luego le haría y le cobraría un legrado. El médico no la orientó en la búsqueda de las pastillas, por lo cual ella tuvo que recorrer varias farmacias y exponerse, llegando a la conclusión que "comprar marihuana era más fácil".

Para comprar el medicamento en la farmacia necesitaron armar estrategias, como conseguir recetas con nombre de varón para despejar sospechas del personal farmacéutico de un posible uso abortivo[1] y, aun así, esto no les aseguraba que las conseguirían. Solo en cuatro ocasiones lograron

[1] Cuando el misoprostol viene acompañado de una dosis de diclofenac en cada comprimido, es frecuente su uso como protector de la mucosa gástrica frente al consumo sostenido de analgésicos.

acceder a la medicación en farmacias de San Luis o por contactos en Córdoba. En cuanto a las entrevistadas que abortaron en Mendoza, la compra en farmacias estuvo impedida por la Ley Provincial Nº 8116/2009. Dos entrevistadas viajaron a San Luis y a Buenos Aires para comprarlas en farmacias, lo cual encareció la práctica por los gastos del traslado.

Algunas mujeres las compraron por internet. Kristina recordó el momento en que fue a buscarlas al centro de envíos y abrió el paquete en el baño del lugar. Fue "el momento más horrible" donde se sintió "como una delincuente". A la vez que sintió mucha desconfianza por no saber si efectivamente le estaban enviando lo que necesitaba porque conocía "chicas que habían sido estafadas".

Eva buscó en páginas de internet sin ninguna recomendación y encontró precios elevados, que le eran imposibles de acceder. Al sentirse "acorralada" y "atrapada" ideó un plan con su hermana que vivía en un país vecino:

> Es que 12.000 pesos en esa época era mucho, yo ganaba 9.000 pesos. "¡¡Qué voy a hacer!?". (…) Al verme así atrapada, hablé con mi hermana (...) Y una solución que habíamos buscado es que ella me podía conseguir la receta y las pastillas allá y ¿cómo las pasábamos?, ¿cómo venían? ¡Mirá lo que pensamos!: mi mamá iba a venir para mi cumpleaños, ¡mirá lo que pensamos! "Te puedo enviar algo y se lo doy a mi mamá y que ella te lo lleve, pero ella no va a saber que está". "Sí, ¿y si se lo encuentran en la frontera?". En la frontera aquí en Argentina a los bolivianos nos tratan muy mal, muy mal. Entonces, no, no, era muy arriesgado, ¡no pensábamos en nada! (Eva).

La desesperación la había llevado a pensar que este plan era posible, aunque al momento de la entrevista lo entendía como sumamente peligroso para su madre. En parte, debido al riesgo al que la hubiera expuesto por pasar la medicación sin declarar por la frontera –y sin que ella supiera– y, en parte, por ser consciente de los posibles maltratos y discriminaciones.

Al igual que Eva expresó ese sentimiento de estar "atrapada" en la desesperación, otras mujeres que tuvieron que confiar en personas desconocidas refirieron "estar entregada", "confiar a ojos cerrados, no me quedaba otra", "era eso o la nada". A pesar de las dificultades, los pasos en falso y los temores, continuaron transitando ese camino y se mantuvieron activas en la búsqueda.

También registramos dos experiencias excepcionales donde la medicación fue entregada por el personal de salud que interpretó la situación como una ILE por causal peligro para la salud, a fines de 2018 y principio de 2019.

Gran parte de las entrevistadas no contaron expresamente cómo accedieron finalmente a la medicación. Es interesante el hecho de que hayan contado que se realizaron un aborto, pero no den detalles del modo en que consiguieron las pastillas. Si bien las dos prácticas eran ilegales, es en el hecho de decir cómo consiguieron las pastillas que perciben un riesgo, que probablemente no tiene que ver con ellas mismas sino con exponer a otras personas que las ayudaron a superar este obstáculo.

El segundo gran obstáculo que las mujeres proyectaron en el camino para abortar estuvo vinculado a las incertidumbres sobre el efecto abortivo de las pastillas, es decir, si podrían realizar y completar el aborto usándolas. Lo observamos, sobre todo, en mujeres que no habían tenido contacto directo con experiencias previas de otras mujeres que usaron misoprostol.

Pensar en tener que continuar el embarazo en contra de su voluntad, porque las pastillas no funcionaran o porque no consiguieran la cantidad necesaria, fue significado como algo semejante a una tortura y hasta destructivo psicológicamente. Ernestina es contundente sobre lo destructivo a nivel psicológico que le sería llevar adelante forzosamente ese embarazo:

> (…) porque pasar por todo ese proceso sin desearlo, ahí la psiquis la hacés mierda. Si yo estuve un mes, que la ansiedad me carcomía, imaginate después, tener que… no, no, no, es impensado [se agarra la cabeza]. Yo decía: "no, no, de ninguna manera, no hay derecho, a mí no me puede estar pasando esto, no, no" (Ernestina).

Tal como se preguntan Chaneton y Vacarezza (2011) ¿es posible pensar la situación de tener que disponer de los propios recursos de su organismo y de su psiquis para hacer viable un nuevo ser por obligación, sin recurrir a nociones como sometimiento o atentado contra la integridad personal? Las mujeres asociaron esa situación con "una bomba", "lo impensado", "trágico", "espantoso", "lo traumático de tener un hijo" en estas circunstancias.

> No podía ni pensar… pero no por el hecho de la traumático de hacerme un aborto sino de tener un hijo. La posta, yo no quería para

> nada tener un hijo (…) Estaba muy mal con el tema de estar embarazada. No quería saber nada (Emilia).

Con estas palabras compartieron los malestares sentidos cuando aún no se aseguraban de que lograrían realizarse el aborto farmacológico.

La desesperación se hizo más evidente en aquellas situaciones en que habían usado la medicación, pero continuaban embarazadas, tal como relataron Marcela y Camila. Ambas se contactaron con lo dramático y trágico de continuar un tiempo más con el embarazo no deseado y experimentaron vivencias agónicas.

> [Tras el primer intento] Yo literalmente en el momento en que ella [la ecografista] me dijo que estaba ahí, [el embarazo] volví a morir, me morí en vida de nuevo. (…) No podía creerlo, yo decía "no puede ser, ¡qué mierda la vida!, ¡necesito que esto termine, nada más, yo quiero que esto termine, yo necesito que esto termine!". (…) me quedaba acostada pensando en lo que me pasaba y me quería literalmente suicidar… ¡No, no, no! Pero siempre estuve super segura que no, que no, que no, no había posibilidad, no se me cruzaba ninguna opción de que sí. Había una sola opción (Camila).

Aún a sabiendas que contaba con apoyo institucional por tratarse de una ILE y que tendría acceso nuevamente a las pastillas, el aumento del tiempo en que estuvo embarazada sin desearlo fue vivido por Camila como una instancia aplastante y desesperante que le imposibilitaba estar bien.

La vivencia emocional de Marcela es similar, aunque a ella se le sumaron los obstáculos propios de la clandestinización en todos sus aspectos. Tras un intento fallido de aborto aumentó el sentimiento de desamparo y desesperación. Para ella, continuar embarazada era estar "en una realidad paralela" y le generaba mucho malestar tener que disimularlo. Se sentía desmejorada, como una "enferma de cáncer" y su sentir interno era insoportable y agónico.

> Fue espantoso. Yo veía que no había resultados de nada. (…) [frente a la indicación de hacer reposo para no "perder" el embarazo] vivía haciendo abdominales, subía y bajaba las escaleras de mi casa, no paraba nunca, no comía, era una cosa espantosa (Marcela).

Relató que intentó abortar con misoprostol durante cuatro semanas

siguiendo indicaciones médicas incorrectas, este mismo médico la dejó "al borde de caer" al decirle que "termine con esas boludeces" y que "tuviera al chico". Luego fue rechazada y maltratada por otros médicos a quienes consultó desesperadamente.

Nuevamente vemos el obstáculo de no tener a quien recurrir, que a Marcela le implicó un peregrinaje por consultorios médicos privados y una exposición maximizada a diversas violencias: ser objeto de juicios morales (fue llamada asesina), de tratos humillantes, de dilaciones temporales, sobreexposición a opiniones médicas y ecografías, ofertas de abortos quirúrgicos sin anestesia o inseguros (con una sonda), sin respetar criterios médicos mínimos. Tras estas interacciones médicas violentas y la soledad en la búsqueda de circuitos más amigables, el uso fallido de las pastillas le impuso la idea de que abortar con ese método era imposible y esto le generó un desesperante sentimiento de falta de control sobre el propio cuerpo y de incertidumbre sobre el propio futuro. Con su relato dio cuenta de una experiencia límite, en la que los múltiples obstáculos y violencias le hicieron fantasear con su muerte como una forma de ponerle fin al sufrimiento.

> Me acuerdo que yo insistía mucho con esto: "todos estos médicos me han dicho tal cosa, yo me voy a terminar matando. La verdad que no funcionó el tema de las pastillas". (…) Había días en que me dormía y decía "ojalá mañana amanezca muerta o tenga una hemorragia espantosa y no sé". Era todo terrible lo que me imaginaba, o sea, ahora me suena exagerado, pero en ese momento era terrible (...) fue como estar entre la espada y la pared, para mí ya no había solución posible, entonces empecé a fantasear con la idea de la muerte. (...) O sea... decir que estaba al borde de caer y que esa caída fuera al vacío y fuera la muerte no es exageración, yo creo que es la descripción de lo que pasaba en ese momento (Marcela).

Sin embargo, el malestar psíquico comenzó a transformarse cuando logró agenciar otros acompañamientos que le demostraban que sí iba a poder abortar de manera segura con esas pastillas. Lo mismo le ocurrió a Camila y al asegurarse que ya no estaba embarazada recuperó el bienestar afectado por el embarazo "[luego del segundo uso de las pastillas] me hice la ecografía de control y me salió que ya no había nada. ¡¡Volví a mi vida normal, nena!!".

Así como los malestares se incrementaron cuando la práctica del

aborto no resultó exitosa, estos cesaron y dejaron lugar al alivio cuando lograron abortar y mantenerse a salvo de las distintas amenazas y riesgos. Todas las entrevistadas manifestaron sentir ese alivio, lo expresaron en términos vitales, por ejemplo, una sensación de que "volvió el alma al cuerpo" o "mi vida volvió (…) y volví a mi vida". Entendemos este alivio como la contracara del malestar.

Vemos que, si el embarazo no deseado es significado por las mujeres como una suspensión de la propia vida, una invasión y una carga, continuar forzadamente esos embarazos era similar a una tortura y su interrupción fue el medio más adecuado para culminar con los sufrimientos. Una vez que las mujeres accedieron a los recursos necesarios para concretar el aborto y "volver a sus vidas", muchos de los malestares cedieron inmediatamente. Como señala Dosso (2017) el reconocimiento del sufrimiento psíquico a causa de un embarazo no deseado no equivale a patologizar a las mujeres ni a sus decisiones. Muchos de estos sufrimientos se ligan a la falta de perspectiva de encontrar respuestas sanitarias y resultan expresiones saludables de quien se encuentra atravesando esos malestares. Por lo tanto, cuando se encuentra una salida o solución con el aborto, el sufrimiento psíquico cesa.

Además del temor a no poder abortar con las pastillas, otro temor frecuente fue que las pastillas les generaran abortos incompletos y, entonces, tener que ir a un servicio de salud donde podrían ser "descubiertas". Esto nos remite al tercer gran obstáculo proyectado: cómo abortar sin ser "descubiertas", para no sufrir consecuencias como las reprobaciones, sanciones o denuncias.

Respecto al personal de salud, imaginaban que podrían ser maltratadas o denunciadas e ir a prisión. De modo que, frente a la posibilidad de un aborto incompleto, para muchas el peor panorama era asistir a un hospital. El conocimiento de denuncias por parte del personal de salud o de intervenciones humillantes, aún sin haberlas sufrido directamente, contribuyó a que en el imaginario de las mujeres la función del sistema de salud fuera castigarlas o incluso, ser la puerta de entrada al sistema penal.

> Tuve miedo hasta el último momento porque empezaba a imaginar cosas, como que se complicara, tener que caer a un hospital, qué decir, empezás a imaginarte las peores cosas. Lo más traumático es lo ilegal, lo clandestino, el miedo a morirte, a que te metan presa, a que te traten mal, llegar al hospital sabiendo que no te vas a morir pero que te van a humillar, esa era la sensación (Violeta).

> El primero que te juzga es el médico y esas situaciones de enfrentarse a esa autoridad que realmente tiene el poder de meterte presa (…) [miedo] a que se dieran cuenta, a que me procesaran (…) es horrible lo que voy a decir: prefería morirme abortando a que me metan en cana por abortar (Amy).

También las mujeres proyectaron como un obstáculo que las atemorizaba, el ser descubiertas por personas de sus círculos sociales cotidianos –familiares o de trabajo– y tener que experimentar la reprobación, o la interferencia y que las obligaran a continuar ese embarazo, por ejemplo, si las denunciaban. Marcela se refirió a la "paranoia" de ser denunciada por sus compañeras de trabajo que tenían creencias religiosas fuertemente arraigadas. Anahí se refirió al aumento de la urgencia por abortar antes de que el varón con el que salía o la familia de él se enteraran del embarazo y la obligaran a continuarlo. Virginia expresó el malestar por tener que ocultar la situación a su madre, con quien convivía, y no poder recurrir a ella por temor a su reprobación e, incluso, una posible denuncia.

> Tenía en ese momento compañeras sumamente religiosas, algunas del Opus Dei y otras de estas religiones que son evangélicas. Entonces, había una cuestión de cierta paranoia. Yo decía: "si algo se me nota adelante de esta gente, ¡me hacen una denuncia y me internan, para asegurarse de que esto va a seguir!" (Marcela).

> No poder contarle a mi vieja, tener que hacerlo en mi casa así (…) Ser tan cercanas y tan lejanas a la vez. Yo estoy pasando por una situación que vos no tenés ni idea y no te puedo pedir ni ayuda ni soporte porque no sé, me vas a mandar directo a… ¡me vas a denunciar vos! (Virginia).

> Estaba super nerviosa, es como que no llegaba más el momento y tenía miedo de que me descubrieran (…) Iba a tener un lío tremendo con la familia de él si se enteraban. No iban a querer… porque han pasado casos de que te denuncian… (Anahí).

De modo que pensar que podían ser descubiertas les generó un sentimiento de persecución y las hizo implementar estrategias para ocultar y disimular los síntomas físicos del embarazo y el estado de shock frente al mismo, que señalábamos anteriormente. También les quitó la posi-

bilidad de contar con la ayuda de algunas personas que sentían "tan cercanas y lejanas a la vez". Significar los embarazos no deseados/abortos voluntarios como experiencias susceptibles de recibir reprobación, reproches y sanciones legales y/o morales configuró otro malestar que vinculamos a los procesos implicados en la clandestinización.

Considerar las significaciones iniciales nos permite comprender la magnitud de los malestares asociados a los embarazos no deseados y al camino tortuoso para concretar la voluntad de abortar. La desesperación se hizo evidente cuando la decisión de abortar estaba tomada, pero proyectaron o experimentaron diversos obstáculos para llevarla adelante. Esto les generó diversas incertidumbres y temores, al atravesar una experiencia marginada de los servicios de salud, susceptible de ser estigmatizada y de ser penalizada. Proyectar o encontrarse con los diversos obstáculos que analizamos anteriormente, las hizo significar que el aborto era una práctica de riesgo –un riesgo que asumieron– y una experiencia que, en principio, era susceptible de ser reprobada y sancionada.

Autorreproches y vergüenza: el embarazo no deseado como evidencia

Algunas de las entrevistadas refirieron haber experimentado vergüenza, autorreproches y culpas por los embarazos, y la necesidad de ocultarlos ante otras personas, sobre todo porque los significaron como la evidencia del ejercicio de su sexualidad de una forma descuidada o reprobable.

Lo que se autorreprocharon, entonces, fue no haberse "cuidado bien". Fabiana, que tenía 37 años, se recriminaba por la ocurrencia del embarazo que entendía como una falla propia en el uso de medidas anticonceptivas, cuando pensaba que tenía "todo bajo control". Camila y Ernestina, también se hicieron reproches, se culpabilizaron y se desvalorizaron por haber quedado embarazadas. En este sentido, el embarazo las interpeló y les generó frustración y dolor emocional, a la vez que les hizo cuestionarse sobre la capacidad de controlar completamente lo que ocurría en su cuerpo. Otras mujeres expresaron vergüenzas y culpas por haber atravesado más de un embarazo no deseado/aborto voluntario.

> Desesperadísima, no podía parar de llorar y de culparme a mí misma y decir: "¿cómo me va a pasar esto a mí? ¿Cómo me va a pasar esto? ¿A mí? Si tengo todo bajo control, ¡si hago todo bien! Si conozco todo,

todos los métodos, todo lo esto, todo lo aquello, ¡yo!, ¿cómo yo? yo, yo estúpida, estúpida". Así. Era un tormento y lloraba, lloraba, en una desesperación insoportable (Fabiana).

Yo lloraba, lloraba, me puteaba a mí misma "¿Cómo puedo ser tan c…., tan c…?" (…) "¡¿Cómo me va a pasar esto?!, ¡¿cómo?!" (Camila).

Sí, además uno se siente medio chota. (…) como a mí, boluda grandota que toda la vida, desde los 15 años utilizo métodos anticonceptivos… y que me venga a pasar esto a los 41 años… (Ernestina).

Con la segunda me sentí muy tonta, porque no pensé que me iba a pasar de nuevo (…) en el sentido de sentirme tonta, no aprender de la experiencia. Se me bajó mucho la autoestima (Amy).

Es así que estos embarazos fueron significados como la muestra de una falla que las hizo menospreciarse e insultarse. Algunas lo vivieron como una falta de capacidad para "aprender de la experiencia" o una falta de capacidad para usar el control sobre el cuerpo o las herramientas de cuidado anticonceptivo que sentían tener. Más allá de las circunstancias específicas de cada una que dieron lugar al embarazo, Rosenberg (2010) relaciona lo traumático que pueden ser estos embarazos involuntarios en la actualidad debido a que nos encontramos en un momento histórico en que "la anticoncepción eficaz forma parte desde hace más de medio siglo, no solo de los recursos, sino también del superyo femenino" (Rosenberg, 2010: 8).

Vera y Amy sentían tanta culpa y vergüenza por estar embarazadas que temían ser juzgadas por sus amigas y esto las llevó a silenciar la situación ante ellas. Se trataba de amigas feministas que ya habían acompañado un embarazo no deseado/aborto voluntario de Amy, o que junto a Vera habían acompañado abortos de otras amigas o mujeres conocidas:

[respecto al tercer aborto] nadie lo sabe (…) O sea, ni mis amigas. Porque la gente te juzga: "¡otra vez te pasó!" (…) piensan que podría haberlo evitado (Amy).

Él nunca se cuidaba, yo antes tomaba pastillas anticonceptivas. Siempre era un tema el uso del preservativo (…) Creo que también como me atravesaba cuestiones con mi ex, contarlo me implicaba contar también cuestiones con mi ex que no tenía ganas de compartir. Tam-

> bién el prejuicio: "bueno, no se cuida, no te cuidaste". Esa carga de "una como feminista…" (…) no tanto por el hecho de abortar sino por: "¿cómo vas a llegar a estar embarazada si no querías?". Igual, rollo mío, no sé, yo lo sentí así y me acuerdo que no lo compartí mucho (Vera).

Los reproches que Amy imaginaba recibir por parte de sus amigas se vinculaban a una reiteración en la falta de cuidado anticonceptivo que, a su entender, había producido un tercer embarazo "evitable". En cambio, para Vera, quien era feminista y sus amigas también, el contar que estaba embarazada le generaba el malestar de tener que socializar los modos de vincularse con su pareja y poner en evidencia una relación de poder asimétrica en donde ella no pudo negociar el uso del preservativo. En el hecho de fallar a un "deber ser" feminista parecía radicar el malestar consigo misma y el avergonzamiento que le impidió buscar ayuda en sus amigas: "una como feminista" tendría que poder negociar completamente todo en la relación con el varón y "una como feminista" debería tener el control total de sus procesos reproductivos y (no) reproductivos. En ambas, el autorreproche y el reproche imaginado estuvo centrado en el modo en que ejercieron su sexualidad que devino en un embarazo, no así en el aborto posterior. El sentimiento de vergüenza por el embarazo y el consiguiente silenciamiento les impidió buscar apoyo en sus amigas.

En mujeres cercanas a los 40 años, como Ernestina, Marcela, Lorela y Fabiana, los autorreproches se incrementaron por la edad. Es decir, que la frustración no solo fue por "quedar embarazada", sino por "que me venga a pasar esto a los 41 años", como decía Ernestina, edad en la que sentían que debían contar con saberes para prevenirlo y controlar eficazmente la propia fecundidad. "Yo creo que ahí radica la culpa de todas las mujeres: «el error que cometí en quedarme embarazada»" (Fabiana).

En estos relatos, la proyección de la condena se ubicó en que los embarazos las dejaban en evidencia. Además de evidenciar lo que entendían como un descuido o la incapacidad de negociación, apareció la vergüenza de que las personas de sus entornos familiares supieran que tenían una vida sexual activa. Esta necesidad de ocultar los embarazos para no develar la vida sexual la encontramos en los relatos de Lorela, Fabiana y Marcela, quienes tenían en común, además de que los embarazos ocurrieron cercanos a sus 40 años, que se encontraban maternando adolescentes y que no tenían pareja conocida por sus familiares.

Al respecto, Lorela expresó la dimensión de este peso sociosubjetivo en su voluntad –multideterminada– de no continuar ni socializar ese embarazo:

> No me imaginaba cómo decirle a mi hija que tenía un embarazo y de quién. No podía soportar esa situación. (…) me estresaba muchísimo pensarlo: "si lo tengo, ¿cómo le explico a ella y cómo lo explico en general?". También hay un tema de la culpa sobre por qué te quedás embarazada y de quién, o sea, en el fondo está todo el tema de la culpabilización por el sexo de la mujer, por qué no te cuidás y con quién andás. Por un lado, está mi decisión de que no quiero criar a nadie más sola, pero también toda esa otra parte a la que yo dije "no me puedo enfrentar", o sea "estás embarazada, ¿estás en pareja? No". Y el peso social que eso tiene… pienso en mi papá, no sé (…) como que no me animaba a tener que enfrentar eso, esa mirada acerca de que estoy teniendo sexo… porque no tengo parejas estables que conozca mi familia [lagrimea] (Lorela).

Fabiana, durante la entrevista, reflexionó en voz alta sobre los motivos que sostenía para no contarles a sus hijas/os adolescentes sobre su aborto, siendo que mantenían un diálogo fluido sobre la sexualidad de ellas/os y sobre temas vinculados al aborto. Incluso, al momento de la entrevista, la apoyaban en su militancia feminista que consistía en acompañar abortos de otras mujeres, pero no estaban al tanto de su embarazo no deseado/aborto voluntario:

> … porque ¿por qué no contarles? Yo creo que sí, que son por estructuras mías, por convenciones que todavía tengo tabuladitas ahí y de a poco se van cayendo. Me parece que tiene que ver con eso, ser juzgada por tus hijos, no por el aborto en sí sino por la situación de haber estado con un hombre y no cuidarme (…) creo que más que nada, me estoy cubriendo yo de no ser juzgada por esa situación (Fabiana).

Entonces, el autorreproche se dirigió hacia la propia sexualidad en dos aspectos: por haber tenido sexo y por cómo lo hicieron, con un desconocido para sus hijos/as y de forma "descuidada". Al significar el embarazo como la evidencia de un error, Fabiana se sintió avergonzada y susceptible de ser juzgada, tanto como se juzgó ella misma, y en ese sentir encontró la respuesta a la pregunta reflexiva sobre ¿por qué no contarles? Siguiendo su reflexión, es interesante señalar que estas "convenciones"

que ella ubica como estructuras propias, pueden ser el resultado de la interiorización y la asunción de un avergonzamiento normativo que la sujeta (Ahmed, 2015) y que genera malestar.

De modo que los malestares que encontramos en estos relatos se vincularon a mandatos sociales sobre cómo deben ejercer la sexualidad y cuáles son los marcos legítimos que ellas sintieron haber transgredido por haber tenido relaciones sexuales con parejas no estables o no conocidas por sus entornos familiares. Para ellas, la continuación del embarazo les implicaba revelar esta forma de ejercer su sexualidad y esto les generaba un alto nivel de incomodidad y angustia que cedió tras la interrupción de dichos embarazos. Frente a esta sexualidad/embarazo vivido como la evidencia de un error, encontraron en el aborto una "solución" y una "liberación", una forma de resolver la tensión entre lo que hicieron y lo que no querían dar a conocer.

> [luego de abortar] pude liberarme de esa culpa porque no era la culpa de hacerme el aborto, jamás tuve culpa de hacerme el aborto sino era la culpa de haberme quedado embarazada (…) Y de última, bueno, hay solución. Hay solución: está el aborto (Fabiana).

El aborto les permitió deshacerse de esta evidencia frente a sus hijos/as o padres y madres. Entendemos, en el sentido que señala Rostagnol (2016) que la vergüenza asociada a la sexualidad/embarazo no deseado, en determinadas condiciones, responde al statu quo de las relaciones de género. Abortar permite continuar ocultando las prácticas sexuales deslegitimadas por los mandatos de género dominantes que las entrevistadas asumieron como propios. En este sentido, la vergüenza y los mandatos sexuales morales sobre la feminidad van de la mano y actúan en la configuración de significaciones iniciales sobre los embarazos no deseados/abortos voluntarios.

Decidir con culpas. La actuación de los mandatos religiosos

En el orden de las emocionalidades y significaciones al atravesar estas experiencias intervinieron las creencias religiosas, sobre todo para las entrevistadas que eran creyentes o practicantes de religiones al momento de abortar, como Guadalupe, Eva y Marisa. Su religiosidad les generó vivencias conflictivas por la incompatibilidad sentida entre la

decisión/acción de abortar que sostenían y estas creencias que lo marcaba como una transgresión.

Guadalupe y Eva iniciaron sus relatos haciendo un recorrido por las diversas instituciones y espacios de socialización religiosa temprana de las que fueron parte, que incluían lo familiar, lo escolar y la comunidad de creyentes. Enfatizaron, en reiteradas ocasiones, cómo el conflicto con sus creencias religiosas fue determinante en lo que sintieron, tanto al momento de asumir la decisión como en la configuración emocional posterior al aborto.

> Soy cristiana católica y practicante, desde chica (…) fue la cuestión que me afectó emocionalmente (…) porque una está muy marcada por los principios morales, religiosos… por todo lo que uno tiene desde la familia, cultural (Guadalupe).

La decisión de abortar para Guadalupe no fue simple debido a sus creencias y valores morales que conceptualizó como "un chip que tenés grabado". Necesitó realizar una evaluación y un reconocimiento de su necesidad de interrumpir el embarazo no deseado y sentido como inoportuno y como una carga. Al respecto, expresó:

> Sentir la culpa, decir: "soy yo la que estoy decidiendo porque es mi situación, no quiero vivir una situación parecida, no quiero pasar por otro momento de necesidad muy grande" y desde lo católico yo decía: "pero ¿cómo? si no está bien, es un pecado mortal, Dios se va a vengar de lo que yo estoy haciendo, decidiendo". Es como que la culpa empieza a trabajar, pero yo dije: "no, pongo en una balanza…" y pude hacerlo, gracias a Dios, ponerlo en la balanza y decidir. Porque puntualmente yo no quería tener otro bebé, otro hijo (Guadalupe).

En este sentido, nos resulta interesante retomar el concepto de moralidad de la situación de Rosalind Petchesky (1986, citada por Rostagnol, 2016) para comprender su decisión. Significar el aborto en función del mandato religioso como un "pecado mortal", es decir, como una transgresión grave de los principios de su religión, le generaba sentimientos de culpa y miedo al castigo. Pero realizó una negociación entre el peso de esta creencia y la imposibilidad que sentía respecto a asumir una nueva maternidad, basándose en su realidad social y en su condición deseante que no estaba vinculada a volver a maternar. El reconocimiento

de esta imposibilidad también se apoyaba en sus experiencias previas de maternaje, donde había sentido una sobrecarga de responsabilidades en las crianzas que había afrontado en soledad económica y emocional con una pareja violenta (su realidad). También jugó un papel importante la creencia de que las decisiones sobre su vida le pertenecían y necesitaba acomodarlas a su deseo actual, porque en definitiva "es mi situación", expresó Guadalupe. El resultado de esta evaluación fue sostener la decisión de abortar, pero con un costo emocional de culpa y miedo a la venganza divina; malestares asociados a significar su aborto como una transgresión del mandato religioso.

Eva también inició la entrevista comentando que era evangelista y que tenía fe en dios, aunque tras abortar se había distanciado de la institución y de la comunidad religiosa. Para ella decidir abortar fue:

> una lucha contra mis creencias, mis ideales, mis valores, mis… una lucha con todo (…) era un asesinato, en pocas palabras. Que era algo muy malo, extremadamente muy malo (…) sentía mucha culpa, bastante culpa, demasiada (Eva).

Al igual que Guadalupe, hizo referencia a una carga intensa de culpa ligada al aborto como "un asesinato" y un acto reprobable, cercano a "lo demoníaco". En función de esto, abortar era significado como una transgresión de los principios de su religión que impregnaban su subjetividad.

El relato sobre su vivencia emocional al momento de abortar con pastillas en su casa fue duro y denotó un gran sufrimiento; utilizó la medicación llorando y sintiendo que merecía el dolor físico que experimentó durante la expulsión del saco gestacional. También expresó que mientras esperaba que las pastillas hicieran su efecto abortivo, soñó con un "feto muerto" y pidió perdón reiteradas veces a "Dios, mi hijito y mi madre". Se sentía mala, asesina e inmoral: "(…) porque sentía que había matado a alguien, esa era mi sensación y que iba en contra de todos los valores que me habían inculcado" (Eva).

Esta significación sobre el aborto impregnó de malestares la decisión y la experiencia posterior. En su sentido de la moral, había una división tajante entre las personas buenas y malas en función de sus actos. Aplicando esta lógica sobre sí misma, a partir de realizar una acción concreta considerada transgresora y gravemente reprobable, su identidad quedó eclipsada bajo esa acción, bajo la lógica de: yo hice algo malo, yo soy mala, yo merezco castigo.

Además, abortar había sido la primera desobediencia a los mandatos familiares y socioculturales de género aprendidos, ya que Eva se veía como una mujer: "(…) sumisa, muy obediente a mis papás, no tenía pensamientos propios".

Luego de practicarse el aborto, sostuvo autorreproches rumiantes, sentimientos de culpa y una actitud de castigo, de "echar sal a la herida", en sus palabras, mediante el recuerdo insistente y detallado de ese momento. No podía escuchar ni mencionar la palabra aborto, que "era como que decir «demonio»".

> Siempre busqué la aprobación de alguien más, ¿me entendés? Entonces al estar mal visto por muchas personas, yo no quería saber que yo lo había hecho. Fue, ni siquiera poder escuchar la palabra, me escapaba, me iba… tremendo (Eva).

En su experiencia observamos la actuación del estigma percibido (Zamberlin, 2015), en el sentido de que su apreciación de que otras personas podrían calificarla como una mala mujer y que desaprobarían su accionar le generó un notable malestar y la llevó a mantener por mucho tiempo un silencio aturdidor sobre la propia experiencia, que también perpetuó el malestar. Sin embargo, este malestar cedió cuando pudo comenzar a replantear sus significaciones sobre el propio aborto, tanto en un espacio psicoterapéutico como en el contacto con las socorristas que la acompañaron. En este sentido, el relato de Eva resulta clarificador para pensar tanto en los aspectos y circunstancias que operan en el proceso de construcción de la culpa y de los malestares, como también en los procesos de salud mental que conlleva el desarmar esas culpas asociadas a modos particulares de significar el propio aborto y el aborto en general.

Por su parte, en el relato de Marisa, creyente en la religión "católica-evangélica", observamos una correspondencia entre las significaciones que construyó sobre sus experiencias y los valores morales que trenzan embarazo con vida/hijo, propios de los discursos religiosos. Respecto a los dos embarazos que interrumpió y a su concepción de aborto antes de atravesar la experiencia, expresó: "son mis hijos, yo ahora tendría cuatro hijos (…) [pensaba que abortar] estaba mal (…) si te quedaste, ya está, tenelo porque es una vida que vas a interrumpir" (Marisa).

De modo que Marisa relató interrumpir "vidas" y abortar "hijos" y vivió las decisiones tomadas con ambivalencias y dudas, entre el alivio

de no tener más hijas/os/es de las que se sentía en condiciones de maternar y que consideraba que podría afectar negativamente la crianza de su hija pequeña y, por otra parte, la culpa por haber abortado, que la llevaba a sostener autorreproches:

> Yo lo hice… sentí mucho alivio, estaba bien, feliz, sentí mucho alivio, dije: "ya está, voy a seguir criando a la Amalita, se llama la chiquitita, bien" y me empecé a cuidar, y está todo bien. Pero es feo porque después sentís una culpa de decir: "¿qué es lo que hice? ¡Eso está mal!". Yo me sentí mal, angustiada, como deprimida, no comía. Claro, porque me sentía culpable (Marisa).

En estos relatos vemos que las creencias religiosas de las entrevistadas que se consideraban creyentes y que sostenían los discursos religiosos institucionales dieron lugar a significaciones que operaron conflictuando la experiencia. El conflicto entre lo que se cree y lo que se siente configuró malestares expresados principalmente bajo la forma de culpas y autorreproches.

Encontramos un último relato de una mujer creyente, Anahí, quien no expresó autorreproches ni culpas sino la autoafirmación de que esta decisión fue la correcta para su vida. Anahí se definió como católica no practicante, no participaba activamente de los ritos eclesiásticos institucionales ni se sentía cercana a una comunidad de creyentes, como sí ocurría en el caso de Eva o Guadalupe al momento de abortar.

> Soy católica pero tampoco es que voy a misa siempre y además de eso, hay una realidad que es la que yo vivo. O sea, si bien creo en Dios y en la Virgen, pero tampoco la Iglesia… Dios sí, siempre está con nosotros, nos ayuda, pero como que uno también tiene su propia situación (…) Entonces, sé bien, obviamente, siempre supe lo que la Iglesia piensa sobre eso, pero… [levanta los hombros] (Anahí).

Su decisión se basó en considerar que continuar ese embarazo le implicaría una interrupción en su proyecto educativo en curso, así como también en evaluar su realidad económica actual y el sentimiento de no estar preparada para afrontar una crianza, que a su entender "no es solo darle cariño". Es decir que decidió apoyada en las circunstancias vitales que para ella eran significativas y, así, configuró un marco subjetivo propio para concretar el aborto sin ambivalencias, arrepentimientos ni re-

proches a lo largo del proceso. En términos de moralidad de la situación (Petchesky, 1986 citada por Rostagnol, 2016), podemos pensar que el resultado de la negociación entre creencias o ideología, la realidad social y el deseo estuvo en armonía con la decisión/acto de abortar y, por ello, no sufrió costos emocionales elevados, como sí pudimos advertir en los relatos de Guadalupe o Eva. En esta negociación, tras la cual cada mujer construye la moralidad de la situación, mantuvo creencias moralmente menos rígidas que las que sostiene la institución misma, lo cual se tradujo en una experiencia emocional sin conflictos con la decisión de abortar. Pudo mantener intacta su religiosidad, a la vez que abortar sin culpas.

Para pensar esto nos resulta interesante la noción de cuentapropismo religioso (Mallimaci, 2015, citado en Morello & Rabbia, 2019) que en Anahí se puede ver en este distanciamiento de las estructuras institucionales del catolicismo acompañado de su ferviente fe en dios y en la virgen. Con este término se puede dar cuenta de fenómenos asociados a creyentes sin iglesias, personas con desapegos institucionales que igualmente se sienten parte de una tradición religiosa o distanciamientos relativos de los mandatos de las cúpulas de la organización religiosa con las que sienten una ligazón. Todo lo cual implica una mayor autonomía de conciencia de las personas creyentes en cuanto a la autoridad religiosa. Este cuentapropismo religioso también lo vemos en Eva tras abortar, como una posible salida frente al conflicto entre sus creencias y su accionar, luego de atravesar la experiencia acompañada por feministas y por un proceso psicoterapéutico que, en su conjunto le había: "(…) abierto mucho más mi cabeza, mi mente. Ahora no creo mucho en la Iglesia".

Además del vínculo que establecen o reformulan con la institución y sus mandatos, la visión que las mujeres creyentes construyeron sobre su dios, en tanto ente supervisor de esta situación vital por su condición de omnipresente, también jugó un papel relevante en la experiencia emocional. En el caso de Anahí, construyó una visión de un dios que la acompañó y/o que comprendió los motivos de su decisión, una presencia no persecutoria que, en sus diálogos internos, la tranquilizó frente a los riesgos. Distinto a Guadalupe, quien refirió un dios sentido como vengativo que le generaba temores y fantasías de castigo por significar el aborto como una trasgresión grave y mala, un acto (auto)reprochable.

> en momentos puntuales se me cruzan las emociones de la culpa. Sí, la culpa y el miedo a que, si en algún momento va a tomar… ¡mirá lo

> que es la locura!, o no sé si es locura… si Dios en algún momento va a hacer algo con mis hijos (Guadalupe).

A diferencia de Anahí, quien expresó no sentir culpa a lo largo de todo el proceso, o de Guadalupe, quien continuaba temporariamente sintiendo la culpa que acompañó su decisión inicial, las configuraciones emocionales culpógenas de Eva se transformaron notablemente luego de la práctica del aborto, como abordaremos en los siguientes capítulos. Esto nos muestra que las significaciones sobre el propio aborto, así como las creencias religiosas y la visión que se tiene de la participación de dios en esta experiencia pueden ser transformadas, al igual que los malestares y las cargas culpógenas que implican. Estas transformaciones son parte fundamental de los procesos de construcción de salud mental a partir de continuar atravesando y resignificando estas situaciones críticas donde las mujeres van negociando las experiencias emocionales de aborto con la religiosidad vivida y esto da lugar a múltiples maneras de significar y sentir la experiencia (Vaggione, 2014b; Johnson, 2018).

Emocionalidades y significaciones en el inicio de un proceso complejo

Las emocionalidades que emergieron en el tránsito por los embarazos no deseados/abortos voluntarios farmacológicos se articularon con diversas y móviles significaciones iniciales sobre estas experiencias. Se hicieron presentes desde el momento en que las mujeres se anoticiaron de los embarazos y asumieron la decisión de abortar, también en la anticipación de las condiciones para acceder al aborto e incluso en el recuerdo de lo experimentado.

Dentro de las principales configuraciones emocionales que conformaron los malestares encontramos la sorpresa, el rechazo y la angustia frente al embarazo que las irrumpió y las invadió. Este estado biológico no se enlazaba con el deseo de continuarlo y ponía en riesgo sus propios intereses, proyectos o condiciones de vida existentes. Veían afectado el sentido propio de integridad personal y su bienestar porque significaban los embarazos como una carga y un problema, frente a lo cual abortar era la solución.

Otros malestares comunes fueron la urgencia subjetiva y la desesperación por interrumpir ese embarazo en un contexto adverso que acre-

centaba las incertidumbres y los temores. Los temores fueron cambiando su objeto en función de cuál amenaza, inherente a los procesos de clandestinización, cobraba primacía en cada experiencia. Es así que nos encontramos con el temor a no poder abortar por no conseguir los recursos y no tener a quién acudir, junto al temor a que el embarazo y la intención de abortar fueran "descubiertos" y recibir reproches, denuncias o el maltrato por parte de profesionales de la salud o de sus seres queridos. Abortar fue significado como un camino lleno de obstáculos que deberían sortear y como una práctica de riesgo que vinculamos a los procesos de estigmatización, de marginación de los servicios públicos de salud y de penalización/criminalización que recaen sobre las experiencias y las subjetividades de quienes abortan.

El hecho de estar embarazada y no querer, y el encadenamiento entre embarazo no deseado/aborto voluntario/circunstancias y condiciones nos muestra la magnitud del malestar emocional que las mujeres experimentaron, previo a contar con la certeza de lograr una interrupción lo más segura posible o con mínimos riesgos. Estos relatos dan cuenta que los malestares y los descontentos no necesariamente se centran en la práctica en sí misma sino en la situación de saberse obstaculizadas, social y legalmente, para abortar y que estos obstáculos se interpusieran frente a la decisión. En otras palabras, los malestares se vincularon a la clandestinización de estas experiencias y para ellas lo trágico no era abortar, sino no poder abortar, lo cual fue significado como similar a una tortura.

Registramos otras formas de malestar cuando las decisiones estuvieron condicionadas por vergüenzas y culpas que asociamos a los mandatos de género sobre el ejercicio de la sexualidad y a mandatos religiosos a los que algunas mujeres estaban ligadas. Esto ocurrió cuando significaron los embarazos como la evidencia de una actividad sexual descuidada o reprobable, o los abortos como asesinatos, como graves transgresiones a los mandatos religiosos que las atravesaban y como experiencias (auto) reprobable/sancionable.

Entendemos que las configuraciones emocionales de vergüenza y culpa junto con los autorreproches por la sexualidad/embarazo se corresponden con la interiorización de ciertos ideales normativos de género que les hicieron significar la propia sexualidad como un error y el embarazo como la evidencia, que era necesario ocultar. ¿Qué errores evidenciaron estos embarazos? Haber tenido relaciones sexuales sin pa-

reja estable y conocida, haberlo hecho de forma "descuidada" o sin capacidad de negociación de las pautas anticonceptivas o haber reincidido en esta actividad sexual "descuidada". Todo esto se vinculó al temor a ser juzgadas como irresponsables, descuidadas o incluso, malas feministas. Utilizamos el término de reincidencia porque está ligado a incurrir en una falta o un error, a diferencia del de repetición que tiene una implicancia más neutra, justamente para dar cuenta del carácter de agravio con el que significaron la ocurrencia de estos embarazos, así como de la necesidad de que el aborto hiciera desaparecer esa evidencia.

Cuando los preceptos religiosos tradicionales fueron una convicción, contribuyeron a engrosar los malestares experimentados. Determinaron la construcción de significaciones sobre aborto como un asesinato y una transgresión, lo cual propició autorreproches, culpas y favoreció la vivencia estigmatizada y el silenciamiento. Si bien esto predominó en las mujeres creyentes, también encontramos un relato de una mujer católica que no refirió tal afectación emocional porque en la construcción de la moralidad de la situación, sus creencias religiosas no quedaron apegadas a lo que dictaminaba la institución y construyó una visión de dios que la acompañó, de manera no persecutoria.

Cuando consideramos la complejidad, los múltiples orígenes construidos y el dinamismo de los malestares asociados a las significaciones iniciales, destacamos que no fueron definitivos. Por el contrario, se fueron transformando a lo largo de las experiencias en función de la construcción de significaciones en tránsito, porque el proceso de resignificación se mantuvo abierto, incluso, al momento de participar en esta investigación. Como veremos a continuación, muchas de estas emocionalidades y significaciones se desarticularon, como así también otras se fueron movilizando a medida que transitaron este proceso acompañado.

II. Tránsitos acompañados

A partir de reconocer y aceptar la ausencia de deseo para sostener el proceso biológico en curso y sus implicancias, las mujeres emprendieron un camino para concretar su voluntad de interrumpirlo, camino que se significó más o menos obstaculizado en función de las condiciones y circunstancias con las que se entramó cada experiencia y que les generaron malestares que debieron atender.

Estos caminos no se recorrieron en soledad. Los tránsitos por las experiencias estuvieron acompañados porque las mujeres gestionaron apoyos de diversas personas y/o redes con quienes sortearon, aminoraron, resistieron e incluso transformaron las implicancias emocionales, físicas, sociales y políticas de la clandestinización. Al vacío y la violencia de lo institucional se contrapuso el encuentro con presencias que sostuvieron y acompañaron, haciendo estas experiencias más transitables, potentes y saludables. Cuando hablamos de las *presencias,* nos referimos a las valoraciones de las mujeres sobre los distintos acompañamientos que gestionaron para atravesar las experiencias, y a cómo estas actuaron en la construcción de las significaciones.

Las presencias fueron facilitadoras y no facilitadoras. En los próximos capítulos ahondaremos en las *presencias facilitadoras*. Específicamente las de otras mujeres con quienes mantenían vínculos afectivos; las de las activistas feministas y las de las profesionales en psicología.

Además, en estos tránsitos acompañados, atendemos al proceso de desarticulación que sufrieron las significaciones iniciales, como a la construcción y reafirmación de otras significaciones y emocionalidades.

Capítulo 6. Vamos juntas: la presencia de las amigas

Los acompañamientos de otras mujeres de sus entornos afectivos cercanos configuraron un verdadero trabajo de cuidados en las experiencias de embarazos no deseados/abortos farmacológicos voluntarios clandestinizados. A continuación, recuperamos las valoraciones sobre la importancia de las presencias de amigas, hermanas y madres, en tanto facilitadoras del tránsito por las experiencias. Nos interiorizamos de cuáles fueron las actividades de asistencia y las estrategias de protección construidas, y cómo afectaron los procesos de construcción de salud mental en torno a las experiencias y sus significaciones en tránsito.

Cuidados en el marco de las relaciones afectivas entre mujeres

Muchas mujeres solicitaron y recibieron cuidados de otras mujeres, principalmente amigas y hermanas. Las valoraciones que hicieron sobre estas presencias nos permiten comprender qué actividades y estados afectivos involucraron dichos cuidados.

Las actividades fueron principalmente de asistencia instrumental y de protección, y se relacionaron directamente con las condiciones de ocurrencia de los abortos clandestinizados. Conllevaron un trabajo afectivo que fue particularmente valorado por las mujeres que abortaron. A continuación, las presentamos en función de tres instancias del proceso de aborto: previo a la autoadministración de la medicación, durante y posteriormente a ello.

Antes de practicarse los abortos farmacológicos, las mujeres gestionaron junto a sus acompañantes los elementos que consideraban necesarios para concretarlo. Recibieron apoyos para proveerse y encontrar información, adquirir los insumos, gestionar un lugar donde realizar la

práctica y las formas de acceder a ecografías que les garantizaran cierta seguridad en el procedimiento.

En cuanto a la información, en muchas ocasiones fueron las amigas quienes facilitaron la posibilidad de pensar en el uso de la medicación para abortar como una opción segura, lo cual era desconocido por algunas. Incluso, a través de ellas llegaron a saber de la existencia de grupos socorristas locales.

> En realidad, es una amiga muy amiga que nunca me había contado y en ese momento cuando yo le cuento me dice: "esto me pasó. Cuando estuve internada fue por esto…" (Guadalupe).

> Y entonces recurrí a una amiga mía que estudiaba conmigo cuando estudiaba y le dije: "Negra, ¡estoy embarazada! ¿Qué hago?". Desesperadísima (…) Mi amiga me dijo: "Bueno, ¿por qué no hablás con la Malona Rosa?". Entonces me pasa un contacto por internet para que me comunique (Fabiana).

> Te juro que no sabía qué hacer, un instante me quedé inmóvil, un segundo, respiré profundo... bueno ¿a quién necesito? y la llamé a mi hermana, mi hermana es mi mejor amiga (…) Me dijo: "bueno, calmate, tranquilizate" y me empezó a contar de esta opción… bah primero me preguntó si yo lo iba a querer tener o no. (…) Ella me dijo: "vos te podés contactar con unas chicas de una agrupación, buscalas como socorristas o Socorro Rosa" (Estefanía).

Es así como amigas y hermanas compartieron sus propias experiencias de aborto farmacológico en ocasiones antes silenciadas o les acercaron información sobre la existencia de la medicación para abortar y de los grupos locales que acompañaban. Este tipo de apoyo aminoró el sentimiento de desesperación inicial cuando la decisión estaba fuertemente afianzada, pero, hasta antes de la comunicación con ellas, no sabían cómo llevarla adelante ni a quién recurrir.

En las situaciones en que las amistades también integraban grupos feministas organizados, esta primera información contó con mayor robustez y precisión. Recibieron de ellas una primera explicación que las orientó y las tranquilizó al sentirse más encaminadas para llevar adelante la decisión.

> Entonces, hablé con mis amigas, de mis mejores amigas y también

compañeras socorristas para, bueno, para entender el proceso y ver qué posibilidades tenía (Bárbara).

Entremedio hablé con una amiga, ex socorrista. Comunicación que parecía un telegrama y además telepático. Le escribí por chat de Facebook, casi que no hicieron falta explicaciones:
-Esta mañana me estuve acordando de vos.
-Mmm, ¿a la mañana?
-Sí.
-¿Durante el primer pis?
-Síiii.
-Bueno, nos vemos más tarde y charlamos (Leonor).

Primeramente, fue comunicándoselo a dos de mis amigas (…) una me hizo el contacto con las socorristas de Córdoba. Me acuerdo que cuando yo hablo con ella, automáticamente me dice: "mirá, yo tengo una amiga que pasó por esta situación, si vos estás segura, seguí". Y fue así, yo me entero, nunca me voy a olvidar del día: 20 de abril. Me hice el test y salió positivo. Ya al día siguiente ya lo había hablado. Nunca me imaginé que iba ser lo que fue, bastante sencillo en relación a otras cuestiones, a otros casos que he escuchado también (Nadia).

Los malestares iniciales empezaron a reducirse porque las mujeres sintieron que las amigas atendieron la necesidad planteada de obtener urgentemente información o una primera orientación. Sus recursos les fueron allanando el camino, lo hicieron más "sencillo", por ejemplo, cuando compartieron sus propios saberes sobre el aborto farmacológico o las contactaron con otras mujeres que ya habían abortado acompañadas por feministas. De este modo, es que se comenzó a desarticular la significación del aborto como un camino lleno de obstáculos, donde la falta de información era uno de los principales. Esto fue posible porque las amigas disponían de esa información o del contacto oportuno y lo pusieron a disposición. Pero, además, porque las mujeres se dispusieron a confiar en ellas y a saltar las vallas del silenciamiento impuesto sobre la práctica, sintiendo que su pedido de ayuda para abortar iba a ser alojado por las acompañantes. La mayoría de las amigas y mujeres familiares a quienes se les solicitó expresamente algún tipo de apoyo estuvieron dispuestas a prestarlo.

Es interesante señalar que las mujeres solicitaron los apoyos de sus amigas cuando la decisión ya había sido tomada. Lo que esperaban de

sus amigas era que las acompañaran en el camino de concretar los abortos. Pero no esperaban que opinaran en la toma de la decisión, la cual estuvo definida por las condiciones únicas y particulares que fueron subjetivamente aprehendidas y consideradas por cada una de ellas en función de la situación presente y de sus historias, con las carencias y posibilidades que habían signado sus experiencias vitales.

Parte de ese acompañamiento esperado y solicitado se dio en la logística previa a la autoadministración del fármaco y consistió en que estuvieran presentes en el encuentro con las socorristas o en las consultas con profesionales de salud.

Las interacciones con las socorristas fueron situaciones novedosas donde valoraron poder contar con una persona auxiliar que retuviera la información que obtenían en un estado emocional de incertidumbre o ansiedad.

En el caso de los acompañamientos durante consultas médicas previas a los abortos, experimentaron protección cuando sufrieron ataques: humillaciones, comentarios reprobatorios, infantilizaciones, ridiculizaciones, indiferencia ante sus estados emocionales y hasta amenazas de denuncias penales por parte de profesionales en quienes buscaban orientación. Emilia relató que, en el marco de la consulta para obtener información, recibió una serie de insultos y amenazas de denuncia por parte de la médica. Ella rompió en llanto y fue su amiga quien logró frenar los ataques: "Y estaba esta piba que es una grosa, le habló, le paró el carro, me agarró del brazo porque yo no me podía ni levantar, estaba como… Fue fuerte, fue un ataque" (Emilia).

En este sentido, atravesar estas situaciones con personas que ayudaron a poner coto a estas violencias resultó un elemento de protección. Camila, quien pudo acceder a una ILE por causal salud, también relató haber sufrido violencias médicas frente a las cuales la presencia de su amiga acompañante fue importante para aminorar su efecto y afianzar su lugar en el proceso. En el relato de Camila, el accionar violento de la médica que trabajaba en el consultorio de ILE de su obra social no apareció criminalizando la práctica –legal– de aborto, sino que lo sintió marcando y actuando fuertemente las asimetrías en la relación médica-paciente. Ella expresó que se encontró con una médica "autoritaria": "No me daba espacio (…) era muy cerrada y tenía una forma de ser que no me daba la confianza ni el lugar como para preguntarle" (Camila).

Frente a esta asimetría, su amiga la apoyó para redoblar su voz en

el intento de hacer oír sus dudas y consultas puntuales. Presenciaba lo que ocurría en la consulta médica y le devolvía a Camila una confirmación de que lo que se estaba poniendo en juego era una actitud de desestimación por parte de la médica, lo cual le permitía a Camila disminuir el malestar de sentirse "una pesadilla" para esta médica y, con ello, no sentir que su demanda de orientación y acompañamiento, en la forma que ella necesitaba, era excesiva e inadecuada. El hecho de sentir que su demanda fuera deslegitimada por la médica, pero no deslegitimada por su amiga acompañante, la impulsó a buscar las respuestas que necesitaba en otras personas para asegurarse que el segundo intento de abortar con pastillas funcionara correctamente, cosa que no había ocurrido en el primer uso. Y en esta búsqueda, su amiga también la apoyó con sus propias experiencias de acompañamientos anteriores y buscando otras fuentes de información –las socorristas–, a la vez que le dio confianza en el acto de "desobediencia" hacia las indicaciones médicas que realizaron juntas en pos de lograr el aborto esta segunda vez.

> Lo íbamos a repetir de vuelta al otro día con Osep, me comuniqué con las socorristas, les expliqué (…) Al otro día lo volvimos a hacer y no obedecimos sobre cómo me había dicho la doctora, lo hice bajo la lengua, no se lo dijimos. Ahí se completó el proceso (Camila).

Construir saberes y afianzar recursos para afrontar la situación crítica es parte de lo que consideramos como aspectos saludables en el tránsito por la experiencia. Y estos saberes, confianzas y reconocimiento de los recursos, Camila los construyó en compañía y con el apoyo de su amiga. Juntas volvieron a realizar el proceso, desobedecieron, decidieron no contarle esta "desobediencia" a la médica, abortaron. El sostén de su amiga la ayudó a no sentirse despojada del lugar protagónico en su propia experiencia, a andar su propio camino acompañado y a subjetivarse en ese andar, pues no asumió ser objeto de la intervención médica omnipotente. Sino que actuó como una sujeta que se reconoció capaz de decidir cuál era la mejor forma de lograr ese aborto y, así, culminar con sus malestares debido al embarazo no deseado.

Otra manera en que las entrevistadas se sintieron acompañadas y protegidas por sus amigas fue cuando las ayudaron a gestionar y hacerse ecografías previas al aborto. Si bien se trata de una práctica de salud enmarcada en la legalidad, anticipaban que podría ser una experiencia difícil al tener que exponer el estado de embarazo mientras ocultaban la

intención de interrumpirlo. Cuando disponían de experiencias previas, las amigas gestionaron turnos con personal de salud que les aseguraran un buen trato. O bien gestionaron turnos rápidamente en respuesta a la urgencia que sentían las mujeres de avanzar en la concreción del aborto, en una especie de carrera contra el tiempo por el avance del embarazo.

En el relato de Camila, previo a que su situación fuera alojada como legal por la institución de salud, el sentimiento de urgencia por comenzar a resolver la interrupción del embarazo y la desesperación por cómo hacerlo fue lo que primó. Camila contó también en esta instancia con su amiga, quien la ayudó a ordenarse e ir definiendo las postas en el camino para abortar.

> Ahí le escribí a mi otra amiga que es la que me ha acompañado. (…) "¿Qué voy a hacer?". Yo lloraba. "Venite a mi casa, te espero acá con mate y charlamos". (…) ella ya había acompañado a otras chicas en su proceso (...) A mí se me habían volado totalmente los pájaros, agradezco haber recurrido a ella porque ella fue la que me tranquilizó y me ayudó. (…) Me dice "lo primero que hemos hecho siempre es sacar un turno para la eco, donde se confirma que esté todo bien y ahí ver qué vamos a hacer". Hicimos eso, yo quería hacerme la ecografía ese día, estaba sacada. "¡¡¡Ya, ya conseguime turno, ya!!!". No teníamos pedido, entonces le habían pasado un número de teléfono de un lugar donde te hacían las eco sin pedido, pero no me aceptaban la mutual, tenía que pagarla. Yo estaba desquiciada, le dije: "¡Llamá ya! ¡Ya! ¡el turno!". Me lo dieron para el otro día. (…) voy con mi amiga, vamos juntas, ella me acompañó al otro día (Camila).

Es decir que, en el momento en que describía su estado emocional como "desquiciado" o con "los pájaros volados", la presencia ordenadora de su amiga que se ajustó a sus necesidades fue especialmente valorada.

En cuanto al apoyo para gestionar los insumos necesarios las mujeres relataron cómo, junto a las acompañantes, se anticiparon a las posibles necesidades físicas que podrían surgirles cuando se autoadministraran la medicación. Por ejemplo, relataron en plural que gracias a esa planificación contaron con alimentos y con elementos para controlar síntomas secundarios, como termómetros o medicación para regular las sensaciones displacenteras como náuseas o vómitos.

> Nos habíamos comprado, con mi amiga, habíamos hecho una compra de cuestiones para no salir de casa (…) ¿¡Qué compramos!? [en tono

gracioso] Compramos un Gatorade, porque según ella se me iba a bajar la presión, ella se inventaba esas cosas, jaja. Y compramos papitas, porque decía que teníamos que, tenía que tener sal en el cuerpo, y cosas dulces también (Nadia).

Teníamos un termómetro para tomar la temperatura, agüita, juguito, frutas teníamos algunas cosas saladas… ellas armaron una comidita (Fabiana).

Y muy especialmente, apreciaron la ayuda en la búsqueda y compra de la medicación, lo cual representó un alivio al restarles una tarea indispensable para concretar la práctica y que, en los momentos iniciales del proceso, habían significado que sería un gran obstáculo. A quienes la consiguieron en farmacias, les evitó exponerse a las opiniones y/o rechazos por parte del personal farmacéutico en esta situación de fragilización emocional inducida. Úrsula contó con gran estima que su amiga consiguió las pastillas y esto le permitió desentenderse de esta parte fundamental, mientras concurría sin éxito a diversas consultas médicas en busca de información sobre su uso; incluso recibiendo comentarios desalentadores y culpabilizantes en torno a su intención de abortar.

No eran caras [las pastillas], no conseguíamos la cajita entera, conseguíamos por 6, por 10… pero es algo que con mi amiga nunca hablamos, no sé cómo fue. "Yo me encargo de eso". "Bueno" jaja ¡ves! Eso, es eso. El poder contar con alguien que se encargara de la logística [lo dice sonriendo], que en ese momento no tenés la cabeza, era ir todos los días a un médico distinto para escuchar cualquier barrabasada… (Úrsula).

Otra actividad fuertemente valorada fue que las acompañantes proveyeran o acondicionaran un lugar adecuado, limpio y con privacidad para realizar la práctica y así hacer que ese momento fuera más cómodo y transitable.

Lo hice en la casa de ella, con ellas tres, tres amigas. Ese momento fue muy lindo, o sea, estaba pasando todas esas cosas que ya sabemos pasan por el cuerpo, estaba con miedo y todo, pero contenida con mis amigas y en un lugar súper tranquilo, nosotras solas (Pato).

Esta vez yo no vivía sola sola porque estaba en mi casa, pero podía

> caer mi abuelo, así que no lo quería hacer ahí. Entonces, hablé con una amiga que vivía sola, me dijo que lo podía hacer en su casa (…) estaba tranquila y estaba con gente que me había acompañado en la primera experiencia (Lola).

> Él [pareja que quería continuar con el embarazo] no sabía bien qué… fui, busqué eso [pastillas], me vine para acá, calladita, la llamé a mi amiga, me fui a la casa de mi amiga (Paz).

Contar con un espacio seguro y privado les resultó fundamental para evitar que ciertas personas convivientes se enteraran del embarazo y de su interrupción, o para evitar malos tratos e interferencias por parte de las parejas que no acordaban o no sabían sobre el aborto. El lugar seguro que proveyeron las amigas actuó a modo de protección, incluso, al fantasear una posible obstaculización de la decisión de abortar por parte de personas del entorno cercano.

Hasta aquí hemos desarrollado cuáles fueron los apoyos instrumentales y de protección valorados en los momentos previos a autoadministrarse las pastillas. Durante la práctica del aborto, las amigas, hermanas y otras mujeres del entorno cercano también colaboraron asistiéndolas y haciéndolas sentir protegidas y cuidadas. Destacamos dos grandes funciones de las acompañantes: el desarrollo de estrategias de amenización y el sostén emocional frente a las incertidumbres y temores.

Por un lado, las estrategias de amenización consistieron en distraer o distender para que la situación fuera lo más apacible posible. Adoptaron la forma de conversaciones sobre otros temas, ver películas, colocar música o aromatizar para que el ambiente resultara más agradable o realizar actividades manuales en conjunto. Estas estrategias muestran que las acompañantes también se ocuparon del estado emocional de las mujeres que estaban abortando. Esta manera de estar supera ampliamente la visión reduccionista sobre este proceso como algo que compromete meramente a lo orgánico.

Por otro lado, la función de sostén emocional operó principalmente frente a las incertidumbres y temores que sentían. La experiencia corporal de un aborto farmacológico clandestinizado se ligaba a la experiencia consciente emocional novedosa que era significada como una práctica de riesgo corporal, principalmente, por la ausencia de supervisión médica y de garantías institucionales de seguridad.

A lo largo del proceso aparecieron nuevos temores y la significación

del riesgo implicado en abortar fue adquiriendo otros matices. En la instancia de la práctica primó el riesgo corporal, sumado al riesgo significado inicialmente por anticipar posibles persecuciones y malos tratos en caso de tener que asistir a un establecimiento de salud y ser "descubiertas". De modo que muchas mujeres experimentaron incertidumbres y miedos vinculados a las consecuencias de la automedicación, es decir, a cómo serían los síntomas, la expulsión del saco gestacional y las reacciones de sus cuerpos. En ocasiones, tanto la falta de estas señales corporales como la presencia de síntomas notables –en cantidad de sangrado o intensidad del dolor– alimentaron el temor a que existieran riesgos corporales concretos, que se magnificaban por la marginación de estas prácticas de los servicios de salud y por la criminalización. Por ejemplo, fue común el miedo a desangrarse o a que "el proceso salga mal", en el sentido de que el aborto no se produjera y, entonces, tener que recurrir a un servicio de salud y ser maltratadas o denunciadas y penalizadas. En este sentido, Emilia valoró reiteradamente la presencia tranquilizadora y de sostén emocional de sus amigas.

> A mí me ayudó un montón hablar con esta chica que había estado con otras mujeres en la misma situación. El hecho de que alguien venga y me lo diga "mirá, se ha hecho y no pasa nada", más allá de que esté el libro. (…) Siempre agradecí esto. ¡A las chicas les debo...! ¡Se re portaron! (…) La segunda dosis también estaban las chicas. Y tratando de relajar, de que no me coma los viajes porque lo mío era una cuestión más de miedos a cualquier cuestión que pueda pasar de salud. (…) Hablaba mucho con la piba esta que había hecho acompañamientos y que me decía: "no pasa nada, relajá. Lo tenés que controlar, pero tampoco volverte loca" (Emilia).

En este contexto, las acompañantes fueron sentidas como una guía y orientación en los sucesivos pasos a seguir, por ejemplo, en el modo e intervalo de horario en que se debían administrar las pastillas. Estuvieron disponibles para calmar y tranquilizar con palabras y con contacto físico afectuoso cuando los temores o incertidumbres se exacerbaron. Brindaron recomendaciones y explicaciones para controlar los síntomas evitando, así, tener que concurrir a una guardia hospitalaria. Ofrecieron una gama de experiencias y saberes con los que ya contaban a partir de los abortos propios o que acompañaron, e incluso, por experiencias de contracciones uterinas en procesos de partos propios. También les ofrecieron saberes que

construyeron especialmente para ayudarlas, por ejemplo, interiorizándose juntas en la lectura del manual de Lesbianas y Feministas. Por todo esto, la presencia de mujeres del entorno afectivo cercano disminuyó las sensaciones y significaciones del aborto como una práctica de riesgo y las hizo significar que sus abortos estaban siendo procesos cuidados.

Finalmente, las mujeres se sintieron sostenidas emocionalmente cuando recibieron apoyo para verificar que habían expulsado el saco gestacional y pudieron compartir las incertidumbres al respecto. Esto fue apreciado cuando no quisieron o no pudieron mirar, e hizo que ese momento fuera más transitable. El relato de la experiencia de Amy y de Pato, quienes transitaron el aborto farmacológico en casa de sus amigas, ilustra estas formas de acompañamiento emocional que calman, tranquilizan, amenizan y les permiten recordar un momento de alta tensión emocional con una cuota de humor.

> Era invierno y... bueno, mis amigas (...) la verdad que muy divinas, leímos, meditamos, siempre meditábamos cuando estábamos juntas o cantábamos. (...) Me estuvieron cuidando mucho. [Yo] temblaba... de miedo... como una hoja. Por eso mis amigas se acostaron una de cada lado, porque yo temblaba frenéticamente del pánico que tenía. Y ellas me calmaron un poco, ahí me dormí y ahí fue que terminó de salir todo (Amy).

> Y después de un momento crítico, en el momento de la expulsión del saco, que era muy gracioso porque estábamos las cuatro así, asomadas mirando el inodoro. Me hubiera gustado tener una cámara en ese momento jaja (…) Momentos pico de síntomas, expulsión del saco que nadie vio, después todas dijimos "sí, sí, sí" así como parlamentariamente "sí, sí" jaja. Y tiramos la cadena como diciendo "ahí se fue", me empecé a sentir mucho mejor y al otro día a la noche estábamos ahí mismo como festejando. Prendimos un fuego, hicimos una comida así, impresionante, como si nada, como muy bien. (…) Yo conociéndolas, que son mis amigas de toda la vida, sé que estaban como asustadas, pero en el plan de "no, no pasa nada, va a estar todo bien", poniendo una postura de tranquilizar, digamos. Muy bien, muy amorosas, muy atentas a todo, muy prolijas: "bueno, ahora va a pasar esto". Teníamos el manual para mirarlo, la guía. Muy bien, iban, compraban comida (Pato).

Es interesante cómo el relato de Pato va repasando su percepción del propio estado emocional como del de sus acompañantes. Todas com-

partían las incertidumbres y se encontraban atemorizadas por lo que podría pasar; acompañar abortos implica actividades y también estados emocionales para quienes están presentes. Sin embargo, según su relato, sus amigas fueron capaces de ocupar este rol de auxiliar que les implicó poner a su disposición los recursos cognitivos y emocionales. Por ejemplo, los recursos atencionales para ir anticipando cómo sería el proceso orgánico y cómo estaba siendo, o asegurarse de que hubiera comida suficiente, a la vez que brindar una contención emocional adecuada que calificó como "amorosa". Esta actitud de sentirse "tranquilizada" por sus amigas que también estaban atemorizadas, supone sentir que sus necesidades fueron puestas en primer lugar. Esta misma actitud relató sentir Fabiana, expresando una especial emoción y gratitud hacia sus amigas, hermana y prima que estuvieron con ella al momento de abortar:

> La previa era mucha charla entre todas, mucho amor, mucha contención. Algo muy bueno fue que mi amiga, la que me acompañó… mi prima tenía mucho temor, mi hermana no decía nada y mi amiga, ella todo el tiempo sostenía que ese era mi momento, que yo era la que necesitaba toooodo lo que necesitara así que la única protagonista en ese momento era yo, jaja. ¡Y fue muy bueno esto! Fue como decir: "acá no importan las emociones de nadie más que las tuyas, y no importan las necesidades de nadie más que las tuyas. Estamos acá para atenderte a vos, así que vos dejate ser y nosotras responderemos". Así. Y fue como… [suspira, se emociona, se le empañan los ojos] muy bueno, muy bueno ese momento. Fue muy lindo eso (Fabiana).

Estas vivencias acompañadas que nos compartieron se alejan de los imaginarios sobre abortos clandestinizados en soledad y deshumanizados, a la vez que nos acercan a experiencias de aborto farmacológico significadas como procesos cuidados. Fueron instancias en que se expresaron los afectos construidos previamente con sus acompañantes elegidas, lo cual fue posible gracias a la existencia previa de dichos vínculos y por las posibilidades del método farmacológico. El poder elegir acompañantes que sean de confianza y que, efectivamente, desarrollen un modo de estar empático y cálido al momento de abortar implica tener a disposición estas acompañantes dentro del propio entorno afectivo. Es decir, haber forjado con anterioridad vínculos de confianza entre mujeres que, a razón de este vínculo, estén dispuestas a asumir los riesgos, las actividades y los estados emocionales implicados en el acompa-

ñamiento de un aborto clandestinizado. En los relatos de las entrevistadas que lograron expresar la necesidad de apoyo y no someterse a los dispositivos de silenciamiento social, vimos que en su gran mayoría esta respuesta empática estuvo presente.

A su vez, poder elegir con quiénes transitar esta instancia del proceso es una de las posibilidades del método farmacológico, que puede ser utilizado autónomamente sin que sea necesaria la intervención de profesionales sobre el cuerpo y en espacios físicos cuyas condiciones de higiene pueden ser provistas por las mismas mujeres. Los relatos de estos modos de abortar con medicamentos y con acompañamientos elegidos dan cuenta de experiencias significadas como procesos cuidados, "con mucho amor, con mucha contención".

No solo elegir qué hacer frente al embarazo no deseado, sino también cómo hacerlo y con quiénes, forma parte de los procesos de construcción de la autonomía subjetiva y, por ende, de salud mental. Y esto las hizo significar que, mediante el acompañamiento elegido, estaban ejerciendo dicha autonomía. Como "una experiencia 100% autónoma", al decir de Bárbara sobre su segundo aborto, farmacológico y acompañado, en contraste con un aborto quirúrgico previo, transitado como "traumático" y "denigrante". O en palabras de Nadia, años después de su aborto y directamente vinculado al acompañamiento elegido, quien en la entrevista expresó satisfecha: "Mi amiga me acompañó en ese momento y fue… fue… La sensación que yo tengo es que pude elegir en muchos, en muchos aspectos. Elegí con quién estar… elegí no estar con él, también… ¡elegí hacerme el aborto! jaja…" (Nadia).

Posteriormente al uso de la medicación, una vez constatada la expulsión del saco gestacional, las presencias afectivas estuvieron allí para acompañar el alivio sentido y el bienestar recobrado tras verificar que ya no están embarazadas; acompañar "el festejo", como mencionaba Pato.

También, cuando fue necesario, estuvieron presentes para continuar asistiendo, conteniendo emocionalmente y protegiéndolas de las diversas violencias que sufrieron o que anticipaban recibir en las interacciones con el personal de salud, particularmente en situaciones de abortos incompletos donde las mujeres evaluaron necesaria la intervención médica. Camila tuvo que repetir el procedimiento y atravesar esa situación altamente angustiante para ella. A continuación, rescatamos tres fragmentos de su relato que muestran cómo su amiga Lola continuó estando a su lado luego del primer procedimiento farmacológico fallido.

> [Tras hacerse la ecografía] salgo y la Lola me vio la cara y le dije que estaba ahí, que no se terminó el proceso. Salí de ahí y me largué a llorar mal y le decía "¡¡qué voy a hacer!! ¡Otra vez! ¡¡Nooooo, no puede ser!!". La Lola lloraba, llorábamos las dos y decía: "¿¡qué hicimos mal!? ¿¡Por qué no salió!?".
> [Al momento de repetir el procedimiento] Me relajé lo que más pude… ya la segunda vez no tenía las mismas energías que la primera, estaba re bajón. La Lola, mi amiga, se dio cuenta: "no estás como la primera, pero esta vez nos va a salir, va a salir todo bien".
> [Luego de la expulsión] Yo estaba de maravilla, seguí sangrando ese día, brindamos, nos tomamos unos mates, comimos con la Lola, festejamos, volví a vivir ¡yo tenía una energía! (Camila).

El relato de Camila sobre la forma de estar de Lola nos sugiere la magnitud de la experiencia compartida y de una implicación corpoafectiva tal, que la llevó a relatar el aborto en plural. El acompañamiento sentido atravesó diversos momentos: tener con quién compartir la angustia, la impotencia y el llanto tras confirmar con la ecografía que seguía embarazada luego de haber usado "juntas" el misoprostol; recibir el aliento de su amiga para encarar el proceso nuevamente; la esperanza compartida de que esta vez la interrupción sería exitosa; y compartir con ella el alivio y la alegría de ya no estar embarazada, lo cual ameritó el festejo.

Es interesante señalar que cuando las entrevistadas se refirieron a las acciones y emociones que iban sintiendo a lo largo del proceso acompañado por sus amigas u otras mujeres del entorno afectivo cercano fue recurrente que lo hicieran en plural. Estos abortos relatados en plural y la sensación de haber superado los obstáculos juntas, nos sugieren la idea de una construcción y ejercicio de autonomía en conjunto que benefició a ambas. Retomando el relato de Camila, ella pudo abortar y el ejercicio de este poder –entendido como potencia de sí en palabras de Ana María Fernández (2021)– es también el poder, la potencia y la apertura de posibilidades para su amiga Lola y para tantas otras mujeres que potencialmente pueden encontrarse en una situación similar, en tanto los procesos de construcción de autonomía subjetiva se vinculan directamente a los de autonomía de género.

Luego de abortar, la presencia de las amistades fue un refugio donde poder expresar verbalmente sus sentimientos y seguir elaborando emocionalmente la situación que atravesaron. Valoraron la importancia de

volver a poner en palabras el proceso de la decisión o las reflexiones post aborto, contando con la escucha empática de sus amigas.

> Después vino una amiga, empezamos a hablar y cuando yo empecé a verbalizar los por qué y le conté todo, me di cuenta de que era una decisión que era correcta (Paz).

> Y después, casualmente, no sé por qué ¡lo que es la vida de nosotras! ¡Es así! Me empecé a encontrar con mujeres que les había pasado lo mismo pero que lo silenciábamos entre nosotras, viste (…) yo me empecé a encontrar en la mirada de otras mujeres que habían vivido como la misma situación, ¿viste? Y fue, para mí, básicamente hice una amistad muy grande con una chica que habíamos vivido el mismo proceso. (…) Entonces, a mí me sirvió un montón para pasar el proceso con otra mujer que había pasado lo mismo que yo. (…) eso realmente fue un sostén muy bueno, y muy muy muy positivo, y a la vez de crecimiento también. Crecés mucho también, no creo que volvés a ser lo mismo que eras, creo que está bueno eso (Nadia).

Este ejercicio de narración y escucha les permitió volver a construir y a validar las razones de sus decisiones de abortar esos embarazos. Contar cómo se sintieron después de abortar y compartirlo con sus amigas, fue un modo de integrar esta experiencia de manera más armónica en su biografía y estos modos saludables de estar facilitaron las experiencias. Como así también, el haber transitado esta situación crítica juntas favoreció dichos vínculos afectivos e, incluso, les permitió forjar nuevas amistades. De modo que fue significado como una oportunidad para crecer en compañía y para el fortalecimiento vincular. La siguiente frase de balance de la experiencia que compartió Eluney resulta sumamente ilustrativa de este fortalecimiento vincular: "De esa experiencia siento (…) primero la seguridad de los vínculos que estuvieron, muy agradecida a eso, mucho apoyo, muchas amigas".

En síntesis, las presencias de las mujeres de sus entornos afectivos cercanos fueron valoradas en todas las instancias del proceso como acompañamientos elegidos que sintieron respetuosos de sus decisiones y emociones, desde posicionamientos empáticos que reafirmaron un sentimiento de protagonismo. Los cuidados implicaron estados afectivos y actividades de trabajo. Junto a sus amigas, hermanas y otras mujeres lograron ambientes de confianza que las sostuvieron en aspectos instru-

mentales del proceso y que actuaron como protecciones frente a las violencias, pudiendo significar que los abortos eran procesos cuidados y que se estaban exponiendo a menos riesgos. Valoraron que sus acompañantes estuvieron centradas en las necesidades físicas y emocionales, así como que estuvieran disponibles para proteger y acuerpar si las interacciones sociales así lo requirieron, sobre todo las interacciones violentas en el ámbito sociosanitario.

Entre los vínculos afectivos y las significaciones de las experiencias: la construcción de salud mental

A partir de las presencias facilitadoras de mujeres del entorno afectivo cercano y considerando los procesos de construcción de salud mental, destacamos tres grandes significaciones en tránsito: el aborto como un proceso cuidado, el aborto como una oportunidad para construir y ejercer autonomía, y el aborto como una oportunidad para fortalecer los vínculos.

Para entender estos modos de significar las experiencias, retomamos el concepto de crisis, central en el modelo tensional-conflictivo desde el que nos acercamos para comprender la salud mental de las mujeres, en sus dos acepciones: la de riesgos y la de oportunidad. El sentido de oportunidad asociado a las crisis remite, en parte, a la oportunidad de construir y poner en juego recursos que permitan transitarla y disminuir la noción de riesgo inherente a las situaciones críticas que, en estos abortos, se exacerbó por los procesos de clandestinización que precarizaron las experiencias.

De los análisis reflexivos que las entrevistadas realizaron sobre sus procesos de embarazos no deseados/abortos voluntarios acompañados surgió la posibilidad de reconocer encarnada y afectivamente cuáles fueron esos recursos que construyeron y junto a quiénes lo hicieron. Podemos afirmar que estas formas de estar y de cuidar de sus amigas, hermanas, primas, madres, conformaron recursos afectivos relacionales fundamentales para transitar las experiencias de maneras más saludables. Vivenciar la asistencia y la protección afectó los malestares y las significaciones iniciales sobre las experiencias: les permitió desarticular significaciones sobre los abortos como prácticas de riesgo y como un camino lleno de obstáculos, para significarlo como procesos cuidados y potentes.

La relación que encontramos entre las experiencias acompañadas de embarazos no deseados/abortos voluntarios y los procesos de cons-

trucción de salud mental es bidireccional y, por ende, doblemente enriquecedora para quienes la transitaron. Este tipo de acompañamiento se desplegó desde el afecto y la confianza mutua; el acompañar fue una forma de demostrar la vigencia y fortaleza de un vínculo afectivo existente y para las mujeres que abortaron fue una manera de sentirse cuidadas y apreciadas por sus amigas, hermanas, etc. Estos sentires no son menores si consideramos que las estigmatizaciones experimentadas e internalizadas influyen en que muchas mujeres vivencian subjetivamente que las personas de sus círculos cercanos pueden retirarles su cariño o aprecio si saben de la realización del aborto. Lo cual hace significar los abortos como experiencias (auto) reprobables y afecta negativamente los sentimientos de valía propia. Por el contrario, las formas de acompañamientos analizadas las robustecieron emocionalmente y, lejos de experimentar una retirada del aprecio, los vínculos se fortalecieron en el tránsito acompañado por la experiencia.

Además, las mujeres no abortaron solas, eligieron a otras mujeres amigas para abortar, muchas de las cuales contaban con anteriores experiencias de acompañamientos o de abortos propios. Todas estas experiencias se fueron encadenando y colectivizando de boca en boca. En este sentido, los abortos acompañados se contrapusieron a los modos dominantes impuestos de transitar los abortos, esto es, como prácticas que deben permanecer aisladas, silenciadas y enquistadas en lo individual.

Entonces, los vínculos afectivos impactaron en las experiencias de abortos: redujeron las significaciones sobre riesgo, aumentaron las protecciones, subvirtieron los sentidos dominantes sobre el aborto como una experiencia individual y solitaria, afectaron los procesos de silenciamiento y nutrieron sentimientos de valía propia al sentirse apreciadas y cuidadas. Pero, además, si invertimos esta relación, apreciamos que los vínculos fueron fortalecidos por estas experiencias. En este sentido, no solo los vínculos afectivos impactaron en las experiencias acompañadas y favorecieron los procesos de construcción de salud mental asociados. Sino que también, el haber atravesado esta situación crítica generó implicancias saludables en los vínculos de amistad y en quienes los sostuvieron, de modo de poder significar estas experiencias acompañadas como oportunidades para el fortalecimiento de los vínculos.

Capítulo 7. Descubrir esta red de mujeres organizadas: la presencia de las activistas feministas

Las entrevistadas transitaron los embarazos no deseados/abortos voluntarios farmacológicos significándolos como un camino lleno de obstáculos que les implicaría afrontar y sortear diversos riesgos. A la vez, fueron gestionando cuidados y contaron con diversas presencias facilitadoras, entre las que encontramos a las activistas feministas, principalmente socorristas de grupos locales y, también, de la línea telefónica de LyF.

Es vasta, y cada vez más creciente, la producción teórica sobre las prácticas feministas de acompañamiento, sus experiencias de organización y politización de los abortos farmacológicos, los sentires políticos de las activistas, sus formas de hacer pedagogías entre feministas, con profesionales y redes del sector salud y con las personas que acompañan. Gran parte de estos escritos e investigaciones muestran el impacto social de esta ingeniería feminista, así como el impacto subjetivo en las acompañantes, de modo tal que afirman haber configurado una subjetividad abortera socorrista.

En este apartado le damos una mirada distinta a la relación entre las activistas y las mujeres que abortan porque nos centramos en las valoraciones que las propias mujeres realizaron sobre los aportes de los acompañamientos feministas, lo cual hemos de llamar presencias activistas. Dichas valoraciones nos permiten comprender cómo afectaron las significaciones y emocionalidades sobre las experiencias y sus aportes a los procesos de construcción de salud mental.

Información, experiencias previas, recursos para lograr abortar, posibilidades de encuentros, sentidos… fueron algunos de los aportes activistas. Para presentarlos, los diferenciamos: los recursos, saberes y la disposición; el acceso a la grupalidad; y otros sentidos sobre los abortos. Finalizamos este capítulo relacionando estos aportes con las dos tensio-

nes que se desplegaron en las experiencias al momento de significarlas: la tensión entre riesgos/cuidados y la tensión entre estigmatización/legitimación.

Recursos, saberes y disponibilidad

Las mujeres valoraron especialmente la información que les brindaron las socorristas porque estuvieron acompañadas de explicaciones personalizadas y contextualizadas y de sus experiencias previas que fueron puestas al servicio de la propia experiencia. Además, valoraron el acompañamiento telefónico y el acceso facilitado a algunas prestaciones médicas, gracias a las articulaciones previas con profesionales de la salud.

Las mujeres encontraron información sobre la existencia de la opción farmacológica para abortar y sobre cómo usar las pastillas en el manual *Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas*, compilado por LyF, y en los intercambios con las activistas cuando llamaron a la línea telefónica "Más información, Menos riesgos", como así también en los encuentros personales y telefónicos con las socorristas locales.

El uso de la línea telefónica y de internet les permitió superar algunas barreras geográficas existentes, previo a la conformación de los grupos socorristas en San Luis y en Mendoza. Gracias al manual algunas comenzaron a interiorizarse sobre cómo sería el proceso, por qué sucedía y cuál era el efecto específico en su cuerpo de la medicación que iban a consumir, cuál era el nivel de efectividad del misoprostol y qué hacer en caso de que no funcionara el primer intento. Mucha de la información que les era negada en el ámbito sanitario, la obtuvieron mediante los recursos provistos por las feministas, y así pudieron disminuir los miedos y las ansiedades iniciales, estar más preparadas.

> Me mandó el manual por internet y después otra de las chicas me mandó el manual en papel, que todavía lo tengo (…) posta que el librito está genial. Incluso para alguien como yo, que necesitaba saber todo, necesito saber ¡¿qué efecto provoca?! ¡¿Por qué abortás?! Y bueno, ahí está todo. Tal vez de otra manera capaz llegaba a lo mismo, con menos información, con más miedos todavía. Con toda la información que tenía estaba bastante cubierta (Emilia).

> (…) sabíamos que podía pasar, que podía fallar. Podía haber una segunda vez, incluso una tercera vez. Eso me lo dijeron por teléfono,

> yo me comunicaba con el número de teléfono del librito, nos comunicábamos con la Línea (Úrsula).

Cuando se conformaron los grupos socorristas muchas mujeres, además de leer el manual, precisaron de los encuentros cara a cara. Marcaron una diferencia entre leer la información y que les fuera transmitida de manera oral y directa, porque accedieron a otros saberes, a partir de las experiencias previas de acompañamiento de las socorristas, que excedían el dato sobre cómo usar las pastillas. También en esos intercambios pudieron expresar activamente sus propias necesidades, sus dudas específicas y encontrar algunas respuestas y tranquilidades.

> A mí me ayudó un montón hablar con esta chica que había estado con otras mujeres en la misma situación. El hecho de que alguien venga y me lo diga: "mirá, se ha hecho y no pasa nada", más allá de que esté el libro (Emilia).

> Me re sirvieron las charlas que tuvimos con las chicas del grupo de las socorristas. Si bien yo sabía, igual necesitaba verlas y que me explicaran; porque una cosa es verlo en teoría y otra es de primera mano ellas, con experiencia, que saben (Ernestina).

> Esta experiencia nueva estuvo buena porque era más físico. Era más sentarte a charlar con alguien de lo que te estaba pasando, y era más cercano (Betzabeth).
> Me explicaron bien bien bien el proceso, eso me dio muchísima tranquilidad (…) con mucha confianza, poder hablar muy tranquila, poder pensar por qué de la decisión en ese momento, los miedos… (Bárbara).

Entonces, por un lado, valoraron que les compartieran los saberes adquiridos en persona o "de primera mano", las explicaciones a partir de la experiencia vivida y los saberes basados en que "se ha hecho", entendiendo que ellas no eran las primeras que estaban experimentando con este método. Así, las mujeres pusieron en valor la experiencia construida por las socorristas y la capitalizaron para sus propias experiencias.

Por otro lado, valoraron el espacio de intercambio para atender sus dudas puntuales y los temores, poder hablar de la decisión tomada y de las fantasías sobre el aborto farmacológico, que algunos son comunes a todas y otros se relacionan con lo que cada mujer había podido conocer

hasta el momento. Las explicaciones y los intercambios fueron disipando las incertidumbres iniciales y el obstáculo sobre cómo conseguir la información, lo cual tuvo efectos tranquilizadores para seguir adelante con el proceso.

La disposición y el trato recibido en los encuentros por parte de las activistas fueron sumamente importantes por el estado emocional en el que llegaban a realizar estos contactos. Algunas mujeres sentían desconfianza, desesperación o desesperanza porque no sabían a quién acudir o porque ya habían experimentado la expulsión o el maltrato de los profesionales de salud. En cambio, el modo en que las socorristas les brindaron la información les permitió sentirse "cómodas", "tranquilas" y en confianza.

> Era como obviamente un momento de desesperación, y de miedo, de "¿qué es esto?, ¿quiénes son estas minas?, ¿cómo es?". Miedo, desinformación. (…) Después nos juntamos con las socorristas, hicimos esa consejería que fue muy linda y tranquilizadora para mí, de pronto se abrió la puerta a todo ese mundo. Pibas muy amorosas y muy desprejuiciadas, está todo bien. Está todo bien (Pato).

> Me sentí súper segura [con la información], previamente a la reunión tenía sensaciones sumamente encontradas, estaba nerviosa (...) Empezaron a hablar, me fui calmando, me fui sintiendo mucho más cómoda. Hablaron de todos los rumores habidos y por haber de cosas que la gente dice que pasa y no pasa... sacaron todas las dudas (Estefanía).

> ¡Tratándote como si te conocieran de toda la vida! (…) "Vos no te preocupes, que tenés tiempo, que estamos re bien, de algún lado lo vamos a solucionar"… espectacular… me bajaron un montón la ansiedad (Ernestina).

Esta información y experiencias que valoraron como un recurso completo, entendible y ajustado a sus necesidades les fue útil al momento de planificar el aborto farmacológico como al momento mismo de usar las pastillas.

> Todo lo que pasó, estaba escrito en el librito ese "Cómo hacerse un aborto con pastillas". Me lo había leído entero, todo lo que pasó, estaba ahí (Andrea).

> Lo mío fue como sentir lo que había leído, lo que me habían dicho las chicas [las socorristas] me fue pasando (Marcela).

> [habla de "contracciones, un poco fuertes"] Me los aguanté, digamos… porque sabía que, me habían explicado antes de hacer todo esto, me habían explicado todos los síntomas además de que me habían dado un folleto escrito con todos los síntomas normales, con los dos procedimientos, si iba a ser vaginal u oral. Estaba todo re bien explicado, estaba preparada. (…) Sabía de los síntomas, por eso también me fue corto y ¡y eso que fueron varias horas! (Anahí).

> Ansiosa, en el momento. Ansiosa pero tranquila porque me habían dado la tranquilidad ustedes [las socorristas] por toda la información que tenía (Karina).

De modo que la información y las experiencias previas de acompañamiento les sirvieron de parámetros para comparar sus experiencias con lo que habían leído o con lo que habían conversado con las socorristas. Y de esta manera, pudieron anticipar los síntomas físicos esperables mientras se autoadministraban el fármaco, logrando un mejor manejo al diferenciar lo esperable de lo que podía resultar alarmante. Todo esto disminuyó las incertidumbres sobre la medicación y el proceso orgánico, e hizo la práctica más sencilla y transitable. Narraron la tranquilidad de tener un proceso "de manual", "muy como el libro" porque contaban con información que describía lo más exactamente posible lo que estaban atravesando y porque la experiencia sentida coincidía con las experiencias registradas y escritas.

Otro aspecto que valoraron de la información y de las experiencias previas fue que estuvieran situadas y enraizadas en el lugar concreto donde iban a abortar, sobre todo porque disminuyó los temores vinculados a los procesos de penalización/criminalización. La necesidad de anticiparse y defenderse de posibles criminalizaciones por profesionales de salud, de que no descubrieran lo inducido del aborto, fue algo común en las experiencias. Como así también las valoraciones positivas de las presencias socorristas en la construcción de herramientas para sortear este riesgo que, en el contexto de Mendoza, se veía incrementado. Los relatos de mujeres que abortaron en Mendoza antes del 2019 coinciden con los de las activistas mendocinas respecto a la dificultad de encontrar profesionales o servicios de salud donde pudieran asegurarse un buen trato y una situación que no les resultara persecutoria.

Además, para las mujeres que abortaron en ambas provincias, representaba una situación persecutoria tener que hacerse una ecografía previa o posterior a la práctica o tener que ir a una guardia de urgencia mientras se autoadministraban la medicación. En San Luis, las articulaciones entre socorristas y médicas/os estaban aceitadas, pero eran puntuales, escasas y sobre todo con médicos/as del primer nivel de atención. Por lo cual no contaban con profesionales "amigables" para hacer ecografías cuidadas o que estuvieran disponibles en guardias permanentes.

Para sobrellevar el riesgo de una posible criminalización concreta, la mejor estrategia fue manejar información confiable científicamente sobre cómo actuaba la medicación para construir, en los intercambios con las socorristas, un "discurso" creíble y bien informado que no evidenciara que el aborto había sido inducido. Esto tenía sentido para las mujeres a partir de que las socorristas les habían contado que las contracciones uterinas producidas por esta medicación no podían ser diferenciadas de contracciones de inicio espontáneo y que el resultado de ambos procesos era el mismo: la expulsión del contenido uterino. También, manejar esta información las protegía frente a la amenaza de que les harían un análisis de sangre para "detectar" el uso de la medicación. Saber que esto no era posible por tener conocimiento sobre la medicación que estaban usando, les dio el poder de protegerse. Las hizo sentirse "preparadas" y con la herramienta de saber "qué tenían que decir" en caso de tener que ir a un servicio de salud.

> Teníamos la información de las socorristas que nos iban diciendo "en el caso que algo salga mal y tengas que ir a una guardia, decís que tuviste un aborto espontáneo y defendés a muerte esa postura" (Andrea).

> Nunca le dije que había sido por pérdida de embarazo, le dije pérdidas de sangre. Todo eso me lo dijeron las chicas del socorrismo, me ayudaron a armar un discurso, entonces yo más tranquila, con muchas respuestas ya pensadas (…) Me fueron orientando ¿no? Así que eso fue interesante, porque una va… sin miedo (Bárbara).

> Nos decían "puede pasar esta situación de que pueden llegar a encontrar restos de misoprostol por vía vaginal…" te decían lo que podía llegar a pasar y cómo podrías cubrirte, era bastante completo en ese sentido. A mí me re sirvió eso, me re sirvió porque yo decía: "no voy a andar diciendo de que me hice un aborto con pastillas, fácilmente podés decir que estabas embarazada y fue un aborto espontáneo.

> Chau. ¿Qué tanta explicación le podés dar a una enfermera o en una guardia? Si te tienen que atender sí o sí (Kristina).

Es interesante, sobre todo teniendo en cuenta la asimetría de poder/saber tan marcada en las relaciones sociosanitarias entre "profesional-paciente", que las mujeres tuvieran acceso a este tipo de saberes sobre el funcionamiento de la medicación. El saber fue una herramienta para posicionarse y reducir la sensación de inermidad frente a dicha asimetría.

Hubo quienes consideraron necesario u oportuno realizar alguna interacción médica durante el proceso. En estos casos, el recurso valorado fue el acceso facilitado que las socorristas ofrecieron. Sobre todo, en la provincia de San Luis donde existía una coordinación entre las socorristas y el personal de salud denominado por las activistas como "profesionales amigables". Las mujeres lo mencionaron en términos de "red" o "conexión".

> Me contacté con las socorristas y después fui a la médica, es como que estaban conectadas con la médica. (…) Me cuido desde que fui a hacerme la ecografía. Y te atiende re bien, la doctora (Anahí).

> Y las chicas, también, las socorristas fueron las que me sacaron el turno en el hospital, entonces iba tal día tal hora y decía "vengo de parte de las socorristas". Hay una red armada, entonces ahí me hice el control. (…) Fue todo tan rápido, me recontra ayudaron, toda la información, también turno en el hospital para ir a hacerme una eco antes (…) más fácil, está más al alcance (Andrea).

> Justo tuve la suerte que haya un buen médico, predispuesto, en un lugar público. Que llegué a través del grupo de mujeres. En realidad, a través de este grupo es que llegué al médico (Eluney).

> Y después, tiempo después, fui a una ginecóloga que me habían recomendado las chicas que fue muy copada. Muy tranquila, muy bien. A ella se le podía contar. A ella fui a ponerme en orden, para mí fue un recomenzar desde el aborto. Era muy desordenada con los controles ginecológicos (…) (Pato).

A partir de estas articulaciones con profesionales en medicina que las socorristas pusieron "al alcance", pudieron atender aspectos del proceso de aborto voluntario, como por ejemplo realizarse ecografías y

hacer consultas médicas previas o posteriores a la práctica con un buen trato. Y también disminuir la probabilidad de futuros embarazos no deseados para aquellas mujeres que no se encontraban usando un método anticonceptivo pero que deseaban contar con uno, como también recobrar el sentido de autocuidado y orden.

Es interesante señalar que estas articulaciones entre socorristas y profesionales de medicina fueron bidireccionales; así como las activistas las contactaban con profesionales amigables, algunas mujeres llegaron a los grupos socorristas por su recomendación, sobre todo en San Luis.

> [la médica le dijo:] "las chicas te van a asesorar bien, te contienen, podés hablar con ellas de todo, cero prejuicios, para eso están. Te van a hablar claro" (Karina).

> Sí, él me mandó con un grupo [el médico], él me explicó también y me mandó con un grupo de chicas, también que hacen esas cosas. Te ayudan, te acompañan mucho y también me explicaron ellas, te explican, te dicen, están al tanto, sí, sí (Marisa).

Estas articulaciones tuvieron un efecto sinérgico en las experiencias de muchas mujeres, para complementar la información y ampliar la red de apoyo. En general, de las/os profesionales obtuvieron el pedido para las ecografías o consultas puntuales donde robustecer la información o complementarla, cuando sentían que les faltaba. De las socorristas obtuvieron información de forma más detallada, amplia y atenta a la situación singular, saberes construidos en base a sus experiencias previas, así como el acompañamiento telefónico sostenido en el tiempo y mientras estaban abortando, que es el cuarto recurso valorado.

Contar con acompañamiento telefónico mientras usaron las pastillas les hizo experimentar un interés genuino por parte de las activistas por saber cómo se iba desarrollando el proceso. En las interacciones telefónicas las sintieron "atentas", "pendientes", disponibles" y se sintieron "contenidas" y "acompañadas".

> Me sentía contenida por alguien (…) Incluso, nos pidieron los números para que podamos llamar o les mandemos un mensaje y ellas nos devolvían la llamada. Bastante bien (Eva).

> Las pibas se portaron de diez, yo les escribí apenas empezó todo y estaban atentas al teléfono. Es otra cosa (Violeta).

> Esa noche que me lo hice había mucha gente pendiente de mí (…) Bastante interesadas las pibas, la verdad, impecable, "si tenés alguna duda o algo, te sentís mal, querés preguntarnos, llamanos. Vos avisame qué día va a ser, así yo estoy atenta al teléfono, no lo pongo en silencio". Super atentas (Estefanía).

> Te decían que coordináramos cuando yo empezara y estaban atentas ¡Se presentaba! Te decía soy Romina, y siempre te atendía la misma. O no, te decía: "mirá, te va a atender mi compañera" (…) Y te llamaban a ver cómo iba todo, estaba buenísimo, y si estabas asustada, te decían "no, eso es normal" ¡y te dejaban tranquila! Increíble (Betzabeth).

De estos relatos rescatamos el asombro que les produjo el modo de disponerse de las activistas socorristas y de LyF: lo amable y sostenido de la atención telefónica y la presentación con un nombre propio. Estas formas las conectaron con otros modos posibles de abortar acompañadas por personas no conocidas, ya que, en el imaginario de las mujeres lo que esperaban recibir era un trato hostil, despersonalizado o recriminatorio, y lo que experimentaron fue que había personas interesadas en su bienestar. En este sentido, consideramos que el buen trato afectó los procesos de estigmatización y la significación del propio aborto como una experiencia susceptible de reproches y sanciones, a la vez que alimentó significaciones sobre el aborto como un proceso cuidado.

Para algunas mujeres fue crucial el momento en que observaban lo que habían expulsado tras las contracciones uterinas, ya que esa era "la señal" concreta y observable de que la medicación había funcionado bien, de que el cuerpo había respondido como esperaban. También resolvían la incertidumbre de no tener que repetir el procedimiento, lo cual a muchas mujeres las angustiaba. Ver lo que expulsaron fue una experiencia novedosa, algunas no sabían si podrían distinguir lo que verían. Además, esta experiencia se veía interferida por lo que imaginaban que iban a ver. ¿Habría formación fetal?, ¿se parecería a las imágenes de bebés formados que habían visto en las propagandas anti derechos?

En ese momento de alto impacto, contar con la disponibilidad de las socorristas para despejar dudas por teléfono fue lo que se valoró por su efecto tranquilizador y de reaseguramiento. Colaboró en que las mujeres llevaran adelante sus procesos sin sobresaltos y sin tener que ir a

una guardia hospitalaria porque, además de conocer sobre lo esperable en ese proceso, disponían de ellas en caso de que surgieran nuevas dudas, temores o incertidumbres.

> En ese momento fue re lindo que las socorristas me pudieran acompañar porque era la noche y yo estaba con eso. Entonces se lo mando a Ramona [le manda una foto de lo que expulsó a la socorrista] y me dice "Sí, Nadia, sí es" (Nadia).

Hasta aquí hemos desarrollado los recursos y saberes activistas valorados que les permitieron disipar y, así, significar sus abortos como procesos cuidados. Nos interesa destacar que la adquisición y apropiación de estos recursos fue posible por la construcción de una confianza y autorización mutua para intervenir en el proceso de aborto.

La grupalidad: abortar como experiencia colectiva enriquecedora

Otro aporte activista valorado fue el acceso a la grupalidad a través del encuentro entre mujeres que transitaban procesos similares. Cuando las entrevistadas hablaron de sus propias experiencias, hicieron referencias a los modos de abortar de otras y con otras, dando cuenta que sus experiencias habían sido fuertemente relacionales. Consideraron que la participación en los dispositivos grupales a los que fueron invitadas resultó "lindo", "piola", "hermoso", "interesante". Ninguna expresó haber sentido incomodidad al tener que compartir su situación de embarazo no deseado/aborto voluntario con mujeres desconocidas, al contrario.

> Estuvo muy piola, porque fuimos tres chicas, yo recuerdo las situaciones que tenían cada una de ellas [comienza a describir cada situación] (Kristina).

> Tuvimos las reuniones grupales, re grupales. También fue una experiencia redimensionalizadora de la vivencia porque un grupo grande de chicas, siete pibas, una flor de ronda (…) Y había una diversidad de cuestiones sociodemográficas, momentos de la vida, motivaciones, trayectorias desde el momento de la decisión de abortar hasta el momento de haber llegado a la reunión que fue muy muy ilustrativa (Leonor).

> Nos contactamos con ellas, fuimos a una consejería acá en la plaza, no las conocía, fui con mi amiga que me acompañó. Imaginate que fue hermoso, increíble. Fue como un mundo para mí (Pato).

> Fue como interesante sobre todo qué había hecho cada una. Me acuerdo que una había enterrado el feto con su novio y se lo había ofrendado a la Pacha Mama, a ese nivel. Y era como "bueno ¡qué diversidad!" jajaja. Pero, fue divertido en ese sentido. Y el clima era todas muy tranquilas. Eso está bueno también (Vera).

Contactarse con otras mujeres que iban a abortar les permitió descentrarse de la propia experiencia y conocer otras realidades sobre cómo atravesaban una situación común a todas pero que, debido a la diferencia en las circunstancias personales, relacionales y sociales, también era heterogénea. La grupalidad las hizo "redimensionar" las experiencias de aborto y actuó como la puerta a un nuevo "mundo"; gracias a esta manera de abortar pudieron ampliar sus miradas y contactar con otros sentires y modos de resolver y transitar los abortos.

Frente a lo que hemos definido como una situación crítica y compleja, cuyo imaginario social ha sido construido enfatizando lo trágico y malo que es abortar, el compartir el dispositivo grupal a Ernestina la enriqueció emocionalmente en tanto pudo experimentar un sentimiento empático que refirió en términos de "sororidad":

> Nos encontramos en la plaza a un horario, yo no las conocía y nos quedamos hablando tres horas, nos abrazamos como si fuéramos las mejores amigas… la solidaridad, sororidad que encontré en todas es impresionante; fue lo mejor de la experiencia. (…) esta chica a la cual yo no conocía con quien hablaba con una confianza… ¡como si nos conociéramos de toda la vida! Ella me contó cómo había llegado a eso, yo le conté lo mío; si bien nos llevábamos 20 años de diferencia sentí esto… una muy joven, la otra más vieja, pero las dos en una misma situación… (Ernestina).

Además, participar de la grupalidad fue una oportunidad para poner en valor la propia experiencia, al compartirla con sus "iguales" y sentir el entusiasmo de ponerla a disposición para otras mujeres que aún no habían abortado.

> Compartir de igual a igual. Estuvo lindo (Vera).

> Me acuerdo que, en el post que hice, apareció otra chica que estaba yendo a la consejería pre ¡y yo iba a contar mi experiencia post aborto! Buenísimo, muy lindo (Pato).

> Y después de que pasó mi propio aborto, nos convocan a un post, a un acompañamiento postaborto colectivo y nos juntamos en un parque con otras cuatro o cinco chicas que también habían pasado por su aborto (…) Yo ahí mismo les dije que quería militar con ellas, así, ese mismo día. Mi compañera también (Fabiana).

En los encuentros con otras mujeres sintieron apoyo mutuo. Experimentaron vinculaciones empáticas entre mujeres que se encontraban en una situación en común: estar atravesando un embarazo no deseado y buscar la manera de interrumpirlo dispuestas a transgredir las normas sociales y legales.

Transitar parte del proceso con otras y encontrarse con otras realidades en torno al aborto les resultó novedoso porque, socialmente, son prácticas estigmatizadas que deben ser ocultadas y de las que no se puede hablar, ni entre quienes lo han practicado ni entre quienes lo irán a practicar. En cambio, los dispositivos socorristas grupales reúnen a varias mujeres en situación de embarazo no deseado/aborto voluntario y buscan intencionadamente que en ese espacio de encuentro pueda circular la palabra, otros relatos, otras experiencias, para despojar a los abortos de la carga de estigmatización (Socorristas en Red, 2014; Grosso y Zurbriggen, 2016).

Además, en estos espacios donde cada una pudo contar cómo estaba gestionando su propio aborto, se rompe "la verdad" impuesta desde los discursos dominantes que condenan a los abortos a ser prácticas excepcionales, desviadas, culpógenas. La vinculación entre mujeres con diversas experiencias y en diversos momentos del proceso de embarazo no deseado/aborto voluntario les permitió ponerlas en común y enriquecerse colectivamente. De modo que la grupalidad se convirtió en un sostén frente a violencias tales como la imposición de sentidos y afectos dominantes sobre el aborto, la violencia del silenciamiento, de la estigmatización y de la soledad impuesta, es decir, las violencias que trae aparejada la configuración social del aborto como una experiencia abyecta y precarizada donde escasean los sostenes interpersonales, sociales e institucionales para contenerla.

Varias de las entrevistadas y de las amigas que las acompañaron se

incorporaron al socorrismo y comenzaron a ser parte de esta grupalidad de forma más cotidiana y sostenida cuando decidieron acompañar los abortos de otras. A Leonor, contactarse con las situaciones complejas y dificultosas de otras mujeres le generó sentimientos movilizantes de preocupación y percepción de injusticia por las condiciones en que tenían que abortar.

> La situación legalidad/ilegalidad más que miedo, me provocó enojo. Un enojo muy conmovedor que toca la fibra de la injusticia. (…) Los obstáculos tienen pesos diferenciales y yo sabía que los estaba sorteando con facilidad, la parte del enojo vino por la percepción de injusticia (…) Hay minas a las que esto no les sale. Y esa fue la parte que sentí más vivencialmente. Por eso pensaba un montón en la piba esta que estaba con el embarazo tan avanzado. Un poco en ella y un poco en la mujer que era más grande. Habían tenido trayectorias de desencuentros diferentes y la parte del enojo con la clandestinidad, viene por ese lado. (…) Responder a la convocatoria de socorristas era por la idea de que algún paquete de recursos tenía, y era mínimo y justo que pudiera ponerlos a disponibilidad de adonde me llevara este movimiento, a disponibilidad de otras mujeres (Leonor).

El enojo dio lugar a la empatía, fruto del contacto con las dificultades de otras mujeres que estaban transitando experiencias clandestinizadas como ella, pero cuyos recursos eran más escasos pues ella reconocía que había podido "abortar en un entramado de privilegios". Leonor se incorporó al grupo socorrista movilizada por la preocupación y la empatía por la realidad de otras, así como por reconocer que portaba una experiencia valiosa que podría ayudar a disminuir los "pesos diferenciales" de la clandestinización. Estos sentires despertados tras su participación en el dispositivo grupal fueron un motor para la acción de organizarse junto a otras y, desde allí, intervenir en las condiciones "injustas" en que se abortaba. Es decir que participar de la grupalidad promovió la transformación de la emocionalidad en acción activista, luego de practicarse su propio aborto acompañado.

Entendemos, entonces, que el recurso de la grupalidad fue significado tanto como una oportunidad para el enriquecimiento emocional que les sumó bienestar, como para la reflexión crítica y el compromiso con la modificación de las condiciones en que acontecen los abortos clandestinizados. Esto último, en ocasiones, dio lugar a la acción grupal activista para

transformar malestares y condiciones propias de la clandestinización. A la vez que abortar junto a otras trastocó las significaciones estigmatizantes del aborto como práctica solitaria, excepcional y desviada.

Sentidos para cuestionar, desarticular y transformar las significaciones sobre las experiencias

Las prácticas socorristas y sus discursos feministas les aportaron otros sentidos para cuestionar, desarticular o transformar algunas significaciones y malestares respecto a los embarazos no deseados/abortos voluntarios.

Algunas entrevistadas habían expresado la vergüenza y los autorreproches que sentían tras saberse embarazadas. Betzabeth, por tener que atravesar un embarazo no deseado/aborto voluntario más de una vez y tener que pedir ayuda a las socorristas nuevamente, y Ernestina por estar embarazada siendo "una mujer adulta (…) boluda grandota". Ambas esperaban recibir los cuestionamientos y reprobaciones que ellas mismas sostenían, pero la valoración sobre la actitud de las socorristas fue distinta.

> Es que han sido dos [abortos] en un año y medio… 2016. Las contacté, me daba mansa culpa volverlas a contactar, porque ya lo hice. ¡Y las minas menos prejuicios! Me decían: "¡pará, no te hagas drama! Si el tema no es cuántas veces lo hagas sino si vos querés llevarlo a término" (Betzabeth).

> [Respecto a las socorristas] Siempre sentí esto de que no preguntaban nada y solamente decir "lo vamos a solucionar, no te preocupes, te vamos a ayudar". En ningún momento cuestionando ni dando opiniones, porque viste que hay gente que te dice "sos grande, vos ya tenés experiencia, ¿cómo te puede pasar una cosa así? Mirá la edad que tenés". Nunca ningún cuestionamiento de ningún tipo, nada. Era: "no te preocupes, vas a estar bien" (Ernestina).

En este sentido, frente al malestar por el embarazo no deseado que las avergonzaba no circularon "prejuicios" ni "opiniones". Por el contrario, ambas destacaron que las socorristas no contribuyeron a aumentar el malestar ni a culpabilizarlas por quedarse embarazadas a esa edad o de nuevo. Sino que estas interacciones tuvieron el efecto de desdramatizar la situación ("el tema no es cuántas veces lo hagas"). También estas interacciones redujeron el sentimiento de desesperación por tener

que abortar en un contexto lleno de obstáculos, porque les aseguraron con palabras y, luego con actos, que les iban a brindar la ayuda necesaria.

En el orden de los sentidos desestigmatizantes, el análisis de los relatos que refieren a las interacciones con socorristas nos muestra cómo la desacralización del embarazo no deseado y la normalización de las prácticas de aborto afectaron las significaciones sobre la experiencia. Betzabeth destacó la naturalidad con que las activistas hablaban sobre los abortos y la frecuencia de esta práctica. Y Ernestina rescató el modo en que le explicaron cómo sería el contenido de la expulsión tras usar la medicación, usando palabras sin rodeos y lo más descriptivamente posible.

> Te citan, casi todas las semanas ellas tienen reuniones, porque nos dicen que es increíble la cantidad de personas que abortan en Mendoza: "es más de lo que ustedes piensan", nos decían. (…) Nos juntamos a charlar en una plaza. Las chabonas son muy buena onda, en un momento yo estaba con una, pasa una amiga y le dice: "Eh, ¿qué están haciendo?" "Naaaa, acá estamos, charlando del aborto", dice. Jajajaja. ¡Qué grande! ¡Así le dijo! Decís: "joya, esto viene para bien, esto viene bueno" (Betzabeth).

> Nos decía… jajaja ¡de manera muy directa!: "esto va a tener esta forma, de este tamaño, parece, viste cuando masticás la masita que tiene grasa, bueno, así". Así, directo, que estuvo re bien ¡yo le agradezco un montón! Tan directa, con ejemplos, y también no se le movió un pelo (Ernestina).

Las estrategias antiderechos y los discursos religiosos y penales han asociado el aborto con un crimen contra la vida (según el Código Penal) o un pecado de asesinato, y estas significaciones sobre aborto/muerte han dominado los imaginarios sobre las prácticas con repercusiones subjetivas en quienes se lo practican (Fernández y Tajer, 2006). Este tipo de significaciones han sido robustecidas por estrategias de humanización del embarazo/embrión/feto para poner en valor esta "vida" que "se ataca". Todo esto, en detrimento de la vida de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar, y en detrimento de la autoridad de estas para tomar decisiones sobre sus propias vidas, todo lo cual queda en un segundo plano opacado por la construcción de una "persona por nacer"[1].

[1] Estas estrategias de agregar valor a unas "vidas" y restarles valor a otras se van aggiornando en función del momento sociohistórico. Por ejemplo, lo vemos en la modificación

En contraposición a este tipo de discursos, Ernestina, en tanto mujer próxima a abortar, reconoció el impacto positivo de encontrarse con el discurso de la socorrista que, según entendemos, portaba el sentido de desacralizar la "vida" otorgada al contenido uterino que iba a abortar, al compararlo con algo inanimado e incluso del orden del desecho (un pedazo de grasa masticada). De esta manera, se apartó de la significación de interrumpir "vidas" y de humanizar embarazos no deseados, ofreciendo sentidos más acordes al sentir de muchas de las mujeres que buscan voluntariamente abortar. En la experiencia de Ernestina, el aborto era "una decisión" que ella, "una mujer grande", tomaba y que "debería ser lo más normal del mundo, debería ser un trámite como ir al odontólogo porque tenés tal problema".

Betzabeth relató con asombro y alegría los modos en que estaban organizadas las socorristas, a pesar de las trabas y obstáculos del contexto mendocino. Sostenía esto que las socorristas le habían contado, basándose en sus experiencias de acompañamiento cotidiano, sobre la gran cantidad de abortos que sucedían en Mendoza. En parte, también lo había podido comprobar al llegar al encuentro grupal en la plaza y ver a varias mujeres tramitando sus abortos, al igual que ella. También le resultó novedoso el modo en que este encuentro fue realizado, que se alejaba de la idea de estar planeando un crimen. Era el año 2016 y a plena luz del sol, a la vista de cualquier transeúnte, las activistas la citaron junto con varias mujeres que necesitaban información y orientación para abortar con medicamentos. No se escondían ni escondían lo que estaban haciendo, en un intento de traer a la luz una práctica que había permanecido en penumbras debido a los múltiples condicionamientos sociales, culturales, legales que influyen anticipadamente en los modos subjetivos de atravesar la experiencia.

Al momento de la entrevista, Betzabeth sostenía que el aborto se vinculaba con el derecho a decidir y que esto, sumado a su gran ocurrencia, eran la base para solicitar su legalización y su formalización como derecho.

---

superficial del discurso antiderecho que circuló fuertemente en el primer debate legislativo sobre el proyecto de Ley presentado por la Campaña en 2018 sobre *salvar las dos vidas*. La estrategia aquí fue incorporar en el discurso la vida de quien aborta e intentar equiparar la importancia que le otorgaban al significante vida, siendo dos las "vidas" que habría que "salvar" del aborto, entendido como un atentado contra las vidas (la del feto y la de la propia persona que aborta).

> Creo que todos tenemos que tener el derecho a decidir cuándo tenerlo y no tenerlo, yo creo que a eso es a lo que más hay que ponerle fichas. Si cada vez hay más gente a favor de esto, es porque cada vez hay más gente que se hace abortos, también. Gente que pasa por eso y conoce a alguien que pasa por eso (Betzabeth).

Nos interesa pensar y contraponer esta visión que Betzabeth construyó sobre el aborto, que se apoya fuertemente en su interacción con las prácticas grupales y los discursos de las activistas, con la paradoja de la prevalencia de la estigmatización del aborto. Esta paradoja se conforma por el círculo vicioso que se produce a raíz de la estigmatización que recae sobre el aborto y las mujeres que abortan, a quienes se las "marca" negativamente y se las inferioriza, lo cual las lleva a silenciar e intentar ocultar el aborto practicado. A su vez, este silenciamiento hace que los abortos sean percibidos socialmente como algo muy poco frecuente, que no forma parte de la vida y de las necesidades de las personas con capacidad de gestar. Este carácter construido de excepcionalidad lleva a alinearlo con una conducta desviada de la norma y a silenciarla. Así, la estigmatización y el ocultamiento se sostienen circularmente (Kumar, Hessini & Mitchell, 2009).

Sin embargo, en el relato de Betzabeth vemos una microruptura de este círculo vicioso. Primero, cuando se apropió de la idea que le transmitían las socorristas sobre la frecuencia de los abortos, prácticas de "todas las semanas" que se realizaban mucho más de lo que se dice y se puede decir. Segundo, por su participación en un dispositivo grupal que le enseñó vivencialmente que no era la única. De esta manera, se desarmaron las significaciones estigmatizantes sobre aborto como práctica poco frecuente, excepcional y desviada.

En su relato observamos un efecto de desarticulación de la significación del aborto como una práctica que debe ser silenciada, en parte, por la configuración que eligieron para llevar adelante las consejerías. Es decir, al realizar el intercambio grupal y sin ocultarse, al proponer un tiempo-espacio donde poder "charlar de aborto" en un espacio público. En el relato de Betzabeth, a partir de su frase que avecina un futuro esperanzador y un cambio que "viene para bien", lo que observamos es la alegría y la comodidad de vivenciar que se podía comenzar a decir sin vergüenzas que ese grupo de mujeres reunidas en una plaza estaba hablando de sus abortos.

Muchas entrevistadas, más allá de definirse como creyentes en religiones o no al momento de abortar, reconocieron que los sentidos religiosos y morales sobre el aborto habían afectado el modo en que significaban la práctica. El contacto con los sentidos feministas disputó dichas significaciones y repercutió en los modos de atravesar y significar el propio aborto. En el relato de Andrea observamos la transformación de emocionalidades y significaciones al contactarse con otro "punto de vista" que le ofrecieron las activistas, es decir, otros sentidos sobre aborto contrapuestos a los religiosos.

> Yo tenía una idea de algo muy oscuro alrededor de eso. (…) Una vez que pude hablar con las chicas, con las socorristas, me cambió muchísimo a mí la visión (…) me daban otra información, o por lo menos, desde otro punto de vista que, en mi caso, me sacaba de esa cosa oscura, incluso de culpa… porque hay una cuestión de la culpa muy fuerte, por lo menos del punto de vista más de la iglesia y todo eso. Creo que juega mucho el tema de la culpa, ¿viste? (Andrea).

Interactuar con otros sentidos cambió progresivamente sus concepciones sobre el aborto voluntario como algo negativo, tal como lo propone la normativa católica. Y este cambio en la significación tuvo sus repercusiones emocionales en su experiencia, porque transitó el proceso despojada de culpas y "oscuridades". Aprehender el punto de vista feminista le facilitó la reflexión crítica y la transformación de los sentires respecto a lo que estaba haciendo. Además de focalizarse en el propio proceso, pudo extenderse a las condiciones y circunstancias en que otras abortan. De hecho, uno de los motores que la llevó a compartir su relato en esta investigación fue el poder pensarse aportando a los procesos de otras mujeres para, usando sus palabras, "echar luz" sobre los abortos.

Virginia se definió como una persona muy católica mientras cursó sus estudios secundarios, en sintonía con las creencias de su familia, principalmente de su madre. Pero antes de atravesar su propia experiencia a los 21 años, ya se había acercado a discursos feministas sobre aborto que circulaban por internet o en la literatura.

> Cuando era católica, que era muy muy católica, decía: "no, no al aborto, es una persona". Después fui entendiendo un montón de cosas, que no es tan así, son más discursos que te meten, discursos ideológicos para irte formando. Y fui entendiendo todo eso, y también

> fui leyendo… relatos y vivencias, de mujeres que abortaron y por qué abortaron y así… abriendo un montón más la cabeza (…) Leí los relatos del libro este que salió el año pasado, que son relatos sobre aborto. El del año pasado que lo presentaron acá [se refiere al libro *Código Rosa. Relatos sobre abortos*] Entonces, de ahí se me fue abriendo un montón la cabeza y entendiendo que no hay una sola visión, cada mujer tiene sus motivos (Virginia).

El discurso católico se le había presentado como el único posible para dotar de sentidos a los abortos. Esto cambió cuando ella buscó y contactó con otros discursos, ya sea en la literatura feminista o en los relatos que circulaban por internet de mujeres que habían abortado. Contactar con un panorama heterogéneo de motivaciones y de experiencias le permitió "abrir su cabeza" y complejizar su mirada sobre el asunto, lo cual estuvo mediatizado por estas estrategias feministas. Disponer de otros sentidos le permitió elegir cuáles eran los más acordes con lo que ella creía y sentía al momento de enfrentar su embarazo no deseado y, así, salir de un lugar pasivo donde "te meten" los sentidos sobre aborto. Al momento de decidir y tramitar su aborto, esta construcción de sentidos previa contribuyó a que su decisión y el tránsito por la experiencia fueran vividos sin culpas ni dilemas éticos, guiada por una decisión clara, propia y coherente para ella.

En el relato de Eva, quien era creyente y practicante del evangelismo, también observamos esta disputa entre sentidos religiosos y feministas. Inicialmente, lo había significado como una acción transgresora de "todos mis valores personales y familiares", cercano a "lo demoníaco" y que la colocaba definitivamente del lado de las "malas mujeres". Las significaciones que prevalecían eran las de aborto como asesinato y como transgresión. Aun así, abortó con socorristas y en estas interacciones pudo contactar con otros sentidos.

> Sentí mucha seguridad y apoyo en [socorrista]. Antes, para mí, lo que yo iba a hacer era matar a un ser. Pero ella me explicó todo: "es así, es así". ¡Yo necesitaba que alguien me dijera lo contrario! Con ella yo vi que lo iba a poder sobrellevar más. Que lo que estaba haciendo no era, no tenía una magnitud tan grande como yo creía… y si ahora yo pudiera hacer eso por alguien más, lo haría (…) contarle la experiencia y tal vez hacerlo más llevadero para esa persona (Eva).

Este proceso acompañado le ayudó a replantearse lo que pensaba y sentía al respecto, disminuir la culpa que sentía y atenuar el conflicto experimentado, ya que los sentidos feministas le permitieron matizar la significación de aborto como una transgresión extraordinariamente grave y mala asociada al asesinato. El tener disponibles y poder apropiarse de estos sentidos tuvo repercusiones emocionales favorables.

Mientras dialogábamos en la entrevista, agradeció a dios la fortaleza para superar obstáculos que le permitieron crecer como mujer y diferenciarse de aquellos mandatos de género que no se correspondían con sus sentires, tarea en la que también se comprometió junto a su psicóloga a partir de la experiencia de aborto, tal como profundizaremos en el capítulo siguiente. Es así que, dos años después de su aborto, invitada por la socorrista, Eva continuaba construyendo sentidos sobre su experiencia y me ofrecía el relato de una experiencia valiosa que ya no la avergonzaba y que deseaba y pensaba que podría serle útil a otras mujeres.

Aportes a las significaciones y emocionalidades sobre los embarazos no deseados/abortos voluntarios

En síntesis, las valoraciones de las mujeres sobre los aportes de las activistas nos muestran una amplia gama que organizamos en términos de recursos, saberes y disposición; grupalidad; y otros sentidos.

Los recursos, saberes y la disposición de las activistas les permitieron sentir que iban superando algunos obstáculos propios de la clandestinización y así, resolver la "tormenta emocional", al disminuir la desesperación y temores iniciales. Fueron sumando herramientas para protegerse en los distintos pasos que dieron. Pensándolo en función de la tensión entre los riesgos y los cuidados, contar con estos recursos y saberes les aportó mayor seguridad, tranquilidad y apoyo en contraposición a la ansiedad, la inseguridad y el sentimiento de inermidad. Al sentir que contaban con mayor control sobre la situación y herramientas, pudieron ir transformando la significación del aborto como una práctica de riesgo y como un camino lleno de obstáculos, para significarlo como un proceso cuidado.

Otro gran aporte de las presencias activistas fue habilitar la participación en los dispositivos grupales y, con ello, la posibilidad de significar estas experiencias como una oportunidad para el enriquecimiento emocional, al experimentar empatía y aceptación, en contraposición a la reprobación y al rechazo.

Las mujeres pusieron en valor sus experiencias y esto las llevó a ponerlas a disposición para que les sirvieran a otras, a partir de compartir el relato en los dispositivos socorristas y hasta incorporándose en los mismos grupos socorristas que las acompañaron. Así, se situaron como agentes de transformación de una parte de los malestares asociados a las condiciones en que se realizaban los abortos. También el hecho de transitar el proceso junto a otras mujeres que estaban abortando trastocó los procesos de silenciamiento y estigmatización inherentes a la clandestinización. En este sentido, aportó a normalizar la práctica, en un contexto donde históricamente las mujeres han abortado con cotidianeidad y frecuencia, pero han sido inducidas a ocultarlo y silenciarlo.

Finalmente, en las interacciones con las activistas encontraron otros sentidos para significar los abortos y vivirlos emocionalmente con menos culpas y vergüenzas, con mayor coherencia y tensionando algunos sentidos religiosos sobre aborto. De estas interacciones valoraron el buen trato y el tono desestigmatizante de los acompañamientos, lo cual aumentó el sentido de legitimidad de la decisión.

Los sentidos feministas sobre abortar y el carácter grupal de los encuentros desafiaron los lugares de abyección donde quedan colocadas las mujeres que se practican abortos. Es decir, aportaron tanto en la desarticulación de significaciones estigmatizantes como en la construcción de nuevas significaciones que dotaron a estas experiencias de mayor legitimidad, valor y cotidianeidad.

Capítulo 8. Un acompañamiento emocional invaluable: la presencia de las psicólogas

A lo largo del proceso, algunas mujeres buscaron el acompañamiento de psicólogas y lo expresaron como "algo que fue fundamental", "un acompañamiento emocional invaluable", una presencia que "me bancó a muerte". En nueve relatos, las psicólogas aparecieron facilitando el tránsito por las experiencias. Denominamos *presencias psi facilitadoras* a las valoraciones que las mujeres otorgaron y construyeron sobre la interacción[1] mantenida con profesionales de psicología durante el tránsito por las experiencias.

Respecto al momento de estas interacciones, Andrea y Camila lo hicieron una vez que decidieron el aborto, previamente a practicárselo y puntualmente por motivo de esta situación. Bárbara –en su primer aborto–, Virginia, Marcela y Leonor encontraron apoyo durante todo el proceso en un espacio psicoterapéutico que ya se encontraban sosteniendo. Kristina –en su primer aborto–, Eva y Pato las iniciaron luego de realizarse el aborto porque deseaban trabajar cuestiones emocionales vinculadas a esta experiencia.

Las profesionales consultadas fueron todas mujeres y pertenecían a los tres subsistemas de salud; la mayoría al subsistema privado. A excepción de Andrea que consultó en el subsistema público y Camila que interactuó con una psicóloga que conformaba un dispositivo interdisciplinario de trabajo en ILE.

Distinguimos cinco formas de presencias psi facilitadoras: las informativas/orientadoras; las contenedoras; las autoafirmativas de la de-

[1] Preferimos utilizar el término interacción antes que "intervención psicológica" por considerar que es en el encuentro entre ambas personas –y no la actuación de una sobre otra– donde se movilizaron los recursos y las significaciones sobre las experiencias.

cisión; las que validaron capacidades y aprendizajes; y las que permitieron problematizar las experiencias para la resignificación.

Presencias que informaron y orientaron

Ese día que hablé con la psicóloga fue maravilloso, una tranquilidad… (Camila).

Para describir y comprender esta forma de presencia psi nos apoyamos en el relato de Andrea, que abortó en 2016, y de Camila, que se realizó una ILE en 2019. Ambas se contactaron con psicólogas al inicio del proceso de aborto en busca de información y orientación.

Andrea se acercó a una profesional que se desempeñaba en un servicio público de salud porque conocía su trayectoria feminista y de trabajo con perspectiva de género y, por ello, consideraba que podría facilitarle orientación sobre los grupos feministas locales. Poder anticipar que la psicóloga respondería positivamente la habilitó para confiarle su pedido de ayuda que consistía en obtener orientación para conectar con las socorristas. Sobre esta interacción, expresó:

> Yo desde un principio supe que no quería seguir. Entonces me comuniqué con [nombre de la psicóloga] y ella automáticamente me dijo: "venite tal día" (…) a los dos días me dijo que fuera al hospital donde está laburando. Fuimos con mi pareja, fuimos los dos y ahí ella nos habló un montón. Nos contó en términos generales cómo era la cuestión del aborto con pastillas, también desde un lugar… también estuvo bueno por eso, porque ella nos decía: "bueno, el aborto es un fenómeno que no es algo nuevo". Que, si bien uno lo sabe, yo sé que no es algo nuevo… por ahí [lo dijo] con una naturalidad que me hizo relajar un montón. Siempre es algo subjetivo como lo vive uno, pero que te cuenten así, un mínimo marco de la historia, de dónde vienen las cosas y un punto de vista también social, porque eso es una cuestión que tapa mucho. La cuestión social en cuanto al aborto te priva de un montón de información… y ella me la dio (Andrea).

Esta forma de interacción orientadora facilitó el tránsito por la experiencia, a la vez que aminoró la significación del aborto como un camino lleno de obstáculos, sobre todo, el de la desinformación. Advertimos varios motivos para que esto pudiera ser valorado de esta

manera. En primer lugar, porque la demanda fue recibida con celeridad, en correspondencia con la urgencia subjetiva de resolver un estado de embarazo vivido desde la incomodidad, la molestia y la invasión. Sentir la disposición y la sensibilidad por parte de las profesionales frente al pedido de escucha y ayuda urgente es un elemento que también destacaron otras mujeres. Contar con la información y orientación completa y adecuada para avanzar en la gestión del aborto le hizo valorar su aborto como "rápido", "fácil", y "más al alcance". Esto, en comparación con experiencias dificultosas de otras mujeres, que conocía superficialmente, en cuanto a la falta de acceso a la información que al estar limitado por "cuestiones sociales" fue un obstáculo común que las mujeres proyectaban.

En segundo lugar, por el posicionamiento que le transmitió la psicóloga, la "naturalidad" para hablar del aborto. Es decir, que su consulta no fuera tratada como extraordinaria, poco frecuente ni desajustada, lo cual aportó a la construcción de significaciones que tendieron a desdramatizar e insertar la práctica del aborto en las trayectorias colectivas de posibles eventos (no) reproductivos de las mujeres.

No menor es el dato sobre el lugar donde se desarrolló la interacción, en el hospital, como cualquier otra práctica vinculada a la salud y dentro de un marco institucional. En este caso, la psicóloga no recibió la consulta como ILE, posiblemente porque las delimitaciones institucionales sobre lo que era posible de considerar legal o no para ese momento, 2016, no lo permitían. Tampoco la provincia contaba con un protocolo para la atención en ese entonces. Pero su relato da cuenta de un rol de acompañamiento de la decisión y de su tratamiento como una consulta de orientación en salud que se contrapone al carácter delictivo que se le ha imprimido al abordaje del aborto voluntario y que, por lo tanto, alimenta su criminalización.

Finalmente, el tipo y la amplitud de la información recibida, que le permitió contar con una contextualización histórica y social como aporte para construir otras significaciones alternativas al tabú.

Por su parte Camila, que abortó en 2019, desconocía la posibilidad de solicitar una ILE por la causal salud integral y consideraba, en sintonía con el imaginario social imperante, que todo aborto estaba penalizado. Accedió a una ILE gracias a la orientación de una psicóloga de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, a la que contactó de forma casual tras enterarse azarosamente que había acompañado a otra mujer, amiga de una amiga. Es decir que tanto la información que cir-

culaba entre mujeres de manera informal como la existencia de una profesional de la Red favorecieron su acceso a la ILE.

La aprobación del Protocolo de atención de ILE en la obra social había sido reciente, tres meses previos a su aborto. Lo azaroso de saberlo nos habla de una falta de estrategias de difusión real sobre la disponibilidad de este servicio para sus afiliadas. Apreciación que también es válida para el subsistema público de salud y confirmada por una de nuestras informantes clave que se desempeñaba en un servicio público en Mendoza. También lo vinculamos con la estigmatización de la práctica que, aunque legal, continuaba limitada en su posibilidad de decirse; eclipsada bajo la significación de que todo aborto debe ser una experiencia ocultable y reprochable y, por ende, inducida al silenciamiento que muchas mujeres adoptan para protegerse de esa estigmatización.

Frente a esto, Camila valoró el accionar proactivo de la psicóloga y sus efectos emocionales:

> La psicóloga con la que yo me contacté es la que me hizo toda la movida para que yo hablara en OSEP. Mi amiga le escribió (…) La psicóloga la llama y le dice que me pase el número y que yo me contactara con ella y me iba a poder ayudar. (…) Al tiempo le vuelve a escribir, re buena onda la psicóloga, re buena onda y le dice: "¿todo bien con tu amiga? Porque no se ha contactado conmigo, decile que me llame, que yo la voy a ayudar". Así que ese mismo lunes le mandé un audio, me llamó y me explicó que por OSEP se podía hacer, que había un protocolo y que dentro de la mutual se manejan con el artículo 86, súper legal, me explicó cómo trabajaban (…)
> Yo estaba re mal, ese lunes estaba muy mal, había llorado tanto, ¡tanto!, me quería matar. Y hablé ese día a las ocho de la tarde que me fui a la plaza de mi barrio, nunca me voy a olvidar. Y cuando corté ¡fue un alivio! Me cambió totalmente el ánimo después de hablar con ella y relajé, porque además ella súper tranquila. (…) Me dijo "yo te voy a sacar el turno para que vayas directamente a OSEP a charlar con ellas". Ese día que hablé con la psicóloga fue maravilloso, una tranquilidad… ese día había estado re mal (Camila).

De modo que valoró tanto la actitud proactiva y disponible para promover que ella pudiera contar con el servicio, como la información y las herramientas concretas que le brindó para acceder a la ILE. La presencia psi direccionó el ingreso al circuito institucional de aborto legal que, a diferencia de la situación de Andrea y de todas las demás entre-

vistadas, se vio clausurado y no fue ofrecido por ningún/a/e profesional de la salud que consultaron.

En síntesis, las presencias psi informativas/orientadoras fueron valoradas como beneficiosas para obtener información sobre los recursos materiales o humanos necesarios para abortar con medicamentos de manera segura. Conformaron un apoyo instrumental que facilitó el acceso a información o servicios y que estuvo acompañado de un apoyo emocional igualmente valorado, por configurar un trato desestigmatizante. Las presencias psi informativas excedieron el acto de informar sobre lo estrictamente instrumental y orgánico del proceso de aborto; también contribuyeron a que las mujeres se posicionaran con mayor legitimidad respecto al propio aborto, afectando la significación de que el aborto era una práctica excepcional y desviada. En el caso de Andrea, la conversación mantenida "con una naturalidad" la tranquilizó al resignificar la decisión que había tomado, de ser significada como una decisión inadecuada que merece convertirse en un secreto oscuro y ocultable, a ser una decisión más en su propia historia sexual y (no) reproductiva. Para Camila, la tranquilidad se asoció a sentir que contaba con un resguardo institucional y legal que la psicóloga supo transmitirle, frente a la significación del aborto como una práctica de riesgo. La profesional fue significada como una figura de protección, no persecutoria.

Localizamos este tipo de interacciones en los momentos previos a la práctica del aborto y destacamos que las condiciones legales-institucionales en las que se insertaron determinaron qué tipo de información y herramientas fue posible obtener.

Observamos que la diferencia en las condiciones en que Andrea y Camila abortaron (respecto a los marcos regulatorios institucionales y legales en 2016 y en 2019 respectivamente) determinó el tipo de información y de recursos ofrecidos y obtenidos en una interacción psi informadora/orientadora. Es así que la presencia psi inscrita en la legalidad tuvo mayores posibilidades de acercar recursos institucionales. Y la información/orientación que no pudo inscribirse en la legalidad acercó recursos feministas y menos institucionalizados. Tener información y orientación sobre cómo abortar conlleva un efecto tranquilizador y matiza la significación del aborto como un camino lleno de obstáculos y como una práctica de riesgo.

Presencias psi contenedoras

Un abrazo sin abrazo (Leonor).

Esta forma de presencia psi se monta sobre las valoraciones que refirieron a estas interacciones como espacios de expresión y de escucha respetuosa, centrados en las necesidades de las consultantes y carentes de los enjuiciamientos morales que esperaban recibir.

Bárbara, en su primer aborto, necesitó compartir las preocupaciones, los temores y las vicisitudes contenidas en esta experiencia, lo cual se encontraba ferozmente limitado por las condiciones de silenciamiento y soledad que caracterizó este aborto. La presencia de su psicóloga se configuró como ese espacio de expresión.

Marcela relató que la manera de estar de su analista fue imprescindible para poder "transitar todo esto", siendo la única persona con la que pudo expresarse genuinamente.

> Fue el único espacio donde lo podía hablar y decirle lo que se venía a la cabeza en el medio del llanto, de la crisis. Y la verdad que, en ese momento, yo creo que fue lo que a mí me sostuvo. Porque, aparte, no había manera de que yo lo pudiera hablar con nadie en ese momento. Y yo creo que ella estuvo como a la altura de las circunstancias. (…) No sé cómo hubiera sido transitar todo esto sin esto, no se me ocurre (Marcela).

Ambas no contaban con un entorno afectivo que las hiciera sentir contenidas emocionalmente, por lo cual la escucha activa y desprejuiciada de las psicólogas se volvió fundamental. Actuó como un continente de emociones y malestares que ellas pensaban que difícilmente podrían ser alojados en otros vínculos o espacios interpersonales.

Las presencias psi contenedoras fueron caracterizadas como "disponibles", "éticas" y "profesionales".

> (…) ¡con mi analista que me bancó a muerte! O sea que veía que yo tenía unas crisis que eran espantosas entonces ella estaba. (…) Ella estaba muy pendiente. Inclusive llamándome por teléfono para, al menos tranquilizarme cuando veía que ya no podía pensar y estaba desesperada y yo me quería morir y que ya no había soluciones. (…) Aparte una cuestión de ética de su parte, me parecía a mí, porque era

> este respeto. Ella estaba interesaba por lo que a mí me pasaba en ese momento, por lo que yo estaba pasando, por ayudarme a pasar ese momento, por ayudarme en lo que fuera necesario. Y jamás hubo alguna cosa que yo pudiera sentir "me estás juzgando" (Marcela).

> Nunca cuestionó la decisión (…) fue siempre estar atenta a cómo me sentía, cómo era el procedimiento, qué márgenes de comodidad y seguridad afectiva yo estaba manejando (Leonor).

> Ella lo manejaba, profesional, preguntándome cómo me sentía, qué pensaba hacer, por qué pensaba abortar (Virginia).

Las mujeres valoraron como ético y profesional que las psicólogas priorizaran la situación emocional singular de cada cual. Esto les permitió experimentar un encuentro donde realmente atendieron sus deseos y necesidades concretas ligadas a la interrupción de esos embarazos, y que no estuvo sesgado por prejuicios, visiones biologicistas y patriarcales sobre la relación mujer-embarazo, ni por la idea de un supuesto instinto maternal, ni por el estatus legal o moral del aborto considerado en abstracto. La disponibilidad también se valoró en función de sentir la actitud empática frente a la urgencia por resolver la situación que avanzaba inexorablemente, o al percibir el contacto con la profesional como accesible y como un espacio seguro donde poder atender lo que les sucedía sin sentirse juzgadas.

En su relato, Leonor contó que antes de compartir su situación de embarazo no deseado y su decisión de abortar, necesitó asegurarse de que no iba a ser juzgada. Por ello, le solicitó expresamente a la profesional, con quien sostenía un vínculo terapéutico de larga data, que le clarificara cuál era su posicionamiento personal y técnico respecto al aborto y cuáles era los discursos psi a los que adhería.

> Yo hacía análisis con ella hace mucho tiempo, psicoanalista lacaniana. (…) le dije que tenía que preguntarle algo de cuya respuesta dependía el resto de la sesión: "necesito saber en este momento cuál es tu posición respecto del aborto". "Yo pienso que, en ese y en muchísimos otros temas, cada persona tiene que hacer con su cuerpo lo que considere necesario, pertinente y acorde a su deseo, momento de vida, lo que mejor haya logrado". (…) Me iba a ir, eso es cierto, si la chabona me decía "a mí me parece que la vida… del feto… o que la mamá deseante… que el embarazo no deseado no existe porque el deseo está operando desde

> no sé dónde… bla bla bla", me iba a ir. Me iba a doler un montón, iba a ser un punto de revisar toooodo lo que había hablado y trabajado con ella. Y fue re lindo no tener que hacerlo, fue un abrazo sin abrazo (…) Reafirmó hasta el proceso mismo de análisis con ella (Leonor).

Leonor contaba con una particularidad que la resguardó frente a una posible intervención iatrogénica: debido a su profesión conocía que algunos discursos psicoanalíticos apelaban a determinismos inconscientes para atribuir de manera universal a todas las mujeres un "deseo de hijo". Este recurso explicativo, cuando se utiliza de manera indiscriminada y descontextualizada, es decir, homogenizando las singularidades de cada situación de embarazo, puede dar lugar a intervenciones que consideramos como violencias simbólicas, porque operan imponiendo sentidos. Configuran dispositivos de control y estigmatización que, desde el campo psi, se suman a otros provenientes de ámbitos como el religioso o el legal. Y en este sentido, son parte de los dispositivos de fragilización de género sobre la salud mental de las mujeres que abortan.

Leonor, desde sus conocimientos teóricos previos, pero también desde su experiencia encarnada de no sentir deseo por continuar ese embarazo, se negó a asumir los efectos de verdad de este tipo de discursos y a involucrarse, eventualmente, en una interacción psicológica que cuestionara su sentir. La respuesta que obtuvo de su analista, sentida como "un abrazo" da cuenta de la función empática y contenedora que sentó un piso sólido para el desarrollo de las demás interacciones que acompañaron su proceso. De modo tal que esta presencia fue "un acompañamiento emocional invaluable".

Nos interesa señalar, entonces, que la clarificación del posicionamiento técnico e ideológico, que puede ser verbal o actitudinal, actuó como la condición previa para dejarse acompañar y sentirse contenida de manera ética.

A partir de lo expuesto sintetizamos que las presencias psi contenedoras fueron aquellas valoradas como un sostén emocional, máxime cuando los apoyos eran limitados en el entorno afectivo cercano. Estas presencias se sintieron como compañías respetuosas, disponibles, receptivas ante la urgencia subjetiva sentida, libres de juicios morales y por ello, éticas y profesionales. La manera en que alojaron las necesidades emocionales de las mujeres próximas a abortar trastocó las significaciones del aborto como una experiencia reprochable, de modo que contrarrestaron las estigmatizaciones percibidas e interiorizadas por algunas mujeres.

Las presencias contenedoras son el trasfondo de las demás interacciones facilitadoras a lo largo de todo el proceso. Comprendieron y respetaron la decisión de abortar y generaron el espacio para experimentar una interacción sensible a los diversos aspectos que cada cual deseó trabajar.

Presencias psi autoafirmativas de la decisión

> *Entender que, a veces, no todo embarazo es deseado y que no siempre al embarazo lo tenés que continuar si no querés* (Bárbara).

A continuación, tomamos los relatos de Bárbara y Andrea para describir y comprender el aporte de las presencias psi autoafirmativas de la decisión de abortar.

Bárbara había decidido su primer aborto en medio de la disyuntiva entre su deseo de interrumpir el embarazo y sus creencias de que el embarazo era un castigo merecido por mantener relaciones sexuales, y como tal, una obligación que debía asumir. En ese entonces, se encontraba sosteniendo un vínculo psicoterapéutico que fue fundamental para tramitar emocionalmente la decisión de abortar en términos de autoafirmación:

> Algo que fue fundamental para mí, en ese momento, que yo lo estaba viviendo con alguna carga "catolicucha", ¿no? (…) entonces yo lo vivía con un poco con culpa. Yo estaba en tratamiento psicológico y ahí mi psicóloga me ayudó a entender y a pensar cómo había sido esa situación de embarazo (...) algo que me dijo y que me ha quedado bastante marcado para pensar es: "lo biológico, vos no estás dejando que lo biológico le gane al deseo. Hay una cuestión que es el deseo de tener un hijo y otra que es un embarazo biológico. Vos tenés que elegir qué querés: si va a ganar lo biológico sobre vos o va a ganar el deseo, de que vos no querés tenerlo" (Bárbara).

Antes de realizarse el aborto, sus necesidades emocionales se centraron en reconocer y darle entidad a su condición deseante, y poder resolver la tensión y la culpa que le generaba por entrar en conflicto con sus creencias.

El trabajo sobre la decisión autónoma es fundamental en estas situaciones. Implica dejar de significar el embarazo como un hecho "natural" e inmodificable, para pensarlo como un proceso pasible de ser problematizado, como un evento que tiene una base orgánica, pero

sobre el cual se puede intervenir de acuerdo a las condiciones que cada mujer reconoce como propias; no solo las condiciones materiales y simbólicas, también las deseantes (Pistani y Ceccato, 2014).

En la interacción con la psicóloga, Bárbara logró instalar la diferencia entre la condición deseante y la condición biológica ("el deseo de tener un hijo y un embarazo biológico"), para jerarquizar y autoafirmar su deseo y, con ello, abandonar el discurso determinista y naturalista sobre el embarazo como el dato natural y verdadero que sostiene la ecuación Mujer = Madre. Problematizar la obligatoriedad de la ligazón embarazo-hijo-maternidad aportó a la construcción de su decisión con mayor firmeza y legitimidad para actuar de acuerdo a su deseo y provocó un efecto desculpabilizador.

> Me parece fundamental entender que a veces no todo embarazo es siempre deseado y que no siempre al embarazo lo tenés que continuar si no querés. (…) Lo pude vivir que era una elección entre mi subjetividad o que ganara algo de afuera, que es un adentro, que era como la naturaleza: el mandato biológico. Bueno, lo que hice fue elegir mi vida, básicamente (Bárbara).

El acompañamiento de la psicóloga le permitió afirmarse en la decisión de interrumpir el embarazo no deseado significándola como una decisión a su favor y no como una transgresión, elegir su vida.

Por su parte, Andrea valoró que la interacción con la psicóloga que la orientó con "naturalidad" y le acercó "un punto de vista social" también constituyó un aporte para autoafirmarse en la propia decisión, con repercusiones en el modo de significar y transitar su aborto voluntario.

En su experiencia, como en la de Bárbara, muchos de los sentidos previos a su aborto habían sido construidos durante la niñez y la adolescencia, en correspondencia con los discursos católicos que tuvo disponibles. Refirió haber visto en la escuela por obligación el documental *El grito silencioso*[2] y recordó haber sentido un gran impacto emocional al ver folletos en la calle que enunciaban que el aborto era un asesinato. Sumado a esto, la muerte de una compañera de colegio por un aborto

[2] El documental producido por la organización antiaborto National Right to Life Committee en 1984 (Estados Unidos) ha sido ampliamente criticado y desacreditado por la comunidad médico-científica estadounidense al considerar que sus imágenes son engañosas y que sostiene afirmaciones y alusiones falaces, entre ellas, sobre los serios problemas psicológicos en las mujeres que abortan (Planned Parenhood Federation of América, 2002).

inseguro y el posterior silenciamiento en la escuela sobre las causas de este fallecimiento, la penalización del aborto y la falta de contacto con otros discursos o posiciones alternativas, fueron la materia prima de la construcción de sus significaciones sobre aborto en la adolescencia: como una transgresión que despertaba reprobaciones y sanciones y, por lo tanto, como un secreto terrible y avergonzante que debía ocultarse. Decidir abortar era cargar con este peso. Pero, cuando atravesó su propia experiencia, la presencia facilitadora de la psicóloga junto a las presencias de las activistas feministas, le ayudaron a desarmar estas significaciones porque pudo ponerse en contacto con otros sentidos y experiencias sobre el aborto.

> Ella [la psicóloga] me contaba de otro caso de una chica, conocida mía, que ella lo hizo público, a la interrupción del embarazo, porque ella quería que se supiera para echar luz justamente. Eso me abrió un montón la cabeza. Me hizo pensar: no tengo que estar ocultando algo. Yo lo puedo compartir o no, pero no es un secreto que tenga que guardar. [...] Y de repente si pasa [la práctica de abortar] un montón y ha pasado un montón y un montón de mujeres con las que te relacionás seguro también han pasado por eso. Y eso te quita un peso. Decís: "bueno, pará, no estoy haciendo nada terrible, oscuro" … como la otra mirada opuesta, ¿no? La que quiere evitar que el aborto sea algo legal, que ha estado metiendo cosas en la cabeza de todos (Andrea).

El silenciamiento y la estigmatización van de la mano, por ello la mayoría de los abortos carecían de rostros y de nombres propios, y por extensión, de aparente y concreta existencia. Sin embargo, esta forma de interacción tuvo un efecto normalizador. Abrió la posibilidad de significar su experiencia de forma alternativa al secretismo social, así como también reconocer algunos de los anclajes sociohistóricos, políticos y de género en torno a la práctica que la presentan como una vivencia excepcional, avergonzante y que debe permanecer en silencio. Esto afectó la estigmatización y le permitió otorgar legitimidad a su decisión. Primero, porque su decisión fue alojada y contenida empáticamente, sin que se pusieran en juego valoraciones peyorativas sobre la práctica ni sobre las personas que la realizan, lo cual aminoró su sentimiento de inadecuación. Segundo, al conectar experiencias entre mujeres y darles entidad –incluso en el relato de Andrea, el nombre y el rostro de alguien que ella conocía–. Lo cual le presentó la práctica como frecuente, no

excepcional y que podía ser atravesada de diferentes formas, no solo desde el secretismo y a las sombras de la estigmatización.

> (...) Y creo que es mejor traerlos así, mirarlos de frente [a los secretos] y poder vivir con ellos de frente, no de atrás. Con el aborto es lo mismo, en cuanto a lo social creo que ese es el camino: tiene que venir por el lado de la luz, de la legalidad, de lo que todos veamos y podamos hablarlo, no que lo tengamos guardado (Andrea).

Normalizar la práctica y comprender los orígenes de los sentimientos consonantes con los discursos dominantes sobre el aborto como un secreto terrible y transgresor le permitió a Andrea transitar una experiencia más saludable y no persecutoria, más "relajada". Además, comprender el origen social de ciertos modos de sentir sobre los abortos propició una transformación en las significaciones, esta vez asociadas a la luminosidad, la palabra, la elección y las decisiones a favor de una misma.

En síntesis, las interacciones autoafirmativas fueron beneficiosas para afirmarse en la decisión de abortar, tras problematizar y transformar significaciones sobre el aborto como transgresión o secreto terrible y asumir otras que las reafirmaran en el proceso que habían emprendido coherentemente con sus propias necesidades y sentires sobre esos embarazos. Normalizaron la práctica y afectaron los sentimientos de inadecuación y de silenciamiento obligado. Las formas de normalizar las prácticas de aborto en estas interacciones fueron estableciendo conexiones con experiencias similares de otras mujeres y aportando elementos para contextualizar sociopolíticamente las significaciones de aborto como lo transgresor, lo incorrecto, lo excepcional.

Presencias que validaron la capacidad de decidir y actuar

> *Me ayudó a reafirmar que estuve bien, que lo resolví* (Pato).

Algunas entrevistadas mencionaron que las interacciones con las psicólogas les permitieron un "encuentro consigo misma" o poder "verse a mí misma" enfrentando una situación accidental e inesperada que no habían imaginado que podrían transitar y enfrentar. En la interacción psi pudieron reconocerse capaces y con recursos para resolver la crisis, reconocieron "cambios" subjetivos y aprendizajes.

> Una no vuelve a ser la misma que era. Fue re loco que me escribieras, hace un año que lo he hecho y justo hablaba con mi psicóloga que, qué distinta que estoy del año pasado. (…) Nunca organicé nada, ni una salida al centro, de repente tenía que organizar cómo me iba a hacer un aborto, en qué momento, todo eso. (…) Y, por lo menos a mí, que en ese momento iba a la psicóloga por otras cosas, me sirvió para eso, encontrarte con vos misma, poder tomar tus decisiones, poder decir hasta acá sí, hasta acá no (Virginia).

En el relato de Virginia, su aborto aparece como un punto de inflexión donde puso en juego múltiples capacidades, como la de decidir, la de organizarse en pro de esa decisión, la de gestionar lo necesario para concretarla, todo lo cual, tras superarlo, la hizo sentirse "distinta".

Por su parte, Leonor relató que en el transcurso de la terapia logró reconocer aprendizajes adquiridos a partir de transitar la situación crítica. Los aprehendía como nuevos recursos para comprender sus signos corporales, antes ubicados en el orden de lo indescifrable. Esto cobró un especial sentido en el entramado de su historia personal que revisó junto a la psicóloga.

> Eso también fue bastante revelador en el curso de la experiencia de análisis, yo insistía en que tenía un historial muy fuerte de desconexión con mi cuerpo y mi analista me incitaba a revisar esto: "podés haber tenido un historial, pero tu historia está cambiando, te diste cuenta de que estabas embarazada antes que la mayoría de las mujeres se dan cuenta, en el primer día de falta" (Leonor).

Los aprendizajes reconocidos como propios le permitieron lograr una sensación de mayor habitabilidad de y en su cuerpo. También refirió otro aprendizaje que validó en compañía de la psicóloga y que, luego, pudo trasladar a otras situaciones críticas o conflictivas de su vida laboral y afectiva: su capacidad de tomar decisiones "contundentes" y de sostener acciones coherentes.

> [la psicóloga] me devolvió una imagen de la solidez de mi decisión que, como imagen externa… eso terminó de cerrar más tiempo después de concluido el aborto. Alguna vez, ella hizo referencia en términos de algún otro asunto afectivo o laboral –que son mis grandes temas–, a que no desconfiara de mi capacidad de decisión, que ella me había visto de frente un día que, si su respuesta no me satisfacía,

> yo me iba a levantar y me iba a ir. "Y estaba clarísimo que vos no seguías con este espacio si no era en concordancia con lo que querías hacer", dijo. Entonces fue un juego de devolverme esto de la contundencia de la decisión (Leonor).

En este caso, la decisión contundente a la que se refería era la de terminar el vínculo terapéutico si sentía que la psicóloga cuestionaba su voluntad de interrumpir el embarazo y no se mostraba dispuesta a acompañarla de la manera en que necesitaba. La experiencia fue aprehendida como una oportunidad para validar lo "contundente" que pueden ser sus decisiones y esta validación, según expresó, le otorgó mayor confianza para el futuro, al momento de tener que tomar y sostener decisiones fieles a sus deseos y/o necesidades.

En síntesis, las presencias psi que las validaron en sus capacidades les permitieron visibilizar que contaron con recursos para atravesar y resolver la situación crítica, y que estos pueden ser extrapolados a otras situaciones vitales de toma de decisiones o de puesta de límites a favor de sí mismas. Este reconocimiento aportó a los procesos de construcción de autonomía subjetiva, entendida como la capacidad de las sujetas de discernir los propios deseos e intereses y emprender acciones acordes a esto (Fernández, 2021). En general, registramos este tipo de interacciones en los relatos sobre los momentos posteriores a la práctica de los abortos.

El proceso reflexivo emprendido junto a las psicólogas les permitió resignificar la crisis en términos de oportunidades para ganar aprendizajes. Frente a las situaciones críticas inesperadas y signadas por la actuación de múltiples dispositivos de poder que tienden a la fragilización de las mujeres, se reconocieron enriquecidas y fortalecidas tras transitar las experiencias. Consideramos esto como una muestra de la capacidad de resistencia frente a estos dispositivos, lo cual involucra un esfuerzo que es personal y también relacional, en la medida que supuso acompañamientos que favorecieron los procesos de construcción de salud mental.

Presencias que ayudaron a problematizar y resignificar

> *Empecé a reconstruirme desde adentro* (Eva).

Esta última forma de presencia psi se vincula con las valoraciones sobre las interacciones que aportaron a los procesos de problematización en

momentos posteriores a la práctica y que se ampliaron a otras situaciones o aspectos de la vida de las mujeres que abortaron.

Eva demandó el espacio psicoterapéutico luego de experimentar un intenso malestar emocional, tanto por significar el aborto como una transgresión a los mandatos religiosos y familiares como por el modo en que abortó, especialmente por la presencia no empática del varón que frustró sus expectativas de ser acompañada. En su relato se dedicó a compartir estos malestares, así como las "duras" interacciones con la psicóloga:

> Al principio fui a exponerle mi problema, de por qué estaba así (…) y como que no me empalmó por ese problema, me fue buscando más cosas y terminé descubriendo que mi problema estaba más enraizado con cosas pasadas de mi familia, de la sumisión, de lo que me habían hecho creer antes, de la falta de toma de decisiones propias y salió un montón de culpa. El primer día salí muy mal porque pensaba: "yo no te fui a hablar de esto, yo quería que me ayudaras con esto ¿por qué me tocaste este otro tema?". Pero después, al pasar las sesiones, empezaba a sentir rabia, enojo, eran muchas emociones. Fui entendiendo que todo esto que me había pasado desencadenaba cosas de antes no solucionadas con mi familia, de la sumisión de mi mamá, porque mi mamá es bastante sumisa, bastante antigua. Y del dolor que me causa ver cómo mi papá maltrataba a mi mamá psicológicamente. (…) Ella me dijo: "¿quién te juzga por lo que hiciste? Nadie lo está haciendo, solamente vos te juzgás, quizás vos te perseguís sola, tenés que solucionar esto de atrás para poder estar mejor". Lo transité, fue bastante duro, fue bastante fuerte (Eva).

Eva se encontró en una interacción que lejos de estigmatizarla o de juzgarla, la impulsó a problematizar desde "pensamientos muy actualizados" los orígenes de sus malestares y de los feroces y sistemáticos autorreproches que se realizaba. Pudo problematizar algunos de sus atravesamientos religiosos y familiares que antes no había cuestionado y que configuraban el estándar moral desde el cual medía su accionar. Poder poner en palabras esta situación, enmarcada en su propia historia, representó un primer paso para enfrentarse con el estigma percibido e interiorizado. A partir de recibir una respuesta contenedora que no lo confirmaba, se encaminó a superarlo y a resignificar su autoimagen como mujer que había abortado y los sentimientos que esto le generaba. Pudo situar esta experiencia en su propia historia vital y relacional, con sus particulares atravesamientos de género, y pensarse

tomando decisiones legítimas, a su favor. Al hacer un balance del proceso terapéutico, expresó:

> Me dio muchas herramientas para poder trabajar en lo mío y esto [el aborto] pasó a segundo plano y como que yo empecé a reconstruirme desde adentro y desde más pequeña (…) Y es difícil, pero tenés que trabajar en vos misma y dejar de juzgarte. Te lo vuelvo a repetir: es algo que me ayudó a solucionar problemas que yo tenía bastante adentro, que estaban tapados y que, gracias a esto, ahora te puedo decir que vivo las cosas de diferente manera (Eva).

La presencia psi habilitó la problematización, a partir y más allá de la situación puntual del aborto, de aspectos de su historia que incluían las relaciones de género de dominación-sumisión entre personas significativas de su vida –su padre y su madre– y la posibilidad de tomar decisiones como una mujer adulta. Eva pudo cuestionar los modelos de género inculcados en su familia y los valores morales de la religión que alimentaban el estigma interiorizado y los autorreproches. Todo lo cual se enmarcó en, pero también excedió, los malestares vinculados a la situación de embarazo no deseado/aborto voluntario y le permitió comprenderlos en su intensidad y singularidad para dejar de sufrirlos.

El relato de Eva muestra el profundo cambio subjetivo, la metamorfosis del dolor, a partir de transitar la experiencia en compañía de la presencia psi facilitadora: de ser "víctima" de su decisión, pero también su propia verduga, a reconocerse como una persona con la fortaleza necesaria para poder atravesar la situación crítica y construir aprendizajes, llegando a expresar: "… me siento orgullosa de cómo salí. Fue una lucha…" (Eva).

Kristina también expresó la necesidad de comenzar un espacio psicoterapéutico luego de su primer aborto debido a los intensos sentimientos de culpa que experimentó.

> Entonces yo decidí abortar. Más allá de que después me trajo una serie de complicaciones mentales, me dejó muy mal, terminé yendo a la psicóloga (…) Después de hacerlo sentí mucha culpa. (…) en el 2015, era el tabú todavía, aún sigue siendo muy tabú. Era la culpa de matar a una persona, de asesina (…)
> [su ex novio] dijo: "está todo bien, yo te apoyo, quiero que vayamos, si tenés que ir al psicólogo, te lo pago". No tenía ningún problema. En algún punto, sentía que se lo debía, era sentirme como culpable

> de que no había aceptado algo que era nuestro. Era culpa. Que después la psicóloga me dijo: "no, en realidad, era por la presión sobre tu cuerpo de la sociedad, de ese imaginario de que las mujeres tienen que cumplir cierto rol, bla bla bla". Me hizo desmenuzar todo eso en las sesiones (Kristina).

En estos fragmentos observamos algunos elementos clave sobre las significaciones sostenidas que alimentaban la construcción de la culpa, sobre todo por significar su aborto como un asesinato y una transgresión de las expectativas sociales dominantes que pesan sobre las mujeres. A la vez, la eficacia de dichas significaciones se vio potenciada por las violencias psicológicas en la relación de pareja y por la asunción de la significación del aborto como un atentado contra un bien común de la pareja y, por ello, una decisión egoísta.

Problematizar y comprender algunos de los anclajes sociales y relacionales que le ocasionaban malestar en torno a esta primera experiencia, le permitió apaciguar la culpa sentida y dejar de significarlo como una decisión egoísta y como una transgresión. A la vez que pudo revisar la relación con esta pareja y ordenar otros aspectos de su vida, contactar con sus "prioridades": "La psicóloga me ayudó muchísimo a ordenar un montón de cosas: prioridades, la facultad, si la relación con mi ex valía la pena o no y que no tuviera culpa, que me liberara de la culpa que tenía" (Kristina).

Esta problematización y construcción de herramientas le fue de gran ayuda para construir otros modos de afrontar y vivir su segundo aborto tres años después, sin sentir que su vida emocional se desestructuraba y sin necesitar el acompañamiento psicológico porque contaba con "los pasos que me había dicho [la psicóloga] para reestructurarme yo misma, eso me ayudó bastante".

Es así que Eva problematizó los mandatos religiosos y familiares y se resignificó como una mujer adulta que tomó una decisión a su favor y Kristina problematizó aspectos de su relación de pareja y resignificó cuáles eran sus prioridades.

En el último relato que presentamos, el de Marcela, observamos que lo que necesitó resignificar fue su posicionamiento frente a los efectos subjetivos de las violencias sufridas en la experiencia.

Las violencias que relató recibir fueron perpetradas tanto por médicos y ecografistas, de quienes recibió humillaciones, desamparos y otras formas de malos tratos, como por el varón responsable del emba-

razo que, por momentos estuvo presente de formas no empáticas, en otros momentos se ausentó y, luego del aborto, la acosó. A partir de todo esto, encontramos dos grandes puntos de elaboración y resignificación. Primero, la elaboración del riesgo al que se sintió expuesta en esta experiencia límite, expresado en la necesidad de emprender un proceso de recuperación de la integridad física y emocional notablemente afectada y susceptible de ser perdida, lo cual expresó en términos de "duelo". Segundo, la elaboración de las violencias sufridas durante y posteriormente al embarazo no deseado/aborto voluntario por parte del varón, junto a la resignificación de su posicionamiento frente a esto.

En cuanto al primer punto, Marcela en su espacio psicoterapéutico pudo recuperarse de una experiencia vivida como agotadora, de supervivencia y de intensa exposición corporal, de riesgo vital que, en sus palabras, la mantuvo "al borde de la muerte". Luego del "alivio físico" que sobrevino tras concretar el aborto, refirió haber comenzado "otra cosa y que tenía que ver también con un duelo", tras haber estado diez semanas y media "donde había puesto el cuerpo de una manera que, como nunca en toda mi vida me había sentido tan al borde de la muerte". Reflexionando en la entrevista, consideró que la vivencia de sentirse "expuesta, humillada, caotizada, desesperada y totalmente manoseada por este sistema médico", sumado al tiempo de espera y de gran incertidumbre hasta poder concretar el aborto, habría sido distinta de no haberse visto envuelta por los intereses de lucro de los médicos a los que consultó inicialmente. Lo que abordó en su espacio terapéutico fue el alto costo emocional por la exposición a las violencias de una práctica significada como riesgosa y estigmatizante, a punto tal de ver afectada su integridad.

En cuanto al segundo punto sobre la presencia/ausencia violenta del varón, gran parte de su relato estuvo centrado en describir y reflexionar sobre las formas de hostigamiento e intimidación que sufrió por parte de este hombre, los sentimientos de impotencia que le había generado su presencia/ausencia y lo "vulnerable" que se sentía frente a él. Cuando ella se negó a continuar la relación, sintió una actitud acosadora, solapada ante los ojos de las demás personas, que ella calificó de "perversa" por parte de este hombre con quien compartía cotidianamente el espacio laboral. "Era tan... por eso yo digo que me suena como una cosa perversa, esta imagen del buen compañero y del tipo amable y paciente y demás, que lo muestra así delante de todos. Y yo conozco la otra versión" (Marcela).

La intromisión en el espacio físico y mental por parte de este varón le generó un sentimiento de humillación, en sus palabras de "paralización" y "vulnerabilidad", y también de "asco" y "repulsión" frente al acoso.

En su relato advertimos el daño emocional y el lugar de centralidad que ocupó esta forma de presencia, debido a lo cual necesitó trabajar su posicionamiento frente a estas violencias en su espacio psicoterapéutico. Este trabajo emocional no estuvo centrado en el acto de abortar –que fue la materialización de una decisión propia– sino en la elaboración de las violencias vividas y en lograr desprenderse del padecimiento que le generaban los recuerdos penosos, así como en poder recuperar el espacio mental fuertemente invadido. Estos son trabajos emocionales característicos de las mujeres que sobreviven a las violencias de género en el marco de dinámicas de pareja con varones violentos (Hirigoyen, 2008; Velázquez, 2010).

En la interacción psi refirió encontrar herramientas para elaborar y protegerse de esta presencia que la acosaba cotidianamente con gestos, susurros y palabras que le resultaban muy perturbadoras y la mantenían en un clima de tensión y agotamiento emocional.

> Ahora es como que me siento como un poco plantada desde otro lugar (…) Esto ha ido cediendo en parte porque, bueno, después de mucho trabajo, después de que pasó el tiempo [suspira] y un par de cosas, las veces en él se ha tenido que dirigir a mí de más yo creo que me he mostrado como menos vulnerable. (…) yo le sostengo la mirada y le contesto con mucha firmeza y con una distancia, yo creo de acá a la China. No me tiembla la voz, no siento nada en el cuerpo, no me siento sonrojada (Marcela).

Tras identificar los ataques, pudo problematizar su lugar de receptora pasiva de esa violencia psicológica. En contraposición a lo que indica el pensamiento dicotómico, que ubica a la víctima en el lado de la pasividad y al victimario como totalmente activo en su acción de hacer sufrir y victimizar, los procesos de supervivencia que emprenden las mujeres implican una elaboración activa de estrategias de acción y transformación para superar, resistir o evitar esas violencias (Kirkwood, 1999; Velázquez, 2010). Apoyada en un intenso trabajo terapéutico, Marcela pudo resignificar su lugar y reposicionarse para sentirse y parecer menos "vulnerable". En este sentido, la presencia psi colaboró en la metabolización del malestar generado por las violencias y en el desarrollo de es-

trategias para protegerse y desarticular este tipo de comportamientos, pudiendo significar esta experiencia acompañada como una oportunidad para adquirir tales aprendizajes.

A modo de síntesis, las interacciones psi problematizadoras les permitieron crear nuevos sentidos para transformar significaciones y emocionalidades sobre las experiencias y las circunstancias singulares en que ocurrieron, para comprender mejor los malestares y las tensiones sufridas. Poder problematizar las significaciones iniciales sobre aborto como un asesinato, como una trasgresión (a los mandatos de género sociales, familiares o religiosos) y como una decisión egoísta por atentar contra "un bien común" de la pareja, las favoreció para desarmar culpas y estigmatizaciones que aparecían bajo formas de autorreproches o sentimientos de deuda y falla.

El trabajo de resignificación resultó un aporte para comprender la decisión y la práctica del aborto en sus anclajes políticos de género, como así también en los marcos relacionales en que ocurrieron. Las resignificaciones se extendieron a otros aspectos de la vida, como la historia familiar, la relación de pareja o los posicionamientos asumidos frente a las violencias sufridas y sus efectos. Todo lo cual, favoreció procesos tendientes a organizar, clarificar y apropiarse de sentidos y sentires que les permitieron integrar la experiencia en el curso de los acontecimientos de la biografía personal.

Las presencias psi facilitadoras de las significaciones de las experiencias. Claves para repensar el rol profesional psi

En este capítulo analizamos las valoraciones sobre las interacciones con profesionales en psicología, que denominamos presencias psi facilitadoras. Consideramos las significaciones que transformaron y construyeron en esas interacciones en relación con los procesos de construcción de salud mental en torno a las experiencias.

Este emergente nos resulta particularmente interesante para reflexionar sobre la relevancia del lugar que ocupan los discursos y prácticas psi en la construcción de significaciones y de salud mental de las mujeres que abortan, en función de la mirada teórico-política que adopten sobre la relación entre aborto y salud mental.

Acorde al modelo participativo que elegimos para comprender la salud mental tomamos como punto central la perspectiva de las mujeres

implicadas, los malestares psíquicos y las necesidades emocionales que expresaron resolver y/o satisfacer en los encuentros con las profesionales. Así como los recursos personales y relacionales construidos en estos encuentros para transitar las situaciones críticas.

Las principales necesidades emocionales que sintieron satisfechas en estas interacciones fueron: lograr tranquilidad por encontrar información y orientación sobre cómo abortar con pastillas de manera segura; ser escuchadas y poder expresarse sin recibir enjuiciamientos morales; ser contenidas emocionalmente y respetadas en la decisión tomada. Además, sentirse apoyadas en la construcción o reafirmación de una decisión acorde a sus deseos; validarse en la capacidad de buscar, encontrar y movilizar los recursos para abortar; y recrear significaciones tendientes a legitimar la propia decisión, tras poder problematizar y revisar mandatos de género que las tensionaban y/o conflictuaban. Asimismo, elaborar los efectos de las violencias vividas y modificar sus posicionamientos frente a estas, y profundizar en la resignificación de la experiencia en función de la historia personal y relacional y reconocer algunas relaciones de poder existentes y las formas en que les ocasionaban malestar.

A lo largo de los procesos fueron predominando distintas formas de presencias psi en función de las necesidades emocionales de las mujeres. En los momentos previos a la práctica, se valoraron las presencias informativas/orientadoras porque lo que primaba era la urgencia por resolver el estado biológico que avanzaba junto a las incertidumbres y angustias propias de un camino obstaculizado por la clandestinización. También, previo a los abortos, valoraron las presencias autoafirmativas de la decisión y del proceso de búsqueda de recursos, y las que normalizaron la práctica. En los momentos posteriores, reconocieron como fundamental la validación de las capacidades y aprendizajes adquiridos, y la problematización de sentidos. Esto ocurrió en momentos donde la resolución del aborto dio lugar a la posibilidad de ampliar y profundizar los procesos reflexivos de elaboración e integración de la experiencia en la trama vital más amplia.

El trabajo de problematización y de transformación de significaciones fue un gran aporte para los procesos de construcción de salud mental en torno a estas experiencias y, también, más allá de estas. Estas interacciones psi fueron la puerta de entrada para repensar otro tipo de situaciones relacionales. Cuando se aborda el aborto como una decisión de las mujeres, se habilitan otros sentidos que conciernen no solo a la legi-

timidad de interrumpir un embarazo no deseado sino también a la posibilidad de interrumpir una situación de violencia o de tutela de otros sobre sí misma (Lenta, Longo y Zaldúa, 2018). En algunos procesos de las entrevistadas, vemos que les permitieron poner en evidencia que contaban con la capacidad de actuar a favor de sí mismas, lo cual muchas veces les implicó poder abandonar relaciones de tutelaje no satisfactorias y/o de violencia con personas significativas. Es lo que Eva narró como el proceso de desenraizar cosas de su pasado y revisar posicionamientos en relación con su padre y con los mandatos que este representaba, o lo que Kristina expresó como "desatar nudos" en la relación de pareja.

En cuanto a los malestares, por un lado, advertimos que muchos resultaron de las condiciones de clandestinización en las que tuvieron que abortar y que las habían hecho significar que estaban atravesando una experiencia de riesgo, excepcional y desviada, que debían silenciar y reprocharse. También hubo malestar por el conflicto entre, por un lado, la voluntad y acto de abortar y, por otro lado, las significaciones que inicialmente asumieron como propias sobre la transgresión y el asesinato, las cuales necesitaron problematizar. Y, finalmente, registramos malestares producidos por los violentamientos de género que sufrieron, principalmente por los varones involucrados en los embarazos y por profesionales en medicina.

En cambio, entre los malestares que consideraron necesario atender junto a las psicólogas no advertimos aquellos producto de las vinculaciones afectivas con la gestación, tampoco por procesos de duelo por un "hijo perdido", como sostienen las teorías que asocian causalmente aborto y trauma. Las mujeres no asumieron una condición relacional con el embarazo porque no basta el hecho biológico de estar embarazada para experimentar un vínculo. Tampoco expresaron haberse sentido "malas madres" ni tener que sanar un vínculo filial roto, pues tal vínculo no fue construido por ellas. Como señala Rostagnol (2016: 126) "hay una madre cuando hay un hijo o una hija". Las interrupciones voluntarias que relataron fueron de embarazos no deseados, lo cual las llevó a gestionar y concretar el aborto. En este sentido, volvemos a remarcar la importancia de entender los embarazos no deseados/abortos voluntarios como un *continuum*.

Las entrevistadas tampoco refirieron malestar y sentimientos de culpa por haber sobrevivido al aborto. Por el contrario, más allá de los conflictos, expresaron un sentimiento de bienestar cuando se aseguraron

de que el embarazo había sido interrumpido efectivamente y no habían sufrido riesgos graves para su salud física.

En los relatos donde registramos culpas o sentimientos de haber sido "malas mujeres" observamos la asunción de significaciones sobre el aborto como una experiencia susceptible de despertar reprobación, ya sea por asociarlo a un asesinato, a una transgresión contra los mandatos religiosos o a una decisión egoísta que atentaba contra la pareja. Pero la posibilidad de revisar dichas significaciones, al desentramar sus orígenes sociales y sus impactos subjetivos para poder diferenciarse, les permitió transformar los malestares sentidos. Esto nos habla de su carácter de construidos, y no de una cualidad intrínseca a la práctica de un aborto.

Desde nuestra perspectiva teórica, nos parece necesario conceptualizar los sentimientos negativos asociados al *continuum* embarazo no deseado/aborto voluntario/condiciones y circunstancias en que ocurren, cuando estos aparecen, desde la noción de malestar psíquico que articula condiciones subjetivas y sociopolíticas. Ya que los abortos no son prácticas que ocurren en el vacío y desentramadas. Por el contrario, las condiciones de realización –sociales, históricas, culturales, legales, políticas– adquieren gran centralidad tanto en estas experiencias como en los procesos de subjetivación de las mujeres. A su vez, dichas condiciones se entraman de maneras únicas, particulares y amalgamadas con los caminos andados y desandados, previos y por venir, de cada mujer.

Concluimos que las presencias psi facilitadoras fueron aquellas valoradas por no hacerse eco de discursos estigmatizantes o patologizantes sobre las prácticas abortivas y sobre las mujeres que abortan y respetaron las necesidades expresadas por las consultantes. Colaboraron en los procesos de diferenciación y problematización de emocionalidades y significaciones iniciales, así como en la construcción y modificación de significaciones en tránsito en torno a la tensión estigmatización/legitimidad.

En compañía de las profesionales psicólogas, las mujeres identificaron algunos dispositivos de fragilización de género que estaban actuando en sus experiencias. Pudieron debilitar sus efectos de poder cuando se afianzaron en la decisión, cuando recuperaron y reconocieron sus capacidades y aprendizajes para superar la situación crítica, y cuando resignificaron la propia experiencia acorde a sentidos propios. Esto les permitió integrarla en el curso de los acontecimientos de la biografía personal, así como ampliar la problematización de sentidos de género a otros aspectos de sus vidas. Al problematizar ciertos mandatos de género, colaboraron

en desarticular significaciones del aborto como una transgresión y una experiencia (auto) reprochable, desviada y poco frecuente, dando lugar a nuevas significaciones tendientes a la normalización.

Estas formas de interacciones profesionales acompañaron la construcción de autonomía subjetiva al proponer un proceso de discernimiento y reafirmación de los deseos e intereses propios para poder, luego, realizar acciones coherentes con esto (Fernández, 2021). Además, propiciaron recreaciones de sentidos para transitar las situaciones críticas imprevistas no como una pérdida o un atentado contra la valía propia, sino como una oportunidad para generar aprendizajes, crecimientos y/o fortalecerse, luego de superar los obstáculos impuestos por las condiciones de realización.

III. Transformaciones asociadas al bienestar de decidir, resolver y narrar los abortos

Hasta aquí hemos analizado las significaciones iniciales sobre las experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios clandestinizados y sus implicancias emocionales. Luego mostramos cómo estas significaciones se fueron transformando, desarticulando y, otras, reafirmando, para lo cual tuvimos en cuenta algunas condiciones y circunstancias comunes y singulares. Pusimos el foco en los procesos de clandestinización, sobre todo en la estigmatización, y en los distintos acompañamientos que gestionaron y valoraron, para comprender cómo y por qué fueron afectando las significaciones en tránsito. En este último nudo temático abordamos las transformaciones asociadas al bienestar, luego de decidir y resolver los abortos.

Es así que en el Capítulo 9 profundizamos en dos significaciones, en tanto aportes significativos a los procesos de construcción de salud mental de quienes abortaron. La primera fue significar el propio aborto como una decisión propia, legítima y a su favor. La segunda fue significar el tránsito por estas experiencias como una oportunidad favorable.

En el Capítulo 10 abordamos el bienestar y las potencias saludables implicadas al narrar estas experiencias, acto que también entendemos como parte de los procesos de construcción de salud mental.

Capítulo 9. Autorizarse a abortar: implicancias de una decisión significada como legítima y a favor de sí misma

Cuando abordamos las emocionalidades iniciales, comprendimos que las mujeres experimentaron diversos malestares debido a los embarazos que les significaban una carga, una invasión y un problema a resolver, y emprendieron un camino que se debatió entre riesgos y cuidados.

A medida que fueron transitando las experiencias y sus complejidades y pudieron resolver los abortos voluntarios, lograron reconocer y vivenciar un mayor bienestar asociado a la construcción y afianzamiento de nuevas significaciones. Este bienestar se vinculó a: dejar de estar embarazadas, sentirse capaces de superar los infortunios producidos por los embarazos no deseados y los obstáculos y riesgos de la clandestinización, y haber experimentado un proceso cuidado y acompañado. El bienestar emergió cuando valoraron que pudieron tomar y concretar una decisión crucial que significaron como propia, legítima y favorable para la propia vida.

Además, en el tránsito por las experiencias reconocieron las herramientas y recursos con los que contaron para abortar de la forma más segura y cuidada posible y, así, superar la situación crítica. La situación crítica fue significada como una oportunidad en tres sentidos: para construir y ejercer autonomía, para implementar cambios que consideraron necesarios, y para ganar aprendizajes que las fortalecieron.

Al revisitar lo ocurrido, las entrevistadas dieron cuenta de cuán importante había sido poder discernir y reconocer sus propios deseos e intereses a lo largo de sus procesos para impregnar de voluntad a los abortos que se practicaron, al significarlos como la acción que mejor se ajustó a dichos deseos e intereses. Existió un vínculo entre el reconocimiento del deseo propio y la seguridad en la decisión de abortar, lo cual se tradujo en la ausencia de arrepentimiento. De modo que las mujeres

significaron que habían tomado una decisión a favor de sí mismas, la "mejor" o la correcta.

> Y después de que se completó y ahora que he vuelto a hablarlo digo, definitivamente, esta era la mejor decisión. Era mi decisión, no me arrepentí, totalmente segura, nunca tuve ese período de dudarlo, de arrepentimiento (Camila).

> Era MI decisión, sobre todo. (…) No tengo ningún problema respecto al aborto y no me arrepiento. Yo sé que hice lo correcto, no me arrepiento (Karina).

> Nosotras podemos decidir, ser libres y elegir el estilo de vida que podamos, en la medida que se pueda, el estilo de vida que queremos llevar. Por eso, no me arrepiento para nada, creo que lo importante es saber tomar una decisión segura, lo más segura posible. Y eso te facilita muchas cosas (Clara).

A la vez que, cuando se apropiaron de la decisión y la vivieron con seguridad, marcaron un límite respecto al lugar de los otros, "los de afuera", en referencia a las parejas, al personal de salud, o de forma más generalizada, a la sociedad.

> Yo como mujer quiero hacer esto, tengo el derecho, poder decidir y que no me rompa nadie las bolas (Ernestina).

> Mi cuerpo. Yo. Mi decisión. El chabón, el médico, los que fueran: de palo. Están de afuera (Úrsula).

> Pero para mí sí está bien, entonces tampoco te metás en eso. Para mí está bien y no te cabe decisión sobre mi vida y sobre mi cuerpo. Yo no le voy a ir a decir a nadie "tenés que estar a favor del aborto", y si no está, bueno, pero no lo estés en tu cuerpo y en tu vida, no en lo de los otros (Charo).

Para dotar de seguridad y legitimidad a la decisión, algunas se reafirmaron en la idea de que estaban tomando una decisión sobre ellas mismas, el propio cuerpo y la propia vida y que no estaban decidiendo "sobre" ni "contra" otros, es decir, "asesinando" o llevando adelante una "decisión egoísta" que damnificara a la pareja. Si la decisión las implicaba a ellas,

entendían que les pertenecía y que podían tomarla en función del propio sentido ético sobre lo que "sí está bien". En algunas entrevistadas, este sentido ético ya estaba instalado y al atravesar la experiencia lo reafirmaron. Para otras, fue una construcción que realizaron a medida que se fueron contactando con otros sentidos sobre el aborto, sentidos que afectaron la significación sobre abortar como una trasgresión cometida por "las malas mujeres" y una experiencia reprobable y sancionable que, por ende, ellas mismas tenían que reprocharse y arrepentirse. Lo que observamos es que cuando estas experiencias fueron significadas como elecciones y decisiones que tomaron a su favor, se vivieron con mayor legitimidad y con una percepción de poseer la autoridad necesaria para tomarla.

> Esa postura la tenía mucho antes de hacerme el aborto, y mucho más ahora. Yo pasé por esa situación (Charo).

> Me salí de un montón de prejuicios, de juzgar, me di cuenta que había sido muy prejuiciosa, y eso, entender que es una elección que una puede hacer sobre el propio cuerpo, así que eso fue también empoderarme, a mí misma, tener en cuenta lo importante que es estar enfocada en mis decisiones (…) al final ¡también aborté los prejuicios! digo, en esa experiencia… (Bárbara).

> Antes quizás sí tenía alguna cuestión medio moral, con el tema del aborto. No sé si moral, quizás más kármica, decir: bueno, es vida, entre comillas y yo la estoy coartando y estoy coartando lo que va a suceder… y eso me va a volver… Todo esto antes de tener el retraso. Era como que en una charla de a favor o en contra del aborto, yo estaba en el medio, no por nada religioso, era como algo más energético. Y después de esto ¡no! Creo que la decisión está en mí porque yo puedo manejar la realidad (Emilia).

Estar implicadas directamente en la situación, les hizo revisar "prejuicios" o generalizaciones sobre el aborto considerado en abstracto. Reconocieron que, si ellas eran las que encarnaban los embarazos, también ellas podían encarnar la toma de la decisión que mejor se ajustara a sus vidas y realidades. Otorgarle legitimidad a la decisión desarticuló culpas –si es que estuvieron presentes– y posibles arrepentimientos, debido a que estas configuraciones emocionales no son inherentes a la práctica sino a las significaciones que las mujeres construyen sobre la misma.

Una de las maneras en que se apropiaron de la decisión con seguri-

dad fue cuando tomaron conciencia de que la maternidad implicaba grandes transformaciones que no estaban dispuestas a asumir.

> Yo siempre pensé que el aborto es, tiene que ser, una decisión de la persona que está embarazada porque no es fácil. No es: "ah bueno, te quedás embarazada" o "ah, bueno, me lastimé y me pongo una curita". No es algo fácil… ahí se te transforman un montón de cosas con un embarazo (Virginia).

> Si antes lo hice, esta vez lo hice con el triple de seguridad. Después de ya tener una hija, sé mejor que nunca que no quiero tener más (Lola).

La maternidad tiene un costo, no se despliega mediante una programación genética y natural. Implica cambios profundos en la vida de quienes gestan, paren y/o crían. En las mujeres que ya se encontraban maternando, gran parte de esa seguridad con la que sostuvieron la decisión de interrumpir los embarazos tuvo su base en sus propias experiencias de maternidad. Ellas contaban con el saber en carne propia sobre el trabajo físico, emocional, económico, simbólico y cultural que les implicaba maternar (Rosenberg, 2020) y se sintieron con la autoridad de decidir en función de eso. Desde el saber de la experiencia, estaban seguras de que no deseaban asumir ese trabajo nuevamente y actuaron acorde a esto. Pudieron escuchar sus propios deseos en el medio de lo aturdidor que resultan los procesos de clandestinización, que les hablaban de la trasgresión hacia el mandato de la maternidad obligatoria, del "instinto materno" que no estaban respetando, de la moral femenina que no estaban sosteniendo, del arrepentimiento como promesa, de un castigo divino que podría recaerles a quienes sentían que estaban yendo en contra de dios, de las consecuencias legales y sociales que podrían sufrir, del riesgo al que se estaban sometiendo y un largo etcétera. A pesar y en contra de todos estos discursos, la fuerza y seguridad de la decisión las empujó a luchar porque estos mandatos no se correspondían con lo que deseaban.

> Yo había algo de lo que estaba segura: no quería tener un hijo e iba a decidirlo por mí misma, o sea, contra el mundo si era necesario. (...) Me ayudó mucho esa seguridad en mí misma, y que mientras pueda, a menos que me pongan un arma en la cabeza, voy a decidir por mí misma (Emilia).

De modo que, en la polifonía de los discursos dominantes que, en definitiva, han construido al aborto como una experiencia abyecta y (auto)reprochable, las mujeres transitaron estas experiencias reafirmando la construcción de una autoridad interna (Lagarde de los Ríos, 2001). No se sintieron "menos mujeres" ni "malas mujeres", sino mujeres más potentes y autónomas por haber podido tomar una decisión que las favoreció. Al significar el aborto como una decisión legítima y a su favor, experimentaron que ejercieron un poder, el de "manejar la realidad" o "tomar su vida en sus manos", utilizando las palabras con las que define la autonomía subjetiva Marcela Lagarde de los Ríos (2001: 98).

Las entrevistadas se sintieron favorecidas por haber decidido el aborto en varios sentidos. Primero, porque pudieron mantener continuidades en sus vidas, en palabras de una de las entrevistadas, sentir que "mi vida volvió (…) y volví a mi vida". Al momento del embarazo, se sentían conformes con sus actividades y logros, deseaban que esto continuara así. En este sentido, la maternidad era una interferencia que no estaban dispuestas a asumir. Clara, Estefanía o Leonor hablaron de la maternidad como una limitación para sus deseos e intereses que estaban orientados hacia otros proyectos considerados por ellas como muy valiosos.

> No estoy interesada en ser madre (…) Todo lo que venía construyendo, construyéndome como persona, porque es mi formación y mis herramientas para coexistir en esta sociedad, ¡se me venía abajo! Estudiar la carrera que yo quería, laburar de lo que yo quería… no iba a poder hacer las cosas que yo quería. Es muy limitante para un montón de proyectos personales que uno tiene que limitar y cerrar, que no me sentía cómoda entregando… no es lo que yo quería para mi vida. (…) Para mí fue simple la situación "no puedo tirar a la basura todo lo que hice, todo lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer. No puedo, no puedo" (Estefanía).

> En ese momento que me quedé embarazada yo sentí que estaba haciendo muchas cosas que a mí me gustaban (…) estoy estudiando lo que a mí me gusta. Eso, por un lado. Después descubrí la militancia política, encontré un lugar donde sentía que mis ideas estaban puestas en ese lugar (…) En ese momento pensé en mí, pensé en las cosas que estaba haciendo, en mi proyecto de vida, en lo que yo quería. Sentía que eso iba a cambiar todo, tener un hijo iba a cambiar todo en ese momento y la verdad que no lo quería para mí. (…) me gustaban las cosas que hacía y no las quería dejar (Clara).

> No es un deseo en negativo, de hecho, estoy convencida que no se desea en negativo. Es imposible desear un no. No es que yo estaba deseando la no maternidad, sino que estaba deseando y haciendo otro montón de cosas en mi vida y eso sucedió por fuera de las cosas que yo podía tener control. Me sigue resultando rara, hasta discursivamente, la idea de las mujeres que no desean ser madre. ¡Loco, somos mujeres que estamos deseando otras cosas! (Leonor).

Estefanía se encontraba armando proyectos personales que no veía compatibles con la maternidad y ese embarazo le significaba una amenaza a todo lo que había construido y lo que deseaba continuar construyendo. En este sentido, interrumpir el embarazo fue defenderse de esa amenaza. Clara, que abortó a los 21 años, eligió seguir con sus estudios en la Universidad, la militancia, el trabajo barrial, el tiempo para sus amistades y para poder sostener su empleo. Leonor, al momento del embarazo tenía 30 años y se encontraba potenciando su desarrollo profesional y decidió seguir "deseando otras cosas" que no involucraban la maternidad. La condición deseante implicada en la decisión se presentó "en positivo" y el aborto no le quitó una posibilidad (la de maternar) sino que le significó una oportunidad para acceder a otros proyectos.

Cuando la maternidad es considerada como un proyecto más entre tantos otros y no como una identidad totalizante, abortar no provoca un déficit subjetivo en la identidad como mujeres, tampoco deja lugar para el arrepentimiento. Y lo que las mujeres consideran que necesitan no es una autorización externa para tomar la decisión, sino respeto por la misma: "Respetar la individualidad de cada una: "yo quiero esto". Eso es también salud mental" (Clara).

Otro sentido en el que se sintieron favorecidas por haber decidido y haber atravesado la experiencia fue cuando lo tomaron como un motor para implementar cambios en sus vidas, como "un antes y un después", o un "primer paso" en el ejercicio de poder decidir sobre el curso de sus vidas. De modo que, transitar el proceso de embarazo no deseado/aborto voluntario dio lugar a otras decisiones para modificar aspectos de la vida que las afectaban negativamente o que no las satisfacían; como terminar una relación de pareja, cambiar de empleo, retomar proyectos postergados o integrarse a la militancia feminista. Por ejemplo, Emilia comenzó a desvincularse de una relación violenta hasta lograr culminarla, Paz y Pato terminaron definitivamente la relación de pareja y Pato sintió que se le abría

"un nuevo mundo" cuando comenzó a ser socorrista. Andrea también decidió finalizar el noviazgo y dedicarse de lleno a su pasión artística, buscando que fuera su fuente de ingresos económicos.

> Creo que fue el primer paso… porque yo siempre de chica me creí tan revolucionaria, independiente y feminista, estaba con el chabón más machista, metida en un mundo de mierda sin darme cuenta y este fue el primer paso, el primer no. (…) Creo que eso [decidir el aborto] me ayudó un montón a salir de eso [la relación violenta], tardé dos años más, pero hay gente que está toda la vida en eso (Emilia).

> Creo que era el aborto de él, fue abortarlo a él. Abortar la relación, ¡eso fue! Fue, creo, lo mejor que me pasó en mi vida. (…) ¡la libertad! Nunca había sido más libre. Fue la mejor decisión que tomé esa, la decisión más coherente, ¡estoy orgullosa! (Paz).

> Fue muy empoderadora, para terminar con un montón de cosas, no solo para terminar con un novio de mierda (…) Fue como una locura para mí, un antes y un después, de pronto descubrir esta red de mujeres organizadas de esta manera, haciendo esto, fue una locura. Yo nada, de otro palo, nunca había militado, estaba en otra (…) entrar en el mundo del feminismo de esa manera fue muy sarpado (Pato).

> Di un giro a mi vida. Decidí hacer más lo que tenía ganas de hacer, dedicarme a la música que es lo mío, me sentí con otras fuerzas, como que renové las fuerzas en un punto (Andrea).

Es decir que esta decisión fue significada como "a su favor" porque operó para que produjeran otros movimientos vitales auspiciosos. En este sentido, atravesar la experiencia fue significado como una oportunidad para promover cambios concretos y moverse hacia lugares que les dieran más fuerza y las hicieran sentir más cercanas a las formas de vida que deseaban.

También hubo quienes reconocieron y expresaron vivir transformaciones a su favor en un nivel más abstracto, asociadas a sentirse con mayor libertad para tomar decisiones en general y para hacer uso de una libertad que hasta el momento no se habían autorizado o no habían sentido propia. Al respecto, Andrea realizó una analogía entre el embarazo no deseado y el sentimiento de incomodidad y esclavización que sentía en su vida en general. Violeta se refirió a los cambios en su vida

tras abortar. Ambas nos muestran lo liberador que puede ser significar esta decisión como a su favor.

> Y bueno, para mí justo coincide, o no sé si es coincidencia, con un cambio en mi vida y en la manera de ver las cosas. Como que viene a marcar un antes y un después. Porque yo venía con una situación, tanto de pareja como en la vida mía, medio perdida. Viste cuando decís: "no me termino de sentir cómoda, no estoy contenta conmigo misma. No, no, no es por acá, no es por allá". Y toda esa espera, en el tiempo que estaba embarazada, me sentía esclavizada de algo, ¿me entendés? Me sentía invadida, esclavizada, molesta. Era casi como un resumen de todo lo que yo venía sintiendo. Siento que es como si se hubiera manifestado toda mi historia de este último tiempo en esa situación, en ese embarazo. ¡Yo le doy ese significado! Y una vez que pasó, sentí que volví a mí misma, a ver las cosas de otra manera. A significar las cosas de otra manera, a disfrutar mucho más de mi libertad, de mi cuerpo, de mi vida, a darle otra importancia. (…) Dije: "bueno, me tengo que tomar yo mis libertades". Lo sentí un poco simbólico en ese sentido. Nadie va a venir a darme libertad si yo no la busco, no la uso, no la conquisto. Y a partir de ahí, he sido bastante distinta (Andrea).

> Entonces después de eso empezó a ser mejor mi vida, empecé a ser más consciente de las decisiones que tomaba, de las cosas que quería y las que no. Me sentí libre, no dejar que las cosas pasen. Viste esa frase que dice la gente: "por algo pasan las cosas", yo me sentí tan libre al decir: "no, no quiero que esto pase, no quiero". Y elegir no querer hacerlo. Y no hacerlo (Violeta).

Para tomar decisiones hay que autorizarse a hacerlo. La autoridad personal interna se construye estableciendo juicios y valores propios, buscando respuestas a la pregunta que está en constante movimiento ¿qué deseo? Porque en caso de no realizarse esa pregunta, es posible quedar sujetas enteramente al deseo de otros y a los discursos sociales patriarcales que establecen qué es lo que debemos desear, cuando la dimensión productiva del poder que fragiliza se pone en marcha e impacta en las subjetividades (Fernández, 2009). En la construcción de la identidad de las mujeres, la cultura patriarcal las ha expropiado de esa autoridad y las ha depositado afuera, en instituciones o en personas que se ubican en un lugar de supremacía. Así, para las mujeres, histórica-

mente, la autoridad ha sido externa a ellas y esto las ha hecho dudar sobre sus juicios, sobre sus interpretaciones, sobre sus valores (Lagarde de los Ríos, 2001). Sin embargo, las entrevistadas que significaron la decisión del aborto como propia, legítima y a su favor, realizaron un trabajo de reconocimiento del propio deseo para sostener acciones acordes y ejercer sus voluntades, en "contra el mundo, si era necesario". El efecto subjetivo fue reafirmar sus decisiones y no dejar espacio para el arrepentimiento o sufrimiento que dictamina la construcción moral social hegemónica sobre abortar. Por el contrario, se autorizaron a decidir sobre sí mismas y se sintieron "feliz de haberlas tomado", "empoderadas", satisfechas de "manejar la realidad", haciendo "lo correcto" para esos momentos de sus vidas.

Es notable que, más allá de las condiciones y circunstancias de cada embarazo no deseado/aborto voluntario, todas expresaron bienestar una vez resuelta su interrupción. Lo hicieron en términos de "alegría", "felicidad total", sentirse "contenta", "relajada", "tranquila". Este bienestar se tradujo como el retiro de una carga, con frases como "sentirme liviana", "muy aliviada" o en términos de "liberación". También expresaron que "me volvió el alma al cuerpo", "solucionarlo y volver a ser yo", "yo sentí como que me volvía a mi vida". Lo cual nos habla de un sentimiento de recuperación de la integridad personal que habían visto afectada por el embarazo no deseado, así como de recuperación de la mismidad, en sentido opuesto a la extrañeza sobre el propio cuerpo y la propia existencia invadida por el embarazo.

El movimiento de autorización que realizaron al tomar la decisión, concretarla y significarla como legítima y a su favor conforma los procesos de construcción de salud mental porque aporta al ejercicio de autonomía subjetiva, a la vez que resquebraja algunos dispositivos de poder y de fragilización que recaen sobre ellas y que afectan la autonomía de género. Haber abortado no fue una experiencia que asociaron a un mal menor que tenían que justificar (Boltanski, 2016), fue una experiencia que les generó orgullo por haber podido ejercer el poder de decidir sobre sus vidas; un ejercicio que consideraban legítimo.

> Esta experiencia me llevó a tomar ese poder, decir: "es mi decisión, es mi decisión y me la banco, como me he bancado un montón de decisiones bien o mal tomadas, las he enfrentado y acá estoy, feliz de haberlas tomado" (Fabiana).

> A mí, particularmente, me sirvió para sentirme más propia de mí misma. (…) Me siento muy segura de la decisión que tomé, en ningún momento sentí complejo con eso, no me siento angustiada ni siento vergüenza de decir que me hice un aborto, de que yo aborté. Estoy orgullosa de decir: "yo tuve el poder de decidir sobre mi cuerpo y lo hice. Me tocó decidir y lo hice" (Estefanía).

Finalmente observamos que, a partir de significar esta decisión como a su favor y el aborto como una oportunidad, el foco de los relatos estuvo puesto en el reconocimiento del crecimiento y los aprendizajes que incorporaron. Atravesar la situación crítica de las maneras en que lo hicieron les devolvió una imagen positiva de sí mismas que les generó satisfacciones, fortalezas y reconocimiento de las potencias saludables.

> La sensación después del proceso fue de fortaleza. Fue de sentir que una misma puede hacer cosas por sí misma, por su propia salud. Y que otras mujeres nos pueden acompañar (…) Fue más que nada aprendizaje, y me atravesó una experiencia que es distinta, es muy distinta porque es autónoma, 100% autónoma (Bárbara).

> Yo nunca me sentí tan fuerte como en ese momento. Jamás. De hecho, me consideraba con bastantes debilidades, a la hora de enfrentar algo. Y me tocó ese momento (Nadia).

> Y bueno, esas cosas me llevaron a sentirme más empoderada, digamos, de la situación y poder ver con claridad, y poder decir las cosas, y decir "acá es no, acá es sí, hasta acá llego" y tomar más determinaciones y con otra libertad, también. Con otro tipo de libertad, sin cargas y sin cuestionarme tanto todo, sino tomando decisiones más sanas para mí (Fabiana).

Es decir que, al momento de hacer un balance sobre qué les implicó atravesar esta experiencia, las entrevistadas enfatizaron en la valoración positiva de lo decidido, en las ganancias emocionales que impactaron en otros ámbitos de sus vidas luego de haber resuelto los malestares y de haber superado la situación crítica. Esto representó una oportunidad para fortalecerse, adquirir aprendizajes, y construir y ejercer autonomía, que entendemos como un acto de subjetivación de sujetas capaces de actuar deliberada y voluntariamente para llevar adelante proyectos que han instituido como propios (Fernández, 2021) y que estos embarazos amenazaban.

Estos modos de significar las experiencias ponen en cuestión las nociones que asocian abortar con una vivencia trágica o traumática *per se*, a la vez que nos permiten hacer reflexiones sobre los sustentos de estas sentencias que atentan contra las mujeres que abortan voluntariamente. ¿Cómo es posible que el ejercicio de la autonomía sea, a priori, considerado como una vivencia trágica o traumática?

Encontramos algunas respuestas, en parte, en el desplazamiento estratégico que se hace desde lo trágico del embarazo involuntario al aborto voluntario del que habla Martha Rosenberg (2020). Para poder realizar esa operación simbólica entre dos términos de una misma experiencia, es necesario deslindar el aborto del embarazo que se aborta. Sin embargo, las experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios se presentan como un *continuum* indisoluble y no como entidades separadas. Lo que abortaron fueron embarazos no deseados, rechazados, amenazantes para la propia integridad y bienestar personal. Por lo tanto, su interrupción fue vivida como un alivio y una forma de recuperar el bienestar que sentían afectado.

Otra parte de las respuestas al interrogante planteado, la encontramos en los intentos sistemáticos y estratégicos de patologización/anormalización/estigmatización que han instalado, en el campo de las disputas de sentidos sobre aborto, los sectores antiderechos. Particularmente, cuando hacen uso de discursos y prácticas del campo psi para continuar esgrimiendo y legitimando argumentos que consideran que las prácticas de aborto dañan la salud mental de quienes se los practican. Más recientemente, la estrategia consiste en instalar la significación de aborto como daño, donde la mujer es víctima y no agente del aborto[1].

[1] Susana Rostagnol (2021) habla de la noción de "mujer-víctima del aborto" como uno de los más recientes discursos preponderantes de los sectores antiderechos en los países donde el aborto por plazos ya ha sido legalizado. Toma el caso de la presentación de un proyecto de ley en Uruguay para realizar ritos fúnebres para productos de abortos espontáneos, pero también inducidos, que se basa en la idea de que las mujeres que abortan sufren y tienen "derecho al duelo y a dar una digna sepultura a los seres queridos" como "un derecho humano fundamental". Rostagnol advierte que esta noción de "mujer-víctima del aborto" supone, entonces, un sufrimiento por el feto en las mujeres que abortan y que traslada el eje de ser acusadas a ser víctimas del aborto, con el objetivo de avanzar en leyes que restrinjan los derechos de las mujeres al humanizar y otorgar derechos al "no nacido" por considerarlo "persona con la dignidad y derechos de cualquier otro ser humano". Encontramos, además, otro riesgo en esta noción de "mujer-víctima del aborto" por su cercanía con la idea que plantea Boltanski (2016) sobre la consideración del aborto como mal menor, que atenta contra los procesos de legitimación de la práctica.

Por lo tanto, esto impide considerarlo como un derecho de las personas con capacidad de gestar que así lo decidan e, incluso, se lo expulsa del campo de lo saludable mientras que se lo abyecta al campo de lo traumático y lo psicopatologizado.

Sin embargo, los procesos a través de los cuales las mujeres construyen salud mental y se subjetivan en autonomía van de la mano. Cuando quienes abortaron significaron sus experiencias en términos de legitimidad y oportunidad, experimentaron bienestar y se reconocieron fortalecidas en el ejercicio de dicha autonomía. Nada más alejado de una vivencia traumática o que afecte negativamente los procesos de construcción de salud mental.

Capítulo 10. Las potencias saludables de narrar las experiencias

En este capítulo vamos a desarrollar por qué consideramos que narrar las experiencias, en este proceso de investigación y en otros espacios que formaron parte de sus vidas, se configuró como un aporte más a los procesos de construcción de salud mental de las entrevistadas.

Algunas investigaciones feministas han puesto el énfasis en los efectos emocionales y políticos de lograr hablar, historizar y socializar las experiencias de abortos. En el transcurso de esta investigación, emergieron intereses sobre la relación entre abortar y poder narrarlo, a la luz de los procesos de construcción de salud mental que nos convocaban. Es así que nos preguntamos por las relaciones entre el acto de asumir la palabra y los procesos de construcción de salud mental: ¿Qué movilizaciones subjetivas saludables se ponen en juego en el acto de narrar la propia experiencia?

Tal como hemos señalado anteriormente, narrar es un proceso de significación constructiva donde se despliegan diversas emocionalidades, sentidos y propósitos. Estos están mediados por un trabajo de interpretación en función de las experiencias y expectativas posteriores y presentes que, a su vez, se vinculan con las coordenadas sociales más amplias del tiempo en que se realiza la narración. Encontramos diversas potencias y bienestares en y por el acto de narrar, tanto cuando las entrevistadas se ubicaron como las destinatarias de sus propios relatos, como cuando los dirigieron hacia otras mujeres. El bienestar se vinculó a la desarticulación de las significaciones sobre los abortos como prácticas excepcionales y desviadas que debían ser silenciadas, mientras afianzaron otras significaciones en tránsito, ligadas a la legitimización de las experiencias, por considerar que portaban valor y que merecían ser compartidas.

Narrarse la experiencia y dar "un gran paso"

Cuando las entrevistadas se implicaron en el intercambio conversacional y emocional que les supuso participar del dispositivo de entrevista feminista en profundidad lograron otro acceso a la propia experiencia. Narrarlas les permitió sacarlas del silenciamiento a partir de encontrar un espacio cuidado de escucha. Lograron reafirmar versiones propias, al disponer del tiempo para conectarse emocionalmente con lo vivido y lo recordado. También, pudieron tensionar los discursos dominantes asociados al sufrimiento, al habilitarse a reconocer y compartir el bienestar y las fortalezas que habían adquirido tras transitar las experiencias.

Por un lado, el dispositivo de entrevista operó como un espacio de expresión. Los abortos han estado históricamente sometidos al silenciamiento y muchas mujeres, acorde a ello, significaban que eran experiencias que debían silenciar porque eran sancionables y reprochables. Algunas habían tenido escasas oportunidades para hablar, entonces la propuesta de una escucha feminista en la entrevista fue la única instancia, posterior a la práctica, para poder poner en palabras sus sentires en torno a las experiencias.

> A partir de ahí [de cerciorarse que ya no estaba embarazada] empieza toda una cuestión que yo creo que todavía continúa… de tratar de ponerle palabras (…) Nunca lo hablo, ese es el tema. (…) me parece que un gran paso lo di hoy al venir acá, pero era esto de ponerle palabra de alguna manera. Y… de ponerle palabras por ahí en otro contexto, por ahí sin la necesidad de tener que contarle a alguien lo que pasó o lo que fue: poder hacer otra cosa, como una elaboración que sea de otra manera (Marcela).

Para Marcela, participar de la entrevista fue parte del proceso aún vigente de encontrar las palabras adecuadas que le permitieran elaborar psíquicamente su experiencia y las violencias asociadas. Poner en palabras los dolores y los malestares ayuda a darles forma y esto limita su magnitud. El dolor puede ser contenido en las palabras cuando se logran condiciones específicas de escucha; una escucha receptiva y empática que pueda alojar y ayudar a inscribir estas experiencias en el registro de lo susceptible de ser dicho, sobre todo para quienes el peso del silenciamiento había sido fuerte o lo seguía siendo.

Mientras que las mujeres más afectadas por los procesos de estigmatización expresaron que ofrecer su relato fue dificultoso, pero aun así "un desafío" frente al silenciamiento, también hubo otras que usaron este espacio de expresión con soltura y comodidad porque no vivieron experiencias dramáticas ni se encontraron marcadas por el sentimiento normativo de vergüenza o culpa. Hablar de sus abortos era algo frecuente, no conflictivo y la entrevista fue un espacio de expresión más.

> [se sintió] Bien, re bien, yo no tengo ni medio problema en hablar de eso. No me quedó ninguna cosa, ningún sentimiento encontrado. Es algo que yo puedo hablar libremente, detalladamente, no tengo ningún problema (Lola).

> Me encanta hablar de esto (…) yo lo re hablo, hablamos de aborto todo el tiempo en nuestras vidas (Pato).

La participación en la entrevista les permitió "regalarse" un tiempo para contactar emocionalmente con las experiencias y recrear o reafirmar sentidos ya construidos que continuaron facilitando la tramitación emocional de las mismas.

> A nadie se lo he contado así, con todos los detalles, ni lo he hablado así (…) Creo que necesitaba hablar, como parte del proceso, hablar del tema y contar absolutamente todo sin tener que justificarme. (...) Yo lo vi como una oportunidad de poder contarlo como realmente era. Lo feo como era, lo malo como era, las cosas malas que pensaba y las cosas buenas que pensaba. Lo que realmente me afectó y lo que no. (…) Creo que necesitaba, yo, lo necesitaba yo, poder hablarlo así todo, largar todo y ver cómo me sentía. Yo no sabía si iba a llorar, no sabía qué iba a pasar, pero me decidí a desarrollar lo que tenía que salir (…) necesitaba cerrar. Creo que por eso dije que sí. (…) Creo que lo más valioso que le podés dar a una persona es el tiempo. Y no te lo di a vos, sino a mí misma, este tiempo (Paz).

> Es la primera vez que hablo dos horas de aborto. Poner en encuentro un montón de narrativas de mi vida y darle, no un cierre, pero admitir que se junta en la misma composición (Leonor).

> A medida que lo voy socializando y compartiendo se va construyendo eso que yo no detecto en mí, ese juicio de "¿qué hice?". Estoy segura de lo que hice, sé lo que hice, lo volvería a hacer, no me arrepiento

(…). Con la seguridad de que estoy hablando de una experiencia propia, de que nadie me la contó (Úrsula).

Con Paz, entrevistada en 2017, el encuentro se extendió a casi cuatro horas de diálogo que vivió como un regalo que se hacía a sí misma, con fines catárticos y de cierre. Parte de ese "cierre" consistió en contar(se) los aspectos que consideró positivos y negativos de sus experiencias, reconocer cuáles fueron las propias afectaciones y ensayar sus por qué, más allá de lo socialmente establecido o de lo que puede ser escuchado. Con Leonor la entrevista fue un tiempo relajado y profundo donde pudo hablar y reflexionar extendidamente. Narrar fue una oportunidad para realizar una síntesis más armónica de esta experiencia, donde le otorgó otros sentidos porque pudo conectarla con otros aspectos y situaciones vitales, armando un relato vital integral. A Úrsula, narrar la experiencia la hizo reafirmar aún más los sentidos propios construidos sobre el aborto.

De modo que muchas de las entrevistadas armaron un relato de forma extendida y profunda por primera vez luego de la práctica. Significaron su participación como una oportunidad para romper silencios y expresarse en un contexto cuidado. Al finalizar las entrevistas, todas compartieron haber experimentado "confianza", "tranquilidad", "sentirse entendida", "empatía de mujer a mujer".

Asumieron un lugar de enunciación y se distanciaron intelectual y afectivamente de los enjuiciamientos sociales sobre el aborto para conectarse con el recuerdo de lo que sintieron y vivieron, para poder "contarlo como realmente era", es decir, para construir versiones propias. En el acto de narrar movilizaron nuevamente los mecanismos de búsqueda, construcción y reafirmación de sentidos sobre las experiencias vividas. Este fue un ejercicio activo para incorporar la experiencia de manera más plena al torrente biográfico, lo cual es fundamental en los procesos de construcción de salud mental. Es así como contar la propia historia las posicionó de otra manera frente a los dispositivos de fragilización de género. Además de romper con los procesos de silenciamiento, las implicó en un ejercicio de autodefinición sobre los modos en que atravesaron las experiencias para dar lugar a relatos más fieles a sus sentires y completos. Y con ello, dejar de ser habladas o "mal-decidas"[1] por los

[1] Ana María Fernández (2022) utiliza este término en referencia al modo en que la lógica epistémica fundante del psicoanálisis comprendió la subjetividad femenina, para referirse

discursos sociales estigmatizantes. Cuando estos relatos se comparten y se socializan, se avanza en la construcción de representaciones de otras formas en que es posible abortar.

Por otro lado, así como el dispositivo funcionó como un continente empático para la expresión de los malestares, hubo quienes se sintieron habilitadas para expresar los bienestares, los procesos de crecimiento y de fortalecimiento a partir de haber transitado las experiencias, aspectos que también son necesarios de reconocer e integrar para dotarlas de pleno sentido. Nos parece significativo, en función de la tensión entre estigmatización y construcción de legitimidad, que las mujeres lograron expresar su bienestar en relación con una experiencia que el discurso dominante reprueba y que, por lo tanto, dictamina que debe ser trágica y vivirse con un sufrimiento espantoso. Estos son discursos funcionales a los sistemas morales patriarcales que asocian la voluntad de abortar con vivencias nada saludables y cargadas de emociones consideradas negativas, como la culpa, la vergüenza o el arrepentimiento (Rosenberg, 2020).

En general, la expresión del bienestar vinculado a la resolución de los embarazos no deseados mediante abortos voluntarios se ha visto coartada por los procesos de clandestinización que actúan a nivel social y subjetivo. Aun cuando las mujeres no sientan que está mal abortar, la fuerza del universo de significaciones míticas sobre las mujeres y la feminidad, donde el mito Mujer = Madre es central (Fernández, 2016), las lleva a reconocer que pueden ser receptoras de los calificativos atribuidos socialmente (malas mujeres, pocas mujeres, antinaturales, ofensoras, egoístas) o de ataques percibidos y/o experimentados que muchas veces son internalizados. Una de las salidas –momentánea o definitiva– frente a estos ataques ha sido acatar el silenciamiento. De modo que esta experiencia, cuando social y subjetivamente está cargada de atributos negativos y estigmatizantes, se presenta como necesaria de ser silenciada y es difícil de compartir. La estigmatización mutila las posibilidades de expresión y socialización de las experiencias de aborto en su integralidad, limita también el reconocimiento social de los variados aspectos que con-

---

tanto a un desacierto como a una desigualación. En nuestro caso, lo recuperamos tanto para referirnos al mal dicho sobre las mujeres que abortan, para mostrar el desacierto y la parcialidad de los discursos dominantes y la distancia entre lo que dicen sobre ellas y lo que las entrevistadas significan sobre sus experiencias, como en el sentido de un maldecir metafórico, es decir, los calificativos estigmatizantes, negativos e inferiorizantes que se les atribuyen a estas experiencias y subjetividades.

forman las experiencias de las mujeres concretas, y ya no de la Mujer mítica que fue y es construida desde una óptica patriarcal.

Si sobre los abortos pesan rechazos y descalificaciones sociales y existen dificultades generalizadas para entenderlos como una solución o un alivio, mucho más difícil es encontrar espacios para socializar estos procesos recordados y expresados con bienestar. Sin embargo, nos encontramos con relatos que no ocultaron los bienestares experimentados y, así, tensionaron esta construcción avergonzante y sufriente sobre el propio aborto cuando se significa como algo incorrecto, reprobable o "el mal menor". Muchas de las entrevistadas pudieron manifestar abiertamente el bienestar, tal como vimos en el apartado anterior, y significar sus experiencias como el ejercicio de un derecho, de una elección propia y a su favor, o como una oportunidad favorable para la construcción de la propia salud mental.

Narrar para las otras y "echar luz" sobre los abortos

Para muchas, narrar sus experiencias les produjo bienestar porque sintieron que podían ayudar a otras mujeres que iban a abortar, ya sea al brindarles orientación y seguridad en cuanto al método, como al sentir que con sus relatos afectaban los silenciamientos y tabúes que rodean la práctica.

> Que estas experiencias sirvan para alguien y no solo para mí misma, vivimos en sociedad y tenemos que crecer como sociedad en conjunto (Estefanía).

> Me parece que toda experiencia contada, sirve para otras personas (Lola).

> Un relato que ayude a otras personas (…) abrirle la cabeza, contarle la experiencia y tal vez hacerlo más llevadero para esa persona (Eva).

En el acto de narrar la experiencia se entraman procesos personales y relacionales que aportan a la construcción de la salud mental. Con Eva nos contactamos por primera vez en 2017 aunque no pudimos concretar un encuentro presencial. Tras el primer debate legislativo y social por la legalización del aborto en 2018, ella insistió en participar de la investigación y logramos hacer la entrevista en 2019. Este encuentro re-

sultó particularmente movilizante para ambas y aconteció en un tiempo personal y social muy distinto al que podría haber sido años antes, tema que también abordamos en nuestra conversación. Al hablar de los porqué de su decisión de compartir su experiencia de aborto, que antes para ella había sido una "mala palabra", impronunciable, destacó:

> En un principio porque yo necesitaba hablarlo, sacarlo con alguien que no era de mi mismo entorno, alguien que no me tenga pena, yo necesitaba hablarlo con alguien de afuera que no me conocía. Necesitaba por eso. Pero ahora (…) yo acepté porque sabía que era para un estudio, yo necesito que otras mujeres sepan: que tu vida no se termina ahí, que son decisiones que vos tomás y que, si este discurso puede servir para ayudar a otras personas, la verdad que para mí sería algo muy lindo (Eva).

El valor que le otorgó a compartir su experiencia, tanto para sí misma como para otras personas, cobra mayor sentido cuando entendemos su relato completo como un testimonio de la metamorfosis del dolor experimentado. Eva transitó la decisión y la práctica de abortar, inicialmente, con mucho dolor y como una "lucha", al significarla como una transgresión por cometer un asesinato y desobedecer mandatos de género que la calaban hondo. Al calor del acompañamiento de las activistas feministas y de su psicóloga pudo recomponer sentidos sobre esta experiencia, y hacer que el tránsito y el recuerdo de la misma fueran, progresivamente, menos sufrientes. El proceso de tramitación emocional y política –política en tanto pudo cuestionar ciertos mandatos de género y religiosos que pesaban normativamente sobre ella– la hizo salir fortalecida de esta experiencia y poder compartirla desde un sentimiento de "orgullo". Porque, para ella, su experiencia portaba valor y le había implicado aprendizajes. Uno de los aprendizajes que buscó compartir fue que la decisión de abortar, aunque difícil, fue integrable al curso de la vida, y que la situación crítica de embarazo no deseado/aborto voluntario, aún en condiciones sociosubjetivas fuertemente opresivas, era posible de ser superada, e incluso, de representar una oportunidad para crecer y fortalecerse. "Me siento orgullosa de todo lo que he pasado, de todo lo que he vivido y de cómo he salido, me siento orgullosa de eso. En otro momento no te hubiera podido decir lo mismo, pero ahora sí" (Eva).

Señalamos, entonces, la conexión entre el proceso personal y lo relacional: transitar un proceso de elaboración emocional y política en lo personal propició el poder pensarse aportando activa y favorablemente

a que los procesos de abortos de otras sean menos sufrientes y más saludables que lo sentenciado por los discursos imperantes. A la vez que sentirse parte activa de un proceso y tiempo colectivo que trastocó los discursos dominantes sobre abortos, también repercutió en el proceso personal afianzando su tramitación emocional y política. Aunar ambos procesos le permitió transformar la vergüenza en orgullo: desde que "decir aborto" sea "mala palabra" a experimentar el bienestar de hablar de su aborto como una experiencia que porta valor.

Este valor que las mujeres encontraron en sus experiencias hizo que se sintieran motivadas a compartir los relatos también en otros espacios. Muchas lo hacían en sus vidas cotidianas cuando detectaban que otras mujeres necesitaban abortar.

> (…) me sirvió mucho porque después de eso me crucé muchas chicas que han estado en la misma situación y no han sabido qué hacer y ha sido: "mirá, ¿sabés que a mí también me pasó?". Y hacerlas sentir un poco más seguras. Me sirvió para acompañar a otras chicas, de no tener miedo, de sentirse que todo va a estar bien, que su vida no se viene abajo, de un montón de cosas (Estefanía).

> Y ahora me gusta contarlo, a mis amigas siempre les cuento esto porque me parece que está bueno que lo contemos. A mí me pasó que cuando me pasó en primera persona otra gente me empezó a contar, y me parece que está bueno que se sepa que existe esta posibilidad y que la gente lo hace (Violeta).

De modo que decidieron compartir sus experiencias porque consideraron que poseían un saber que merecería ser compartido con otras mujeres que estuvieran próximas a abortar. Significaron que abortar es una experiencia que porta valor, que les otorgó herramientas para brindar conocimientos y orientaciones sobre el método farmacológico y, de esta manera, ayudar a simplificar otros procesos para que sean transitados con mayor seguridad. Allí radica otra de las potencias saludables de hablar de la experiencia: brindar seguridad y orientación a otras, habilitar posibilidades y tranquilizar.

Finalmente, lo que observamos es que, al hablar de sus abortos, además de tender puentes entre sus experiencias, buscaron darles entidad y existencia a nivel social y, así, afectar los procesos de silenciamiento y anormalización de estas prácticas que ellas habían logrado normalizar,

porque a las mujeres “les pasan” y “lo hacen”, porque “los abortos siempre estuvieron”.

> Una cuando empieza a hablar, después, con doñas o con gente que te encontrás en la vida y en la militancia, te das cuenta que los abortos siempre estuvieron, siempre se hicieron. También, esto que te decía recién, de sacar prejuicios (Bárbara).

> Estaba bueno el hecho de que deje de generarse tabú alrededor de esto y la forma es hablando (Estefanía).

> Me gusta que sirva mi testimonio y también que le saque un poquito de esa cuestión… no sé… está bueno hablarlo porque es algo que pasa, sacarle ese misterio (…) Hay que hablarlo, hay que hablarlo y contarlo. Y contar si estuvo buena la experiencia, si estuvo mala también, para que le ayude a alguien más (Violeta).

> La mejor manera es llevarlo a la legalidad. Eso lo pensaba desde mucho antes. Emm, pero bueno, ni hablar una vez que lo vivís en carne propia (Andrea).

Una de las motivaciones que se reiteró para ofrecer sus relatos fue el de quitar el “tabú” o el “misterio” que ronda en torno a los abortos, lo que entendemos como dejar de perpetuar el estigma para contribuir a normalizar su práctica. A continuación, retomamos parte del relato de Andrea, quien dio cuenta de un cambio progresivo en sus concepciones sobre aborto a partir de atravesar la experiencia. Ella se sintió convocada a participar de la entrevista para contar “la otra cara del aborto”, poder “ponerlo sobre la mesa” y “echar luz al aborto”, es decir, desocultar y mostrar su propia visión y versión sobre abortar.

> Quería yo venir y poder hablar esto y colaborar de alguna manera desde mi lugar para que esto pueda agarrar otro rumbo… para que otras chicas… para que se sepa, viste, un poco más al respecto. Para que no haya tantos miedos. Porque me parece que el peor enemigo en estas cuestiones es el miedo (…) creo que ese es el camino: tiene que venir por el lado de la luz, de la legalidad, de lo que todos veamos y podamos hablarlo, no que lo tengamos guardado (Andrea).

Si, parafraseando a Audre Lorde (1984) es en la soledad del silencio

donde cada una dibuja el rostro de sus miedos, Andrea entendió que poner en palabras su experiencia para dirigirla a otras podía romper esas soledades e, incluso, matizar los miedos.

> (…) la cuestión social en cuanto al aborto en particular te priva de un montón de información… (…) [pareciera] ¡que no pasa! Y de repente sí pasa un montón y ha pasado un montón y un montón de mujeres con las que te relacionás seguro también han pasado por eso. Y eso te quita un peso. Decís: "bueno, pará, no estoy haciendo nada terrible, oscuro", como la otra mirada opuesta, ¿no? (Andrea).

Sus reflexiones sobre la claridad que otorga el poder hablar de las experiencias nos remite a la importancia de visibilizarlas como un modo de romper los dispositivos de silenciamiento social y de invisibilización que han instalado la creencia de que abortar es una experiencia poco frecuente y por ello desviada y "terrible", sosteniendo el estigma sobre el aborto (Kumar, Hessini y Mitchell, 2009). Para Andrea, haberse encontrado con otras mujeres que rompieron ese velo social de silencio y que le hicieron saber que "un montón de mujeres" han abortado, le quitó el peso de "lo terrible". Luego de su aborto y al momento de ofrecer su relato en la entrevista, es ella quien va al encuentro de otras mujeres para mostrarles que se puede abortar con luz y sin miedos.

En síntesis, con sus relatos, las entrevistadas desearon acercar un mensaje a otras mujeres. Significaron que sus experiencias contenían un saber valioso para alivianar o enriquecer los procesos de otras y buscaron dar a conocer cómo fueron sus modos de transitar y superar los obstáculos y la situación crítica. Se reconocieron portadoras de esos saberes y buscaron compartirlos, tanto en el dispositivo de entrevista como en sus vidas cotidianas.

Acercarnos comprensivamente a estas visiones y versiones narradas nos lleva a afirmar que cuando las mujeres que abortan asumen la palabra sobre sus experiencias y dirigen los relatos hacia otras mujeres están aportando a los procesos de desclandestinización sociosubjetiva de los abortos. Por un lado, porque los relatos que ponen a circular se contraponen a los secretismos y silenciamientos que han teñido las prácticas abortivas y que han obstaculizado la socialización de estas experiencias. Por otro lado, porque asumieron posicionamientos subjetivos para dar contenido a sus relatos que no aceptaron las significaciones con efectos estigmatizantes y criminalizantes. De modo que las mujeres percibieron la exis-

tencia del estigma sobre el aborto, en tanto atributo negativo que las intentaba inferiorizar y fragilizar, pero no lo internalizaron pasivamente ni lo aceptaron acríticamente. Lo entendieron como un artificio social que está en la base de las emocionalidades normativas vinculadas a los embarazos no deseados/abortos voluntarios, como la culpa o la vergüenza. Hicieron un trabajo de comprensión de la raíz de sus propios malestares, lo cual hizo que los dejaran de experimentar, los apaciguaran o los relativizaran. En lugar de la internalización acrítica, narraron con vistas a la transformación. Es decir, luego de ser conscientes de las valoraciones negativas que pesan sobre el aborto –el estigma percibido– buscaron transformarlas, apoyadas en sus experiencias. Se autorizaron a hablar en voz alta y de formas que buscaron sacarle las características atribuidas de sombrío y tenebroso, para construir versiones menos clandestinizadas.

Narrar y construir salud mental

En este capítulo fuimos mostrando cómo se potenciaron diversos procesos del orden de lo saludable cuando las mujeres tomaron la palabra para construir, recrear y reafirmar sentidos propios sobre sus experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios clandestinizados.

Desde nuestra concepción, la salud mental es un proceso complejo y fluctuante que sus mismas protagonistas van construyendo en distintos momentos de sus vidas. Esta construcción se da en función de los tránsitos por las sucesivas crisis vitales y sus constantes procesos de resignificación. Son procesos abiertos y en permanente cambio que, además, presentan otra característica que nos interesa destacar: son procesos relacionales.

En las experiencias analizadas, su carácter relacional se manifestó en la importancia de las interacciones con las diversas presencias que acompañaron los tránsitos por las situaciones críticas y que impactaron en las significaciones sobre las experiencias. Consideramos que otra forma de acompañar estos procesos fue a partir de las interacciones dadas en el dispositivo técnico-ético feminista de entrevista en profundidad. Desde mi rol como investigadora feminista, reconozco la instrumentación de dos recursos que favorecieron condiciones para una expresión integral de los múltiples aspectos de las experiencias, incluida la expresión del bienestar socialmente vedado. Uno fue el ejercicio de una escucha desprejuiciada y lo más empática posible. Y otro fue el ejercicio activo de poner a disposición vivencias similares o disímiles de

otras mujeres –de otras entrevistadas, de otras mujeres que yo había acompañado en calidad de activista, incluso la propia–. Con ello, construimos puentes entre las experiencias, para despojarlas de la inusualidad con que socialmente se perciben. Esto animó a las entrevistadas a profundizar en los procesos de significación reconstructiva que se actualizaron en el narrar.

De modo que, cuando narraron sus experiencias en el marco de las entrevistas pudieron dotarlas de nuevos sentidos y comprensiones, en función de lo actual y de lo nuevo (Chaneton y Vacarezza, 2011), porque las significaciones sobre las experiencias vividas continúan en proceso de actualización y transformación en relación a múltiples presencias, entre las que me incluyo como investigadora feminista. Las reflexiones que acontecieron en el acto comprometido de narrar superaron ampliamente el ejercicio descriptivo y conformaron procesos de reinterpretación y de recreación de sentidos desde una posición presente afectada por el tiempo personal y social.

En este sentido es que afirmamos que el dispositivo de entrevista en profundidad y feminista posibilitó un espacio-tiempo para atender algunas necesidades específicas de las participantes y provocó movilizaciones subjetivas saludables en función de las condiciones de escucha, expresión, interacción y resignificación. Estas movilizaciones son constitutivas de las experiencias mismas y de los procesos de construcción de salud mental que estamos investigando.

Acordamos con Harding (2002) cuando señala que la investigación feminista está a favor de las mujeres porque atiende a sus necesidades y busca ofrecer explicaciones que las beneficien, al favorecer un mejor entendimiento de sí mismas y del mundo social. Pero, además, consideramos que haber participado del proceso de investigación feminista, más allá de sus resultados, estuvo a favor de quienes lo hicieron, porque les representó beneficios directos y concretos para sus procesos de construcción de salud mental.

La concepción de salud mental que sostenemos también es relacional en el sentido de que reconoce un espacio común y compartido en su construcción, que se potencia cuando se logran colectivizar los saberes contenidos en las experiencias singulares. Además de aquella capacidad para transitar las crisis y resignificar las situaciones y los malestares, la salud mental supone sentirse capaz de colaborar en la transformación de las situaciones y las condiciones que generan dichos malestares, con

vistas a favorecer procesos de construcción de autonomía subjetiva y de género. Muchas de las entrevistadas narraron sus experiencias con la intención de colaborar en la transformación de las condiciones opresivas que cercenan las autonomías de género y que generan padecimientos, temores y pesos diferenciales en los procesos de embarazos no deseados/abortos voluntarios clandestinizados. Significaron que sus experiencias portaban un valor que merecía ser compartido y se reconocieron como agentes de transformación de dichas condiciones opresivas y estigmatizantes. Al hacer públicas sus experiencias, usando esta investigación para ello o en sus vidas cotidianas, contribuyeron a romper con la paradoja de la prevalencia del estigma sobre el aborto, con la creencia de que es una experiencia que necesariamente debe cargarse con atributos negativos que deben asumirse y que deben avergonzar (Kumar, Hessini y Mitchell, 2009). Entendemos que la posibilidad de sentirse implicadas activamente en desarmar los significados impuestos viene de la mano de procesos de desestigmatización subjetiva que lograron poner al servicio de otras y en un contexto social determinado por disputas de sentidos sobre abortos, donde los sentidos feministas y sus narrativas se fueron convirtiendo gradualmente en protagonistas de estas disputas.

Muchas de las mujeres que se sintieron convocadas en esta batalla discursiva y semiótica de narrativas sobre abortos, lo hicieron desde el reconocimiento de poseer un poder importante: la experiencia vivida y significada como valiosa, la posibilidad de ofrecer una definición propia sobre los procesos que transitaron para trastocar las narrativas dominantes y de sentido común sobre aborto. Estas redefiniciones en voces de mujeres se orientan a favor de las mujeres como grupo social, tanto por su contenido como por su forma de narrar. Y aportan a la construcción del aborto, en tanto experiencia subjetiva y social, de formas menos sufrientes y clandestinizadas, más legítimas, favoreciendo así los procesos de construcción de salud mental asociados a estas experiencias.

Conclusiones

En esta investigación abordamos las significaciones de las mujeres que abortaron sobre sus experiencias de embarazos no deseados/abortos farmacológicos voluntarios y clandestinizados, para comprenderlas en relación a la salud mental. Nos centramos en las transformaciones que sufrieron las significaciones y las emocionalidades, al ir atravesando y resignificando estas situaciones críticas. Transformaciones que fueron fundamentales en los procesos de construcción de salud mental.

Dos aspectos centrales caracterizaron estas experiencias y el proceso de transformación de significaciones: que fueron experiencias clandestinizadas, es decir, afectadas por procesos de penalización/criminalización, de marginación de los servicios de salud, por los pesos de la estigmatización y la imposición del silenciamiento, con diversos impactos subjetivos. Pero también que fueron experiencias acompañadas, ya que las mujeres gestionaron diversas presencias que facilitaron los tránsitos y la tramitación emocional de estas experiencias. Entre estas presencias, se destacaron las valoraciones sobre otras mujeres de sus entornos afectivos, las activistas feministas –principalmente socorristas– y las psicólogas que ofrecieron interacciones sensibles a los dispositivos de fragilización de género.

A continuación, compartimos conclusiones sobre el complejo entramado entre experiencias, significaciones, configuraciones emocionales, clandestinización y acompañamientos a partir de dos grandes tensiones:

- la tensión entre los riesgos y los cuidados,
- la tensión entre la estigmatización y la búsqueda y construcción de legitimidad y valor sobre estas experiencias.

Finalizamos con algunas conclusiones sobre la importancia de los discursos y prácticas psi críticos de los dispositivos de fragilización de

género para los procesos de construcción de salud mental de las mujeres que abortan.

Entre riesgos y cuidados...

La actuación de los procesos de clandestinización generaron las condiciones no elegidas, pero presentes, que dieron forma a las significaciones iniciales y los malestares. De modo que las experiencias se transitaron en el marco de múltiples violencias imaginadas, percibidas y experimentadas. Violencias funcionales a los dispositivos de fragilización de género que alimentaron la vivencia y la significación del aborto como una práctica de riesgo y como un camino lleno de obstáculos que deberían superar.

A medida que fueron transitando por estas situaciones críticas, las significaciones iniciales sufrieron transformaciones y se tensionaron gracias al trabajo activo de gestión y obtención de protecciones, recursos y apoyos a su favor, que conceptualizamos en términos de relaciones de cuidados principalmente con otras mujeres.

Las presencias facilitadoras acompañaron, sostuvieron e hicieron estas experiencias más transitables, potentes y saludables. Tuvieron una participación decisiva en la construcción de significaciones que operaron a favor de los procesos de construcción de salud mental. En parte, porque permitieron desarticular el peso del propio aborto significado como una práctica de riesgo y, en parte, porque en el tránsito mismo, lo fueron significando como un proceso cuidado en el que superaron los obstáculos percibidos y proyectados.

Sobre estos tránsitos acompañados y sus implicancias en cuanto a la tensión entre riesgos/cuidados, compartimos dos conclusiones.

Primero, destacamos el rol activo y protagónico de las mujeres para gestionar y obtener apoyos y recursos, en tanto alternativa saludable. Las redes que construyeron junto a otras mujeres de sus entornos afectivos o con las activistas feministas y el trabajo que esto les implicó, fueron verdaderas estrategias de supervivencia frente a la experiencia precarizada. Les permitió disminuir los riesgos concretos y las violencias asociadas a una práctica clandestinizada. Por ello, las pensamos como una forma de batallar potentemente contra la precaridad inducida. En este sentido, rescatamos las palabras de Butler (2017) cuando señala que actuamos desde el sentido de precaridad y en contra de esta cada vez que nos rehusamos a que nuestras vidas sean desechables. Las experien-

cias de las mujeres –las que abortaron y las que acompañaron– dan cuenta de esas batallas.

Como segunda conclusión destacamos el carácter relacional de las significaciones y de las transformaciones afines a los procesos de construcción de salud mental. Dedicamos varios capítulos a analizar cómo y con quiénes pudieron abortar, es decir, los modos en que lograron abordar y superar los obstáculos e ir transformando las significaciones de riesgos y los malestares hacia significaciones vinculadas con el cuidado, lo cual les generó bienestar. Estos procesos sucedieron junto a las presencias facilitadoras que actuaron de forma eslabonada y sinérgica.

Hasta hace una década atrás, las revisiones de las investigaciones sobre abortos en Latinoamérica destacaban el gran potencial del método farmacológico para la salud de las mujeres (Zamberlin, 2015). En esta investigación, lo que mostramos es cómo la potencia del método farmacológico para abortar de manera voluntaria, autogestionada y saludable se multiplica cuando esta tecnología se sostiene en las relaciones humanas. Es decir, en las presencias facilitadoras que construyeron a partir de sus vínculos afectivos y en las redes de acompañamiento activistas y profesionales disponibles. Esta potencia no solo preserva la salud física, sino también promueve los procesos de construcción de salud mental.

Desde el modelo teórico elegido, que revaloriza lo participativo en la construcción de acciones y criterios de salud mental y que se centra en las experiencias y saberes de las mujeres sobre sus propios procesos, encontramos un valor particular en las valoraciones de las entrevistadas sobre los modos de acompañar de amigas, feministas y profesionales del campo psi. Es así que estas formas de acompañamientos, gestadas en los márgenes de los servicios formales de salud, nos brindan elementos interesantes para seguir pensando y exigiendo cómo queremos que sean los cuidados y las participaciones cuando los servicios de salud sí alojan estas experiencias. Mucho más a partir del cambio normativo ocurrido a finales del año 2020 que regula el acceso a las interrupciones voluntarias de embarazos en dichos servicios.

Entre la estigmatización y la construcción de legitimidad y valor sobre las experiencias…

Tras realizar este recorrido podemos caracterizar las significaciones y las configuraciones emocionales sobre estas experiencias como heterogéneas

y múltiples, además de destacar su carácter cambiante y dinámico. Esto se corresponde con el constante devenir abierto de los procesos de construcción de salud mental, incluso al momento de participar del dispositivo de entrevista que propusimos.

Asociamos esta caracterización de las significaciones a las disputas de sentidos sociosubjetivos sobre abortos en las que acontecieron las experiencias analizadas; disputas que alimentaron la tensión entre estigmatización/legitimidad. La estigmatización asociada al aborto fue un emergente que recuperamos a lo largo de esta investigación por su notable presencia en los procesos de significación de las experiencias.

Esta tensión se sostuvo en un particular tiempo histórico-social, donde coexistieron con fuerza, por un lado, los discursos que patologizaban, culpabilizaban, avergonzaban, silenciaban y estigmatizaban y, por otro lado, los discursos y prácticas feministas que buscaban instalar sentidos sobre abortos como experiencias legitimadas, posibles de ser visibilizadas, habladas y compartidas como prácticas frecuentes y normalizadas. Observamos que, lejos de ser determinantes contextuales, ambos polos de esta tensión se instalaron como textos que determinaron las variadas formas de atravesar y significar los abortos.

Encontramos una fuerte actuación de significaciones estigmatizantes sobre todo en los momentos iniciales, aunque sin determinar una única forma de vivir y significar la experiencia. Luego, en los tránsitos acompañados, las mujeres fueron buscando y encontrándose con prácticas y discursos feministas de desclandestinización, que les aportaron otros sentidos y direccionaron los procesos de construcción de legitimidad. La conjugación del tiempo histórico-social con los tiempos biográficos subjetivos de cada mujer dio lugar a diversos matices al momento de encarnar y ubicarse frente a dicha tensión.

De modo que, algunas quedaron más atravesadas por los efectos de la estigmatización en el sentido de asumirlos y significar las experiencias en consonancia con los ideales normativos de género y desde un sentimiento de inadecuación, sufriendo los silenciamientos impuestos. Las principales significaciones iniciales estigmatizantes fueron: que el aborto era una decisión egoísta, que era una transgresión del mandato religioso por ser considerado un asesinato, o que era una transgresión de las expectativas sociales dominantes sobre las mujeres. También que era una experiencia (auto) reprobable y sancionable, y una práctica excepcional y desviada que debían silenciar. Quienes significaron inicialmente los

abortos desde estos posicionamientos, experimentaron malestares vinculados a la culpa, el avergonzamiento, el temor a una venganza divina, el temor a la retirada del cariño de algunos seres queridos y la falta hacia un "deber ser femenino", que en algunos casos ampliamos a la falta hacia un "deber desear femenino".

Sin embargo, muchas otras entrevistadas dieron cuenta de los esfuerzos y procesos de reflexión crítica y resignificación para transformar los impactos de la estigmatización. Pudieron construir significaciones más asociadas a la legitimidad de sus deseos, decisiones y experiencias que colaboraron en transformar los malestares experimentados o sentenciados. A la vez que pudieron experimentar y reconocer el bienestar ligado a atravesar y superar estas situaciones críticas. Estos procesos de resignificación también fueron relacionales y facilitados por las presencias que gestionaron.

Concluimos, entonces, que los procesos de construcción de salud mental se vieron favorecidos cuando las mujeres construyeron significaciones que desarmaron el peso de la estigmatización, para avanzar en la construcción de legitimidad y valor sobre sus experiencias. Una de estas significaciones fue la de oportunidad, que en las experiencias analizadas asumió tres grandes sentidos: la oportunidad para afianzar vínculos afectivos; la oportunidad para enriquecerse por ganar aprendizajes y afianzar recursos y saberes y, la oportunidad para ejercer/construir autonomía.

Oportunidad para afianzar vínculos afectivos

Esta forma de significar las experiencias estuvo vinculada a la posibilidad de establecer relaciones de cuidado con otras mujeres de sus entornos afectivos cercanos, principalmente hermanas y amigas.

Sabemos que la estigmatización sobre el aborto alimenta su significación como experiencia avergonzante y susceptible de ser reprochada y sancionable si toma estado público. Por lo tanto, suele ser silenciada y esto priva de pedir y recibir ayuda. Sin embargo, en los relatos analizados las mujeres superaron activamente la barrera social del silenciamiento impuesto y desarticularon estas significaciones para solicitar ayuda a sus vínculos cercanos.

Tras dar esos pasos iniciales, estos acompañamientos colaboraron en desconfirmar los efectos del estigma percibido. Ya que, en lugar de rechazo, maltrato y soledad, recibieron aceptación empática, cuidados

y acuerpamientos, incluso algunas refirieron sentir verdaderos "equipos" que las sostuvieron. Las relaciones con sus amigas, en lugar de verse deterioradas o quebradas, se afianzaron al transitar juntas estas experiencias. De modo que estas experiencias representaron una oportunidad para afianzar los vínculos intragénero. A la vez que representaron un avance en el proceso saludable de desclandestinización y construcción de legitimidad, en el sentido de que para gestionar los acompañamientos tuvieron que subvertir, de alguna manera, los procesos de silenciamiento y, cuando abortaron en compañía, alteraron los modos dominantes impuestos de transitar los abortos. Esto es, como prácticas que deben permanecer aisladas, silenciadas y enquistadas en lo individual.

Oportunidad para enriquecerse por ganar aprendizajes y afianzar recursos y saberes

Esta forma de significar las experiencias se asocia al reconocimiento de las redes, apoyos, estrategias de protección y saberes que gestionaron y construyeron, en el entramado de las relaciones de cuidado. En los tránsitos por las experiencias fueron afianzando ciertos micropoderes a partir de validar encarnadamente los propios saberes, tanto los de las mujeres que abortaron como los de las que las acompañaron. Se sintieron portadoras de saberes y experiencias valiosas, para ellas mismas y para otras. Y al ponerlas a disposición mediante sus relatos, ya sea en distintos momentos de sus vidas cotidianas y/o en este proceso de investigación, las mujeres se significaron como agentes activas de transformación de los sentidos sobre los abortos.

Las transformaciones en las significaciones, necesarias para poder socializar las experiencias de aborto, estuvieron al compás de procesos sociales y colectivos más amplios de deconstrucción de la clandestinización. De modo que, los procesos instituyentes de subjetivación del derecho al aborto, al decir de Rosenberg (2020), que fueron protagonizando, interiorizando y exteriorizando se entrelazaron con la reconfiguración de otros marcos de inteligilidad sobre los abortos que los feminismos fueron construyendo y ofreciendo para ampliar las condiciones de enunciabilidad del propio aborto y de los abortos en general.

Como vimos, parte del resultado de este arduo trabajo en Argentina se hizo evidente en el año 2018, mientras realizábamos el trabajo de campo de esta investigación, cuando las activistas organizadas princi-

palmente en la Campaña, lograron poner en la agenda pública la necesidad de la desclandestinización y las voces de quienes abortaban y acompañaban abortos. Consideramos que nuestro proceso de investigación es parte de estos andares feministas que se propuso dar lugar a esas voces y relatos sobre abortos.

En este sentido, concluimos que la influencia entre los discursos feministas y las experiencias de abortos voluntarios de las mujeres es recíproca y circular. Ya que los discursos feministas pusieron a disposición repertorios emocionales y significaciones que instalaron otras legitimidades. Estos repertorios novedosos fueron construidos en conjunto con las mujeres que abortaron, como vimos que estratégicamente hicieron Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto o Socorristas en Red. Las entrevistadas que se sintieron cercanas o parte de estas prácticas y discursos feministas pudieron apropiárselos. Así, significaron sus abortos como experiencias que contenían un valor positivo, cuyo tránsito y superación desdijo eso de avergonzante y trágico que se les supone.

Pero a la vez que cuando asumieron la palabra, ellas aportaron a robustecer los marcos afectivos y de significación política feminista sobre aborto. Por ejemplo, cuando expresaron que abortar y hablar de ello no les generó vergüenza ni incomodidad o cuando pudieron significarlo y compartirlo como un acto de autonomía, de cuyo ejercicio se sentían orgullosas, o como una experiencia que portaba un valor positivo.

Oportunidad para construir y ejercer autonomía

Hemos definido teóricamente la importancia de la autonomía en los procesos de construcción de salud mental. A partir del análisis realizado, entendemos la construcción y ejercicio de autonomía en estas experiencias concretas en dos sentidos.

El primer sentido se refiere a poder diferenciarse de las significaciones iniciales estigmatizantes y de las configuraciones emocionales culpógenas y avergonzantes, para construir significaciones propias.

Las mujeres realizaron el trabajo de discernir cuáles eran sus deseos en torno a los embarazos para lograr acciones voluntarias a favor de la propia condición deseante y, así, significar que estaban tomando una decisión a su favor. En este proceso, lograron desligarse de ciertas narrativas míticas sobre la Mujer = Madre, pudieron decir no al mandato de la maternidad obligatoria y a la ligazón indisoluble entre embarazo y mater-

nidad, cuando así lo desearon, para reafirmar otros sentidos y proyectos vinculados a su feminidad sin sentirse egoístas o "malas mujeres".

A la vez que pudieron repensar cómo estaban habitando los cautiverios que les imponía la cultura patriarcal. Realizaron un trabajo emocional y político de cuestionar los malestares que las aquejaban y las condiciones socioculturales que los producían. Sobre todo, aquellos vinculados al avergonzamiento y a la culpabilización que socialmente se asocian a los abortos por ser experiencias estigmatizadas.

El segundo sentido se refiere a la capacidad de elegir abortar y, sobre todo, cómo abortar. Es decir, cuando significaron que abortar era coherente con sus deseos y decisiones, y cuando dicha elección se extendió, además, a los modos en que abortaron, a poder elegir quiénes fueron sus acompañantes y quiénes no. El reconocimiento de estas elecciones cobró vital importancia frente a una serie de condiciones no elegidas e impuestas por la clandestinización, ya que las entrevistadas valoraron que sí hubo aspectos fundamentales de las experiencias que lograron elegir.

A su vez, consideramos que tanto estas elecciones como los procesos de diferenciación de las significaciones estigmatizantes fueron posibles porque hubo presencias disponibles, facilitando recursos y ofreciendo sentidos para resignificar las experiencias. Al respecto, destacamos los aportes de las presencias activistas y de las presencias psi.

Salud mental y aborto: la importancia de los discursos psi críticos de los dispositivos de fragilización de género

A lo largo de este proceso, conocimos cuáles fueron las necesidades emocionales de las mujeres, sus malestares y sus valoraciones sobre cómo operaron las interacciones con profesionales del campo psi en sus procesos de significación. Esto nos permite concluir en la importancia de los discursos y prácticas psi que colaboraron en la transformación de los malestares y las significaciones sobre las propias experiencias, para poder situarse de maneras más saludables en la tensión estigmatización/legitimidad.

Partimos de entender que las prácticas y discursos psi no son ajenos ni neutrales a las disputas de sentidos de género sobre abortos, sino que conforman dispositivos eficaces en la producción de significaciones sociosubjetivas. Ya que cuentan con una especificidad técnica-disciplinar y política, debido al poder atribuido a las profesiones psi desde el imaginario social en cuanto a la producción de discursos de verdad sobre la

salud mental. De modo que construyen sentidos sobre lo que es pertinente y transgresor para cada género y, por lo tanto, lo que se considera normal y lo anormalizado en cuanto a acciones, expresiones, elecciones, sentires, deseos, etc. Estos sentidos se materializan en las prácticas, las formas de interacción concretas, donde los/as/es profesionales pueden contribuir a reproducir sentidos que generan o agudizan malestares y estigmatizaciones, o a fisurarlos y trastocar las prescripciones y transgresiones establecidas desde las normatividades de género. Y, en este último sentido, colaborar en la recreación de sentidos que faciliten el tránsito por las experiencias.

Las presencias psi valoradas como facilitadoras fueron las que no descontextualizaron los malestares ni despolitizaron sus intervenciones. Es decir, consideraron estas experiencias entramadas en las condiciones y relaciones de género en que ocurrieron y no se redujeron a explicaciones individualistas reduccionistas. Según las valoraciones, actuaron como discursos y prácticas que reconocieron, de algún modo, la actuación de los dispositivos de fragilización de género y contribuyeron a debilitar sus efectos de poder, fomentando la construcción subjetiva de autonomía de las mujeres consultantes. Es por ello que concluimos en que las situaciones de embarazos no deseados/abortos voluntarios clandestinizados y la complejidad de los sentidos de género que se encuentran contenidos en dichas consultas convocan a sostener discursos psi críticos de los dispositivos de fragilización de género y a politizar las prácticas profesionales.

Al hablar de discursos psi, diferenciamos dos grandes miradas teórico-políticas sobre la relación entre aborto y salud mental, que situamos en el marco de la tensión estigmatización/legitimación. Una de ellas, es la que está atenta a los dispositivos de fragilización de género y contribuye a su desarticulación y cuestionamiento. La otra mirada es la que patologiza estas experiencias, lo cual entendemos como un dispositivo más de fragilización de género. Estos enfoques parten de suponer una relación filial entre la mujer que abortó y el "hijo abortado" y refuerzan la significación estratégica del aborto como un atentado que (les) provoca daños y, por ende, ubica a las mujeres que abortan como dañinas, a la vez que como víctimas de los abortos. Las intervenciones que se proponen desde este enfoque buscan disuadir de la decisión, al intentar fomentar sentimientos positivos hacia el embarazo o atemorizar con advertencias sobre los riesgos patológicos que conllevaría abortar. A su vez,

las intervenciones post aborto se centran en ayudar a elaborar supuestos procesos de duelo por la pérdida de "un hijo" del que necesitan recibir un perdón para liberarse de la culpa.

Sin embargo, las necesidades que las mujeres reconocieron como propias en esta investigación nos muestran otro tipo de vivencias y emocionalidades que nos permiten cuestionar las miradas patologizantes y sus propuestas de intervención, y que son bien distintas de las interacciones psi facilitadoras que pudimos delimitar a partir de las valoraciones de las protagonistas de las experiencias.

Los discursos patologizantes, a pesar de haber sido objeto de reiteradas y fundamentadas críticas en cuanto a su solvencia metodológica y teórica (Rondón, 2009), continúan circulando con fuerza y ofrecen a las mujeres y a los/as/es profesionales determinadas representaciones sobre salud mental y aborto ligadas al polo de la enfermedad que, desde el modelo tensional-conflictivo participativo, buscamos revisar críticamente. Considerando su carácter performativo y el contexto de enunciación en el que se inscriben estos argumentos, consideramos que son científicamente irresponsables y políticamente peligrosos para los procesos de construcción de salud mental de las mujeres que, concreta o potencialmente, transitan un aborto y deciden contar con apoyo profesional psicológico en este tránsito.

Científicamente irresponsables por la dificultad que presentan para reconocer públicamente sus propias inscripciones ideológicas vinculadas a concepciones religiosas y conservadoras de género, mientras que, a la vez, realizan un llamado a realizar investigaciones empíricas científicas "libres de sesgos ideológicos" sobre el tema (Gómez Lavín y Zapata García, 2012). Además, por la ausencia de observancia sobre las severas deficiencias teórico-metodológicas que estos postulados ya han recibido a modo de crítica, a pesar de lo cual siguen circulando como discursos de carácter científico que afirman la existencia de un cuadro psicopatológico con estatus de "síndrome".

Los consideramos políticamente peligrosos por las repercusiones de la patologización y estigmatización en diversos campos, entre ellos, el de la formación y el ejercicio profesional psi, lo cual tiene efectos concretos en las experiencias de las mujeres que abortan.

Asumir la sentencia "abortar trauma", desde un lugar de experticia, obtura las posibilidades de interrogarse por el universo particular y complejo implicado en los procesos de salud mental de las mujeres en rela-

ción con estas experiencias, ya que parten de una respuesta: abortar afecta negativamente la salud mental de quien aborta. Y esto opera tanto como una sentencia intimidante, potencialmente dirigida hacia quienes abortaron/abortarán, como un *a priori* iatrogénico en la práctica clínica o en la teorización psi sobre el tema, cuando se acata acríticamente y se desconocen sus andamiajes políticos. La patologización anticipada del aborto puede llevar a que los/as/es profesionales se vinculen anticipadamente con mujeres patologizadas, esto es, consideradas como traumadas, o a quienes se les suponga un estado de duelo o una relación filial sufriente con el producto de un embarazo que fue o será interrumpido. Por lo tanto, el resultado de esa intervención o pedido de escucha solicitado por las mujeres puede devenir en un espacio violento por la inoculación de sentidos sobre el embarazo/aborto que no se correspondan con los que ellas mismas están construyendo y transitando.

Además, el hecho de fomentar, como regla general, sentimientos positivos hacia un embarazo que se busca interrumpir, ubica a los/as/es profesionales por encima de las necesidades de las consultantes. Viola principios éticos básicos de las prácticas profesionales en psicología como el respeto por los derechos, la dignidad, la autonomía y el bienestar, y el principio de integridad que compromete a realizar un quehacer íntegro, mantener una especial prudencia frente al uso de nociones que generen devaluación o discriminaciones y realizar una vigilancia estricta para que los propios sistemas de creencias, valores y limitaciones no produzcan efectos adversos en el trabajo profesional (Fepra, 2013).

En definitiva, pueden devenir en el ejercicio de violencias iatrogénicas y afectar negativamente los procesos de construcción de salud mental cuando las mujeres solicitan este tipo de acompañamientos. Pero es necesario reiterar una aclaración: los discursos patologizantes no conforman prácticas singulares y deliberadas de tal o cual profesional, sino que su poder performativo, el de producir los efectos que nombra, se hace posible al apelar a una serie de convenciones normativas de género a las que referencian y a las que encubren. Normativas de género que circulan al interior de las disciplinas y las habitan y que es necesario seguir desmontando ya desde la misma instancia de la formación de grado en salud mental.

Concluimos reconociendo la importancia del acompañamiento profesional psi en los tránsitos por las experiencias de embarazos no deseados/abortos voluntarios cuando así lo eligen las mujeres, desde

posicionamientos que logren una escucha genuina frente a las necesidades y deseos planteados por las mujeres. Acompañamientos que respeten las maneras de transitar sus decisiones y que colaboren en desarmar los efectos de los dispositivos de fragilización de género sobre las mujeres que abortan. Tanto para sostener intervenciones éticas a favor de la vida, de la salud integral y de la construcción de autonomía, como para que la presencia profesional no se convierta en una instancia más de ejercicio de violencias, en el marco de las hostilidades y las violencias que las mujeres enfrentan al momento de decidir y atravesar una experiencia estigmatizada.

Forma parte de los desafíos actuales, el seguir construyendo buenas y respetuosas intervenciones profesionales frente a las demandas para implementar las políticas públicas de salud que garanticen las Interrupciones Voluntarias de Embarazos, prácticas que ya se encuentran insertas de manera formal y regulada en el universo de prestaciones profesionales dentro de los servicios de salud públicos y privados.

Aperturas, nuevos interrogantes, nuevas incertidumbres

El trayecto de investigación emprendido nos invita a plantear nuevos interrogantes y a alentar futuras investigaciones. La práctica del aborto con medicamentos y con acompañamiento feminista, el compromiso corporal y la movilización emocional que para muchas mujeres supone, se convierten en una oportunidad para seguir repensando los entrecruzamientos entre los recursos promovidos desde los feminismos y los procesos de construcción de salud mental, a partir de las experiencias.

Además, la complejidad de la noción de *clandestinización* nos abre un interesante campo para investigar las transformaciones y continuidades que conlleva la modificación del escenario legal, sociosubjetivo y al interior de las relaciones sociosanitarias tras la sanción de la Ley Nacional Nº 27610/2020 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto. Nos preguntamos cómo continuará operando la estigmatización en las experiencias de las mujeres que abortan en un escenario social y político complejo y renovado. Ya que, por un lado, se avanza en la descriminalización formal y en la incorporación de estas prácticas en los servicios de salud, que hoy tienen obligaciones y responsabilidades formales para garantizar el acceso a los abortos voluntarios como derecho. Pero, por otro lado, nos vemos afectadas por un recrudecimiento conservador en el marco de un gobierno

nacional de ultra derecha que viene a atentar, desde lo discursivo y lo práctico, desde lo simbólico y lo material, contra algunos de los derechos más básicos que se habían logrado formalizar. El modo en que estos devenires se entramen en las experiencias concretas de quienes quieran/necesiten ejercer su derecho al aborto nos muestra un interesante camino para seguir indagando. Así como abre interesantes preguntas sobre cómo se desplegarán los procesos de estigmatización y de construcción de legitimidad en estos cambiantes escenarios legales y sociosubjetivos.

Anticipamos, en función de la distinción entre despenalización, legalización y legitimación del aborto que realiza Luc Boltanski (2016), que consolidar la legitimidad de abortar es y será un proceso espinoso, tenso y nunca definitivo. Incluso, las experiencias investigadas en otras geografías, donde el aborto por plazos lleva cerca de una década en estado de legalización, como en el DF mexicano, muestran la necesidad de las mujeres y los grupos feministas de continuar delimitando estrategias para debilitar el estigma asociado. Como también, para sostener la legitimidad de las decisiones de abortar frente a la constante amenaza de retrocesos por el accionar de sectores anti derechos y conservadores (Cedeño *et al*., 2019). Podemos anticipar, atentas a la realidad sociopolítica argentina actual, que esa disputa tensa entre sectores se irá recrudeciendo y adquiriendo una complejidad distinta.

Frente a este panorama, cuáles están siendo y serán las estrategias desde los feminismos locales, cuáles sus continuidades y reformulaciones, cuáles los nuevos obstáculos a enfrentar y cuáles sus aportes a los procesos de construcción de salud mental en torno a estas experiencias son interrogantes que pueden guiar las futuras y necesarias investigaciones.

Cierro este libro con muchas incertidumbres, pero con la fuerte convicción feminista de que "los derechos no se mendigan, se conquistan" (Anzorena y Zurbriggen, 2013: 13). Y en los tiempos que corren nos toca defenderlos y ampliarlos.

Bibliografía

AAVV (2013). *El aborto como derecho de las mujeres. Otra historia es posible*. Buenos Aires: Herramienta.

Adler, Nancy; David, Henry; Major, Brenda; Roth, Susan; Russo, Nancy & Wyatt, Gail (1990). "Psychological Responses after Abortion". *American Association for the Advancement of Science,* 248 (4951): 41-44. [En línea] https://doi.org/10.1126/science.2181664

Adler, Nancy; David, Henry; Major, Brenda; Roth, Susan; Russo, Nancy & Wyatt, Gail (1992). "Psychological factors in abortion: a review". *American Psychologist*, 47 (10): 1194-1204. [En línea] http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.47.10.1194

Ahmed, Sara (2015). "Vergüenza ante los otros". En *La política cultural de las emociones* (pp. 161-190). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Alma, Amanda y Lorenzo, Paula (2009). *Mujeres que se encuentran. Una recuperación histórica de los Encuentros Nacionales de Mujeres en Argentina (1986-2005).* Buenos Aires: Feminaria Editora.

APA [American Psychological Association] Task Force on Mental Health and Abortion (2008). *Report of the Task Force on Mental Health and Abortion*. USA: APA. [En línea] http://www.apa.org/pi/wpo/mental-health-abortion-report.pdf

Anzorena, Claudia (2002). *Las representaciones de la sexualidad femenina en el campo de las políticas públicas. Un seguimiento de organismos y programas en la provincia de Mendoza, 1988-2001*. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Cuyo. Repositorio digital de Universidad Nacional de Cuyo. [En línea] https://bdigital.uncu.edu.ar/5366

Anzorena, Claudia (2013a). "Romper la ley: el gobierno de Mendoza frente al aborto no punible". *Revista Bagoas, Estudos Gays, Gênero e Sexualidades*, 7: (9): 267-292. [En línea] https://periodicos.ufrn.br/bagoas/article/view/4665

Anzorena, Claudia (2013b). *Mujeres en la trama del estado. Una lectura feminista de las políticas públicas*. Mendoza: Ediunc, Ediciones Biblioteca Digital UNCuyo.

Anzorena, Claudia y Zurbriggen, Ruth (2013). "Presentación. Trazos de una experiencia de articulación federal y plural por la autonomía de las mujeres: la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina". En AAVV, *El aborto como derecho de las mujeres. Otra historia es posible* (pp. 9-38). Buenos Aires: Herramienta.

Aznar, Justo y Cerdá, German (2014). "Aborto y salud mental de la mujer". *Acta Bioethica*, 20 (2): 189-195. [En línea] https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v20n2/art06.pdf

Bach, Ana María (2010). *Las voces de la experiencia: el viraje en la filosofía feminista*. Buenos Aires: Biblos.

Bartra, Eli (2010). "Acerca de la investigación y la metodología feminista". En Norma Blázquez Graf (comp.), *Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales* (pp. 67-78). México: CEIICH-UNAM. [En línea] https://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceiich-unam/20170428032751/pdf_1307.pdf

Bellucci, Mabel (2014). *Historia de una desobediencia. Aborto y feminismo.* Buenos Aires: Capital Intelectual.

Bergallo, Paola (2011). "Aborto y justicia reproductiva: una mirada sobre el derecho comparado". *Cuestión de Derechos*, 1 (20): 20-44. [En línea] https://salutsexual.sidastudi.org/es/registro/ff8081814ace5f93014af1d2445600c2

Biggs, Antonia; Rowland, Brendly; McCulloch, Charles & Foster, Diana (2016). "Does abortion increase women's risk for post-traumatic stress? Findings from a prospective longitudinal cohort study". *BMJ Open* 6, e0009698.

Boltanski, Luc (2016). "Capítulo VI. La justificación del aborto". En *La condición fetal. Una sociología del engendramiento y del aborto* (pp. 269-328). Madrid: Akal.

Brown, Josefina (2006). "De cuando lo privado se hace público, o de cómo se construyen las políticas sobre sexualidad y (no) reproducción. El caso de Mendoza". En M. Petracci y S. Ramos (comps.), *La política pública de salud y derechos sexuales y reproductivos en la Argentina: aportes para comprender su historia* (pp. 131-156). Buenos Aires: Cedes.

Burin, Mabel (1990). *El malestar de las mujeres. La tranquilidad recetada*. Buenos Aires: Paidós.

Burin, Mabel (1992). "Nuevas perspectivas en salud mental de las mujeres". En A.M. Fernández (comp.), *Las mujeres en la imaginación colectiva* (pp. 314- 332). Buenos Aires: Paidós.

Burin, Mabel (1999). "Género y psicoanálisis: subjetividades femeninas vulnerables". En M. Burin y E. Dio Bleichmar (comps.), *Género, Psicoanálisis y subjetividad* (pp. 61-99). Buenos Aires: Paidós.

Burin, Mabel (2009). "Salud mental". En S. Gamba (coord.), *Diccionario de estudios de género y feminismos* (pp. 291-292). Buenos Aires: Biblos (2ª ed.).

Burin, Mabel (2017). "A veinte años del Foro de Psicoanálisis y Género: mis aportes a la construcción de un campo complejo". En I. Meler (comp.), *Psicoanálisis y género. Escritos sobre el amor, el trabajo, la sexualidad y la violencia* (pp. 45-69). Buenos Aires: Paidós.

Burin, Mabel; Giberti, Eva; Dio Bleichmar, Emilce; Coria, Clara; Moncarz, Esther; Carreño, Dolly; Velázquez, Susana; Meler, Irene y Castro, Inés (2002). *Estudios sobre la subjetividad femenina. Mujeres y salud mental*. Buenos Aires: Librería de mujeres (2ª ed.).

Burton, Julia (2017). "De la comisión al socorro: trazos de militancia feminista por el derecho al aborto en Argentina". *Descentrada*, 1 (2), e020. [En línea] http://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe020

Burton, Julia (2021). "Los estudios sobre aborto en Argentina. Un estado de la cuestión". *Cadernos Pagu*, (63). [En línea] https://doi.org/10.1590/18094449202100630014

Butler, Judith (2002). *Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*. Buenos Aires: Paidós.

Butler, Judith ([1990] 2007). "Sujetos de sexo, género y deseo". En *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad* (pp. 45-99). Buenos Aires: Paidós.

Butler, Judith (2010). *Marcos de Guerra. Las vidas lloradas*. Buenos Aires: Paidós.

Butler, Judith (2017). "Vulnerabilidad corporal, coalición y la política de la calle". *Nómadas*, 46: 13-29. [En línea] https://doi.org/10.30578/nomadas.n46a1

Cámara de Diputados (2012, 30 de agosto). Versión taquigráfica del 30/08/2012. Cámara de Diputados. Provincia de San Luis. [En línea] https://diputados.sanluis.gob.ar/diputadosasp/paginas/pagina.asp?paginaID=96

Caridad, Ada y Rodríguez, Alfonso (2002). "La salud mental de las mujeres. Una propuesta para el debate". *La Ventana*, (16): 36-55.

Carrera, María Lina; Saralegui Ferrante, Natalia y Orrego-Hoyos, Gloria (2020). "Informe: La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina". CELS, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y CUSAM. [En línea] https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2020/12/La-criminalizaci%C3%B3n-por-aborto-y-otros-eventos-obst%C3%A9tricos-en-la-Argentina20201228.pdf

Carril Berro, Elina y López Gómez, Alejandra (2007). *Resultados de la investigación: Aspectos psicológicos del aborto voluntario en contextos de ilegalidad y penalización*. Montevideo: Cátedra libre en Salud reproductiva, sexualidad y género. Facultad de Psicología. Universidad de la República.

Carril Berro, Elina y López Gómez, Alejandra (2008). *Entre el alivio y el dolor. Mujeres, aborto voluntario y subjetividad.* Montevideo: Ediciones Trilce.

Carril Berro, Elina y López Gómez, Alejandra (2010). "Aborto voluntario y subjetividad en contextos de penalización. Efectos y significados en mujeres, varones y profesionales de la salud". *Psicología, Conocimiento y Sociedad - Revista de la Facultad de Psicología*, (2): 1-36. [En línea] https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/article/view/40/187

Castañeda Salgado, Martha (2006). "La antropología feminista hoy: algunos énfasis claves". *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 48 (197): 35-47. [En línea] http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v48n197/0185-1918-rmcps-48-197-35.pdf

Cedeño, Lurel; Tena Guerrero, Olivia; Flores, Fátima y Rocha Sánchez, Tania Esmeralda (2019). "Guardar/romper el silencio sobre la interrupción voluntaria del embarazo: narrativas de mujeres mexicanas". *Athenea Digital*, 19 (2), e2313. [En línea] https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2313

Chaneton, July y Vacarezza, Nayla (2011). *La intemperie y lo intempestivo: experiencias del aborto voluntario en el relato de mujeres y varones*. Buenos Aires: Marea.

Chaparro, Amneris (2021). "Entrevista a Marta Lamas. De activismos, academia y feminismos: un diálogo con Marta Lamas". *TyR*, Nº 1. [En línea] https://www.clacso.org/de-activismos-academia-y-feminismos-un-dialogo-con-marta-lamas/

Charles, Vignetta; Chelsea, Polis; Sridhara, Srinivas & Blum, Robert (2008). "Abortion and long-term mental health outcomes: a systematic review of the evidence". *Contraception*, 78: 436-450. [En línea] https://doi.org/10.1016/j.contraception.2008.07.005

Checa, Susana (comp.) (2006). *Realidades y coyunturas del aborto. Entre el derecho y la necesidad*. Buenos Aires: Paidós.

ciriza, alejandra (2009). "Notas sobre ciudadanía sexual: El derecho al aborto y la ciudadanía de las mujeres en el debate argentino". *Escenarios Alternativos* 24-3: 1-9 [En línea] https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/40313

CLACAI - Ipas (2011). *Misoprostol y aborto con medicamentos en Latinoamérica y el Caribe*. [En línea] https://clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/62/Misoprostol.aborto.ALC.pdf?sequence=15&isAllowed=y

Código Penal de la Nación (1921). Argentina.

Cohen, Susan (2006). "Abortion and Mental Health: Myths and Realities". *Guttmacher Policy Review*, Summer, Vol. 9, Nº 3. [En línea] https://www.guttmacher.org/gpr/2006/08/abortion-and-mental-health-myths-and-realities

Corte Suprema de Justicia de la Nación [CSJN] (2012). Fallo "F.A.L. s/ medida autosatisfactiva", expediente 259/2010, tomo 46, letra F, sentencia del 13/3/2012. [En línea] https://www.csjn.gov.ar/archivo-cij/nota-8754-La-Corte-Suprema-precis—el-alcance-del-aborto-no-punible-y-dijo-que-estos-casos-no-deben-ser-judicializados.html

Curley, Maureen & Johnston, Celeste (2013). "The Characteristics and Severity of Psychological Distress After Abortion Among University Students". *The Journal of Behavioral Health Services & Research*, 40 (3): 279-293. [En línea] https://doi.org/10.1007/s11414-013-9328-0

De Lauretis, Teresa (1990). "La esencia del triángulo, o tomarse en serio el riesgo del esencialismo: teoría feminista en Italia, los E.U.A. y Gran Bretaña". *Debate feminista*, 1 (2): 77-115.

De Lauretis, Teresa (1992). "Semiótica y experiencia". En *Alicia ya no. Feminismo, semiótica y cine* (pp. 251-294). Madrid: Cátedra.

De Lauretis, Teresa (1996). "La tecnología del género". *Mora*, 2: 6-34.

De Lellis, Martín; Berra, Andrea; Basilio, Malena; Da Silva, Natalia; Falk, Federico; Reck, Luciana; Russi, Mauro y Sondereguer, Eugenia (2017). "Opiniones y conocimientos de estudiantes universitarios sobre el aborto como problema de salud pública". *Anuario de investigaciones*, Vol. XXIV: 201-220. [En línea] https://www.psi.uba.ar/publicaciones/anuario/trabajos_completos/24/de_lellis.pdf

Defensoría General de la Nación (2018). "Informe: Causas penales por abortos propios". [En línea] https://bit.ly/2JNHCLB

Dosso, Daniela (2017). "Miradas Integrales de la Causal Salud para la Interrupción Legal del Embarazo". En FUSA AC, *La salud como causal de acceso al aborto desde un enfoque integral* (pp. 7-36). [En línea] https://grupofusa.org/descargas/LIBRO-de-ensayos-FUSA-baja.pdf

Drovetta, Raquel (2014). "Acciones feministas en las Líneas de Información Aborto Seguro (LIAS) en Latinoamérica y el Caribe". En A. Carosio (coord.), *Feminismos para un cambio civilizatorio.* Caracas: Clacso.

Drovetta, Raquel (2015). "Líneas telefónicas de información sobre aborto seguro: una estrategia efectiva para incrementar el acceso de las mujeres a los abortos seguros en América Latina". *Reproductive Health Matters*, 23 (45): 47-57.

Drovetta, Raquel (2018). "Profesionales de la salud y el estigma del aborto en Argentina. El caso de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir". *Salud problema, Segunda época*,

12 (24). [En línea] https://saludproblemaojs.xoc.uam.mx/index.php/saludproblema/article/view/594

Federación de Psicólogos de la República Argentina [Fepra] (2013). "Código de Ética Nacional". [En línea] https://fepra.org.ar/wp-content/uploads/2021/06/Codigo-de-E%CC%81tica-de-la-FePRA.pdf

Fernández, Ana María (2009). *Las lógicas sexuales. Amor, política y violencias*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Fernández, Ana María (2011). "Hacia los estudios transdisciplinarios de la subjetividad: reformulaciones académico-políticas de la diferencia". *Revista Investigaciones en Psicología*, 16 (1): 61-82.

Fernández, Ana María (2016). *La mujer de la ilusión. Pactos y Contratos entre hombres y mujeres*. Buenos Aires: Paidós.

Fernández, Ana María (2021). *Psicoanálisis. De los lapsus fundantes a los feminismos del siglo XXI*. Buenos Aires: Paidós Psi.

Fernández, Ana María (2022, 26 de febrero). "Conversatorio sobre su libro *Psicoanálisis. De los Lapsus Fundacionales a los Feminismos del Siglo XXI*". Asociación Psicoanalítica de las Configuraciones Vinculares de Córdoba. Córdoba.

Fernández, Ana María y Tajer, Débora (2006). "El aborto y sus significaciones imaginarias: dispositivos políticos sobre los cuerpos". En S. Checa (comp.), *Realidades y coyunturas del aborto: entre el derecho y la necesidad* (pp. 33-46). Buenos Aires: Paidós.

Fielding, Stephen & Schaff, Eric (2004). "Social Context and the Experience of a Sample of U.S. Women Taking RU-486 (Mifepristone) for Early Abortion". *Qualitative Health Research*, 14 (5): 612-627. [En línea] https://doi.org/10.1177/1049732304263677

FLASOG (2013). *Uso del misoprostol en Obstetricia y ginecología* (3ª ed.). [En línea] https://www.fasgo.org.ar/images/Uso-de-misoprostol-en-obstetricia-y-ginecologia-FLASOG-2013.pdf

Foro (2009, agosto). "Las acciones de la Campaña ante el Aborto No Punible (2006-2009)". En *Foro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito*. La Pampa, Argentina. [En línea] http://www.abortolegal.com.ar/wp-content/uploads/2013/02/foro-aborto-no-punible-2009.pdf

Foster, Diana; Steinberg, Julia; Roberts, Sarah; Neuhaus, John & Biggs, Antonia (2015). "A comparison of depression and anxiety symptom trajectories between women who had an abortion and women denied one". *Psychological Medicine*, 45 (10): 20732082. [En línea] https://doi.org/10.1017/S0033291714003213

Goffman, Erving (2003). *Estigma. La identidad deteriorada*. Amorrortu.

Gómez Lavín, Carmen; Uroz Martínez, Victoria y Zapata García, Ricardo (2018). "Precedentes del aborto provocado en mujeres con síndrome posaborto". *Salud i Ciencia*, 23, (1): 27-33, mayo-junio. [En línea] https://www.siicsalud.com/saludiciencia/pdf/sic_23_1_72018.pdf

Gómez Lavín, Carmen y Zapata García, Ricardo (2005). "Diagnostic categorization of postabortion syndrome". *Actas Españolas de Psiquiatría*, 33 (4): 267-272. [En línea] http://www.bioeticadebat.org/contenidos/PDF/Postaborto.pdf

Gómez Lavín, Carmen y Zapata García, Ricardo (2012). "El Síndrome Post-aborto". *Congreso Mundial de las familias*. [En línea] https://tallerdeldialogoleyaborto.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/07/congreso-mundial-de-las-familias-elsc3adndrome-postaborto-2.pdf

Gregorio Gil, Carmen; Pérez Sanz, Paula y Espinosa Spínola, María (2020). "La construcción de relaciones de confianza: tensiones y contradicciones en el campo desde una mirada feminista". En A. Álvarez, A. Arribas y G. Dietz (eds.), *Investigaciones en movimiento: etnografías colaborativas, feministas y decoloniales* (pp. 297-324). Buenos Aires: Clacso.

Grosso, Belén y Zurbriggen, Ruth (2016). "Coaliciones y alianzas entre activistas feministas y el sistema de salud: Relato de una experiencia situada en pos del derecho a abortar". *Documento REDAAS*, 8, agosto. [En línea] https://redaas.org.ar/documentos-redaas/coaliciones-y-alianzas-entre-activistas-feministas-y-el-sistema-de-salud-relato-de-una-experiencia-situada-en-pos-del-derecho-a-abortar-2016/

Gurpegui, Manuel y Jurado, Dolores (2009). "Complicaciones psiquiátricas del aborto". *Cuad bioét*, 20 (70): 381-392.

Haraway, Donna (1995). "Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial". En

Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza (pp. 313-345). Madrid: Cátedra.

Harding, Sandra (1996). *Ciencia y feminismo*. Madrid: Morata.

Harding, Sandra ([1987] 2002). "¿Existe un método feminista?" (trad. Gloria Elena Bernal). En E. Bartra (comp.), *Debates en torno a una metodología feminista* (pp. 9-34). Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma de México.

Hemmings, Clare (2018). *La gramática de la política feminista*. CABA: Prometeo.

Hirigoyen, Marie-France (2008). *Mujeres maltratadas. Los mecanismos de la violencia en la pareja.* Buenos Aires: Paidós.

IBIS Reproductive Health (2018, abril). "El aborto y la salud mental". [En línea] https://www.ibisreproductivehealth.org/publications/el-aborto-y-la-salud-mental

Johnson, Cecilia (2018). "«Ni la pareja, ni la familia, ni la Iglesia deciden por mí». La experiencia del aborto en mujeres católicas". *Sexualidad, Salud y Sociedad*, (28): 51-70. [En línea] https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2018.28.04.a

Kirkwood, Catherine (1999). *Cómo separarse de su pareja abusadora*. Granica.

Knowles, Jon (2007). "The emotional effects of induced abortion". *Planned Parenthood Federation of America*. [En línea] https://www.plannedparenthood.org/files/8413/9611/5708/Abortion_Emotional_Effects.pdf

Kornblit, Ana Lía (2007). *Metodologías cualitativas en ciencias sociales* (pp. 9-33). Editorial Biblos.

Kumar, Anuradha; Hessini, Leila & Mitchell, Ellen (2009). "Conceptualising abortion stigma". *Culture, Health & Sexuality*, 11 (6): 625-639. [En línea] https://doi.org/10.1080/13691050902842741

Lafaurie, María Mercedes; Grossman, Daniel; Troncoso, Erika; Billings, Deborah; Chávez, Susana; Maira, Gloria; Martínez, Imelda; Mora, Margoth; Ortiz, Olivia (2005). *El aborto con medicamentos en América Latina. Las experiencias de las mujeres en México, Colombia, Ecuador y Perú.* [En línea] http://promsex.org/publicaciones/el-aborto-con-medicamentos-en-america-latina-las-experiencias-de-las-mujeres-en-mexico-colombia-ecuador-y-peru/

Lagarde, Marcela (2000). *Claves feministas para la autoestima de las mujeres*. Cuadernos Inacabados, 39. Madrid: Horas y Horas La Editorial.

Lagarde de los Ríos, Marcela (2001). *Claves feministas para la negociación en el amor*. México: Puntos de encuentro.

Lagarde de los Ríos, Marcela (2011). *Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas.* Madrid: Horas y horas.

Lenta, Malena; Longo, Roxana y Zaldúa, Graciela (2018). "Interrupción legal del embarazo: nudos críticos de las intervenciones de psicólogas/os en consejerías de salud sexual y reproductiva". *Anuario de investigaciones de la Facultad de Psicología*, UBA, Vol. XXV: 95-104.

Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto (comp.) (2010). *Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas*. Editorial El colectivo. [En línea] https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/0d64cf05-a0e4-4791-9668-14e750d7506c/content

Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto (2012, noviembre). "Las mujeres ya decidieron que el aborto es legal. Quinto informe de atención de la línea Aborto: más información, menos riesgos". [En línea] http://clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/451/INFORMELINEAABORTO.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Ley Nacional Nº 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 14 de abril de 2009. Argentina. [En línea] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm

Ley Nacional Nº 26529. Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. 21 de octubre de 2009. Argentina. [En línea] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/norma.htm

López Gómez, Alejandra (2015). "Mujeres y aborto. El papel de las condiciones legales y sociales en las trayectorias y experiencias subjetivas de las mujeres frente al aborto inducido". En. S. Ramos (comp.), *Investigación sobre aborto en América Latina y El Caribe: una agenda renovada para informar políticas públicas e incidencia*

(pp.19-40). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Cedes; Mexico DF: Population Council; Lima: Promsex.

López Gómez, Alejandra y Carril Berro, Elina (2010). "Efectos del aborto clandestino en la subjetividad de las mujeres. Resultados de una investigación cualitativa en Uruguay". *Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia*, Nº 5: 127-164. [En línea] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3345910

López Martín, Isabel; Rivas Jerez, Alba; Alférez Maldonado, Almudena; Sánchez Salas, Ester; Doblado Pedrosa, Antonia; Montes Galdeano, Francisco (2014). "Síndrome post aborto". En P. Moreno Gea y J. Saiz Ruiz (presidencia), *Interpsiquis*, XXV Congreso Virtual de Psiquiatria.com.

Lorde, Audre (1984). "La transformación del silencio en lenguaje y acción". En *Sister Outsiders. The Crossing Press/Feminist* (trad. Diana Mines). [En línea] https://negracubanateniaqueser.files.wordpress.com/2014/05/la_transformacion_del_silencio_en_lenguaje_y_en_accion_audre_lorde.pdf

Maffeo, Florencia; Santarelli, Natalia; Satta, Paula y Zurbriggen, Ruth (2015). "Parteras de nuevos feminismos. Socorristas en Red - feministas que abortamos: una forma de activismo corporizado y sororo". *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer*, 20 (44): 217-227. [En línea] https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5855566

Major, Brenda; Appelbaum, Mark; Beckman, Linda; Dutton, Mary Ann; Russo, Nancy Felipe & West, Carolyn (2009). "Abortion and mental health: Evaluating the evidence". *American Psychology*, 64 (9): 863-90. [En línea] https://www.apa.org/pubs/journals/features/amp-64-9-863.pdf

Maroto Vargas, Adriana (2009). "El trauma post-aborto: Un mito creado por los sectores conservadores". En Colectiva por el Derecho a Decidir, *Interrupción Terapéutica del Embarazo: Aportes para la reflexión* (pp. 137-159). [En línea] https://colectiva-cr.com/wp-content/uploads/2020/06/Interrupci%C3%B3n-terap%C3%A9utica-del-embarazo_-aportes-para-la-reflexi%C3%B3n.pdf

Maroto Vargas, Adriana (2010). "Al amparo de la noche: abortos clandestinos y salud mental". *Revista Costarricense de Psicología*, 29,

(44): 65-75. [En línea] http://www.rcps-cr.org/openjournal/index.php/RCPs/article/view/56/58

Martínez-Salgado, Carolina (2012). "El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias". *Ciência & Saúde Coletiva*, 17 (3): 613-619. [En línea] http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232012000300006

Maure, Gabriela (2021). "La ética del cuidado en los acompañamientos feministas de mujeres que deciden abortar. Reflexiones a partir del diálogo con una colectiva feminista en Mendoza, Argentina". En C. Anzorena, P. Schwarz y S. Yañez (comps.), *Reproducir y sostener la vida: abordajes feministas y de género del trabajo de cuidados* (pp. 161-188). CABA: Teseo.

Meler, Irene (1999). "Psicoanálisis y género. Aportes para una psicopatología". En M. Burin y E. Dio Bleichmar (comps.), *Género, Psicoanálisis y subjetividad* (pp. 241-266). Buenos Aires: Paidós.

Mendizábal, Nora (2006). "Los componentes en el diseño flexible de la investigación cualitativa". En I. Vasilachis de Gialdino (coord.), *Estrategias de investigación cualitativa* (pp. 65-105). Buenos Aires: Gedisa Editorial.

Ministerio de Salud de la Nación Argentina [MSAL] (2013). Decreto Reglamentario Nº 603/2013. Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657. [En línea] http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento224.pdf

Ministerio de Salud de la Nación Argentina [MSAL] (2015). *Guía Técnica para la atención integral de los abortos no punibles*. [En línea] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/senaf/materiales-otros-organismos/Guia%20t%C3%A9cnica%20para%20la%20atenci%C3%B3n%20integral%20de%20los%20abortos%20no%20punibles.pdf

Ministerio de Salud de la Nación Argentina [MSAL] (2019). *Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.* Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. [En línea] http://iah.salud.gob.ar/doc/433.pdf

Ministerio de Salud de la Nación Argentina [MSAL] (2021). *Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción*

voluntaria y legal del embarazo: actualización. Ministerio de Salud de la Nación. Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. [En línea] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/06/res_1535_-_2021_protocolo_ive_anexo_i.pdf

Morán Faúndes, Juan Manuel (2017). *De vida o muerte. Patriarcado, heteronormatividad y el discurso de la vida del activismo "Pro-Vida" en la Argentina*. Tesis de Doctorado en Estudios Sociales de América Latina, Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba: Edicea. [En línea] https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/5503/Moran%20Faundes.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Morello, Gustavo y Rabbia, Hugo (2019). "Introducción". En H. Rabbia, G. Morello, N. Da Cota y G. Romero (comps.), *La religión como experiencia cotidiana: creencias, prácticas y narrativas espirituales en Sudamérica* (pp. 9-32). Editorial de la Universidad Católica de Córdoba / Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú / Universidad Católica del Uruguay.

Organización Mundial de la Salud [OMS] (2012). *Aborto sin riesgos. Guía técnica y de políticas para sistemas de salud*. OMS (2ª ed.). [En línea] https://iris.who.int/handle/10665/77079

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014). *Manual de práctica clínica para un aborto seguro*. [En línea] https://bit.ly/3jIQBLN

Organización Mundial de la Salud [OMS] (2018). *Tratamiento médico del aborto*. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. [En línea] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328166/9789243550404-spa.pdf?ua=1

Paragis, María Paula; Sardar, Brian; Ramallo, Gustavo; Delconte, Cecilia y Pisani, Paula (2020). "Interrupción legal del embarazo y derechos reproductivos. Aportes para la implementación de dispositivos de consejería en hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". *Perspectivas en Psicología*, 17 (2): 66-78. [En línea] http://perspectivas.mdp.edu.ar/revista/index.php/pep/article/view/508

Pérez, Moira (2019). "Salud y soberanía de los cuerpos: propuestas y tensiones desde una perspectiva queer". En Fundación Soberanía Sanitaria (comp.), *Salud feminista. Soberanía de los cuerpos, poder y organización.* CABA: Tinta Limón.

Pistani, María Laura y Ceccato, Bárbara (2014). "Práctica voluntaria del aborto e impacto subjetivo en mujeres. Representaciones, sentidos e imaginario en escenario de clandestinidad". *Vertex, Revista Argentina de Psiquiatría*, XXV: 363-369. [En línea] http://www.polemos.com.ar/docs/vertex/vertex117.pdf

Planned Parenhood Federation of America (2002). "Los hechos hablan más claro que *El grito silencioso*". Biblioteca Katharine Dexter Mc Cormick, Planned Parenhood Federation of America. [En línea] https://www.plannedparenthood.org/uploads/filer_public/36/b8/36b8bbdd-f945-4aa9-a441-b71f6f348908/elgritosilencioso_03-02.pdf

Ramos, Silvina; Romero, Mariana y Aizenberg, Lila (2015). "Women's experiences with the use of medical abortion in a legally restricted context: the case of Argentina". *Journal Reproductive Health Matters*, 22: 4-15. [En línea] https://doi.org/10.1016/S0968-8080(14)43786-8

Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir (2021). "Quiénes somos". *Redsaluddecidir*. [En línea] http://redsaluddecidir.org/quienes-somos/ [Consulta: 23 de septiembre de 2021].

Ripamonti, Paula (2017). "Investigar a través de narrativas: notas epistémico-metodológicas". En M. Alvarado y A. De Oto (eds.), *Metodologías en contexto: intervenciones en perspectiva feminista, poscolonial, latinoamericana* (pp. 83-104). CABA: Clacso.

Robinson, Gail; Stotland, Nada; Russo, Nancy Felipe; Lang, Joan & Occhiogrosso, Mallay (2009). "Is there an "abortion trauma syndrome"? Critiquing the evidence". *Harv Rev Psychiatry*, 17 (4): 268-290. [En línea] https://doi.org/10.1080/10673220903149119

Rondón, Marta (2009). *Resultados de la investigación sobre las consecuencias emocionales y psicológicas del aborto inducido*. Lima: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).

Rosenberg, Martha (2010, diciembre). "Sobre el aborto no punible". Trabajo presentado en *Congreso de Países del Mercosur sobre Bioética y Derechos Humanos*. Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, Buenos Aires, Argentina. [En línea]

http://www.abortolegal.com.ar/wp-content/uploads/2011/01/trabajo-marta-rosenberg.pdf

Rosenberg, Martha (2013). "¿Quiénes son esas mujeres? II". En AAVV, *El aborto como derecho de las mujeres. Otra historia es posible* (pp. 103-110). CABA: Herramienta.

Rosenberg, Martha (2020). "Escuchar las demandas, instituir la subjetivación del derecho al aborto". En B. Riveros (comp.), *El derecho al aborto en la formación "psi": tensiones, demandas y desafíos* (pp. 41-51). CABA: Teseo.

Rostagnol, Susana (2016). *Aborto voluntario y relaciones de género: políticas del cuerpo y de la reproducción.* Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires. Repositorio digital de Universidad de Buenos Aires [En línea] http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1248

Rostagnol, Susana (2021). "La legalización no siempre alcanza. Tensiones entre el movimiento feminista y el avance anti-derechos". En P. Rodríguez López (coord.), *Miradas y horizontes feministas: expresiones de violencia contra las mujeres Latinoamericanas* (pp. 13-22). Boletín del Grupo de Trabajo Feminismos, resistencias y emancipación. CABA: Clacso. [En línea] https://www.clacso.org/boletin-4-miradas-y-horizontes-feministas/

Santarelli, Natalia (2019a). "Discursos médicos disciplinadores y experiencias emocionales de aborto farmacológico de mujeres en Cuyo, Argentina". *Musas. Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad*, 4 (2): 78-99. [En línea] https://doi.org/10.1344/musas2019.vol4.num2.5

Santarelli, Natalia (2019b). "Embarazo no deseado/aborto voluntario y salud mental de las mujeres: una problematización de discursos psi patologizantes". *Revista Electrónica de Psicología Política*, 17 (43): 33-53. [En línea] http://www.psicopol.unsl.edu.ar/pdf/A17-N43-Articulo02-Dic2019.pdf

Santarelli, Natalia (2019c). *En el borde y sostenidas… Experiencias de aborto farmacológico clandestino de mujeres en interacción con profesionales de Psicología.* Tesis de maestría no publicada. Universidad de Málaga.

Santarelli, Natalia (2021). "Significaciones y representaciones de género sobre abortos y mujeres que abortan en dos obras literarias su-

damericanas". *Polémicas Feministas,* (5): 1-16. [En línea] https://revistas.unc.edu.ar/index.php/polemicasfeminista/article/view/35754

Santarelli, Natalia y Anzorena, Claudia (2017). "Los socorrismos y las disputas de sentidos sobre el aborto voluntario. Consideraciones teóricas desde una perspectiva del feminismo crítico". *Descentrada*, [S.l.], Vol. 1, Nº 1: e008. [En línea] https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe008

Santarelli, Natalia y Anzorena, Claudia (2020). "Experiencias emocionales y significaciones en torno al embarazo no deseado/aborto voluntario. Aportes a los alcances de la causal salud integral para la interrupción legal del embarazo en Argentina". *Clivajes. Revista de Ciencias Sociales*, VII, Nº 14: 207-228. [En línea] https://doi.org/10.25009/clivajes-rcs.v0i14.2673

Santarelli, Natalia; Quintana, Carla; Saad, Araceli; Martínez, Carolina y De la Rosa, Melisa (2014). "La realidad del aborto: El Socorrismo como práctica comunitaria". Trabajo presentado en 7º Congreso Multidisciplinario de Salud Comunitaria del Mercosur. Universidad Nacional de San Luis.

Sautu, Ruth (1999). "Estilos y prácticas de la investigación biográfica". En R. Sautu (comp.), *El método biográfico. La reconstrucción de la sociedad a partir del testimonio de los actores* (pp. 21-60). Editorial de Belgrano.

Sautu, Ruth; Dalle, Pablo; Boniolo, Paula y Elbert, Rodolfo (2005). *Manual de Metodología. Construcción de marco teórico, formulación de objetivos y elección de la metodología*. CABA: Clacso.

Socorristas en Red (2014). "Declaración de la Tercera Reunión Plenaria Nacional de Socorristas en Red (Feministas que Abortamos)". [En línea] http://socorristasenred.org/index.php/2015/12/11/en-lucha-porel-derecho-al-aborto-legal-seguro-y-gratuito-ponemos-el-cuerpo-a-los-abortos-en-clave-feminista/

Socorristas en Red (2021). "Sistematización de acompañamientos a abortar". [En línea] https://socorristasenred.org/sistematizacion-2020/

Speckhard, Anne & Rue, Vincent (1992). "Post Abortion Syndrome: An Emerging Public Health Concern". *Journal of Social Issues*, 48: 95-119. [En línea] http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1992.tb00899.x

Steinberg, Julia & Finer, Lawrence (2012). "Coleman, Coyle, Shuping, and Rue make false statements and draw erroneous conclusions in analyses of abortion and mental health using the National Comorbidity Survey". *Journal of Psychiatric Research*, 46: 407-409. [En línea] 10.1016/j.jpsychires.2012.01.019

Steinberg, Julia & Rubin, Lisa (2014). "Psychological Aspects of Contraception, Unintended Pregnancy, and Abortion". *Policy Insights Behav Brain Sci*, 1 (1): 239-247. [En línea] https://doi.org/10.1177/2372732214549328

Stotland, Nada (1992). "The myth of abortion trauma syndrome". *Journal of the American Medical Association*, 268: 2078-2079.

Tajer, Débora (2020). "La importancia de la pluralidad. Abortos, clandestinidades y derechos". En B. Riveros (comp.), *El derecho al aborto en la formación "psi": tensiones, demandas y desafíos* (pp. 53-62). CABA: Teseo. [En línea] https://www.teseopress.com/derechoalaborto/

Tarducci, Mónica (2018). "Escenas claves en la lucha por el derecho al aborto en Argentina". *Salud Colectiva*, 14 (3): 425-432. [En línea] https://doi.org/10.18294/sc.2018.2036

Vacarezza, Nayla (2015). "Aborto, experiencia, afectos". En Dahiana Belfiori, *Código rosa. Relatos sobre abortos* (pp. 137-141). Buenos Aires: La Parte Maldita.

Vacarezza, Nayla (2018). "Perejil, agujas y pastillas. Objetos y afectos en la producción visual a favor de la legalización del aborto en la Argentina". En D. Busdygan (ed.), *Aborto. Aspectos normativos, jurídicos y discursivos* (pp. 195-202). CABA: Biblos.

Vacarezza, Nayla (2019). "Afectos y emociones en las luchas por la legalización del aborto". En M. Pecheny y M. Herrera (comps.), *Legalización del aborto en Argentina. Científicas y científicos aportan al debate* (pp. 45-56). Los Polvorines: Ediciones Universidad Nacional de General Sarmiento.

Vacarezza, Nayla (2020). "La mano que vota. Visualidad y afectos en un símbolo transnacional del movimiento por el derecho al aborto en el Cono Sur". *Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana*, Nº 35: 35-57.

Vaggione, Juan Marco (2014a). "Prólogo". En M. Bellucci, *Historia de*

una desobediencia: aborto y feminismo (pp. 9-19). Buenos Aires: Capital Intelectual.

Vaggione, Juan Marco (2014b). "La politización de la sexualidad y los sentidos de lo religioso". *Sociedad y Religión*, XXIV (42): 209-226. [En línea] http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=387239045010

Velázquez, Susana (2010). *Violencias cotidianas, violencia de género: escuchar, comprender, ayudar.* Buenos Aires: Paidós.

Vergara Sánchez, Patricia Karina (2017). *Indómita versa. Poesía feminista*. Ginecosofía Ediciones.

Wolcott, Harry (2003). *Mejorar la escritura de la investigación cualitativa.* Medellín: Editorial de la Universidad de Antioquia.

Zamberlin, Nina (2015). "El estigma asociado al aborto como objeto de estudio: los primeros pasos en América Latina". En S. Ramos (comp.), *Investigación sobre aborto en América Latina y El Caribe: una agenda renovada para informar políticas públicas e incidencia* (pp.173-190). CABA: Cedes. [En línea] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-72102016000300833&lng=es&tlng=es

Zamberlin, Nina; Romero, Mariana & Ramos, Silvina (2012). "Latin American women's experiences with medical abortion in settings where abortion is legally restricted". *Reproductive health*, 9 (34). [En línea] https://doi.org/10.1186/1742-4755-9-34

Colección Tesis

Títulos publicados (disponibles en https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/553)

Carreros de la esperanza. Ante el racismo y la resignación neocolonial
Ignacio Pellón Ferreyra

Estados Unidos, Venezuela y la cultura del miedo: una lectura crítica del discurso mediático
Rodrigo Bruera

Ciudadanía y primer peronismo. Un análisis sobre conflictividades sociales en La Rioja (1944-1955)
Marilina Truccone

¿Necesitan que el feminismo las salve? Reflexiones sobre las normas de género y la agencia de las mujeres evangélicas en Córdoba
Melisa R. Sánchez

Personas y deportistas para la vida: la escuela en el club, ¿una nueva manera de educar a través del deporte?
Franco Balaguer

"Del yerbal a las calles". Prácticas comunicativas de una organización de cosecheras y cosecheros de yerba mate
María Josefina Pividori

El mundo árabe-islámico en el cine estadounidense.
Narrativas del miedo durante la segunda gestión de George W. Bush
Daniela Marina Martín

Ahora nosotras. La estrategia de las ex presas políticas uruguayas para contar públicamente cómo vivieron el terrorismo de Estado
Romina Verrua

Monseñor Angelelli (título arriba). El pastor de la renovación evangelizadora
Jorge Alberto López

Imaginar contenidos audiovisuales desde las cooperativas. Una propuesta de serie animada transmedia para la Cooperativa de Río Ceballos
Juan Pascual Sgró

Derecho de acceso a la información pública. Análisis de la Ley 27275 durante la tratativa del proyecto en 2016
Noemí Camisassa

La fragua de la democracia mendocina.
Reformas electorales y partidos políticos entre 1910 y 1922
Andrés Abraham

Trans-acciones semióticas. Alteraciones, presencias, diálogos.
Una incursión a la experiencia del trabajo ambulante
Javier F. H. Chemes

Impacto de las políticas de offset en Sudamérica. Argentina, Brasil, Chile y Perú durante 2000-2017
Pablo Américo Aramayo

El dilema de los intelectuales argentinos.Revolución, democracia y poder
Baal Delupi

Género audiovisual escolar. Teoría y metodología para el análisis de videos realizados en el nivel secundario
Diego Agustín Moreiras

Narrar la frontera. Relatos, experiencia y vida cotidiana en los umbrales de la alfabetización semiótica
Froilán Fernández

Transformación agraria en los valles templados de Jujuy. La situación de los productores campesinos en finca El Pongo. 1980-2015
María Eugenia Calvó

Configuración de una matriz identitaria formativa a partir de un análisis de tesinas de Comunicación Social
Vanina Ramé

La invención del rancho. Análisis de la construcción discursiva del hábitat rural en programas de desarrollo en el noroeste cordobés
María Inés Sesma

Comunicación, participación y diplomacia en los movimientos sociales. Las TIC y la construcción de discursos en medios digitales acerca de los mapuches en la Patagonia argentino-chilena
Jorge Luis Dallera

El peronismo revolucionario durante el primer tramo de la reconstrucción democrática. Una mirada desde Córdoba
Ernesto Roland

El Índice EME: un modo de evaluar robots y computadoras para educación infantil
Martín Ignacio Torres

La cosecha de caña de azúcar en Tucumán: cambios e innovaciones entre 1960-2005 Un estudio sociotécnico de mecanización agrícola
Marcos M. Ceconello

Mediatecas y canales cooperativos a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El caso de Mediateca Colsecor
Patricia Denise Gualpa

La politicidad popular entre el fin del ciclo kirchnerista y el inicio del gobierno de Cambiemos: hacia una pragmática de la gubernamentalidad
María Luz Ruffini

Lo que fue un paraíso, se tornó un infierno. Experiencias educativas de infancias en un hogar escuela de la ciudad de Córdoba durante la década de 1950
Mariano Pussetto

Biología sintética y producción de biocombustibles. Un análisis en el marco de la teoría crítica de la tecnología de Andrew Feenberg
Ariel Goldraij

Participación política femenina: escenarios, prácticas e identidades en el radicalismo y el peronismo (Córdoba, 1945-1955)
Marina Inés Spinetta

Con la gente adentro. Apuntes para pensar la inclusión social en la producción del hábitat. La experiencia de Bariloche
Virginia Martínez Coenda

¿Qué puede un espacio? Sacrificio ambiental y subjetividades disidentes en Ituzaingó Anexo (Córdoba, Argentina)
Fernando Vanoli

Reformas políticas en la Córdoba reciente (2001-2008): sus efectos sobre el sistema político-electoral provincial
Nadia Kohl

Escuela y niñez: conflictividades cotidianas y relaciones sociales en contextos de pobreza urbana
Gustavo Enrique Rinaudo

Las implicancias de la Unión Europea en la política exterior de España (1996-2004): el tratamiento de las migraciones en las relaciones bilaterales con Ecuador
Silvana E. Santi Pereyra

La palabra, la política, la vida. *Estética* y *política* en las trayectorias y producción intelectual de Eduardo Galeano y Francisco Urondo: 1955-1976
Gabriel Montali

"Me voy para estudiar, estudio para volver". Un estudio sobre trayectorias educativas con jóvenes de una localidad del interior del sur cordobés: entre la universidad, el pueblo y el trabajo
Carla Falavigna

Editoriales literarias en el cambio de siglo: entre el mercado, la autogestión y el disfrute cultural
Lucía Coppari

Territorialidad y resistencias campesinas: el conflicto de Los Leones (Mendoza, Argentina)
Gabriel Liceaga

Literatura y narcotráfico en Colombia (1994-2011). La construcción discursiva de la violencia en la novela colombiana
Vanessa Solano Cohen

Escuela, Estado y sociedad: una etnografía sobre maestras de la Patagonia
Miriam Abate Daga

Oficialismo y oposición en gobiernos posneoliberales en el Cono Sur: los casos de Kirchner-Argentina y Tabaré Vázquez-Uruguay
Iván Tcach

Prácticas de resistencia de los productores familiares en el agro uruguayo
Virginia Rossi Rodrígue

Los lineamientos y estrategias del desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo 1960-2014. Análisis crítico
Guillermo Jorge Inchauspe

¿Qué es la escuela secundaria para sus jóvenes? Un estudio sociohermenéutico sobre sentidos situados en disímiles condiciones de vida y escolaridad
Florencia D'Aloisio

Estrategias de organización político-gremial de secundarios/as: prácticas políticas y ciudadanía en la escuela
Gabriela Beatriz Rotondi

"No era solo una campaña de alfabetización". Las huellas de la CREAR en Córdoba
Mariana A. Tosolini

El turno noche: tensiones y desafíos ante la desigualdad en la escuela secundaria. Estudio etnográfico en una escuela de la provincia de Córdoba
Adriana Bosio

El Partido Nuevo de Córdoba. Origen e institucionalización (2003-2011)
Virginia Tomassini

La cirugía estética y la normalización de la subjetividad femenina. Un análisis textual
Marcelo Córdoba

La extensión rural desde la comunicación. Los extensionistas del Programa ProFeder del INTA en Misiones frente a sus prácticas de comunicación con agricultores
Francisco Pascual

Artes de hacer en Encuentros Culturales de la Provincia de Córdoba, 2010- 2013
Florencia Páez

Estados locales y alteridades indígenas: sentidos sobre la inclusión habitacional en El Impenetrable
Cecilia Quevedo

La integración de la Región Norte de San Juan y la IV Región de Chile (La Serena y Coquimbo)
Laura Agüero Balmaceda

Las formas de hacer política en las elecciones municipales 2007 de Villa del Rosario
Edgardo Julio Rivarola

Análisis de una estrategia didáctica y de los entornos digitales utilizados en la modalidad B-Learning
Liliana Mirna González

Enseñar Tecnología con TIC: Saberes y formación docente
María Eugenia Danieli

De vida o muerte. Patriarcado, heteronormatividad y el discurso de la vida del activismo "Pro-Vida" en la Argentina
José Manuel Morán Faúndes

Lógica del riesgo y patrón de desarrollo sustentable en América Latina. Políticas de gestión ambientalmente adecuada de residuos peligrosos en la ciudad de Córdoba (1991-2011)
Jorge Gabriel Foa Torres

El neoliberalismo cordobés. La trayectoria identitaria del peronismo provincial entre 1987 y 2003
Juan Manuel Reynares

Marxismo y Derechos Humanos: el planteo clásico y la revisión posmarxista de Claude Lefort
Matías Cristobo

El software libre y su difusión en la Argentina. Aproximación desde la sociología de los movimientos sociales
Agustín Zanotti

Democracia radical en Habermas y Mouffe: el pensamiento político entre consenso y conflicto
Julián González

Radios, música de cuarteto y sectores populares. Análisis de casos. Córdoba 2010-2011
Enrique Santiago Martinez Luque

Soberanía popular y derecho. Ontologías del consenso y del conflicto en la construcción de la norma
Santiago José Polop

Cambios en los patrones de segregación residencial socioeconómica en la ciudad de Córdoba. Años 1991, 2001 y 2008
Florencia Molinatti

Seguridad, violencia y medios. Un estado de la cuestión a partir de la articulación entre comunicación y ciudadanía
Susana M. Morales

Reproducción alimentaria-nutricional de las familias de Villa La Tela, Córdoba
Juliana Huergo

Witoldo y sus otros yo. Consideraciones acerca del sujeto textual y social en la novelística de Witold Gombrowicz
Cristian Cardozo

Género y trabajo: Mujeres en el Poder Judicial
María Eugenia Gastiazoro

Luchas, derechos y justicia en clínicas de salud recuperadas
Lucía Gavernet

Transformaciones sindicales y pedagógicas en la década del cincuenta. Del ocaso de la AMPC a la emergencia de UEPC
Gonzalo Gutiérrez

Estrategias discursivas emergentes y organizaciones intersectoriales. Caso *Ningún Hogar Pobre en Argentina*
Mariana Jesús Ortecho

Vacilaciones del género. Construcción de identidades en revistas femeninas
María Magdalena Uzín

Literatura / enfermedad. Escrituras sobre sida en América Latina
Alicia Vaggione

El bloquismo en San Juan: Presencia y participación en la transición democrática (1980-1985)
María Mónica Veramendi Pont

La colectividad coreana y sus modos de incorporación en el contexto de la ciudad de Córdoba. Un estudio de casos realizado en el año 2005
Carmen Cecilia González

"Se vamo' a la de dios". Migración y trabajo en la reproducción social de familias bolivianas hortícolas en el Alto Valle del Río Negro
Ana María Ciarallo

La política migratoria colombiana en el período 2002-2010: el programa Colombia Nos Une (CNU)
Janneth Karime Clavijo Padilla

El par conceptual pueblo - multitud en la teoría política de Thomas Hobbes
Marcela Rosales

El foro virtual como recurso integrado a estrategias didácticas para el aprendizaje significativo
María Teresa Garibay

"Me quiere… mucho, poquito, nada…". Construcciones socioafectivas entre estudiantes de escuela secundaria
Guadalupe Molina

Biocombustibles argentinos: ¿oportunidad o amenaza? La exportación de biocombustibles y sus implicancias políticas, económicas y sociales. El caso argentino
Mónica Buraschi

Educación y construcción de ciudadanía. Estudio de caso en una escuela de nivel medio de la ciudad de Córdoba, 2007-2008
Georgia E. Blanas